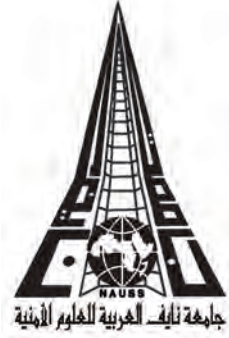


جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

كلية الدراسات العليا

قسم العلوم الاجتماعية



بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان وقياس فاعليته

إعداد

يزيد بن محمد بن حسن الشهري

إشراف

أ.د. عبدالحفيظ سعيد مقدم

أطروحة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة
في العلوم الأمنية

الرياض

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

كلية الدراسات العليا

قسم العلوم الاجتماعية

إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية

الاسم الرباعي: يزيد محمد حسن الشهري الرقم الأكاديمي: (٤٢٦٤٠٠٩)

الدرجة العلمية: دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية

عنوان الأطروحة: "بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان وقياس فاعليته".

تاريخ المناقشة: ١٤٣١/٦/١٢ هـ الموافق ٢٦/٥/٢٠١٠ م.

تمت مناقشة الأطروحة وأوصت اللجنة بإجازتها كمتطلب تكميلي للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية تخصص علم الجريمة.

والله الموفق،،

أعضاء لجنة المناقشة:

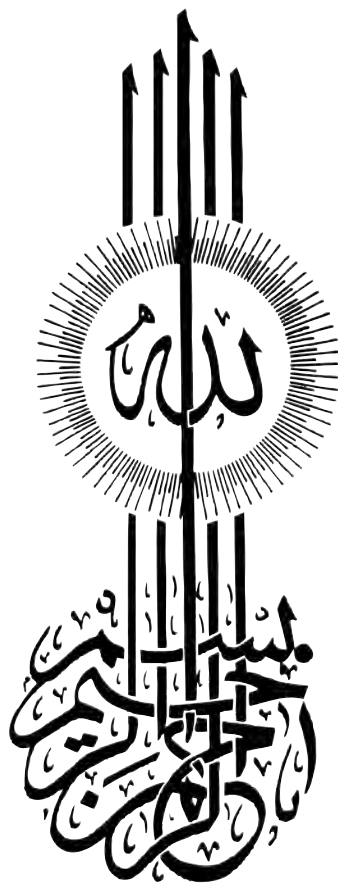
- ١- أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم مشرفاً ومقرراً
- ٢- أ.د. سعيد بن عبدالله بن ديبس عضواً
- ٣- أ.د. فاروق السيد عثمان عضواً

رئيس القسم

الاسم: أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم

التوقيع: 

التاريخ: ٢١/٦/١٨



نموذج رقم (١١)

قسم: العلوم الاجتماعية

مستخلص أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية

عنوان الأطروحة: بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان وقياس فاعليته.

إعداد الطالب: يزيد بن محمد بن حسن الشهري

إشراف: أ.د. عبد الحفيظ سعيد مقدم

مشكلة الأطروحة: تعد مشكلة الانتكاسة من أبرز المشاكل التي تبدو على رأس هرم المشكلات الإدمانية، وأنه ومن خلال ما لاحظته الباحث فإن من بين أسباب تكرار الإدمان في كل مرة هو عدم وجود رغبة وقناعة من قبل المدمن نفسه في العلاج من الإدمان، وعدم وجود برنامج علاجي متخصص لتنمية الدافعية.

هذا وتم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما مدى فاعلية برنامج علاجي سلوكي معرفي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى عينة من مدمني المخدرات؟. **مجتمع الأطروحة:** يشمل مجتمع الدراسة الحالية على جميع حالات المدمنين بقسم مكافحة المخدرات بجلدة.

منهج الأطروحة وأدواتها: تعتمد الدراسة الحالية على المنهج شبه التجريبي حيث أستخدم الباحث تصميم المجموعة الضابطة : اختبار قبلي واختبار بعدي مع مزاجعة.

أهم النتائج:

توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.

أهم التوصيات:

١ - تبني البرنامج العلاجي الذي استخدمه الباحث على جميع مراكز علاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية.

٢ - تبني طريقة العلاج المعرفي السلوكي نظرا لفاعليتها في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.

٣ - تبني مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان كأحد أساليب التقييم في مراكز علاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية.

الكلمات (المفاتيح) Key Words

Motivation	الدافعية
Effectiveness	فاعلية
Addiction	الإدمان
Psychotherapy	العلاج النفسي
Cognitive Behavioral Therapy	العلاج المعرفي السلوكي
Psychotherapy Group	العلاج النفسي الجماعي
Cognitive behavioral program	برنامج معرفي سلوكي
Addict	المدمن
Therapeutic Session	جلسة علاجية
Drugs	المخدرات
Participant in Therapy	المشارك في العلاج
Quasi-experimental approach	المنهج شبه التجريبي

الإهداء

أهدي عملي وخلاصة جهدي و صبري إلى
والدي وأقول له: قلب الأب هو هبة الله الرائعة
فليس هناك فرح أعظم من فرح الابن بمجد أبيه، ولا أعظم من فرح الأب بنجاح
ابنه.
وأمي وأقول لها : لا وسادة أنعم من حضن الأم ولا وردة أجمل من النظر في
وجهها
وأخوتي وأقول لهم : أنتم مكسبي في الدنيا وزيتتي في الرخاء وعدتي في البلاء
وزوجتي وأقول لها : الزوجة أنشودة الرجل
فنبيلها موضع اعتماده وصبرها جنة أفراحه وبسمتها مكافئة أتعابه
كما أهدي هذا الجهد لكل من ساندني ودعمني من الأقارب والأصدقاء وأسأل
الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

الباحث

شكر وتقدير

لحمد لله تعالى حمداً كثيراً طيباً كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فلا يسعني بعد إتمام هذه الأطروحة إلا أن أعترف بالجميل لمن قدمه، وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى قدوتي في دروب العلم والخير:

إلى أستاذي سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الحفيظ سعيد مقدم الذي قدم لي كل ما يملك من جهد ووقت في سبيل الخروج بهذه الأطروحة إلى النور، إذ كان لجهوده القيمة الأثر العظيم في إنجاز هذه الأطروحة، أسأل الله ألا يجرمه الأجر، وأن يحفظه ويبقيه لمن يحبه.

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي على دعمه المستمر للطلبة وتسهيل ما يصعب عليهم.

كما أتقدم بالشكر للهيئة العلمية بقسم العلوم الاجتماعية وكلية الدراسات العليا وجميع اللذين تلقيت منهم العلم والمعرفة.

ويشرفني أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة:

الأستاذ الدكتور سعيد بن دبس . والأستاذ الدكتور فاروق عثمان الذين تطفوا بقبول مناقشة هذه الأطروحة.

ولا ينتهي الشكر لجامعة الملك عبد العزيز التي تبنت ابتعائي لهذا الصرح العلمي ، والذي أسأل الله أن أكون عند حسن ظن المسؤولين والتشرف بخدمة الجامعة في شتى الميادين.

وأخيراً أتوجه إلى العلي القدير بالحمد والشكر ما حييت على أن وهبني الصبر والمثابرة على إنجاز هذا العمل.

الباحث

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	مستخلص الأطروحة باللغة العربية
ب	مستخلص الأطروحة باللغة الإنجليزية
ت	الكلمات (المفاتيح) Key Word
ث	الإهداء
ج	شكر وتقدير
ح	قائمة المحتويات
د	قائمة الجداول
١	الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأبعادها
٢	١. ١ مقدمة الدراسة
٥	١. ٢ مشكلة الدراسة
٧	١. ٣ فروض الدراسة
٩	١. ٤ أهداف الدراسة
٩	١. ٥ أهمية الدراسة
١٠	١. ٦ حدود الدراسة
١١	١. ٧ مفاهيم ومصطلحات الدراسة
١٦	الفصل الثاني: الخلفية النظرية للدراسة
١٧	٢. ١ الإطار النظري
١٧	٢. ١. ١ الدافعية
٥٢	٢. ١. ٢ الإدمان
٦١	٢. ١. ٣ العلاج المعرفي السلوكي

الصفحة	الموضوع
٨٦	٢. ١. ٤. العلاج النفسي الجماعي
١٠٣	٢. ٢. الدراسات السابقة
١١٣	الفصل الثالث: الإجراءات المنهجية للدراسة
١١٤	١. ٣. المنهج المستخدم والتصميم التجريبي
١١٦	٢. ٣. مجتمع الدراسة
١١٦	٣. ٣. عينة الدراسة
١١٦	٤. ٣. أدوات الدراسة
١٤٢	الفصل الرابع: عرض وتحليل بيانات الدراسة وتفسير نتائجها
١٤٣	١. ٤. خصائص العينة
١٤٥	٢. ٤. نتائج الدراسة التجريبية
١٦٠	٣. ٤. التحليل الكيفي لنتائج الدراسة
١٦٣	٤. ٤. التعليق العام على النتائج
١٦٧	الفصل الخامس: الخلاصة والنتائج والتوصيات
١٦٨	١. ٥. الخلاصة
١٦٨	٢. ٥. التوصيات
١٦٩	٣. ٥. مقترحات الدراسة
١٧٠	المصادر والمراجع
١٨٢	الملاحق

قائمة الجداول

رقم الصفحة	الموضوع
١٢١	الجدول رقم (١) يوضح نسب اتفاق المحكمين على صدق عبارات المقياس.
١٢٤	الجدول رقم (٢) يوضح أبعاد مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان
١٢٥	الجدول رقم (٣) بيان بالمقاييس الموزعة والمستلمة والمعتمدة
١٢٥	الجدول رقم (٤) يوضح خصائص عينة التقنين لمقياس الدافعية من مدمني المخدرات
١٢٦	الجدول رقم (٥) يوضح معامل ثبات التجزئة النصفية للصورة الأولية للمقياس
١٢٧	الجدول رقم (٦) يوضح معاملات الارتباط البينية للمقياس والأبعاد الفرعية
١٣٤	الجدول رقم (٧) يوضح تخطيط البرنامج العلاجي
١٤٣	الجدول رقم (٨) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئات العمرية
١٤٤	الجدول رقم (٩) توزيع افراد عينة الدراسة حسب مدة التعاطي
١٤٥	الجدول رقم (١٠) تويغ أفراد العينة حسب المستوى الدراسي
١٤٦	الجدول رقم (١١) لمعرفة الفرق لمتوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي البعدي
١٤٧	الجدول رقم (١٢) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات تحمل المسئولية للمجموعة التجريبية للإختبار القبلي والبعدي
١٤٨	الجدول رقم (١٣) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات الاستقلال التجريبية للإختبار القبلي والبعدي
١٥٠	الجدول رقم (١٤) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات الدافعية الموجبة التجريبية للإختبار القبلي والبعدي
١٥١	الجدول رقم (١٥) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات الإستبصار للمجموعة التجريبية للإختبار القبلي والبعدي
١٥٢	الجدول رقم (١٦) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات المثابرة والتوجه للمستقبل للمجموعة التجريبية للإختبار القبلي والبعدي
١٥٣	الجدول رقم (١٧) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات الشعور بأهمية الزمن للمجموعة التجريبية للإختبار القبلي والبعدي

١٥٤	الجدول رقم (١٨) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات الفعالية الذاتية للمجموعة التجريبية للإختبار القبلي والبعدي
١٥٥	الجدول رقم (١٩) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات التعافي الإيجابي للمجموعة التجريبية للإختبار القبلي والبعدي
١٥٦	الجدول رقم (٢٠) اختبار (ت) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات الحاجة إلى التقبل للمجموعة التجريبية للإختبار القبلي والبعدي
١٥٧	الجدول رقم (٢١) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة في الإختبار القبلي والبعدي
١٥٨	الجدول رقم (٢٢) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في القياس القبلي
١٥٩	الجدول رقم (٢٣) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في القياس البعدي

الفصل الأول

مشكلة الدراسة وأبعادها

١ . ١ مقدمة الدراسة

١ . ٢ مشكلة الدراسة

١ . ٣ فروض الدراسة

١ . ٤ أهداف الدراسة

١ . ٥ أهمية الدراسة

١ . ٦ حدود الدراسة

١ . ٧ مفاهيم الدراسة

الفصل الأول

مشكلة الدراسة وأبعادها

١ . ١ مقدمة الدراسة

تعتبر مشكلة إدمان المخدرات من أعقد المشكلات التي تواجه المجتمعات في الوقت الحاضر. ولا يكاد يفلت منها أي مجتمع، سواء كان متقدما أو ناميا. لأنها تمسه في أمنه وفي اقتصادياته، كما أنها شديدة التعقد لأنها تنفذ بآثارها إلى جميع مستويات الحياة في المجتمع وفي الفرد، في حاضر كل منهما ومستقبله. فهي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا لا تقل تعقيدا عنها في المملكة العربية السعودية أو مصر أو الجزائر.

وتزخر دوريات التخصص بالتناول المفصل أحيانا والمقتضب أحيانا أخرى للاضطرابات النفسية، والمشكلات الاجتماعية، المترتبة على تعاطي المواد المخدرة بجميع أنواعها. حيث أمكن حصر (٢٦) اعتلالا بدنيا ومن أمثلتها: الإختلالات البدنية وإصابات الجهاز التنفسي، واضطراب وظائف الكبد، والفشل الكلوي، واضطرابات الجهاز الدوري القلبي، والجهاز الدوري الدماغي، ونقصان وزن الجسم، وارتعاش الأطراف. كما يوجد (٣٥) اضطرابا نفسيا ومن أمثلتها: حالات الخلط الذهني والتسمي، والتفكير الإلظهادي، والتدهور العقلي، والنوبات الذهانية الحادة، والاكتئاب، والهلاوس، واضطراب النوم. بالإضافة إلى (٥٥) إشكالا اجتماعيا ومن أمثلتها: الانزلاق نحو زيادة الإقبال على المخدرات، وكثرة النزاعات الشخصية، والانسحاب الاجتماعي، وتدهور الشعور بالمسؤولية وسوء التوافق الاجتماعي، وتدهور في مستوى الأداء في العمل، وارتفاع احتمالات البطالة، وقصور في الدافعية، وتدهور الإنتاجية كما وكيفا، والتسرب الدراسي، والانهيار الأسري، وارتفاع معدلات الهجرة، والطلاق، وارتفاع معدلات الجريمة، والعنف والشراسة، والسرقه، والتزوير، والاغتصاب، والقتل (سوييف، ٢٠٠٠م، ص ٤-٢٨).

ونحن نذكر هذه الحقائق لسبب رئيسي هو أن يكون فيها الرد الكافي على البعض ممن يهونوا من أمر الأضرار المترتبة على تعاطي المخدرات بكافة أنواعها.

وعند النظر إلى الظواهر السلبية لتعاطي المخدرات فإن المتعاطي ينتهي غالباً بالإدمان عليها وإذا سلم من الموت لقاء جرعة زائدة أو تأثير للسموم ونحوها فإنه يعيش ذليلاً بائساً مصاباً بالوهن وشحوب الوجه وضمور الجسم وضعف الأعصاب وفي هذا الصدد تؤكد الفحوص الطبية للملفات المدمنين العلاجية أو المرفقة في قضايا المقبوض عليهم التلازم بين داء فيروس الوباء الكبدي الخطر وغيره من الأمراض الفتاكة بتعاطي المخدرات والإدمان عليها (الجيوي، ٢٠٠١م، ص ١ - ٢).

والحديث عن علاج مدمني المخدرات يعود إلى الثلاثينيات حيث بدأت المعاملة العلاجية لهؤلاء الأفراد من المعالجة الدوائية العقاقيرية لبعض الحالات من خلال مستشفى لكسنجتون في ولاية كنتكي بالولايات المتحدة الأمريكية ١٩٥٣م ومستشفى فوت ورث في ولاية تكساس ١٩٣٨م (العنزي، ١٤٢٤هـ، ص ١ - ٣).

وفي إطار العلاج من إدمان المخدرات أولت الدولة اهتماماً كبيراً بفئة المدمنين الذين وقعوا ضحية الإدمان حيث قامت بإنشاء مستشفيات الأمل في أهم مناطق المملكة : الرياض، جدة، الدمام، والقصيم لرعايتهم وتأهيلهم .

إلا أن عدم وجود رغبة وقناعة من قبل بعض من المدمنين في العلاج من الإدمان أدى إلى تزايد نسبة متكرري العلاج، مما خلق الحاجة لإيجاد برنامج متخصص في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان تعنى بهذه الفئة الغير مقتنعة بالعلاج ضمن برامج العلاج من الإدمان. من هنا جاءت أهمية الدراسة من خلال اكتشاف الدوافع النفسية وراء عدم الرغبة في العلاج والتي بدورها تساعد في بناء برنامج علاجي متخصص لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى المدمنين.

وتزداد أهمية الدافعية العلاجية في أنها توضح الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف تصرفات الإنسان، كما أنها مهمة في علاج أنواع السلوك المنحرفة أو الوقاية منها، بل إن معرفتها مهمة وضرورية لكل من يشرف على جماعة من الجماعات ويوجهها، ويعمل على حفزها على تحقيق

أهداف محددة، فكثيراً ما يكون التقصير في بعض المرضى ليس لأسباب تعود إلى النقص في قدراتهم، بل يكون راجعاً لعدم توفر الميل، والاهتمام. هذا فضلاً عن أن دراسة الدوافع لا تقتصر أهميتها على النواحي العملية، فهي وثيقة الصلة بجميع موضوعات علم النفس، حيث لا بد من الدوافع؛ لتفسير كل سلوك، إذ لا سلوك بدون دافع. (الرشدان والهمشري، ٢٠٠٢م، ص ٣ - ٦).

وتمثل دوافع السلوك منزلة كبيرة في العلوم النفسية لأنها تمثل الأسس العامة للعملية العلاجية وطرق التكيف مع العالم الخارجي، واكتساب الخبرات المختلفة، وتحقيق الأهداف والصحة النفسية للفرد، بحيث أن الخلل بها يؤثر في تنظيم الدوافع وإشباعها على التنظيم العام للشخصية وتكيفها. (ناصر الدين، ١٤٢٨هـ، ص ١)

إن الدافعية كانت - ولا تزال - محور اهتمام المؤسسات العلاجية المختلفة، الذين يسعون باستمرار لتحقيق أفضل خدمة علاجية للمرضى من خلال تحفيزهم ورفع مستوى دافعتهم عبر البرامج المتخصصة. وهكذا، تحاول تلك المؤسسات العلاجية - وبشتى الوسائل والطرق الممكنة - حث الأفراد على بذل أقصى جهد وعطاء لتحقيق أفضل الأهداف العلاجية إلا أنه ومع ذلك كله قد لا تحقق المؤسسات العلاجية في جميع الظروف والأحوال ما تصبو إليه من أهداف من قبل المرضى ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود برامج علاجية متخصصة، وكذلك إلى مدى تعقد وحساسية نظام الدافعية لدى الإنسان (حريم، ١٩٩٧م).

الأمر الذي يتطلب إعداد برامج متخصصة تتناسب ووضع المدمنين وتراعي كل المتغيرات والظروف الخاصة لطبيعة الإدمان. فالدافعية هي أحد القوى المهمة في نظام بناء الشخصية وحفز السلوك وتوجيهه نحو وجهة معينة أو تأجيله أو حتى إيقافه (محمود، ١٩٩١م، ص ٢ - ٩).

ويمكننا أن نميز بين نوعين من الدافعية بحسب مصدر استثارتهما: هما الدوافع الخارجية والدوافع الداخلية.

فالدافعية الخارجية: هي التي يكون مصدرها خارجياً وتشمل البيئة المحيطة بالمدمن كالأخصائي والفريق العلاجي، وأولياء الأمور، أو حتى الأقران. فقد يُقبل المدمن على العلاج سعياً وراء رضا المعالج أو لكسب إعجابه وتشجيعه والحصول على الجوائز المادية أو المعنوية

التي يقدمها، أو قد يُقبل على العلاج إرضاءً لوالديه وكسب حبهما وتقديرهما لتركه للتعاطي، أو للحصول على تشجيع مادي أو معنوي منهما، ويمكن أن يكون الأقران مصدرًا لهذه الدافعية فيما يبدو من إعجاب أو تشجيع لقرينهم. أما الدافعية الداخلية : فهي التي يكون مصدرها المدمن نفسه، حيث يُقدّم على العلاج مدفوعاً برغبة داخلية لإرضاء ذاته، وسعيًا وراء الشعور بمتعة الصحة والراحة. والدافعية الخارجية تبقى ما دامت الحوافز موجودة، أما الدافعية فتدوم مع الفرد مدى حياته . (تركي، ١٩٩٠م، ص ٣-٩).

وترتبط الدافعية الإنسانية ارتباطاً وثيقاً بنواتج سلوك الفرد، الأمر الذي جعل لها أهمية كبيرة ضمن موضوعات علم النفس، فيمكن تفسير كثير من أنماط السلوك في ضوء دافعية الفرد. كذلك، فإن أداء الفرد وإقباله على القيام بسلوك معين مرهون بنوعية الدافعية لديه، أما وظائف الدافعية فمتنوعة فهي التي تمدّ السلوك بالطاقة وتستثير النشاط وتحرر السلوك من حالة السكون إلى حالة الحركة، حيث تمد بعض الدوافع الداخلية السلوك بالطاقة أكثر مما تمدّه بها غيرها من المثيرات الخارجية كالجوائز والحوافز المادية، وهي كذلك تحافظ على استمرارية السلوك (عبانة، ١٩٩٩م، ص ٤ - ٢٢).

ومن هنا يرى الباحث أن تناول موضوع الدافعية للعلاج لدى المدمنين من خلال بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان وتصميم مقياس يساعد في تشخيص نقص الدافعية للعلاج من الإدمان لدى المدمنين، يسهم أولاً في معرفة الأشخاص الذين نتعامل معهم، ومن ثم تقديم خدمات علاجية تسهم في زيادة الدافعية للعلاج لدى المدمنين والتي بدورها تساعد في استفادة المرضى من الإمكانيات المقدمة لهم ومحاولة استغلال كل الفرص التي تسهم في تعافيهم من هذا الاضطراب الفتاك.

١ . ٢ مشكلة الدراسة

من خلال عمل الباحث في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض - وهو أحد المراكز المتخصصة في علاج الإدمان على المخدرات في المملكة العربية السعودية - (سابقاً) لاحظ الباحث أن مشكلة الانتكاسة من أبرز المشاكل التي تبدو على رأس هرم المشكلات الإدمانية،

وأنه ومن خلال ما لاحظته الباحث فإن من بين أسباب تكرار الإدمان في كل مرة - هو عدم وجود رغبة وقناعة من قبل المدمن نفسه في العلاج من الإدمان .

وعندما نتحدث بالأرقام نجد أن نسبة الانتكاسة عالمياً تصل ٩٠٪ (Adate eta 1992:107).

ويؤكد الحجار نفس النسبة وذلك عندما تتبع عينة من المدمنين لمدة ستة أشهر (الحجار، ١٤٠٩هـ، ص ٣- ١٥). وفي إحصائية محلية بمجمع الأمل للصحة النفسية بلغ متوسط نسبة متكرري العلاج ٦٣٪ خلال ثلاث سنوات (إحصائيات غير منشورة).

وللوقوف على حجم مشكلة العودة للإدمان في المجتمع المحلي والعربي قام الغريب (٢٠٠٧م) بدراسة استطلاعية حديثة على عينة من المؤسسات العلاجية في بعض الدول العربية، وقد تم تطبيق الدراسة في عدد من المؤسسات العلاجية في (١٤) مؤسسة من المؤسسات العلاجية في الدول العربية، من (٨) دول عربية. فوجد أن هناك ارتفاعاً في أعداد المدمنين بالمؤسسات العلاجية في كل سنة عن السنة السابقة لها في معظم الدول العربية عينة الدراسة. وجاء في المرتبة الأولى من كانت عودتهم أربع مرات، وجاء في المرتبة الثانية خمس مرات، وفي الثالثة من كانت عودتهم لمرتين، والرابعة من عادوا مرة واحدة. وهذا يعني زيادة عدد مرات العودة لدى المدمنين في المؤسسات العلاجية المشمولة بالدراسة حيث أشار الغريب أن من بين الأسباب الهامة وراء عودة المدمن إلى التعاطي بعد خروجه من المراكز العلاجية، هي عدم وجود الدافعية لدى المدمن للعلاج. (الغريب، ٢٠٠٧م، ص ١).

وعندما نطلع على المدمن نجد أنه لا يستطيع ترك التعاطي إلا إذا كانت لديه قوة تدفعه إلى التوقف والعلاج وهذه القوة الدافعة للنشاط أو السلوك هي التي تسمى الدافعية فسلوك الإنسان يرتبط بدوافعه وحاجاته المختلفة، فلكل سلوك هدف؛ وهو إشباع حاجات الإنسان. والحاجة باعتبارها حالة من التوتر أو عدم الاتزان تتطلب نوعاً من النشاط لإشباع هذه الحاجة. ونتيجة لذلك التوتر الداخلي ينشأ الدافع الذي يحفز الإنسان للقيام بالسلوك. ويعني ذلك أن حياة الإنسان مليئة بالحاجات والدوافع التي تؤثر على سلوكه وتوجهه، فهو لا يستطيع البقاء دون إشباع تلك الحاجات أو الدوافع .

وهذا ما دعا المسؤولين في مجال الخدمات النفسية بمجمع الأمل إلى ضرورة إيجاد برنامج يزيد من دافعية المرضى في العلاج، الأمر الذي دعا الفرق العلاجية بالتوصية بضرورة وجود قسم خاص بالمرضى الذين ليس لديهم دافعية لعمل برنامج خاص بهم ينمي من دافعيتهم، إلا أن تنفيذ ذلك البرنامج أصطدم بعدم وجود برنامج ومقياس للدافعية، مما أحبط تلك الخطط العلاجية وقتلها في مهدها، من هنا أراد الباحث بناء برنامج علاجي لزيادة الدافعية ومقياس فاعليتها لدى مدمني المخدرات بقسم مكافحة المخدرات بجدة .

من ذلك نجد أن لدراسة الدافعية أهمية كبيرة في مجال علاج الإدمان ذلك أن وجود برنامج علاجي سلوكي معرفي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان ومقياس يقيس درجة الدافعية للعلاج من الإدمان أهمية كبيرة في محاولة للتقليل من معدلات الانتكاسة والعلاج من الإدمان والاستمرار في التعافي ومن ثم يسهم ذلك في التكيف مع العالم الخارجي، واكتساب الخبرات المختلفة، وتحقيق الأهداف والصحة النفسية للفرد.

هذا ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي :

ما مدى فاعلية برنامج علاجي سلوكي معرفي مقترح لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى عينة من مدمني المخدرات ؟

١ . ٣ فروض الدراسة

بعد مراجعة الباحث للكتابات والبحوث والدراسات العربية والأجنبية في مجال الدافعية والتي حاولت على تعدد مناحيها إلقاء الضوء على طبيعة الدافعية الإنسانية وما تتضمنه من معاني ودلالات وما يصاحبها أو يترتب عليها من تصرفات ونشاطات سلوكية وتوجهات حياتية بصفة عامة، وإجراء دراسة استطلاعية على مدمني المخدرات توصل الباحث إلى الفروض التالية :

الفرض الرئيس

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياس القبلي و البعدي على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي .

ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية :

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد تحمل المسؤولية لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي .
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد الإستقلال لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي .
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد الدافعية الموجبة لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي .
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد الاستبصار لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي .
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد التوجه للمستقبل لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي .
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد الشعور بأهمية الزمن لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي .
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد الفعالية الذاتية لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي .
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد التعافي الإيجابي لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي .
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين

القياسين القبلي و البعدي على بعد الحاجة إلى التقبل لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة بين القياس القبلي و البعدي على مقياس الدافعية بعد تطبيق البرنامج العلاجي

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية و متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية قبل تطبيق البرنامج العلاجي

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية و متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

١ . ٤ أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي :

١ - بناء برنامج علاجي سلوكي معرفي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى عينة من مدمني المخدرات .

٢ - اختبار فاعلية برنامج علاجي سلوكي معرفي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى عينة من مدمني المخدرات .

١ . ٥ أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي :

من الناحية النظرية

في كونها ستضيف شيئاً إلى التراكم المعرفي فيما يتعلق بالبرامج العلاجية وقياس الدافعية،

كما تلقي مزيداً من الضوء على أهمية الدافعية في تفسير السلوك الإدماني، ولقلة الدراسات التي تناولت ذلك الجانب على المستوى العربي بشكل عام، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية بشكل خاص - في حدود علم الباحث - فإن هذه الدراسة يمكن أن تضيف للأطر النظرية فيما يتعلق بتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.

ومن الناحية التطبيقية

فإن هذه الدراسة تقدم برنامج علاجي سلوكي معرفي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى عينة من المدمنين، وتقيس فعاليته. كما تقدم مقياساً يقيس درجة الدافعية للعلاج من الإدمان، يمكننا بإذن الله من تشخيص درجة الدافعية لدى المدمنين، وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان، وبذلك أثبت البرنامج جدواه في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان. وبالتالي يمكن توظيفه واستخدامه في مراكز علاج الإدمان ضمن الخدمات العلاجية النفسية المقدمة لمدمني المخدرات .

١ . ٦ حدود الدراسة

تحدد الدراسة الحالية بالمنهج المستخدم وهو المنهج شبه التجريبي، كما تتحدد بالعينة المستخدمة وهي جميع المرضى المنومين بقسم (أ) الخاص بالمدمنين المحولين من مكافحة المخدرات بجدة مقسمين على مجموعتين متساويتين. كما تحدد هذه الدراسة بمقياس الدراسة (الدافعية للعلاج من الإدمان). وكذلك سوف يحدد الدراسة الأسلوب الإحصائي المستخدم في ضوء الفروض. كما تتحدد الدراسة بمتغيراتها الرئيسية خلال الفترة ١٤٣٠ هـ إلى ١٤٣١ هـ. كما تلخص حدود الدراسة في الحدود التالية:

- ١- حدود المتغيرات: وتتمثل في متغيرات الدراسة المحددة في متغير الدافعية للعلاج من إدمان (تابع) والبرنامج العلاجي النفسي (مستقل).
- ٢- الحدود البشرية: تتحدد في مجتمع الدراسة الحالية وهم جميع مرضى الإدمان المنومين في مكافحة المخدرات بقسم (أ) .

٣- الحدود القياسية: التي تم تحديدها في أداة الدراسة، والتي تتضمن مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان.

٤ - الحدود الإحصائية: التي ستبدو في الأساليب الإحصائية المحددة في ضوء الفروض. حيث استخدم الباحث اختبار كل من ويلكوكسن و مان وتني.

٥ - الحدود الزمانية : تتحدد الدراسة الحالية بالفترة الزمنية التي جرت فيها الدراسة خلال العام ١٤٣٠هـ - ١٤٣١هـ .

١ . ٧ مفاهيم ومصطلحات الدراسة

العلاج المعرفي السلوكي Cognitive Behavioral Therapy

يذكر المحارب بأن العلاج المعرفي السلوكي: هو نموذج علاجي يركز على المهارات السلوكية والعمليات المعرفية بالدمج بين الفنيات المستخدمة في العلاج السلوكي التي ثبت نجاحها في التعامل مع السلوك، مع الجوانب المعرفية بهدف إحداث تغييرات مطلوبة في سلوك طالب المساعدة (المحارب، ٢٠٠٠، ص ١)

ويعرفه عبد الله بأنه « عبارة عن مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تشترك في افتراض أن العمليات المعرفية تؤثر في السلوك، وأن هذه العمليات تتغير من خلال الفنيات المعرفية والسلوكية». (محمد، ٢٠٠٠، ص ٢٣)

وتعرفه الدراسة الحالية إجرائياً: بأنه أحد أساليب العلاج النفسي الحديث والذي يستخدم أساليب وطرق أكثر ايجابية عن طريق استخدام فنيات العلاج السلوكية والمعرفية بالدمج بينها بما يحقق أهداف البرنامج حيث يتم فيها التركيز على تعليم المريض الاستراتيجيات السلوكية والمعرفية، لمواجهة الضغوط بدلاً من التفكير في كيفية الوصول لمخرج من الموقف، والذي يتم من خلاله التركيز على الطريقة التعليمية في الإدراك. ومن ثم إعادة بناء أفكارهم وطريقة تفكيرهم و أفعالهم، وممارسة السلوكيات الإيجابية وتدعيمها.

البرنامج المعرفي السلوكي Cognitive behavioral program

يعرفه الباحث إجرائياً بأنه: سلسلة من الخطوات المتتابعة التي تطبق على هيئة جلسات تجمع بين المعالج ومدمني المخدرات في ضوء المنظور المعرفي السلوكي عبر استخدام العديد من الفنيات العلاجية المستخدمة في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان والتي تهدف إلى تحقيق أهداف البرنامج . (أعدّه الباحث)

الدافعية (Motivation)

يشار إلى مفهوم الدافع في اللغة اللاتينية بكلمة «Move» ويشار إلى مفهوم الدافع في اللغة الإنجليزية بكلمة «Motive» ويعني يحرك، وهو عبارة عن أي شيء مادي أو معنوي يعمل على تحفيز وتوجيه الأداء والتصرفات . أي أن كلمة دافع مأخوذة من الفعل الثلاثي : دفع، أي حرك الشيء من مكان إلى مكان آخر وفي اتجاه معين . فكلمة الدافع على وزن فاعل، لذا فإن دافع السلوك هو هذا الدافع، فهو الذي يحول السلوك إلى فعل، وعليه فأى سلوك يقوم به الإنسان يحتاج إلى تفعيل، فالذي يعم على إظهار هذا السلوك وتفعيله هو هذا الدافع . (بني يونس، ١٤٢٧هـ، ص ١٤)

وتعرف الدافعية : «بأنها عبارة عن القوى المحركة للسلوك وتوجيهه نحو تحقيق غايات معينة، يشعر الفرد بالحاجة إليها، أو بأهميتها المادية أو المعنوية له، حيث يتم استثارة هذه القوى المحركة بعوامل متعددة، قد تنشأ من داخل الفرد ذاته أو تنشأ من المحيط المادي أو الاجتماعي .» (بني يونس، ١٤٢٧هـ، ص ١٦)

كما تعرف الدافعية : بأنها مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل تحقيق حاجاته، وإعادة الاتزان عندما يختل وبالتالي تحقق الدافعية وظائف أساسية في السلوك، هي : تحريكه وتنشيطه، وتوجيهه، والمحافظة على استدامته إلى حين إشباع الحاجة . (الترتوري، ٢٠٠٦ م)

كما تعرف الدافعية بأنها مثير داخلي يحرك سلوك الأفراد ويوجهه للوصول إلى هدف معين . (قطامي وقطامي، ٢٠٠٠ م)

ويعرف الباحث الدافعية بأنها : حالة داخلية أو خارجية تحث الفرد نحو الوصول إلى هدف معين عبر استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه، ويمكن إن يستدل على هذه الحالة من تتابعات السلوك الموجهة نحو الهدف، وتنتهي هذه التتابعات بتحقيق موضوع الدافع .

وتعرف الدراسة الحالية الدافعية للعلاج من الإدمان إجرائيا « درجة الفرد في مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان المكون من (١١٣) عبارة مصنفة إلى تسعة أبعاد حيث تم الإجابة عليها بحسب سلم ليكرت الخماسي .

الإدمان(Addiction):

يشار إلى التعريف اللغوي للإدمان: من دمن وأدمن الشراب وغيره، لم يُقلع عنه. ويقال: فلان يُدمن الشرب والخمر إذا لزم شربها. ومدمن الخمر الذي لا يُقلع عن شربها. ويُقال: فلان مُدمن خمر أي مداوم شربها. ويؤيد الحديث الشريف مداومة الشراب لمدمن الخمر. ففي الحديث: مُدمن الخمر كعابد الوثن، وهو الذي يُعاقِر شربها ويلازمه ولا ينفك عنها. (الجوهري، ٢٠٠٤م، ص٣٥).

ويعرف (الكفافي وجابر) الإدمان بأنه اعتماد سيكولوجي وفي بعض الحالات فسيولوجي أيضا - على تعاطي الخمر والعقاقير المخدرة والدخان وبعض المواد الأخرى . والمعياري حدوث حالة الإدمان هو:

- اللهفة إلى زيادة الجرعة وذلك بسبب ارتفاع مستوى الإطاقة

- الانسحاب الشديد أو الانصراف عن كثير من الأنشطة.

- ظهور أعراض معينة إذا خفضت جرعات المادة المتعاطاه أو إذا توقفت . (جابر والكفافي،

١٩٨٨م)

ويعرف الإدمان لدى (شحاته ربيع) بأنه : الحد الأدنى الذي تفسد معه الحياة الاجتماعية والمهنية للفرد المدمن حيث يصل إلى صورة مركبة معقدة تتميز ببعض السمات مثل الرغبة الملحة في تكرار التعاطي والاتجاه نحو زيادة الكمية والتأثيرات السلبية على الفرد وعلى الوسط الاجتماعي المحيط به (ربيع، ١٩٧٧م، ص١٢٦).

والمدمن (Addict): هو الفرد الذي تعود على تعاطي مادة مخدرة بأي صورة من صور التعاطي وحيث ينتج عن الإفراط في التعاطي تبعية نفسية أو جسمية أو كل منهما (منصور، ١٩٨٦ م). وقد ازداد استخدام مصطلح الإدمان واستمر لفترات طويلة حيث عرفت لجنة خبراء العقاقير والتي هي الآن فرع من منظمة الصحة العالمية عرفت الإدمان: بأنه حالة من التسمم الدوري أو المزمن ضار بالفرد والمجتمع ينشأ بسبب الاستعمال المتكرر للعقار الطبيعي أو الصناعي ويتصف بقدرته على إحداث رغبة أو حاجة ملحة لا يمكن قهرها أو مقاومتها للاستمرار في تناول العقار والسعي الجاد للحصول عليه بكل الوسائل الممكنة وكما يتصف بالميل نحو مضاعفة مقدار الجرعة ويسبب حالة من الاعتماد النفسي أو الجسدي أو كليهما (بابكر، ٢٠٠٣ م، ص ٢٥١).

وبالرغم من أن كل نوع من أنواع المخدرات له من خصائصه الإدمانية ما قد يختلف عن الآخر إلا أن التعريف أعلاه يمكن أن يكون شاملا لكل أنواع المخدرات بصفة عامة.

والباحث يتبنى تعريف لجنة خبراء العقاقير والتي هي فرع من منظمة الصحة العالمية كتعريف إجرائي.

العلاج النفسي (Psychotherapy)

تشير الجمعية الطبية النفسية الكندية للعلاج النفسي بأنه: الوسيلة الطبية التي يقوم بها المعالج النفسي عن طريق جلسات من الحديث، أو وسائل اتصال أخرى للكشف عن سلوك الفرد المضطرب بهدف إصلاحه، والتقليل من معاناته. ويعرف أيضا: بأنه الوسيلة العلاجية التي تفعل عن طريق العلاقات الشخصية والسلوكية، وليس عن طريق الفعل الفسيولوجي بشكل خاص (كمال، ١٩٩٤ م، ص ٨٨ في الزهراني، ٢٠٠٦ م).

والعلاج النفسي بمعناه العام هو: نوع من العلاج تستخدم فيه أية طريقة نفسية لعلاج مشكلات، أو اضطرابات، أو أمراض ذات صبغة انفعالية يعاني منها العميل، وتؤثر في سلوكه وفيه يقوم المعالج - وهو شخص مؤهل علميا وفنيا - بالعمل على إزالة الأعراض المرضية الموجودة أو تعديلها، أو تعطيل أثرها، مع مساعدته على تنمية شخصيته ودفعها في طريق النمو النفسي الصحي، بحيث يصبح العميل أكثر نضجا وأكثر قدرة على التوافق النفسي في المستقبل (زهران، ٢٠٠٣ م، ص ١٨٣ في الزهراني، ٢٠٠٦ م).

وتعرف الدراسة الحالية العلاج النفسي إجرائياً: بأنه الطريقة التي يستخدمها المعالج النفسي في مراكز علاج الإدمان والمعتمدة على العلاج السلوكي المعرفي لتعديل الحالة المزاجية والانفعالية والسلوكية للمضطربين. (دليل السياسات والإجراءات بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ١٤٢٨هـ).

العلاج النفسي الجماعي Groub Psychotherapy

العلاج النفسي الجماعي عبارة عن: «علاج مجموعة من المرضى في جلسة علاجية واحدة». (كمال، ١٩٩٤م، ص ٤٤٣).

كما عرفته سري بأنه: نوع من العلاج المتخصص تستخدم فيه طرق وأساليب نفسية لعلاج المشكلات أو الاضطرابات أو الأمراض نفسية المنشأ، بهدف حل المشكلات وإزالة الأعراض والشفاء من المرض، ونمو الشخصية، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق النفسي، والتمتع بالصحة النفسية (سري، ١٩٩٠م، ص ٩٠).

وتعرفه الدراسة الحالية إجرائياً بأنه: أسلوب علاجي يشتمل على العديد من النشاطات يسعى إلى تبصير المشاركين بمشكلاتهم، وزيادة الوعي لديهم عبر إعطاءهم الحرية للتعبير عن مشاعرهم ومناقشة مشكلاتهم، وإعطاء صورة واضحة للفرد في تعامله مع المجتمع وتعامله مع باقي أعضاء الجماعة وتفاعله معهم، وإعادة الثقة بنفس المشارك وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديه ومساعدته على اكتشاف قدراته والتعبير عنها بطريقة تمكنه من تعديل سلوكياته، ومساعدة في التخلص من أفكاره التي تقوده إلى الاستسلام للمواقف والإحداث بصور سلبية ومن ثم تكوين أفكار غير منطقية تسهم في سوء مسلكه .

الفاعلية Effectiveness

لقد عُرفت الفاعلية بأنها عبارة عن: «القدرة على تحقيق النتيجة الإيجابية المقصودة حسب المعايير المحددة مسبقاً، حيث ترتفع درجة الكفاية عندما يتم تحقيق النتيجة بشكل كامل». (الشبانات، ١٩٩٦م، ص ١٥).

وتعرف إجرائياً: بأنها الأثر الذي يتركه العلاج المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى عينة من مدمني المخدرات.

الفصل الثاني

الخلفية النظرية للدراسة

٢ . ١ الإطار النظري

٢ . ٢ الدراسات السابقة

الفصل الثاني

الخلفية النظرية للدراسة

٢ . ١ الإطار النظري

٢ . ١ . ١ الدافعية

يعد موضوع الدافعية من أهم موضوعات علم النفس، وأكثرها دلالة سواء على المستوى النظري أو التطبيقي. فلا يمكن حل المشكلات السلوكية دون الاهتمام بدوافع الكائن الحي التي تقوم بالدور الأساسي في تحديد سلوكه كما وكيفاً.

ويرتكز تراث علم النفس التجريبي الخاص بعمليات التعلم والتذكر والعمليات الإدراكية ومعظم جوانب سلوك الإنسان أو الحيوان على أساس فروض لها علاقة بمبادئ الدافعية في علم النفس، وهي أنها تساعد في الوقوف على أفضل فهم وتفسير لسلوك الكائن الحي حتى يمكن التنبؤ بها وضبطها في المستقبل.

إن دراسة دوافع السلوك الإنساني أو الحيواني تزيد من فهم الإنسان لنفسه ولغيره من الأشخاص، وذلك لأن معرفتنا بأنفسنا تزداد كثيراً إذا عرفنا الدوافع المختلفة التي تحركنا أو تدفعنا إلى القيام بأنواع السلوك المتعددة في سائر المواقف والظروف. كما إن معرفتنا بالدوافع التي تدفع الآخرين إلى القيام بسلوكهم تجعلنا قادرين على فهم سلوكهم وتفسيره.

كما تساعدنا دراسة الدوافع كذلك على التنبؤ بالسلوك الإنساني في المستقبل. فإذا عرفنا دوافع شخص ما، فإننا نستطيع إن نتنبأ بسلوكه في ظروف معينة.

كما نستطيع إن نستخدم معرفتنا بدوافع الأشخاص في ضبط وتوجيه سلوكهم إلى وجهات معينة وأهداف معينة، من خلال تهيئة بعض المواقف الخاصة التي من شأنها إن تثير دوافع معينة تحفزهم إلى القيام بالأعمال التي نريد منهم أداؤها، ونمنعهم من القيام ببعض الأعمال الأخرى التي لا نريد منهم أداؤها. لذلك تظهر أهمية دراسة الدوافع في مختلف الميادين العلمية التطبيقية كميدان التربية والصناعة والعلاج النفسي وغيرها.

وقد بدأ الاهتمام بموضوع الدافعية منذ أواخر القرن الماضي، وأوائل القرن الحالي إلا إن هذه البداية شهدت معالجات سطحية قامت على أساس مفاهيم ومناهج بحث تختلف عن تلك التي تستخدم اليوم. ومع ذلك كان هناك اهتمام ببعض المشكلات التي نطلق عليها اليوم «مشكلات الدافعية» (رضوان، ٢٠٠٧م)

مفهوم الدافعية:

تحتل المكونات الدافعية موقعا رئيسي في كل ما قدمه علم النفس حتى الآن من نظم وأنساق سيكولوجية ويرجع ذلك إلى الحقيقة التالية: أن كل سلوك وراءه قوى دافعية معينة. ورغم التباين والتعدد الهائلين في نظريات علم النفس، ورغم ما قد يشيع بينها من تناقض أو تعارض ومن وصل أو فصل، فهي تكاد تتفق فيما بينها على هذه الحقيقة، وتقرر لها كل نظرية بشكل أو بآخر، وتفرد لها مكانا متميزا في نسقها العلمي. (قشقوش، ١٩٧٩، ص ٥)

ونشير هنا إلى أن مفهوم الدافعية، مثله مثل غيره من المفاهيم السيكولوجية الأخرى كالإدراك والتذكر والتعلم، بمثابة تكوين فرضي يستدل عليه من سلوك الكائن الحي.

وبالتالي يستخدم مفهوم الدافعية لتحديد اتجاه السلوك وشدته. وبالإضافة إلى ذلك يكون كل منا على وعي بمختلف دوافعه ومقاصده السلوكية وهناك مبرران رئيسيان للاستدلال على مفهوم الدافعية من سلوك الكائن الحي وهما:

أ- يكون السلوك المدفوع والموجه إلى هدف بمثابة شيء معتاد، ومستمر بصورة ملحوظة، وبالتالي يفترض وجود عملية دينامية تقف خلفه وتحدد قوته.

ب- ربما لا تصدر استجابات الكائن الحي نتيجة لمنبهات خارجية محددة، ويعني ذلك وجود محددات داخلية توجه السلوك إلى أهداف بعينها. (غباري، ٢٠٠٨م، ص ١٦)

ومن هنا سنعرض بعض تعريفات للدافعية وهي على النحو التالي، ولكن علينا أولاً أن نوضح من البداية أن مفهوم الدافع يرادف مفهوم الدافعية، ويعبر كلاهما عن الملامح الأساسية للسلوك المدفوع، وإن كانت الدافعية هي المفهوم الأكثر عمومية. وبالتالي عند استخدامنا لأي من المفهومين، نقصد شيئاً واحداً.

إذن فإنه يشار إلى مفهوم الدافع في اللغة اللاتينية بكلمة (movere) «ويشار إلى مفهوم الدافع في اللغة الانجليزية بكلمة (motive)» ويعني يحرك، وهو عبارة عن أي شيء مادي أو مثالي يعمل على تحفيز وتوجيه الأداء والتصرفات. أي أن كلمة دافع مأخوذة من الفعل الثلاثي : دفع، أي حرك الشيء من مكانة إلى مكان آخر وفي أي اتجاه معين وعندما نقول بأن الذي دفع شخص للقيام بسلوك معين، فإننا نعني إن شيئاً ما هو الذي حركه، وهذا المحرك هو ما نقصد به الدافع. وعليه فأي سلوك يقوم به الإنسان يحتاج إلى تفعيل، فالذي يعمل على إظهار السلوك وتفعيله هو هذا الدافع. (بني يونس، ٢٠٠٧، ص ٤٩)

فالمدلول اللفظي الحرفي لكلمة دافع يتضمن معنى التحريك أو الدافع. أما المعنى السيكلولوجي فيستعمل للدلالة على فكرة تستخدم لكي نوضح بها أن سلوك الكائن الحي يتوقف في تغيره وتعديله على إخضاع الكائن الحي وتعرضه لعمليات معينة. (فهمي، ١٩٦٠م، ص ٤٩).

أما تعريف الدافع إجرائياً: فإنه مفهوم كباقي المفاهيم في علم النفس هو مفهوم افتراضي أي انه ليس مفهوماً فرضياً أي (تخمينياً) بل هو مفهوم فعلي وموجود أصلاً، ووجوده غير قابل للشك وهو مفهوم إجرائي أي قابل للقياس والتقييم والملاحظة غير المباشرة، كما أنه قابل للتجريب والتقويم أيضاً. فالدافع ينتمي إلى السلوك ذاته ويعد صفة شخصية ثابتة خاصة بالسلوك والتي تعمل على تحفيز السلوك من الداخل نحو انجاز تصرفات معينة.

فالدافع عموماً يمثل جملة من الاستعدادات المسبقة، أو التأهب المسبق عند الإنسان نحو القيام بأفعال خارجية أو الداخلية. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ٤٩)

وقد تعددت التعريفات الإجرائية وتنوعت، وذلك بسبب اختلاف الخلفيات النظرية لعلماء النفس.

ففي أوائل القرن العشرين، أصبحت الدوافع موضوعاً هاماً في علم النفس، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى جهود وليم ماكدوجل (١٨٧١م - ١٩٣٨م) وهو عالم سلوكي انجليزي. وقد أطلق على الدوافع مصطلح «الغرائز»، وعرفها على أنها قوى موروثية لاعتقالية، تجبر السلوك على اتجاه معين. (دايفيد وون، ١٩٣٨م، ص ٤٣١)

ويعرف «بول توماس ينج» (١٩٦١م) الدافعية: على أنها «عملية استثارة وتحريك السلوك أو العمل، وتعزيد النشاط إلى التقدم، وتنظيم نموذج النشاط».

أما «دونالد لندزلي» (١٩٧٥م) فيعرف الدافعية على أنها «مجموعة القوى التي تحرك السلوك وتوجيهه وتعزده نحو هدف من الأهداف». ويؤكد كلا هذان التعريفان، وهما لإثنين من أعظم الثقة في سيكولوجية الدافعية على الوظيفتين الأساسيتين للدافعية: ١ - الوظيفة التنشيطية أو التحريكية ٢ - الوظيفة التوجيهية أو التنظيمية. (قشقوش، ١٩٧٩م، ص ١١٠ - ١١١)

كما يشير «هب» (١٩٤٩م) إلى أن الدافعية: «عملية يتم بمقتضاها إثارة نشاط الكائن الحي وتنظيمه وتوجيهه إلى هدف محدد.

«ويرى «دريفر» (١٩٧١م) أن الدافع عبارة عن «عمل دافعي انفعالي يعمل على توجيه سلوك الكائن الحي إلى تحقيق هدف معين».

كما يرى «أتكنسون» (١٩٧٦م) أن الدافعية تعني «استعداد الكائن لبذل أقصى جهد لديه من أجل تحقيق هدف معين». (السيد وآخرون، ١٩٩٠م، ص ٤١٧ - ٤١٨)

ويعرف طلعت منصور الدافع على أنه حالة للكائن الحي يمكن إن يستدل عليها من تتابعات السلوك الموجهة نحو أهداف معينة، ويؤدي تحقيقها إلى إنهاء التابع، وتعمل هذه الحالة على استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه نحو الهدف، والدافعية بذلك تكوين فرضي، وهي عملية استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه نحو الهدف (قشقوش ومنصور، ١٩٧٩م، ص ١١٣).

ويورد إبراهيم قشقوش وطلعت منصور (١٩٧٩م) تعريفا إجرائيا يتميز بالعمق والشمولية وهو أن «الدافعية تكوين فرضي، وهي عن حالة يعيشها الكائن الحي تعمل على استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه نحو هدف معين، ويمكن إن يستدل على هذه الحالة من تتابعات السلوك الموجهة نحو الهدف، وتنتهي هذه التتابعات بتحقيق موضوع الدافع ويتضمن هذا التعريف تحديد الخصائص الوظيفية به من استثارة وتنشيط وتوجيه السلوك». (قشقوش ومنصور، ١٩٧٩م، ص ١٠).

وهكذا يتفق علماء النفس في تحديد مفهوم الدافعية على وجود القوة أو الطاقة التي تحرك السلوك وتوجهه. ومع ذلك، فهم يختلفون فيما بينهم بشأن طبيعة هذه القوى التي تستثير السلوك

وتعضده. فيرى «سنج وكوميز» (١٩٥٩م) على سبيل المثال، إن السلوك يتزود بالقوة والطاقة من خلال المحاولات المستمرة من جانب الفرد للمحافظة على مفهومه عن ذاته وتعزيزه وترقيته. أما «جاثري» (١٩٥٢م) فيرى الدافعية ببساطة على أنها «تلك الحالة التي تزيد من قوة الاستجابات ونشاطها» (المدني، ٢٠٠٠م، ص ١٥)

كما يعرفها كوني: بأنها حافز داخلي توجه السلوك نحو بعض الغايات، فتعمل الدافعية على مساعدة الأفراد على التغلب على حالة الكسل والقصور. وقد تعمل القوى الخارجية على التأثير في السلوك، ولكن القوى الداخلية للدافعية هي التي تعمل على دفع السلوك وتحفيزه. (Connie,1997)

كما يعرفها محمد حسن عمران (٢٠٠٤م) بأنها مجموعة المشاعر التي تدفع المتعلم إلى الانخراط في نشاطات التعلم التي تؤدي إلى بلوغه الأهداف المنشودة. وهي ضرورة أساسية لحدوث التعلم، وبدونها لن يحدث التعلم. (عمران، ٢٠٠٤م ص ١٨).

وقد عرف أحمد (٢٠٠٠م) الدافعية بأنها قوة ذاتية تحرك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة تشعره بالحاجة إليها ويستشعر أهميتها المادية أو المعنوية. (أحمد، ٢٠٠٠م، ص ١٠)

وعرفتها الزعبي (٢٠٠٣م) بأنها القوة التي تدفع الأفراد لأداء أعمالهم، فالأفراد الذين يمتلكون دافعية عالية يحاولون الوصول إلى أقصى حد من الأداء تسمح به طاقاتهم بينما، الأفراد الذين لا يمتلكون الدافعية لا يصلون إلا إلى مستوى أداء منخفض. (الزعبي، ٢٠٠٣م، ص ١٩).

وعرفها توق (٢٠٠٣م) بأنها مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل إعادة التوازن الذي اختل، فالدافع بهذا يشير إلى نزعة الوصول إلى هدف معين، وهذا الهدف قد يكون إرضاء حاجات داخلية أو رغبات خارجية. (توق، ٢٠٠٣م، ص ١٢١)

وعرفها أبو جادو (٢٠٠٣م) بأنها حالات داخلية وخارجية تحرك سلوك الفرد وتوجهه نحو تحقيق هدف أو غرض معين، وتحافظ على استمرارية حتى يتحقق ذلك الهدف. (أبو جادو، ٢٠٠٣م، ص ٩٢)

كما عرفها قطامي (٢٠٠٣م) بأنها حاجة تستدعي استجابات فسيولوجية وسيكولوجية داخل الفرد تجعله يندفع إلى القيام بأنواع معينة من السلوك في اتجاه معين، وتهدف إلى خفض حالات التوتر لدى الكائن الحي وتخليصه من حالة عدم التوازن. (قطامي، ٢٠٠٣م، ص ١٤٥) ويعرفها الترتوري (٢٠٠٦م) بأنها «مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل تحقيق حاجاته، وإعادة الاتزان عندما يختل. وللدوافع ثلاث وظائف أساسية في السلوك، هي تحريكه وتنشيطه، وتوجيهه، والمحافظة على استدامته إلى حين إشباع الحاجة. (الترتوري، ٢٠٠٦م، ص ٢)

وقد عرفها أبو رياش وآخرون (٢٠٠٦م) بأنها مجموعة الظروف الداخلية والظروف الخارجية التي تعمل على تحريك سلوك الإنسان والحيوان على حد سواء. (أبو رياش، ٢٠٠٦م، ص ١٢).

أما ملحم (٢٠٠٦م) فقد عرفها بأنها عملية يتم بمقتضاها إثارة نشاط الكائن الحي وتنظيمه وتوجيهه إلى هدف معين. (ملحم، ٢٠٠٦م، ص ١٢٢).

نجد من التعريفات السابقة أنها تباينت واختلفت، فمنها ما ركز على الدافعية الداخلية، ومنها ما ركز على الدافعية الخارجية.

ويرى الباحث في تعريفه للدافعية بأنها حالة داخلية أو خارجية تحث الفرد نحو الوصول إلى هدف معين.

وهناك اعتبارات عدة لتعدد تعريفات مفهوم الدافعية بحسب ما قدمه علماء النفس، ربما كان من أهمها:

١ - تركيز المنظرين المختلفين على مظاهر بعينها من هذا المفهوم دون غيرها بحكم التوجهات المتميزة لهؤلاء المنظرين. فهناك من يركز على بعض المظاهر مثل التوتر العضلي أو معدل النبض بوصفها مظاهر لعملية الاستثارة عند الفرد، وهناك من يركز على كيفية تعامل الفرد مع الأهداف المنوط بها إشباع حاجاته الملحة.

٢ - اختلاف مناحي التعامل مع مفهوم الدافعية بوصفه مكونا فرضيا، فهناك من الباحثين من يركز على محددات هذا المفهوم وهناك من يركز على النتائج المترتبة على افتراضه.

٣- تضمين هذا المفهوم مفاهيم أخرى متعلقة به، وتعامل بعض الباحثين مع هذه المفاهيم على أنها ذات معنى واحد، وتعامل بعض آخر منهم على أنها ذات معان مختلفة، ومن أمثلة هذه المفاهيم: الحاجة والحافز والدافع الباعث والتوتر والاستثارة وما إلى ذلك.

ومن ثم حاول بعض العلماء تقرير عدة من الجوانب نرى ضرورة استيعابها في أي تعريف يقدم لمفهوم الدافعية. وقد انتظمت هذه الجوانب في وظائف الدافعية ذاتها وهي:

١- وجود حالة من الاستثارة العامة منشؤها عدم التوازن الذي يشعر به الفرد بحكم ما لديه من حاجة تلح عليه في اتجاه الإشباع، بمعنى آخر توجيه نشاط الفرد إلى أهداف بعينها والعمل على تحقيق هذه الأهداف.

٢- الإبقاء على الكائن معباً النشاط ما بقيت الحاجة بكاملها أو بدرجة منها. قائمة.

٣- العلاقة القائمة بين الدافعية والإطار الاجتماعي حتى ونحن عن الحاجات البيولوجية، فالكيفية التي يتم بها إشباع حاجة بيولوجية مثل الجوع على سبيل المثال من حيث أنواع الطعام التي يقبل عليها الأفراد أو تنظيم التعامل معها في أوقات محددة إنما تتحدد جزئياً بالسياق الاجتماعي. زان صدق هذا على الحاجات البيولوجية فانه يصدق أكثر وأكثر على الحاجات الاجتماعية.

٤- العلاقة القائمة بين الدافعية وخبرة الفرد الخاصة، إذا تحدد خبرة الفرد الخاصة مدى تعبئة طاقته في اتجاه أو آخر. فان أصبحت خبرة الفرد عن جدوى سبيل معين من حيث الوصول إلى هدف بذاته. كان له في هذا السبيل مسلوكاً، وان لم تفصح جدواه ضعف تحمسه له (حسين، ١٩٨٨م، ص ٦-٧).

وانطلاقاً من المفاهيم السابقة للدافعية يمكن استنتاج مجموعة من الخصائص التي تميز الدافعية، أشارت الزعبي (٢٠٠٣م) إلى بعضها وهي:

١- الدافعية عملية معقدة التركيب

ويعود ذلك إلى عدم إمكانية رؤية الدافع، بل رؤية السلوك الدال عليه، وأن حاجات الإنسان وتوقعاته متعددة وتتغير باستمرار؛ نظراً لأن الأفراد يشبعون حاجاتهم بطرق مختلفة.

٢ - الدافعية عملية متطورة باستمرار

فالدافعية نشاط مستمر لدى الأفراد؛ لأن الحاجات والرغبات كثيرة، وكل حاجة تسبب حدوث حاجة أخرى.

٣ - الدافعية متعددة الوجوه

فقد تكون الدافعية إيجابية أو سلبية، فالدافعية الإيجابية تعتمد على البواعث أو المثيرات الإيجابية سواء أكانت داخلية أم خارجية، أما الدافعية السلبية فتعتمد على البواعث والمثيرات السلبية سواء أكانت داخلية أم خارجية أيضاً.

وأضاف ملحم (٢٠٠٦م) بعض الخصائص للدوافع منها:

١ - الدوافع مركبة

تختلف الدوافع التي تحث الكائن الحي تبعاً لنوع الكائن نفسه وللمواقف التي يتعرض لها، فدافع الكائنات الحية الدنيا مادية أولية في الغالب، كدافع البحث عن الطعام، أما حالة الإنسان فيتعلم عادةً تحت تأثير دافع واحد وفي الغالب يكون الفرد واقعاً تحت تأثير مجموعة من الدوافع، فالتلميذ مثلاً قد يكون الدافع له على التعلم هو إرضاء المعلم، والحصول على أعلى تقدير أو على تقدير مناسب، وفي الوقت نفسه إرضاء غروره والتفوق على الآخرين.

٢ - مدى تأثير الدافع

لا علاقة لقوة الدافع بالفترة التي يستغرقها تأثيره، فدافع مثل الجوع قد يشبط قوة الفرد عن التفكير في أي موضوع آخر غير الحصول على الطعام، ولكن تأثيره ينتهي بمجرد تناول الطعام.

٣ - قوة الدافع

يبدأ التعلم عندما يواجه الكائن الحي موقفاً جديداً لا يستطيع أن يتصرف بالنسبة له عن طريقة استخدام سلوكه المعتاد، فالدافع هو المحرك الأساس وراء أوجه النشاط المختلفة التي

يكتسب الفرد عن طريقها أشياء جديدة أو يعدّل عن طريقها سلوكه. (ملحم، ٢٠٠٦م، ص ١١٠ - ١٣٠)

وعندما مراجعة التعريفات السابقة نخرج ببعض الاستدلالات والتي يمكن تحديدها على النحو التالي:

١ - تعبئة الطاقة أو تنشيط الدافعي، ويعني ذلك حالة الاستعداد لإصدار السلوك، وما يرتبط بها من يقظه وتوتر عام. ومن أمثلة ذلك استعداد مجموعة من الأشخاص لبدء سباق في العدو، أو البحث عن الطعام، أو عقد علاقة اجتماعية مع آخرين.. الخ

٢ - تنظيم السلوك وتوجيهه إلى هدف محدد. فبعد وصول الكائن الحي إلى حالة تعبئة الطاقة أو التنشيط الدافعي، يتجه بسلوكه إلى هدفه المحدد الذي يشبع حاجت، وفي الأمثلة السابقة يبدأ الأشخاص السباق من أجل تحقيق مراكز متقدمة والفوز بها، ويبدؤون في تناول الطعام بعد الحصول عليه، والتعرف على مجموعه من الأشخاص وإقامة صداقة معهم.

٣ - تتناسب قوة الدافع المثار مع مقدار الطاقة الناتجة عنه. فالشخص الذي استمر جائعا لمدة يوم كامل يكافح بقوة لإشباع حاجته للطعام، وذلك مقارنة بشخص آخر تناول الطعام منذ ساعة واحدة.

٤ - تستمر الطاقة المعبأة لتحقيق الهدف حتى يصل الكائن الحي إليه.

٥ - القابلية لتغيير مسار الهدف. فالكائن الحي يستمر في بذل الجهد من أجل تحقيق هدفه وخفض توتره المرتبط بدافع معين سواء كان فسيولوجيا (كالجوع أو العطش) أو سيكولوجيا (كالإنجاز أو السيطرة) وفي هذا الإطار يمكنه تغيير مسار الهدف إذا شعر إن الطريق الذي يسلكه لا يوصله إلى هدفه، فيسلك طريقا آخر.

وإذا لم يستطع تحقيق هدفه بأي من هذه الطرق، فإنه يصاب بحالة من الإحباط (غباري، ٢٠٠٨م، ص).

بعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم الدافعية

من الأهمية بمكان ونحن بصدد تقديم تعريف مقبول الدافعية، أن نميز بين هذا المفهوم والمفاهيم الأخرى التي ترتبط به مثل الحاجة، والحاجز، والباعث، والعادة، والانفعال، والقيمة. وذلك على النحو التالي:

مفهوم الحاجة

تشير الحاجة إلى شعور الكائن الحي بالافتقار إلى شيء معين ويستخدم مفهوم الحاجة للدلالة على مجرد الحالة التي يصل إليها الكائن نتيجة حرمانه من شيء معين، إذا ما وجد تحقق الإشباع . وبناء على ذلك فإن الحاجة هي نقطة البداية لإثارة دافعية الكائن الحي، والتي تحفز طاقته وتدفعه في الاتجاه الذي يحقق إشباعها. (عبد الله، ١٩٩٠م، ص ٤١٥ - ٤٥١).

مفهوم الحافز

يشير الحافز إلى العمليات الداخلية الدافعة التي تصحب بعض المعالجات الخاصة بمنبه معين، وتؤدي بالتالي إلى إصدار السلوك (marx, 1976)

ويرادف البعض بين مفهوم الدافعية على أساس إن كل منهما يعبر عن حالة التوتر العامه نتيجة لشعور الكائن الحي بحاجة معينة. وفي مقابل ذلك فإن هناك من يميز هذين المفهومين على أساس إن مفهوم الحافز اقل عمومية من مفهوم الدافع. حيث يستخدم مفهوم الدافع للتعبير عن الحاجات البيولوجية والاجتماعية، في حين مفهوم الحوافز للتعبير عن الحاجات البيولوجية فقط. وبوجه عام فإن الحافز والدوافع يشيران إلى الحاجة بعد إن ترجمت في شكل حالة سيكولوجية تدفع الفرد إلى السلوك في اتجاه إشباعها (حسين، ١٩٨٨م، ص ٩).

مفهوم الباعث

يعرف «فيناك» الباعث بأنه يشير إلى محفزات البيئة الخارجية المساعدة على تنشيط الدافعية الأفراد سواء تأسست هذه الدافعية على إبعاد فسيولوجية أو اجتماعية. وتقف الجوائز

والمكافآت المالية والترقي كأمثلة لهذه البواعث. فيعد النجاح والشهرة مثلاً من بواعث الدافع للانجاز (حسين، ١٩٨٨م، ص ١٠).

وفي ضوء ذلك فإن الحاجة تنشأ لدى الكائن الحي نتيجة حرمانه من شيء معين. ويترتب على ذلك إن ينشأ الدافع الذي يعبئ طاقة الكائن الحي، ويوجه سلوكه من أجل الوصول إلى الباعث (الهدف).

مفهوم العادة : أشار «كورمان» إلى إن مفهوم العادة قد تم تضمينه كمتغير أساسي في بناء نظرية أو منحى التوقع - القيمة، من قبل بعض الباحثين مثل «أتكنسون، وبرش وفيروف». وذلك نظراً لأهمية هذا المفهوم في إعطاء القيمة النوعية، والتوقع النوعي، وفي مجال اختيار الفرد لسلوك معين يمكن انجازه». (korman,1974).

وقد نشأ نوع من الخلط بين استخدام كل من مفهوم العادة، ومفهوم الدافع. على الرغم من وجود اختلاف بينهما. فالعادة تشير إلى قوة الميول السلوكية، التي ترتقي وتنمو نتيجة عمليات التعميم. وتتركز على الإمكانية السلوكية إما الدافع فيتركز على الدرجة الفعلية لمقدار الطاقة التي تنطوي عليها العادة. وبالتالي يمكن اعتبار الدافع نوعاً فعالاً من العادات (marx,1976) وقد يكون التباين في العادات أو السلوك المتعلم ضئيلاً ومحدوداً بين الأفراد. في حين إن الدوافع هي التي تزيد من نطاق هذا التباين. حيث يؤدي التذبذب في حالات الدافعية إلى تغيير السلوك عبر المواقف المتشابهة (عبد الله، ١٩٩٠م)

مفهوم الانفعال

كثيراً ما يخلط الباحثون بين مفهوم الانفعال ومفهوم الدافع. حيث ينظر بعض الباحثين إلى الدوافع كنتيجة مترتبة على ظهور الإنفعالات.

في حين ينظر البعض الآخر على أن بعض الدوافع يمكن أن يترتب عليها ظهور انفعالات معينة (Ms Ciellnd,et,1976,pp87)

ويعرف الانفعال بأنه اضطراب حاد يشمل الفرد كله ويؤثر في سلوكه وفي خبرته الشعورية ووظائفه الفسيولوجية الداخلية وينشأ في الأصل عن مصدر نفسي (Marx,1976,pp556) ويعد الانفعال من الحالات الشعورية المحيرة، فهو يتضمن الخوف، والكرهية، والغضب، كما يتضمن السعادة، والبهجة، والاستثارة .

وينظر إلى الحالات الانفعالية على أنها أقل عقلانية بالمقارنة بالدافعية . ولكنها أي الانفعالات، تتضمن عمليات معرفية أيضا . فالتقويم المعرفي يمكن أن يحدد طبيعة الخبرة الانفعالية، بالإضافة إلى ذلك فإن الانفعالات يمكن أن ينظر إليها كعوامل تتغير بتغير العمليات المعرفية (Jung,1978)

لذلك فإن التمييز الدقيق بين الدوافع والانفعالات لا يمكن تحقيقه في كل الحالات فالإنفعالات تعمل أحيانا كدوافع في توليد الاستجابات فالغضب على سبيل المثال في موقف ما يمكن أن يدفع الفرد لأن يسلك بشكل معين في هذا الموقف . وبالتالي استخدام البعض كل من الدوافع والانفعالات على أنها يعنيان نفس الشيء (Jung. 1978)

وفي الواقع لا يوجد تمييز حاسم وقاطع بين الانفعالات والدوافع إلا أن أهم الأسس والملاح التي يمكن من خلالها التمييز بينهما تتمثل فيما يأتي :

١ - في حالة الانفعالات يكون التركيز على الخبرات الذاتية والوجدانية المصاحبة للسلوك. إما بخصوص الدوافع فيكون التركيز على النشاط الموجه نحو الهدف

٢ - يتسم السلوك الانفعالي عن أنواع السلوك الأخرى بأنه سلوك مضطرب وغير منظم، ويصاحبه العديد من التغيرات الفسيولوجية الداخلية ويتميز بأنه أكثر حدة ووجدانية (خليفة، ١٩٩٠م، ص ٤٥٣ - ٤٩٦).

مفهوم القيمة : هناك خلط شائع لدى بعض الباحثين في استخدام كل من القيمة والدافع والنظر إلى القيم على أنها ما هي إلا أحد الجوانب لمفهوم أشمل هو الدافعية وقد تستخدم القيم بالتبادل مع الدافعية (Sibulkin, 1983,pp 139-162)

فعلى سبيل المثال اعتبر «ماكليلاند» الدافع للإنجاز بمثابة قيمة (Mecielland, 1961) وأيد ذلك ويلسون من خلال نتائج دراسته التي أوضحت أن هناك ارتباطا مرتفعا بين دافع الأمن وقيمة الأمن القومي على مقياس القيم لروكتش (Wilson, 1981, pp 210 - 254)

وتعامل «فيذر» مع الدوافع على أنها مرادفة أو مكافئة للقيم حيث عرف القيم بأنها بناء مترابط يتضمن الوجدان، والموقف الحالي الذي يوجد فيه الفرد، وأنها تتكون من ما يراه الفرد حسنا أو سيئا، إيجابا أو سلبا . وأوضح «فيذر» أن ذلك يتسق مع «النظرية المعرفية - الدافعية» التي تدعم الاقتراب بأن دوافع الأفراد نحو الموضوعات أو الأنشطة في موقف معين تتحدد حسب رغبتهم لما هو مفضل أو غير مفضل من هذه الموضوعات أو الأنشطة وما هو إيجابي ويحاولون الوصول إليه وما هو سلبي ويحاولون الابتعاد عنه (Feather, 1979, pp 243 - 260)

وتصور القيم - كما يرى «فيذر» : بأنها فئة من الدوافع لا يعني أن كل القيم تعتبر دوافع، فأحيانا يريد الشخص شيئا ما أو يشعر بوجوب عمل معين ولكنه لا يفعل شيئا. فالقيم لها وجهتان أحدهما سلبية والأخرى إيجابية .

وفي ضوء تعريف (الدافع) بأنه حالة شعورية تدفع الكائن الحي نحو هدف معين، وأنه أحد المحددات الأساسية للسلوك، يمكن المقارنة بين القيمة والدافع على أساس نوع الهدف في كل منهما حيث أن الهدف في القيمة من النوع المطلق ويتسم بالوجوب . ففي حالة القيم يقو الشخص مثلا يجب أن أعمل هذا الشيء إما في الدوافع فإنه يقول أريد أن أعمل هذا الشيء . وفي حالة عدم وجود قيمة للدافع فإننا لا نشعر نحوه بالرغبة . (English, 1958)

وقد اعتبر «ماسلو» أن الأفضل بالنسبة للفرد هو تحقيق ذاته فمن الأفضل أن يكون الفرد مدفوع أساسا بدافع الإنجاز أو بدافع تحقيق الذات . أما «بركوفتز» فقد أعطى قيمة عالية للإنجاز لما لهذه القيمة من أهمية كبيرة للنهوض بالفرد. إلى أن هناك اختلافا بين ماسلوا وبركوفتز في تحديد ماهية الأفضل، فلديهما معياران مختلفان يقومان على قيم مختلفة. فالأفضل قد يعني شيئين: أحدهما يتمثل في ماذا يجب الناس أن يكونوا؟ أما الآخر فيشير إلى أننا نحب أن نكون أفضل طبقا لقيمتنا (Deci, 1975, pp 86 - 87).

بوجه عام فإن القيم ليست كالدوافع أو البواعث مجرد ضغوط تعمل على توجيه السلوك في اتجاه معين، بل تعني القيم نظاما من الضغوط لتوجيه السلوك، ومن الأفكار والتصورات لتأويل هذا السلوك بإعطائه معنى وتبريرا معينا (Rokeach.1976).

وفي ضوء ذلك يتضح أن هناك فرقا بين مفهوم الدافع وبين مفهوم القيمة. فالدافع هو حالة توتر أو استعداد داخلي يسهم في توجيه السلوك نحو غاية أو هدف معين. أما القيمة فهي عبارة عن التصور القائم خلف هذا الدافع. فالتوقع المنخفض لقيمة الإنجاز يترتب عليه نقص في السلوك الموجه نحو الإنجاز. أما التوقع المرتفع لقيمة الإنجاز فيؤدي إلى زيادة هذا السلوك.

مكونات الدافعية

تعد عملية الدافعية بمثابة نظام مفتوح، تتألف من تفاعل خليط من المكونات التمايزية والتكاملية في آن واحد وهذه المكونات واحدة من حيث النوع عند كافة أبناء الجنس البشري، لكنها مختلفة في درجتها أو مستواها، وهذه المكونات هي:

- المكون الذاتي أو الداخلي، ويشتمل على المكونات المعرفية والانفعالية والسيولوجية معا.
- المكون الموضوعي أو الخارجي، ويتضمن المكونات المادية (الفيزيائية، والكيميائية والبيولوجية) والمكون الاجتماعي.

وعليه فالدافعية هي نتاج تفاعل خليط من هذه المكونات معا وهي تختلف من شخص إلى آخر باختلاف نواتج التفاعل في درجات هذه المكونات المذكورة آنفا. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ٢٤).

نظريات الدافعية

يعد موضوع الدافعية من أكثر موضوعات علم النفس أهمية ودلالة سواء على المستوى النظري أو التطبيقي. فمن الصعب التصدي للعديد من المشكلات السلوكية دون الاهتمام بدوافع الكائن الحي التي تقوم بالدور الأساسي في تحديد سلوكه كما وكيفا (السيد وآخرون، ١٩٩٠م، ص ٤١٧).

ولا توجد نظرية واحد جامعة ومانعة في تفسير عملية الدافعية، بل توجد نظريات عديدة ظهرت عبر مراحل تاريخية متتالية، وتختلف كل واحدة منها عن الأخرى في تفسيرها للدافعية، وذلك لاختلاف الخلفية النظرية لعلماء النفس. كما توجد تصنيفات عديدة لهذه النظريات، تختلف فيما بينها من حيث المنشأ أو الأصل، فمنها من ركز على الجوانب البيولوجية للدافعية، ومنها من ركز على الجوانب السيكلولوجية (المعرفية منها والانفعالية) ومنها من ركز على الجوانب البيئية (المادية منها والاجتماعية).

لذا ظهرت العديد من النظريات التي فسرت عملية الدافعية، وتمتد هذه النظريات في جذورها إلى أعمال الفلاسفة والمفكرين قديما.

وفي الوقت الحاضر توجد العشرات من هذه النظريات، ولكي نفهم هذه النظريات لابد من التعرف إلى شروط وتاريخ ظهور هذه النظريات، حيث إن أصل النظريات المعاصرة في تفسير الدافعية يتطلب البحث عنها في المكان الذي ولدت فيه المعارف السيكلولوجية لأول مرة، أي في الحضارة اليونانية القديمة.

لقد تغيرت لأكثر من مرة وجهات النظر والآراء عبر التاريخ والمتعلقة بدراسة ماهية وأصل دافعية الإنسان، وكلها انحصرت بصورة ثابتة بين اتجاهين فلسفيين هما: الاتجاه العقلاني والاتجاه اللاعقلاني.

لقد تمثل الاتجاه العقلاني في أعمال الفلاسفة والمفكرين القدماء وامتد حتى أواسط القرن السابع عشر الميلادي ومن أبرز الآراء في هذا الاتجاه هو أن :

- الإنسان كائن مدهش ومن جنس خاص به.
- لا توجد قواسم مشتركة بين الإنسان والحيوان .
- يقتصر كل من وجود العقل والوعي والتفكير على الإنسان فقط.
- يمتلك الإنسان حرية الإرادة (أو الإرادة الحرة) وحرية الاختيار لأفعاله
- يوجد مصدر الدافعية للسلوك في عقل الإنسان ووعيه وإرادته.

أما الاتجاه الثاني اللاعقلاني فهو يقتصر على الحيوانات وخاص بها، حيث أكد هذا الاتجاه على إن سلوكيات الحيوانات تختلف عن سلوك الإنسان حيث إن سلوكيات الحيوانات وفقاً لهذا الاتجاه هي سلوكيات غير حرة، وغير عقلانية كما يتم توجيهها بقوى خفية غير مدركة، وذات طابع بيولوجي والتي تتمثل في الحاجة العضوية. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ١٠٣)

وتختلف النظريات الكلاسيكية والمعاصرة التي فسرت الدافعية من حيث المعايير وفقاً للتالي:

١ - الفروق في أنواع الدوافع، حيث ركزت مجموعة من النظريات على تفسير الدوافع الأولية أو البيولوجية، بينما ركزت المجموعة الثانية من النظريات على تفسير الدوافع المتعلمة أو الاجتماعية.

٢ - الفروق بين علماء النفس في المدارس والاتجاهات التي اعتمدها في تفسير الدافعية، فبعضهم اعتمد المنحى البنائي أو الامبريقي، واعتبروا بأن عملية الدافعية عملية متعلمة وبعضهم اعتمد المنحى الجشتالتي واعتبر عملية الدافعية بأنها عملية وراثية، وقسم ثالث من علماء النفس، اعتمد المنحى السلوكي الكلاسيكي، وبعضهم اعتمد المنحى السلوكي الجديد أو المعرفي السلوكي، حيث اظهروا أن عملية الدافعية ليست عبارة عن مثير واستجابة كما هو لدى أنصار المنحى السلوكي الكلاسيكي، بل يوجد دور هام للصندوق الأسود في إظهار الدافعية، كما هو الحال في المنحى المعرفي السلوكي.

وقسم آخر اعتمد المنحى الفرويدي والفرويدي الجديد، وهناك مجموعة من علماء النفس اعتمدوا المنحى الإنساني في تفسير الدافعية. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ١٠٤).

أولاً: نظرية التحليل النفسي

وتعزي هذه النظرية إلى سيجموند فرويد، حيث ينظر فرويد إلى الدافعية على أنها تعبير لاشعوري - بصورة كبيرة - لل رغبات العدوانية والجنسية، التي قد يعبر عنها بطريقة صريحة أو ببعض الصور الرمزية مثل الأحلام أو «زلات اللسان».

ولقد ذهب فرويد إلى أن الإحداث أو الأفعال التي تشوه صورة الفرد عن ذاته ينشأ عنها قلق الأنا، وفي محاولة لخفض درجة التشويه أو مستوى القلق إلى أدنى حد ممكن، يقوم الفرد بتكوين الحيل الدفاعية بالأنا واستخدامها كسبيل لحماية الذات. وكان فرويد أول من أشاع ما وصف بأنه النظريات الدفاعية في الشخصية ثم جاء «كارل يونج» وقبل الكثير من تفسيرات فرويد ولكنه اختلف عنه في عدة جوانب، حيث ركز على الأحداث الجارية أكثر من تركيزه على خبرات الطفولة، وعلى الدوافع الاجتماعية أكثر من تركيزه على الدوافع الجنسية، وهذا ما ذهب إليه «الفريد ادلر» أيضا. غير أن «أريك اريكسون» حاول المزج بين تركيز فرويد على الدوافع الجنسية والتركيز على الدوافع الاجتماعية التي ذهبت إليه النظريات الأخرى، والذي أسفر عن نظرية المراحل الثماني التي تتميز بوجود أزمة في كل مرحلة يتعين حلها في المرحلة نفسها. (ارنوف، ١٩٧٧، ص ٢٥٨ - ٢٥٩)

ثانياً: النظرية البيولوجية

وتفسر هذه النظرية عملية الدافعية وفقاً لمفهوم الاتزان الداخلي أو تجانس الوسط حيث تؤكد هذه النظرية على دور الاتزان الداخلي، حيث إن العمليات البيولوجية وأنماط السلوك تخضع إلى حالة الاختلال في التوازن العضوي، الأمر الذي يتسبب في استمرار هذه العمليات حتى يتم تحقيق التوازن.

ويؤكد والتر إن الحوافز تنشأ عن عدم التوازن بالاشتراك مع عمليات معرفية مما يؤدي إلى ظهور السلوك الهادف لإشباع الحاجات وإعادة حالة التوازن الداخلي لدى الأفراد، لقد وسع والتر مفهوم عدم التوازن. ليصبح مفهوم التوازن والفيسيولوجي. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ١٠٥).

ثالثاً: النظريات السلوكية

تفسر هذه النظريات الدافعية على أنها تنشأ بفعل مثيرات داخلية أو مثيرات خارجية. حيث تعددت تفسيرات هذا الاتجاه إلى النظريات التالية:

أ- نظرية خفض الحافز

صاحب هذه النظرية هو عالم النفس السلوكي «هل» تعد هذه النظرية ممثلة لنمط النظريات الترابطية التي عنت بمفهوم «الحافز» في مجال الدافعية، ويعود إدخال مفهوم «الحافز» في دائرة علم النفس التجريبي إلى عالم النفس الأمريكي «وود وورث» حيث قاده اهتمامه بالدافعية لإن يفترض إن الاختلالات الفسيولوجية تحفز الكائن لأن يصدر سلوكا يتعامل مع هذه الحاجات المنبثقة من الخلل الفسيولوجي ومن ثم إعادة الكائن إلى حالته الأولى وهي حالة الاتزان (حسين، ١٩٨٨م، ص ٢٠).

ويرى «هل» إن أي فعل يقوم به الكائن الحي تسبقه أو تصاحبه حاجة تدفع أو تحفز النشاط المرتبط بها. ويشير الحافز إلى درجة التوتر التي يشعر بها الكائن الحي نتيجة اختلال التوازن الذاتي لديه فكلما زاد هذا الاختلال زاد الحافز وكلما زاد الحافز كانت الاستجابة أسرع وأكثر مقاومة للانطفاء. وتشير دافعية الباعث إلى حجم المكافأة المقدمة للكائن الحي ونوعها لمساعدته على إصدار الاستجابة. ولا يمكن بحكم هذا المعنى إن يصدر الكائن الحي سلوكا معيناً دون إن يكون مدفوعاً بحافز من الخوافز ويتضمن التدعيم عند «هل» خفضاً في منبه الحافز أو بمعنى آخر إعادة الكائن الحي إلى حالة التوازن، ويعد خفض الحافز أمراً هاماً للغاية سواء عند «هل» أو عند زملائه أمثال «ميللر» و«دولارد» وفي المقابل حاول بعض الباحثين التقليل من أهمية الدور الذي تلعبه الخوافز في تشكيل دافعية الفرد، وتعد نظرية «سنكر» نموذجاً لهذه الفئة حيث اهتم «سنكر» بالبواعث الخارجية بوصفها حاكمة للسلوك كمصدر للإثابة والتدعيم تعد مدخلاً صحيحاً لزيادة احتمال صدور استجابة معينة أو خفض هذا الاحتمال (السيد وآخرون، ١٩٩٠م، ص ٤٣٧-٤٣٩).

هذه النظرية ركزت على دور الحافز الداخلي في تحريك السلوك، بينما أغفلت دور المثيرات الخارجية كمحركات للسلوك. وفي هذه النظرية يوجد نوعان من الخوافز هما:

- حوافز أولية: وهي ذات أساس بيولوجي .
- حوافز ثانوية: وهي لا تشبع حاجات بيولوجية مباشرة بل ترتبط بالحاجات البيولوجية من خلال عمليات شرطية.

ب - نظرية البواعث

وصاحب هذه النظرية هو العالم «هارلو» حيث ركزت هذه النظرية على دور المثيرات الخارجية كمحركات للسلوك، وهناك تكامل بين نظريتي خفض الحافز والبواعث. وهكذا تفسر النظريتان (أ+ب) عملية الدافعية تبعا للمثيرات الداخلية (كالاحتياجات والحوافز)، والمثيرات الخارجية أيضا (كالبواعث الخارجية) وهي تركز على تفسير دوافع البقاء أو الدوافع الأولية. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ١٠٦)

ج - نظرية الاستشارة

إذا كانت النظريتان (أ+ب) تركزان على تفسير الدوافع البيولوجية أو الفطرية، فإن النظرية (ج) تركز على تفسير الدوافع المتعلمة أو الاجتماعية. ووفقا للنظريتين (أ+ب) فإن السلوك يظهر لإشباع الحاجات الفسيولوجية والحوافز، واستجابة للبواعث الخارجية بينما في نظرية الاستشارة يظهر السلوك عند بعض الأفراد استجابة لإشباع الدوافع الاجتماعية، كدوافع (الاستكشاف والاستطلاع والالتقاء، والقبول الاجتماعي وغيرها) بالرغم من أن الدوافع الفطرية ربما تكون غير مشبعة. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ١٠٧).

د - نظرية التعلم الاجتماعي والفاعلية الذاتية

وصاحب هذه النظرية هو عالم النفس السلوكي «باندروا» وهذه النظرية تنطلق من افتراض أساسي مفاده إن الإنسان عبارة عن كائن اجتماعي، أي أنه جزء من كل وهو يعيش ضمن جماعة يؤثر ويتأثر بها على شكل تنافس أو تعاون أو امتثال أو طاعة.

وترى هذه النظرية أن العديد من دوافع الإنسان هي متعلمة، يتم اكتسابها من خلال تفاعله مع الآخرين باستخدام نماذج المحاكاة أو التقليد، والملاحظة، والنمذجة وغيرها، وأن التعلم السابق يعتبر أهم مصدر من مصادر الدافعية، فالنجاح أو الإخفاق لاستجابات معينة يؤدي إلى تفهم الأشياء التي تؤدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية، ومن ثم الرغبة في تكرار الأنماط السلوكية الناجحة. وإن الخبرة الشخصية لا ترتبط بالضرورة بحدوث التعلم الاجتماعي، فقد يكون

التعلم بملاحظة بعض الأشخاص الآخرين الناجحين أو الفاشلين كافيا لاستثارة حالات دافعية، كما أن الثواب أو العقاب قد يكون داخليا أو خارجيا (ارنوف، ١٩٧٧، ص ١٢٧)

ويعتقد باندرورا بأن عوامل الخطط والفاعلية الذاتية لها دور بارز في الدافعية، فالخطط تشتمل على وجود أهداف محددة لدى الفرد تعد بمثابة محركات للدافعية نحو الأداء لفترات مختلفة.

إما الفاعلية الذاتية فإنها تشير إلى اعتقاد الفرد بأنه قادر على التمكن من موقف معين والحصول على فوائد ايجابية، فالخطط والفاعلية الذاتية تختلف بين الأفراد في مستوياتها. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ١٠٨)

رابعاً النظرية الإنسانية

يعد «أبراهام ماسلو» صاحب هذه النظرية، ومؤسس الاتجاه الإنساني في علم النفس حيث يعد هذا الاتجاه القوة الثالثة في علم النفس إضافة إلى القوتين (المدرسة السلوكية والمدرسة الفرويدية).

وقد جاءت هذه النظرية بمثابة انتقاد لكل من المدرسة الفرويدية التي اعتبرت أصول السلوك بيولوجية تتمثل في غرائز الموت والحياة، والمدرسة السلوكية التي اعتبرت السلوك مدفوع بعوامل كالتعزيز والحرمان والحوافز والمكافآت.

وتركز هذه النظرية على تأثير سلوك الإنسان وفقا لمفهوم الحاجات أي إن وراء كل سلوك حاجات معينة وقد رتبها ماسلو ترتيبا هرميا تبعا لأوليوياتها، حيث صنفت في مجموعتين هما: الحاجات الأساسية أو الحاجات الفسيولوجية اللازمة لبقاء الإنسان وإستمراريته كحاجات الطعام والهواء والحاجات النفسية والاجتماعية أو الحاجات الإنمائية (كحاجات الأمن والانتماء وتحقيق الذات).

وقد أشار ماسلو إلى إن الإنسان حرا في إرادته واختياره. كما انه يمتلك الحق في تقرير مصيره وانه ليس منفعلا فحسب بل فاعلا أيضا، أي إن الإنسان سلبي وإيجابي في آن واحد. بمعنى أنه يتأثر (مستقبل) ويؤثر (مرسل) في وقت واحد ويرى ماسلو إن إشباع الحاجات يتم بالتسلسل أي من الأدنى إلى الأعلى على التوالي.

وفي الستينيات من القرن العشرين قام ليان بورتر بتكييف نظرية هرمية الحاجات عند ماسلو بتهيئة بيئة تعزيز النمو، وذلك بإضافة مستوى جديد للهرم، وهو الاستقلالية، ويعود هذا الحاجة الأفراد للمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر فيهم. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ١١٠).

خامساً: النظريات المعرفية

إذا كان النشاط السلوكي يعد وسيلة للوصول إلى هدف معين ومستقل عن السلوك ذاته، أي إن الاستجابات الصادرة من أجل الحصول على المكافآت تشير إلى دافعية خارجية تحددها عوامل مستقلة عن صاحب السلوك ذاته وفقاً للتفسيرات السلوكية والارتباطية، فإن التفسيرات المعرفية تنظر إلى الكائن الحي بأنه كائن عاقل، ويتمتع بإرادة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واعية على النحو الذي يرغب فيه، كما إن هذه التفسيرات تؤكد على مفاهيم: كالقصد أو النية والتوقع. والنشاط العقلي الذاتي، وتشير أيضاً إلى النشاط السلوكي كغاية بحد ذاته وليس كوسيلة. أي إن عملية استثارة دافعية الفرد نحو ممارسة أداء معين ترتبط بقانون «التوقع × القيمة»، أي حاصل ضرب: الدرجة التي يتوقع بها القيام بمهمة ما بنجاح إذا ما بذل جهد معين وبالتالي الدرجة التي يتوقع بها الحصول على المكافآت التي تأتي من خلال أدائه الجيد للمهمة × الدرجة التي بثمن أو يقيم بها قيمة هذه المكافآت.

وبهذا، فهذه النظريات تؤكد على المصادر الداخلية والتوقعات والاهتمامات والخطط التي يسعى الأفراد إلى تحقيقها من خلال السلوكات التي يقومون بها، فالتفسيرات المعرفية ترى إن الأفراد لا يستجيبون إلى المثيرات الخارجية والداخلية على نحو تلقائي، بل في ضوء نتائج العمليات (معالجة المعلومات أو ما يسمى الصندوق الأسود) لهذه المثيرات فهنا تدخل العمليات العقلية المعرفية وغير المعرفية في إطار تفسير الدافعية واستثارها.

وبالرغم من أهمية استثارة الدافعية القائمة على التعزيز إلا إن «ديسي» أحد الإعلام المعرفين البارزين قد انتقد استخدام التعزيز كمحرك للدوافع، وذلك لأن التعزيز من وجهة نظرة يمثل دافعية خارجية وهذا يعني إن الشخص المتعلم يقوم بسلوك ما بهدف الاهتمام بالسلوك، وعلى النقيض من الدافعية الخارجية توجد الدافعية الداخلية والتي تهدف إلى إشباع حاجات معرفية

داخلية كأن يصبح الشخص المتعلم أكثر كفاءة وثقة أو استقلالية ..الخ وعلية يكون مصدر الدافعية الخارجية هو المحيط الفيزيائي (المادي والاجتماعي) بينما مصدر الدافعية الداخلية هو الشخص المتعلم نفسه، ولهذا فالدافعية الداخلية تعد بمثابة شرط أساسي للتعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.

ففي المراحل الإنمائية الأولى تكون استثارة الدافعية ذات مصادر خارجية ومع مرور المراحل الإنمائية تنتقل استثارة الدافعية إلى مصادر داخلية فالدافعية الخارجية تبقى ما دامت الحوافز والمكافآت موجودة، بينما تستمر الدافعية الداخلية مع الفرد مدى الحياة.

إن الأسلوب الأمثل في استثارة الدافعية هو الموازنة بين الدافعية الخارجية والداخلية والتوجه نحو تعزيز الدافعية الداخلية لكي تصبح هي الأساس في استثارة السلوك وتوجيهه. (غباري، ٢٠٠٨م، ص ٦٩ - ٧٠)

ومن النظريات المعرفية التي اهتمت بالدافعية هي نظرية التنافر المعرفي « لفستنجر »

حيث قام عالم النفس فستنجر بتطوير هذه النظرية حيث أكد فيها بأن دافعية الأفراد نحو تحقيق التوازن المعرفي أو التآلف المعرفي ينشأ نتيجة لعدم التوازن المعرفي، وعليه تنشأ حالة التنافر المعرفي عندما يقوم الشخص بسلوك يتعارض مع الأنا الأعلى أو المثل العليا لديه، مما يدفعه إلى ممارسة سلوك لكي يصل إلى حالة التآلف المعرفي، فعندما يقوم الفرد بسلوكات مخالفة لمثله العليا يبدأ يبحث عن مبررات لسلوكاته. (بني يونس، ٢٠٠٧م، ص ١١٣)

وفي هذا الإطار تفترض هذه النظرية أن لكل منا عناصر معرفية تتضمن معرفه بذاته (ما نحبه وما نكرهه وأهدافنا وأشكال سلوكنا) كما أن لدى كل منا معرفة بالطريقة التي يسير بها العالم من حولنا فإذا ما تنافر عنصر من هذه العاصر مع عنصر آخر، بحيث يقضي وجود أحدهما منطقيا بغياب الآخر، كأن نعتقد مثلاً في ضرر التدخين في الوقت الذي ندخن فيه بشراهة، حدث توتر الذي يملينا ضرورة التخلص منه . وهناك أكثر من طريقة يمكن لنا بها خفض التوتر الناتج من التنافر المعرفي، والعودة إلى حالة الاتساق . فإما أن نغير أحد الاعتقادين السابقين، كأن نقلع عن التدخين أو لا نرى فيه ضرراً . أو نلجأ إلى طريقة ثالثة نضمن خلالها مع هذين الاعتقادين اعتقاداً ثالثاً أو عنصراً معرفياً ثالثاً مؤداه أن هناك العديد من الأشخاص الذين يدخنون بشراهة، ولم يحدث لهم أي ضرر (غباري، ٢٠٠٨م، ص ٧١).

الدافعية والإدمان

يعتبر السلوك الإدماني أحد السلوكيات المرضية التي تناولته الدراسات بالبحث وعلاقته بمتغيرات مختلفة، تتعلق بأن المدمن في الغالب ما هو إلى ضحية لمتغيرات خارجية جعلته ينخرط في هاوية الإدمان .

وعلى الرغم من كثرة تلك الأبحاث المقدمة للمساهمة في فهم تلك المشكلة ومحاولة التقليل منها إلى أن نسبة الانتكاسة تظل عالية.

وعليه فإن دراسة دوافع السلوك لدى المدمن تساعدنا على التنبؤ بالسلوك الإدماني في المستقبل. فإذا عرفنا دوافع شخص ما، فإننا نستطيع إن نتنبأ بسلوكه في ظروف معينة. كما نستطيع أن نستخدم معرفتنا بدوافع الأشخاص في ضبط وتوجيه سلوكهم إلى وجهات معينة وأهداف معينة، من خلال تهيئة بعض المواقف الخاصة التي من شأنها أن تثير دوافع معينة تحفزهم إلى القيام بالأعمال التي نريد منهم أداءها، ونمنعهم من القيام ببعض الأعمال الأخرى التي لا نريد منهم أداءها. لذلك تظهر أهمية دراسة الدوافع في مجال العلاج من الإدمان .

وعليه فإن الدافعية تقوم بالعديد من الوظائف التي تمكننا من فهم طبيعة الإدمان، ومن بينها:

١- الوظيفة التفسيرية: وهي الوظيفة الأساسية للدافعية، فمن خلالها يتم تفسير السلوكيات الإدمانية بمختلف أنواعها والصادرة عن المدمن ويطلق على هذه الوظيفة وظيفة العزو.

٢- وظيفة التشخيص والعلاج: تستخدم في تشخيص العديد من الاضطرابات السلوكية والنفسية، كما تستخدم في علاج هذه الاضطرابات. إن معرفة الدوافع النفسية للمدمن يمكن إن تساعد القائمين على علاج المدمنين في تفسير سلوكياتهم وزيادة فهمنا لهم، وبالتالي مساعدتهم بدلا من اتخاذ عقوبات ضدهم .

كما أنها تساعد في تعديل سلوكيات المدمنين من خلال التحكم في دوافعهم، للوصول إلى السلوك المطلوب وتساعد أيضا في تشخيص وتحديد السلوك المشكل والمرضي، وبالتالي السعي لإيجاد الحل الأمثل لهذا السلوك، كما إن معرفة الدوافع تقلل من الجهود المبذولة

وتختصر الوقت في تعلم سلوكيات تكيفيه ملائمة من خلال إثارة انتباههم واهتمامهم لذلك، وزيادة تشويقهم إليها.

٣ - وظيفة الطاقة والنشاط: حيث تقوم بإطلاق الطاقة واستثارة النشاط من خلال تعاون المفاتيح الخارجية (كالجوائز، والتهديد، واللوم، والثناء) مع المفاتيح الداخلية (كالأهداف، وال رغبات، والاهتمامات) في تحريك السلوك وتدفعه نحو تحقيق أهداف معينة، أي إن الدوافع تقوم بتنشيط السلوكيات الجزئية (أو الفسيولوجية)، والسلوكيات المركبة أو الكلية (أو السيكولوجية).

٤ - توجيه سلوك المدمن نحو وجهة معينة دون أخرى، ونحو تحقيق الأهداف المنشودة، بمعنى أن الدوافع تعمل على توجيه وتركيز انتباه المدمن نحو مواقف معينة وتعمل على تشتيت انتباهه عن مواقف أخرى، أي إن الدوافع تملي على المدمن إن يستجيب لمواقف معينة، ولا يستجيب لمواقف أخرى، كما إن الدوافع تملي على المدمن طريقة التصرف في مواقف معينة، إذ أن اختيار المدمن لنشاط ما يتأثر بالدوافع التي تمليها عليه ميوله، واهتماماته، وحاجاته .

٥ - المحافظة على استمرار السلوك: أي إن السلوك يبقى مستمرا ونشطا ما دامت الحاجة قائمة ولم يتم إشباعها.

٦ - تنشيط التوقعات المتصلة بتحقيق الأهداف أو إشباعها: حيث توجد علاقة بين مفاتيح الدافعية، ونواتج الاستجابة المتوقعة والقيمة المادية والمعنوية أيضا عن هذا الدافع، أي ينطبق عليها قانون: الدافع = القيمة × التوقع.

٧ - تعد الدوافع بمثابة مصدر للمعلومات عن إمكانية الوصول إلى الهدف: أي إن الدافعية تزداد بالاقتراب من الهدف، فمثلا تزداد الدافعية العلاجية للمدمن عندما يرى غيره من المدمنين يجاهد في عملية العلاج، ويقترب من تحقيق الهدف، بينما تقل دافعيته نحو العلاج عندما لا يرى مثل تلك النماذج الجيدة، فيتبعد عن تحقيق الهدف.

التعليق

يرى الباحث أنه لا توجد نظرية واحدة جامعة ومانعة في تفسير عملية الدافعية، بل توجد نظريات عديدة ظهرت عبر مراحل تاريخية متتالية، وتختلف كل واحدة منها عن الأخرى في

تفسيرها للدافعية، وذلك لاختلاف الخلفية النظرية لعلماء النفس . كما توجد تصنيفات عديدة لهذه النظريات، تختلف فيما بينها من حيث المنشأ والأصل، فمنها ما ركز على الجوانب البيولوجية للدافعية، ومنها ما ركز على الجوانب السيكلوجية ومنها ما ركز على الجوانب البيئية .

وبالتالي فإنه يمكن استنتاج أن تلك النظريات تختلف فيما بينها باختلاف المعايير الآتية :

١ - الفروق في أنواع الدوافع، حيث ركزت مجموعة من النظريات على تفسير الدوافع الأولية أو البيولوجية، بينما ركزت المجموعة الثانية من النظريات على تفسير الدوافع المتعلمة أو الاجتماعية

٢- الفروق بين علماء النفس في المدارس والاتجاهات التي اعتمدها في تفسير الدافعية، فبعضهم أعتمد المنحى البنائي أو الإمبريقي، واعتبروا بأن عملية الدافعية عملية متعلمة وبعضهم اعتمد المنحى السلوكي حيث أظهروا أن عملية الدافعية عملية متعلمة وبعضهم أعتمد المنحى المعرفي السلوكي، حيث أظهروا أن عملية الدافعية ليست عبارة عن مثير واستجابة فقط، بل يوجد دور هام للصندوق الأسود في إظهار الدافعية، كما هو الحال في المنحى المعرفي السلوكي . وقسم آخر اعتمد المنحى الفرويدي، وهناك مجموعة من علماء النفس اعتمدوا المنحى الإنساني في تفسير الدافعية .

وعليه فإن كل نظريات الدافعية إنما تتضمن عنصرا من الحقيقة والفعالية، وينبغي لذلك أن تكون موضع اعتبار فيما يطرح من تفسيرات وتحليلات لتلك الظاهرة المعقدة والمتعددة الأبعاد والتي تنتمي إلى أنظمة علمية متنوعة .

ومن هنا فإن نتائج المنحى التكاملي الذي يفيد وظيفيا في كل ما تقدمه النظريات ونتائج البحوث من إسهامات متنوعة هو الأسلوب الأمثل في فهم وتفسير الدافعية وتضميناته في استراتيجيات وأساليب وإجراءات التدخل الوقائي والعلاجي .

ونظراً لتعقد تفسير الدافعية، فإنه يصعب تحديد نظرية واحدة لتفسيرها. حيث يرى الباحث أن وجود نظرية واحدة لا يمكنها تفسير كل جوانب الدافعية .

وذلك لان كل نظرية لها حدودها النظرية والمنهجية التي لا يمكن أن تتجاوزها من ناحية، وكذلك لطبيعة تداخل وتعقيد دراسة الدافعية.

ولذلك فإن الهدف العام هو الخروج من هذه النظريات بأساليب تطبيقية لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.

ومما لا شك فيه أن هذه النظريات قد أَلقت الضوء أمام الباحث، حيث اطلع على أغلب التفسيرات التي تناولت موضوع الدافعية مما ساعده على فهم طبيعة المشكلة وعلى تفسير النتائج التي حصل عليها.

٢ . ١ . ٢ الإدمان

مفهوم الإدمان

كان تطور كلمة «إدمان» addiction، بطيء في معناه الحالي، رغم أن ظاهرة الإدمان كانت شائعة بدرجة كبيرة . فالإدمان كان يعني في الماضي تسليم أو استلام شخص لكي يوسم «عبداً» slave من الناحية القانونية، ثم تطورت هذه الكلمة فيما بعد حينما صارت تأخذ معنى «الإدمان الذاتي» addiction - self، وعندئذ تطورت في معناها الحديث المرتبط بالإدمان على العقاقير أو المخدرات. والواقع أن هذه المجموعة من الألفاظ المتغيرة لاستخدام أو لسوء استخدام العقاقير أو المخدرات، إنما تعكس تناقض وتضارب إدراكات واتجاهات الناس نحو هذه المواد عبر القرون. (الرشيدي وآخرون، ٢٠٠٠م، ص ٢٠)

التعريف اللغوي للإدمان

(دمن وأدمن الشراب وغيره، لم يُقلع عنه).

ويقال: فلان يُدمن الشراب والخمر إذا لزم شربها. ومدمن الخمر الذي لا يُقلع عن شربها. ويُقال: فلان مُدمن خمر أي مداوم شربها. ويؤيد الحديث الشريف مداومة الشراب لمدمن الخمر. ففي الحديث: مُدمن الخمر كعابد الوثن، وهو الذي يُعاقِر شربها ويلازمه ولا ينفك عنها. (الجوهري، ٢٠٠٤م، ص ٣٥).

التعريف الاصطلاحي للإدمان

لقد كانت هناك بعض المحاولات المبكرة لتعريف المخدرات وتعاطيها ومنها يذكر «بين» Bean أول تعريف رسمي وضعته لجنة رولستون Rolston عام «١٩٢٥م» حيث اعتبرت أن المدمن:

«شخص يحتاج إلى تعاطي المخدرات بشكل مستمر لتخفيف أعراض مرض عضوي، بل اكتسبت نتيجة لتعاطيها المتكرر رغبة قاهرة بمواصلتها وهو من يؤدي إقلاعه عن تعاطيها إلى أعراض محددة من الألم أو الاضطرابات العقلية أو الجسمية». (العيان، ١٩٩٦م، ص ٢٧)

وفي عام ١٩٣٧م عرف كل من «هيملسباخ» و«سمول» Himmelsbach & Smal الإدمان بالقول: «إن إدمان الأفيون والمخدرات الشبيه له، يشمل ثلاث ظواهر ترتبط ارتباطاً وثيقاً، لكنها متميزة عن بعضها البعض وهي: (١) قوة التحمل. (٢) الاعتماد الجسدي. (٣) التعود». (الشهري، ١٤٢٦هـ، ص ٤٨ - ٨٥)

كما تعرف قوة التحمل على أنها: انخفاض التأثير مع تكرار تعاطي الجرعة نفسها من المخدر أو الحاجة إلى زيادة الجرعة للحصول على أثر يعادل أثر الجرعة الأصلية عند تعاطي المخدر باستمرار على مدى فترة من الزمن. أما الاعتماد الجسدي فيشير إلى تغير الحالة الفسيولوجية التي يحدثها التعاطي المتكرر للمخدر على مدى فترة من الزمن، وهذا يتطلب استمرار استعمال المخدر، للحيلولة دون الإصابة بمرض يتلازم مع الامتناع عن المخدر، وهو ما يسمى بمتلازمة الانقطاع عن تعاطي المخدرات. ويشير التعود إلى الاعتماد النفسي أو الفسيولوجي أو الجسمي على المخدر، الاستعاضة بالمخدر على أنواع أخرى من السلوك الاعتيادي ومن ثم فإن التعود يرتبط بصورة وثيقة بآثار الشعور بالخفة والنشاط، أي تخفيف الألم أو الانزعاج العاطفي. (الشهري، ١٤٢٦هـ، ص ٤٨ - ٨٥).

وعلى الرغم من تركيز هذا التعريف على العمليات الفسيولوجية لقوة التحمل والاعتماد. إلا أنه تعرض للنقد على أساس أنه غير مقبول، ذلك لأنه يميل إلى الاقتصار على الأفيون ومكوناته ومستحضراته المخلقة.

أما التعريف الذي وضعه كل من «فوجل» وزملاؤه Vogel et al عام ١٩٤٨م فيعرف المدمن على «أنه شخص فقد القدرة على السيطرة على نفسه أمام المخدر ويتعاطاه لدرجة الضرر بنفسه أو بالمجتمع». (الشهري، ١٤٢٦هـ، ص ٤٨ - ٨٥)

ويتضح من التعريف السابق انه ليس من الضروري أن تتوافر جميع العوامل الثلاثة المذكورة في تعريف «هيملسباخ» و «سمول» وهي قوة التحمل، الاعتماد الجسدي و التعود. لكي نسمي الشخص مدمناً. إلا أن ما هو أهم من ذلك أن هذا التعريف قد أضاف عنصراً اجتماعياً أخذاً في الاعتبار ما يسببه المخدر من ضرر على المجتمع.

وهناك العديد من المحاولات الأخرى لتعريف الإدمان، وكل منها ينظر إليها منظور معين. فبعضها يميل نحو الشمول والتفصيل والبعض الآخر يركز على الآثار الفسيولوجية أو النفسية أو الاجتماعية. ولتحديد المصطلح فإن منظمة الصحة العالمية حاولت وضع عدداً من التعاريف خلال العقود الماضية. لتحديد المشكلة من خلال وضع تعريف يمتاز بالتحديد والشمول لكي يمكن اللجوء والاعتماد عليه. (الجوهي، ٢٠٠٤م، ص ٣٥)

حيث تعرف «الرابطة الأمريكية لطب النفسي» مصطلح «إدمان» على أنه:

«الاعتماد على مادة كيميائية إلى الحد الذي تنشأ معه حاجة فسيولوجية أو نفسية أو كليهما. ويظهر ذلك في تجمع من زملة من الأعراض التالية: التحمل (الإطاقة)، والانشغال بالحصول على مادة العقار/ المخدر وبتعاطيها، وتعاطي المادة رغم توقع حدوث عواقب ضارة محتملة، والجهود المتكررة للتوقف عن التعاطي أو للتحكم فيه، ونشوء أعراض الانسحاب حينما لا تكون مادة العقار، المخدر متيسرة أو حينما لا يتعاطاها الفرد (Lawson,1984:37).

ففي حالة الإدمان ينشأ تغير في خلايا الجسم يحدث مع التعاطي المتزايد لمعظم عقاقير المثبطات. وتتمثل المعالم الإكلينيكية الأولية في نمو التحمل (الإطاقة) وفي نمو أعراض الانسحاب عند استبعاد العقار (4 - 3: Edgrton,1994).

كما يعرف «الإدمان» Drug Addiction بأنه : الحالة النفسية أو العضوية التي تنتج عن تفاعل العقار في جسم الكائن الحي (تعريف منظمة الصحة العالمية (W.H.O) (في ١٩٧٣م).

ومن خصائص الإدمان أنماط سلوكية واستجابات مختلفة، تشمل دائماً الرغبة الملحة في تعاطي العقار بصورة متصلة أو غير متصلة (دورية) للشعور بآثاره النفسية أو تلافي الآثار المقلقة نتيجة لعدم توافره.

هذا وقد يدمن المتعاطي على أكثر من مادة واحدة، وقد يُعرف الإدمان أيضاً على أنه حالة تسمم مزمنة ناتجة عن الاستعمال المتكرر للمخدر، وإضافة إلى التعاريف السابقة للإدمان، فإن من خصائصه:

١ - الإلحاح والرغبة في الاستمرار على تعاطي المخدر، والحصول عليه بأي وسيلة، والحاجة هنا مُكرهة للمتعاطي في الحصول على المخدر بجميع الطرق والوسائل.

٢ - الرغبة في زيادة الجرعات، وإن كان بعض المدمنين يظل على جرعة ثابتة.

٣ - الاعتماد النفسي والعضوي على المخدر، أي الخضوع والتبعية النفسية والعضوية لمفعول المخدر.

٤ - ظهور أعراض نفسية وجسمية عند الامتناع المفاجئ أو الانقطاع الفوري عن المخدر، سواء تم ذلك بطريقة إجبارية أو اختيارية ويسمى ذلك ردود النقص.

٥ - الآثار الناجمة الضارة والمؤذية على الفرد والمجتمع. (منصور، ١٩٨٦م، ص ٢٤)

استخدم مصطلح الإدمان حتى عام ١٩٦٤م. للدلالة على حالات استعمال المواد إلى حد عدم مقدرة الفرد على التخلي عن تناولها. وقد استبدل حديثاً بمصطلح الاعتماد على العقاقير. الاعتماد على العقاقير له نوعين:

الاعتماد النفسي

يدعى أيضاً التعود يتصف بمعاناة الفرد من وحم دائم ومتكرر للمادة التي يتعاطاها لكي يتلافى حالة عسر المزاج التي يعانيتها أو يتوقعها نتيجة عدم توفر المادة أو حاجته لتناولها.

الاعتماد الجسدي.

تتسم هذه الحالة بالحاجة لتناول المادة المعينة لمنع حدوث متلازمة التوقف عن الاستعمال والتي تدعى متلازمة السحب (الشهري، ١٤٢٦هـ، ص ٤٨ - ٨٥)

وإذا نظرنا للإدمان كمفهوم شمولي فإنه سيبدو هناك خلط وتداخل بين مصطلح «الإدمان» ومصطلحات «سوء الاستخدام» و«الاعتماد» و«التحمل» و«الانسحاب». وقد يكون هذا التداخل طبعياً لما بين هذه الحالات المختلفة من علاقات وتفاعلات وثيقة حتى أنه قد يصعب الفصل بينها في بعض الأحيان.

فقد يستخدم مصطلح «سوء الاستخدام» بطريقة تبادلية مع مصطلحات أخرى، مثل مصطلح «إدمان»، تعني الاستخدام غير العادي للعقار أو المخدر، حيث يكون «سوء الاستخدام» بذلك هو عبارة عن فئة فرعية من الإدمان بدلاً من أن يكون انحرافاً عن المعايير الاجتماعية. (Helzer, 1994, pp25)

وقد يُطرح مصطلح «الإدمان» على أنه مرادف أو بديل لمصطلح «الاعتماد» ويتمثل ذلك خاصة فيما قدمته «منظمة الصحة العالمية» (W.H.O) من تعريف حددته لجنة من الخبراء الدوليين لمصطلح «الاعتماد» في عام ١٩٧٤، ١٩٧٤ (World Health Organization Expert Committee on Drug Dependence)

إن ثمة محاولة في هذا الشأن للتمييز بين المكونات الجسمية والمكونات النفسية للاعتماد. فلا شك في أنه يمكن أن تكون هناك ظروف ينظر فيها إلى الاعتماد الجسدي في شكل «خالص» نسبياً. فعلى سبيل المثال، بينت نتائج بعض البحوث التجريبية على الكلاب أنه نشأ عندها اعتماد جسدي على المورفين والميثادون في المناطق المنعزلة من الحبل الشوكي، كما نشأ هذا الاعتماد عند الكلاب التي استأصل منها لحاء المخ. (Gossop, 1994, pp366).

ويتبين أيضاً أن المرضى الذين يتناولون أدوية من مشتقات الأفيون لخفض الألم عندهم بعد عمليات جراحية أجريت لهم، قد يبدون أعراض الانسحاب حينما يتوقف هذا الدواء عنهم ولكنهم مع ذلك لا يبدون أية رغبة في الاستمرار في تناول هذا العقار، أي لا ينشأ عندهم حالة من «الاعتماد» على هذه العقاقير.

ويلاحظ في توضيح المصطلحات والمفاهيم في هذا الميدان أن هناك اختلافات واضحة بين الخبراء، فلقد ظلت مفاهيم «التحمل» (أو الإطاقة) و«الانسحاب» تمثل الأعمدة التي يستند إليها مفهوم «الإدمان» وقد ينظر إلى الإدمان غالباً على أنه مركب من «الاعتماد» و«الانسحاب». (Brannon, 1992, pp366).

ولعل ذلك الاختلاف يستلزم منا بالتالي أن تستبين ما بين هذه المصطلحات والمفاهيم من تفاضل وتكامل ومن فصل ووصل يتضح معها أن «الإدمان» في حقيقته «مفهوم شمولي» يتضمن في الأصل مكونات «التحمل» و «الاعتماد» و «الانسحاب» وديناميات تلك الحالات التي تعتمل في عملية الإدمان. وهذه المفاهيم يمكن مناقشتها وتعرف خواصها في علاقتها بعقاقير ومخدرات متعددة، الأمر الذي ينطوي على أهمية كبيرة في تقدير الآثار الناجمة عن أي عقار أو مخدر وكذلك في تقدير الأخطار الكامنة فيه:

إن التحمل « (الإطاقة) مصطلح يطبق على تأثيرات العقار أو المخدر حينما تنمو عند الفرد، مع التعاطي المستمر، حاجة متزايدة أكثر فأكثر إلى تعاطي العقار أو المخدر لإحداث نفس تلك التأثيرات، ذلك أن التعاطي المتكرر لعقاقير / مخدرات معينة يؤدي إلى تناقضات متوالية في بعض تأثيراتها. ويحدث ذلك مع التأثيرات الإنشائية والمسكنة لمشتقات الأفيون مثل الهيروين والميثادون، كما يحدث مع الكحوليات. وتعد العقاقير والمخدرات التي تتصف بالجهد العالي للتحمل مواد خطيرة لأن الفرد الذي ستنمو عنده تلك الإمكانية سوف يحتاج إلى تعاطي كميات كبيرة من تلك المواد للتوصل إلى التأثير الذي يريده ويتوقعه.

والتحمل والاعتماد خاصيتان مستقلتان. فالعقار / المخدر قد يخلق حالة من التحمل، ولكنه لا يؤدي إلى حالة من الاعتماد، وكذلك قد ينشأ الاعتماد على عقار / مخدر ليس له جهد للتحمل أو يتصف بجهد ضئيل للتحمل، فإن بعض العقاقير والمخدرات تتصف بإمكانات كل من التحمل والاعتماد. بل وتوضح بعض البحوث أن التحمل والاعتماد ليسا بالضرورة مترتبات ناتجة عن تعاطي العقاقير والمخدرات. (Zinberg, 1981, pp 91 - 108).

ومع نمو «التحمل» ينمو أيضاً «الاعتماد» و «الانسحاب». فالاعتماد، وإن كان منفصلاً عن التحمل، فإنه أيضاً مصطلح يمكن تطبيقه على عقاقير ومخدرات كثيرة. فالاعتماد ينشأ عند الفرد حينما تصبح مادة العقار / المخدر مستدمجة داخل أنسجة الجسم وتوظيفها الحيوي فيها حتى إنها تصبح ضرورية للتوظيف «العادي» عند الفرد. أما إذا حدث توقف أو عدم استمرار في تعاطي تلك المادة، فإن حالة الاعتماد على ذلك العقار / المخدر تصبح واضحة وهي: نمو أعراض الانسحاب.

إن زملة أعراض الانسحاب هي الدلائل أو العلامات الجسمية على أن الجسم قد تكيف للتوظيف البدني من دون العقار/ المخدر، وهذه الدلائل أو العلامات تأخذ مظاهر وأعراضاً متعددة كالتهييج والقلق والاكتئاب والهلوسات واختلال الذاكرة والأرق وتصبب العرق ورشح الأنف وابتلال العينين والارتعاشات ونوبات صرعية. ويلاحظ في ذلك أن الاعتماد والانسحاب يعتملان جسيماً ويظهران في صورة أعراض جسمية.

وغالباً ما تعتبر زملة الانسحاب عن الأفيون ومشتقاته كظاهرة نمطية مميزة لحالة الانسحاب، رغم أن أعراض الانسحاب تختلف وفقاً لنوعية الاعتماد على عقار معين. ولا يعتبر الانسحاب عن الأفيونيات أكثر الاستجابات خطورة جسيماً لعدم الاستمرار في التعاطي، فالانسحاب عن الكحوليات أو الباربيتورات أو البنزوديازيبينات قد تنتج عنه مشكلات أكثر خطورة. ويعتبر الانسحاب عن العقاقير والمخدرات إحساساً مؤلماً وفاضحاً بشكل رديء السمعة، والكحوليات هي واحدة من أسوأ هذه المواد. ويتوقف مدى صعوبة عملية الانسحاب على عوامل كثيرة منها طول مدة التعاطي ودرجة الاعتماد. وفي بعض الحالات قد يؤدي الانسحاب عن الكحوليات إلى تهديد حياة الفرد، مع احتمالات للوفاة بمعدلات تصل إلى ما بين ٥ و ١٠٪ (Lerner,1985.pp951 - 952)

ولقد شاع بين الخبراء والباحثين لسنوات طويلة أن التحمل والانسحاب من الخصائص المحددة للاعتماد الجسيمي، ولكن بات من الواضح أن الاحتمال يحدث أيضاً بالنسبة لعقاقير/ مخدرات لا تعتبر من العقاقير الإدمانية جسيماً مثل الأمفيتامينات والقنب (الحشيش). كذلك تنشأ استجابات شبيهة بالانسحاب لعدم الاستمرار في تعاطي هذه العقاقير/ المخدرات بعد التعاطي المنتظم لها. (Gossop,1982.pp177 - 183) وسواء كنا نطلق أو لا نطلق على هذه الاستجابات مسمى «أعراض الانسحاب» فإن تلك في الحقيقة مشكلة (دلالية) أكثر منها مشكلة علمية. فعلى سبيل المثال، وُجد أن الكوكايين الذي نظر إليه لفترة من الزمن على أنه ليس من المواد الإدمانية لأنه لا يؤدي إلى زملة انسحابية من نمط الأفيونيات، يسبب مشكلات من الاعتماد الشديد لدى الكثيرين من المتعاطين له وبخاصة حينما يتم التعاطي عن طريق التدخين.

إن محاولة موازنة الاضطرابات الإدمانية داخل نظام تقليدي لتصنيف الطبي النفسي القائمة على فئة الاضطراب تعد محاولة غير دقيقة. فلقد توجهت هذه الجهود إلى التركيز على مواد نوعية دون ما اعتبار كاف للتباين في الأنماط السلوكية والمشكلات المرتبة بالتعاطي. ولقد تأسس أيضاً الكثير من هذه الجهود على مفاهيم التحمل والانسحاب كخصائص أساسية للاعتماد على العقار أو المخدر، ومن الخطأ تقييد التعقيدات الاجتماعية والنفسية داخل تلك الحدود الفسيولوجية الضيقة.

إن تغير المصطلحات من «الإدمان» إلى «الاعتماد» طُرِح جزئياً لتشجيع الحركة في هذا الميدان بعيداً عن النظرة الفئوية للإدمان على أنه حالة (هل هذا الشخص معتمد / مدمن؟) إلى النظر إليه على أنه بُعْد (ما مدى شدة الاعتماد / الإدمان عند هذا الشخص؟).

إن جوهر الاعتماد هو أن العلاقة بين المتعاطي والعقار الذي يستخدمه هي علاقة متغيرة. ففي البداية، ربما تستخدم العقاقير والمخدرات لأسباب كثيرة، ولكن القرار باستخدام العقار / المخدر من عدمه إنما يتخذه الشخص كاختيار إرادي. ومع نمو الاعتماد يصير الشخص بشكل متزايد مستوعباً ومتملكاً بواسطة العقار / المخدر ويشعر بدرجة من القُهار الذي يجبره قسراً على تعاطيه. وفي تلك الحالة فإن الأسباب الأولى للتعاطي قد تكون موجودة أو غير موجودة، ولكن مع نمو الاعتماد فإن ثمة عوامل جديدة تضاف إلى التعاطي وتعمل بالتالي على تعقيد الصورة وزيادة احتمال تزايد شدة الاعتماد. (Gossop, 1994, pp365 - 368).

والواقع إنه بذلت جهود مختلفة لتحديد ما الذي نعنيه على وجه الدقة بالاعتماد، يذهب بعض الباحثين إلى أن الاعتماد ينبغي النظر إليه على أنه زملة يكون فيها لتعاطي عقار معين أو حتى مجموعة من العقاقير أولوية أكبر بكثير عن أي سلوك آخر كانت له عند الفرد قيمة أكبر في وقت ما. فالاعتماد يحدث كجزء من نمط أوسع للسلوك، حيث لا يكون من الضروري أن توجد كل مكونات زملة الاعتماد، ولا دائماً بنفس الشدة. ومن أبرز التأثيرات المختلفة الفسيولوجية والسلوكية والمعرفية التي يفترض أنها تكون زملة الاعتماد ما يلي:

الشعور بالقُهار، أي السلوك القسري، لتعاطي العقاقير، الرغبة في التوقف عن التعاطي، وجود أسلوب للتعاطي نمطي نسبياً، وجود دلائل من التكيف العصبي (أعراض التحمل

والانسحاب)، وأخيراً هيمنة سلوك تعاطي العقار على الأولويات الأخرى في حياة الفرد والنزعة إلى العودة إلى تعاطي العقار توأ بعد فترة من التوقف أو الامتناع. (Edwards,1981,pp225 - 242). وبناءً على هذا التحديد، فإن أياً من هذه البنود في حد ذاته ليس كافياً لتحديد الاعتماد على تعاطي العقار/ المخدر، وإن قياس الاعتماد على تعاطي العقاقير أو المخدرات ينبغي أن يستند إلى محكات متعددة. ومع ذلك ينبغي أن نبرز في هذا التحديد عاملاً أساسياً هو الرغبة الغالبة أو القُهار المسيطر لتعاطي العقاقير والمخدرات. فالإحساس بالقُهار يعتبر مقوماً أساسياً من مقومات الاعتماد. وهذا ما يناقض فهمنا لما نعنيه بمفهوم الإدمان من أن شخصاً قد يكون مدمناً لشيء ما ولكنه لا يخبر حاجة قوية إليه. ومن ثم فإن الاعتماد في جوهره ينبغي اعتباره «ظاهرة نفسية» (Gossop,1984,pp 365 - 368).

ومع ذلك، فقد تعرض مفهوم الاعتماد إلى النقد. فقد وجه البعض النقد إلى أن مفهوم زملة الاعتماد قد يهدد بدوام بقاء بعض التضمينات غير المرغوبة لمفهوم الإدمان كمفهوم من طراز قديم للمرض. فلا شك في أنه إذا كان الهدف من العلاج هو قناع الأشخاص المدمنين أو السكيرين بأنهم ضحايا عاجزون لعملية مرضية تعتمل فيهم، وبأنهم لا يستطيعون بالتالي التحكم في أفعالهم، فإن تلك التضمينات المتعلقة بالمرض تكون بلا جدوى وينبغي تجنبها. وفي دراسة عن «نقد مفهوم زملة الاعتماد» يتبين أن زملة الاعتماد تعطي تأكيداً غير مناسب لعناصر القُهار (السلوك القهري) و «فقدان التحكم» وإلى أن المدمنين للعقاقير والمخدرات لا ينبغي أن ينظر إليهم على أنهم ضحايا سلبيون لاعتمادهم ما داموا قادرين على أن يظهروا تحكماً في بعض جوانب تعاطيهم للعقاقير والمخدرات (Gossop,1989).

ويشير ذلك قضية أخرى هي أن التركيز على فقدان التحكم يكون من مكونات الاعتماد قد يعمل على جذب الانتباه بعيداً عن القضايا الأكثر تعقيداً فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع شخصاً إلى تعاطي العقاقير أو المخدرات وعن الظروف التي يحدث فيها التعاطي.

والحقيقة إن الكثير من هذه الاعتراضات موجه نحو مفهوم الاعتماد كمفهوم تفسيري ويرون أنه من الأفضل النظر إلى الاعتماد على أنه صفة تُعزى إلى التعاطي. وقد يبدو ذلك غريباً من أنه لا يوجد عند هؤلاء الباحثين مكان لمفهوم الاعتماد، ما دامت صفات العز وربما تكون هي ذاتها عوامل مهمة في تحديد سلوك الاعتماد.

ورغم هذا النقد يبدي باحثون آخرون حماسة أكبر لمفهوم الاعتماد ويفترضون أن اعتبار الاعتماد مفهوماً بُعدياً، بدلاً من كونه مفهوماً فئوياً إنما ينطوي على قيمة إكلينيكية مباشرة. (Hodgson,1980,pp255 - 263).

واعتبار الكل ذلك، فإن قيمة مفهوم الاعتماد ينبغي الحكم عليها ليس من مجرد الجدل المثار حوله ولكن في ضوء استخداماته في الممارسة الإكلينيكية وفي البحث العلمي.

أنماط وأنواع التعاطي

يشير لويس مليكه (١٩٩٩م) إلى أن هناك أنماطاً وأنواعاً للتعاطي وهي كالتالي:

١ - التعاطي التجريبي: Experimental use ويقصد به محاولة تجريب المادة النفسية لاستكشاف آثارها، وقد يترتب على ذلك الاستمرار في تعاطيها مرات قليلة، ثم لا يعود مطلقاً إلى التعاطي مرة أخرى. وهذا النوع من التعاطي له خطورته فهو قد يعتبر المدخل إلى إدمان المواد المخدرة.

٢ - التعاطي بالمناسبة: Casual use ويقصد به التعاطي في المناسبات الاجتماعية، وهي مرحلة متقدمة عن مرحلة التعاطي التجريبي. أو قد يرتبط التعاطي بالرغبة في مواجهة المواقف الضاغطة كالامتحانات، أو الحروب، أو المباريات الرياضية.

٣ - التعاطي المنتظم: Regular use ويقصد به التعاطي على فترات منتظمة يتم تحديدها بحسب إيقاع سيكوفيسيولوجي داخلي خاص بمدى احتياج الشخص لمادة التعاطي. ويعتبر هذا المستوى درجة متقدمة من حيث علاقة المتعاطي بالتعاطي.

٤ - التعاطي الكثيف أو القهري: Heavy or compulsive use وهو يمثل أعلى درجات العلاقة بين المتعاطي وبين المخدر، حيث يكون التعاطي بصورة متكررة، وفترات متقاربة.

٥ - التعاطي المتعدد للمواد النفسية: ويقصد به التعاطي لعدد من المواد النفسية، سواء كان التعاطي لها في وقت واحد، أو الانتقال عبر فترة زمنية (درويش ٢٠٠٤م، ص ٣٠).

طرق التعاطي للمخدرات

تتنوع طرق تعاطي المواد المخدرة حسب نوع المادة نفسها، وبصورة مجملة فإن تعاطي هذه المواد يمكن أن يتم بإحدى الطرق التالية:

١ - عن طريق الفم: ومن ذلك الشراب، كتعاطي الخمر بكافة أنواعها، حيث يتم تناولها عن طريق الشرب، وكذلك القات الذي يمضغ ويخزن في الجزء الأيمن أو الأيسر من الفم (الشدق) في عملية تعرف بالتخزين، ويندرج أيضاً تحت هذا الصنف بعض الأنواع التي يتم تناولها عن طريق الاستنشاق لارتباط التجويف الأنفي بالتجويف الفمي، كما هو الحال في تعاطي الحشيش أو غيره من المواد.

٢ - عن طريق الشم: الأسلوب الآخر لتعاطي المخدرات هو الشم عن طريق الأنف حيث يستنشق ذلك المسحوق المخدر كالهروين أو الأفيون مثلاً بالأنف فيدخل عبر الخياشيم إلى الدماغ مسبباً أعراضاً مخدرة رهيبة نتيجة سرعة وصوله إلى الدماغ.

٣ - عن طريق الحقن: يتعاطى الفرد بعض أنواع المخدرات عن طريق الحقن عبر الوريد حيث تسير المادة عبر الدم فيمتص الجسم تلك المادة المخدرة لتصبح جزءاً من تركيبة الدم وبالتالي لا يستطيع الجسم أن يستغني عنها، إلا من خلال خفض التدرجي للجرعة حتى التخلص منها.

نظريات الإدمان

١ - النموذج المرضي The Disease Model

تحدد هذا النموذج ابتداءً بما أقرته «منظمة الصحة العالمية» (W.H.O) في عام ١٩٥٢ م والرابطة الطبية الأمريكية في عام ١٩٥٦ م من إطار تشخيصي لإدمان الكحوليات كمرض، ومن أن تعاطي العقاقير والمخدرات هو حالة من الاضطراب تصيب الأشخاص المتعاطين وتؤدي إلى الإدمان الفسيولوجي، أي إلى تغير في فسيولوجيا الجسم نتيجة لسوء استخدام العقاقير والمخدرات كما يتضح في زميلات التحمل والانسحاب. وتنشأ مع التعاطي حاجات متنامية إلى زيادة كميات التعاطي وجرعاته، الأمر الذي يجعل المتعاطي يدخل في دائرة مفرغة من عملية المرض (Oetting, 1991).

ومن الصعب أن ندخل النموذج المرض لتفسير سوء الاستعمال أو الإدمان في أي من النظريات النفسية أو النظريات السلوكية البيئية. رغم مسمى هذا النموذج فإن نموذج المرض ليس نموذجاً طبيّاً ولا بيولوجياً ورغم قدم هذا النموذج فلا يزال واعداً في هذا الميدان.

لكن لسوء الحظ فإن النموذج لا يشتمل على تفسير واضح للإدمان وجوهر هذا النموذج يشير إلى أن سوء الاستخدام أو بصفة محددة «الإدمان» هو مرض. فالإدمان مرض قائم بذاته وليس عرضاً أو جزءاً من مرض آخر والإدمان كمرض ليس تفسيراً بقدر ما هو تقرير للحقيقة حول أنماط الاستخدام غير المتكيف وخطر التكرار لهذه الأنماط أثناء حياة المدمنين.

ويرى القصور المرضي لسوء استخدام العقاقير يعتبر شائعاً في المجتمع، ومعظمنا يشعر أن الذين يسيئون استخدام العقاقير إنما هم مرضى ويحتاجون للعلاج. حيث يتضمن المرض وجود شذوذ بدني سواء كان هذا الشذوذ تشريحياً أو فسيولوجياً، حيث إشارة الأدلة إلى وجود خصائص شذوذ بيولوجية للذين هم عرضة لسوء استخدام العقاقير.

فلقد أوضحت الدراسات الوراثية وجود (جين) مستقل عن التأثيرات البيئية. يمد الفرد بنشاط لتطوير سوء استخدام العقاقير، وقد اقترح الباحثون عدة نظريات وراثية حيوية تشتمل على شذوذ في وظيفة نقل السيالات العصبية مثلاً السيروتين أو الكاتيكول أمينيات أو اختلافات في تمثيل الكحول. وغياب دليل طاغي لأي من هذه العلامات البيولوجية يجعل من أي سبب بيولوجي منفرد أمر غير وارد. (الشناوي وعبد الرحمن، ١٩٩٨م، ص ٤٤٤).

٢- النظريات النفسية Psychological theories

يشيع في ميدان التعاطي ولإدمان العديد من النظريات والنماذج والمناحي المختلفة التي تسعى إلى تفسير وفهم طبيعة ظاهرة الإدمان واضطرابات الإدمان ويقصد بها في هذا المقام النظريات التي تعتمد في تفسيرها على العمليات العقلية الداخلية للفرد ورغم أن لا أحد يتجاهل العوامل البيئية فإنه قد يكون للعوامل الداخلية مثل العواطف والمشاعر وخصائص الشخصية دورها الأساسي في هذا السلوك المرضي:

٣- النظرية السيكدينامية Psychodynamic Theory

سادت المدرسة السيكدينامية المجال النفسي في النصف الأول من القرن العشرين وهي مثل نظريات أخرى تنظر للإدمان على أنه عرض أكثر من كونه سبباً لمشكلات سلوكية أو انفعالية. وهناك عدة مدارس رئيسية تدخل في أدبيات المدرسة السيكدينامية فهناك تفسير يدور حول التثبيت الفمي خاصة في تفسير سوء استخدام أو الاعتماد على الكحول.

ثمة تفسير آخر نشأ في المدرسة السيكدينامية يرى أن عدم مقدرة الأم أو الأسرة على الوفاء بحاجات الطفل الاعتمادية في المرحلة المبكرة مما ينتج عنه عدم تأكيد لدى الطفل حول إشباع هذه الحاجة، وبذلك فإن الطفل لا يطور القدرة على تأجير الإشباعات وهذا تحمل المنخفض للإحباط يظهر في صورة سلوك اندفاعي مثل الغضب أو الانسحاب أو في صورة استخدام للمواد الذي يعتبر أسلوب غير ناضج لتحقيق الإشباعات الفمية (Blanc 1990).

ثمة تفسير آخر طوره ميننجر Menninger (١٩٣٨) الذي يرى أنه طالما الحاجات الشخصية لم تشبع فإن الفرد يصبح غاضباً من والديه ولأنه غير قادر على التعبير عن هذه الرغبات العدائية نحوهما فإن غضبه يتجه داخلياً ويظهر في شكل سلوك مدمر للذات من خلال سوء استخدام العقاقير. وفي رأي كثير من منظري المدرسة السيكدينامية فإن المدمنين يشتركون في الغالب في بعض الخصائص مثل الاعتمادية، والاندفاعية، والرجسية، والانعزال العاطفي، ومشاعر عدم الملائمة والاكتئاب. وينظر إلى الخمر والمخدرات على أنها طريقة للوفاء بحاجات الاعتمادية واستبعاد عدم الارتياح النفسي الناتج عنها وتعمل المواد المنشطة نفسياً كمعينات للأنا (Wieder&Kaplan, 1969, pp399).

وهناك تفسير آخر تأتي به المدرسة السيكدينامية ترى فيه المادة أو العقار الضار على أساس أنها موضوع والإدمان على أساس أنه يشابه الاعتماد على أناس آخرين. (Meeks, 1987, pp388 - 393). كذلك فإنه ينظر للإدمان على أنه بديل عن علاقات مع آخرين قد تؤدي بالفرد إلى صراع أو أضرار.

وهناك فرض التداوي الذاتي باعتباره تفسيراً نفسياً لظاهرة الإدمان حيث يرى أن الفرد يستخدم الكحول وغيره من العقاقير لمداواة عدم تحمل الحالات الوجدانية. وفي رأي خانتازيان (١٩٨٥) Khantazian أن اختيار العقار أو المادة التي تستخدم يتم بناءً على قدرتها على ضبط حالات وجدانية معينة. فبعض المدمنين يستخدمون العقاقير المنشطة للتعامل مع الاكتئاب والضجر أو الخوف بينما آخرون يستخدمون المهدئات لعلاج أخطار الغضب أو الهياج.

٤- نظريات السلوكية (التعلم) والبيئة

النظريات السلوكية أو نظريات التعلم هي تلك النظريات أو التفسيرات التي تبحث عن تبرير السلوك. وهو هنا استخدام أو إساءة استخدام العقاقير. على أساس من تفاعلات الفرد مع البيئة وأثار متغيرات بيئية معينة على السلوك. وتتضمن النظريات السلوكية نظرية التعلم الاجتماعي، النظريات التفاعلية وجوانب من نظرية التوقع ونظرية خفض التوتر ونظرية كبح استجابة الانضغاط.

أ- نظرية التعلم الاجتماعي Social Learning theory

تفترض نظرية التعليم الاجتماعي أن كل صور استخدام المواد تحكمه القواعد الإجرائية وقواعد التعلم بما في ذلك العوامل المعرفية (Abrams & Niaura 1987). ويتعرض الشباب لنماذج تنمي الاتجاهات نحو استخدام العقاقير وكذلك المعتقدات السائدة حوله ونماذج من سلوك التعاطي حيث يتعلمون منهم هذا السلوك. وبناءً على التعرض للمواد أو العقاقير فإن الخبرة المباشرة تجعل استخدام العقاقير إما يعزز إيجابياً أو سلبياً عن طريق إثارة (أنظر الحديث عن التعزيز في الجزء الخاص بالأسس النظرية) وتشتمل المعززات الناتجة عن المخدرات خفض التوتر وخفض الانضغاط أو التعامل مع الحالات الوجدانية السلبية أو زيادة التفاعلات الاجتماعية. وإذا استمر استخدام العقار فإن زيادة التحمل (الإطاقة) للآثار المعززة يتطلب كميات أكبر لتحقيق نفس الآثار والحصول على كميات أكبر قد ينتج عنه انشغال زائد بالحصول عليها. وبالمثل فإن الاعتماد البدني قد ينتج عنه ما يستلزم مزيد من الاستخدام لتجنب أعراض الانسحاب. والحصول على المعززات قصيرة المدى قد يحقق الرغبة في تجنب تعزيز السالب من النتائج السلبية السابقة الناتجة عن استخدام المادة.

وقد أعطت التعديلات الأكثر حداثة لنظرية التعلم الاجتماعي أهمية أكبر للعوامل الأخرى في ذلك الخصائص الشخصية، والعوامل المعرفية ونواقص مهارات التعامل الاجتماعية النفسية (Abrams & Niaura, 1987).

ب - النظريات التفاعلية Interactional theories

تقترح هذه النظريات أن السلوك بما فيه سلوك استخدام العقاقير هو نتيجة للتأثيرات المتبادلة بين الشخص (الفرد) وبيئة هذا الشخص ومخزون السلوك الفردي. وإذا قارناها بنظرية التعلم الاجتماعي فإن الفرد يعتبر عاملاً نشطاً يتأثر بالعوامل المعرفية، والوجدانية والدافعية بجانب تأثره بالبيئة. ومن شأن عملية التفاعل المستمرة والتغذية المرتدة بين البيئة والفرد أن تؤثر على السلوك. وتقوم النظرية التفاعلية الحديثة على أساس من نماذج إحصائية للتباين المتعدد وتمثلها نظرية السلوك المشكل التي اقترحها جيسور وجيسور (١٩٩٧) ونموذج المجال الذي اقترحه هوبا وبتنلر (١٩٨٢) Huba & Bentler والنموذج النهائي لزوكر (١٩٧٩) Zucker.

وفي رأي جيسور وجيسور أصحاب نظرية سلوك المشكلة، أن مشكلة تعاطي الخمر هو واحدة من عدة مشكلات، وهذه السلوكيات المشكلة هي نتيجة للتفاعل بين ثلاثة أنظمة داخل الفرد: الشخصية، البيئة المدركة، والسلوك: وفي داخل كل نظام هناك خصائص أو متغيرات تمثل تعرضاً أو ميلاً للانحراف أو السلوك المشكلة، وكل سلوكيات المشكلة. فإن سلوك الشرب سواء كان يمثل أو لا يمثل مشكلة هو متغير مستمر أكثر من كونه حالة متقطعة.. ولا يذكر جيسور شيئاً عن الآثار الصيدلانية أو الاستهداف البيولوجي.

وفي نموذج المجال يرى هوبا وبتنلر أن الشرب هو واحد من مجموعة أكبر من النزاعات السلوكية أو طرز الحياة. وهذه النزوعات هي نتيجة للتفاعلات بين عدة مجالات هي المجالات البيولوجية والداخلية الشخصية والبيئية والثقافية وبذلك فإن نموذج المجال يبدو أنه أكثر شمولاً عن غيره من النظريات التفاعلية بإدخاله استخدام العقاقير في إطار واسع من السلوك والتأثيرات بكل من العوامل البيئية والبيولوجية.

٥ - النظرية المعرفية

اعتمدت كثير من الخطط العلاجية الرامية إلى تثبيت موقف الامتناع عن تعاطي الكحول أو المخدرات، على ما يسمى بأساليب منع الانتكاسة، وهي كلها أساليب سلوكية معروفة، طبقت أساساً على مدمني الكحول وكان هدف العلاج لهؤلاء المدمنين مساعدتهم على الامتناع ثم تدعيم موقف الامتناع هذا. والنظرية المعرفية Cognitive Theory لا تربط بين أسباب الإدمان والكيفية التي تعالج بها في المراحل الأولى من العلاج. فالهدف الأول للعلاج هو التركيز على الاعتقادات الخاطئة التي يحملها المدمن، ثم الانتقال إلى التركيز على المشكلات السلوكية الأخرى عندما تظهر، فأصحاب هذه النظرية يرون أن تصحيح اعتقادات المدمن الخاطئة لا تنحصر في مجال الإدمان، بل أيضاً في أنماط تفكيره الجديدة بناء على ما تعلمه. وذلك ليتحسن تكيفه في مشكلاته الأخرى التي تعترضه. (الحجار، ١٩٩٢م، ص ٢٥)

وهذه النظرية تفسر الإدمان على العقاقير بناء على العمليات المعرفية الإدراكية، فالإدمان أحد الأساليب السلوكية اللاتكيفية المرضية، وقد اكتسب المدمن تلك الأساليب بناء على البنية الفكرية المعرفية لديه. فجوهر النظرية المعرفية أن «الأحداث الخارجية ليست هي التي تزعجنا وتكدرنا ولكن تأويلاتنا واعتقاداتنا إزاء هذه الحوادث هي المسببة للكدر والقلق والغم. (الحجار، ١٩٩٢م، ص ١٦)

ويرى «بيك» أن حدوث الإدمان يرجع إلى نظام من الاعتقادات الإدمانية Addictive beliefs ويشير هذا المصطلح إلى مجموعة من الأفكار التي تركز على البحث عن المتعة وحل المشاكل وعلاجها أو الهروب منها. وهو مصطلح يرتبط بشكل خاص باعتماد هذه الأفكار على تفضيل مادة ما للتعاطي دون غيرها من المواد الإدمانية الأخرى. (الشهري، ١٤٢٦هـ، ص ٤٨ - ٨٥). وتكون الاعتقادات الخاطئة نسقا من التفكير يسيطر على المدمن فيرى أن احتياجه للمخدر لإحداث قدر من التوازن النفسي والانفعالي وأن أدائه الاجتماعي والوظيفي يتحسن بتعاطي المخدر بالإضافة إلى قدرة المخدر على التغلب على المشاعر المزعجة كالضيق والملل وما يمنحه للمدمن من نشاط و طاقة.

وتفترض النظرية المعرفية أن الاعتقادات الخاطئة تولد التحمل المنخفض للإحباط، وهذا

ما نجده بخاصة لدى المدمنين على العقاقير. وقد طرح «آليس» Ellis تعبيراً جديداً اسماءه قلق الانزعاج Discomfort / Anxiety أو اضطراب الانزعاج في وصفه للحالة النفسية الجديدة التي تعترى المدمن نتيجة تفكيره اللاعقلاني تجاه إدمانه على العقاقير، وبفعل التحمل المنخفض للإحباط الناجم عن الامتناع عن تعاطي المخدر.

ويتصف هذا القلق المزعج في توقع الشخص المدمن على العقاقير، للألم والانزعاج وعدم الشعور بالراحة والتوتر. وتعتبر تلك المشاعر التي تتاب المدمن عن نمط حياته الإدماني والاعتقادات الخاطئة التي تدور بخلفه والتي تكون نسقاً من التفكير المضطرب.

وبالإدمان على المواد النفسية، من أجل الوصول لحالة من التكيف، يحرم المدمنون أنفسهم من تعلم آليات أكثر فعالية للتكيف، ويصبحون أقل احتمالاً لآلام القلق. فهم يوقنون في هذه المرحلة أنه ليس من الضروري تحمل القلق، طالما أن تعاطي المادة النفسية قد نجح في إزالة التوتر وفي جعلهم يعيشون خبرات ومشاعر وجدانية ومعرفية إيجابية، عندها يصبح من المتوقع أن يتزايد تعاطي المواد النفسية، سواء في عدد مرات التعاطي أو أنواع المواقف التي تؤدي إليه - وهكذا يؤدي الإدمان على المواد النفسية إلى دائرة مفرغة.

٦- نظرية التوقع Expectancy theory

تعتمد هذه النظرية في تفسيرها للإدمان على العوامل المعرفية، وعلى توقع وجود علاقة منظمة يمكن التنبؤ بها بين حدث أو شيء وبين النتيجة أو العائد منه. (الرشيدي وآخرون، ٢٠٠٠م، ص ٩٩)

إن التوقعات هي عمليات معرفية تربط الأحداث أو بشكل أدق توقع الأحداث لنتائج معينة. ومن خلال قواعد التعلم يتعلم الفرد أن يتوقع العلاقات بين الأحداث أو الموضوعات في موقف قادم. وبالنسبة لنظريات التوقع، فإن ما يتم تعلمه هو العلاقة بين استخدام المادة ونتائج معينة مرغوبة نتيجة أنها معززة. ويحدث سوء استخدام العقار عندما يكون لدى المدمن توقعات إيجابية للاستخدام أكبر من عددها أو قيمتها عن التوقعات السلبية وهذه التوقعات قد تُعزز في خبرة قصيرة المدى. ونظراً للكميات المحدودة للخبرة والاستهداف لتأثيرات الثقافة الشائعة وخرافتها فإن المراهقين قد يكونون أكثر عرضه لتنمية التوقعات التي لا يثبت صدقها في المدى البعيد.

٧ - نظرية خفض التوتر أو محق استجابة الانضغاط

على الرغم من أن فكرة أن مدمني الكحوليات يكونون متوترين نتيجة لإحباط الصراعات المتصلة بالجوانب الفمية والاعتمادية التي قد نشأت في إطار أدبيات مدرسة التحليل النفسي. فإن نظرية خفض التوتر تقوم أساساً على قواعد التعلم التي ينظر فيها لسلوك الإدمان على أنه سلوك يكافأ. والعناصر الرئيسية في نظرية خفض التوتر تقرر أن الكحول يخفض التوتر الذي يشتمل على الخوف، والقلق والصراع والإحباط وأن الكحول يستخدم لخصائصه المخفضة للتوتر. وقد أوضحت البحوث الأكثر حداثة أن خصائص خفض التوتر للكحول تشاهد فقط في إطار منحني استجابة لجرعة كحول محدودة وأن خفض التوتر ليس عاملاً وحيداً صادقاً لتفسير الاستخدام وسوء الاستخدام (Cappell, H & Greeley, J 1987)

أما نظرية محق أو إخماد استجابة الانضغاط فهي شبيهة بنظرية خفض التوتر. حيث يتعلم الفرد أن العقاقير يمكن أن تخفض من استجابة الجسدية للضغوط وبذلك فهي تلقن وتشجع استخدام العقار في مواقف ضاغطة مماثلة وتشمل العمليات المعرفية بما فيه التوقعات وخصائص الفرد مثل الاستجابة والحساسية للضغط مما قد تكون هامة في تحديد الأشخاص المستهدفين.

٨ - الإعاقة الذاتية Self - Handicapping

الأشخاص الذين ليسوا متأكدين حول جدارتهم في مواقف محددة قد يستهلكوا المواد المخدرة لكي يُعزّون (يُرجعون) أداءهم الضعيف لحالة التسمم بدلاً من عزوها لضعف جدارتهم أو قدرتهم الحقيقية.

٩ - الوعي الذاتي Self - awareness

إن المواد المخدرة بكافة أنواعها تؤثر على العمليات المعرفية بما فيها الوعي بالذات (Hull 1987) ويصبح الفرد أقل قدرة على تقويم خبراته الشخصية السليمة بما فيه الإخفاق والنتائج السلبية للاستخدام أو سوء الاستخدام المستمر للعقار، ومن ثم فإن الاستخدام يمكن أن يستمر. وبالنسبة للشباب المدمن فإن إدراك الآثار السلبية للعقار هو أمر ضروري للفرد كي

يكون قادر على تفادي استخدام هذه العقاقير كلها أو لتجنبه التقدم من الاستخدام التجريبي إلى الاستخدام الحقيقي للعقار.

ثالثاً : التفسيرات الاجتماعية والثقافية

ترتكز التفسيرات الاجتماعية والثقافية للتعاطي والإدمان على الأسرة والأقران والبيئة الاجتماعية والثقافية . فمن ناحية الأسرة نجد أن العامل الأساسي في اضطراب البيئة الأسرية هو اضطراب في عملية الوالدية وما يحدث فيها من أساليب وممارسات خاطئة أو شاذة في تنشئة ورعاية الأبناء وفي تلبية حاجاتهم، ومن الملاحظ في هذا الشأن أن الإدمان كثيراً ما يرتبط بالتصدع الأسري، وهو ما يرتبط بدورة أيضا بوجود البيئة المهيأة لنشوء الاضطرابات النفسية والانحرافات السلوكية كالجناح والسلوك المضاد للمجتمع والإدمان . (الشهري، ١٤٢٦هـ، ص ٤٨ - ٨٥)

كما يرتبط التعاطي والإدمان ارتباطا كبيرا بتأثير جماعات الأقران التي يتفاعل الفرد معها وبخاصة في مرحلة الشباب، فيما يعرف بجماعة الأقران ففي هذه الجماعات الاجتماعية يندمج الفرد في أسلوب حياتها ويتوحد معها . فيرتبط تعاطي المواد المخدرة بوجود مثل هذه الجماعات الذين تتفق معتقداتهم واتجاهاتهم وقيمهم وتبريرهم لتعاطي المخدرات، وقد يفسر التعاطي بأنه قد يؤدي دورا هاما في عضوية الجماعة وفي التوحد مع الجماعة. (Dupont، ١٩٨٤)

وتعتبر البيئة الاجتماعية من العوامل المساهمة في التعاطي والإدمان، وتشمل البيئة في هذا الشأن متغيرات عديدة مثل المتغيرات السكانية والعمرية والمستوى الاجتماعي الاقتصادي والعمل والمهنة والمستوى التعليمي والمعايير الاجتماعية والقيم الدينية ونظم المعتقدات والتقاليد وغير ذلك من المتغيرات التي تعتبر محددات للتعاطي والإدمان . كما أن للعوامل الثقافية التي تشيع في جامعة من الجماعات وتمثل أسلوب حياة تلك الجماعة دور في تفسير التعاطي والإدمان، لذا تؤكد التفسيرات الثقافية للتعاطي والإدمان أهمية دور الاتجاهات والمعتقدات والقيم السائدة في المجتمع . (Biernacki,1986)

التعليق

يرى الباحث أن كل نظريات الإدمان إنما تتضمن عنصراً من الحقيقة والفعالية، وينبغي لذلك أن تكون موضع اعتبار فيما يطرح من تفسيرات وتحليلات لتلك الظاهرة المعقدة والمتعددة الأبعاد والتي تنتمي إلى أنظمة علمية متنوعة . ومن هنا فإن نتائج المنحى التكاملي الذي يفيد وظيفياً في كل ما تقدمه النظريات ونتائج البحوث من إسهامات متنوعة هو الأسلوب الأمثل في فهم وتفسير التعاطي والإدمان وتضمناته في استراتيجيات وأساليب وإجراءات التدخل الوقائي والعلاجي . ونظراً لتعدد مشكلة الإدمان، فإنه يصعب تحديد نظرية واحدة لتفسير السلوك الإدماني. حيث يرى الباحث أن وجود نظرية واحدة لا يمكنها تفسير كل جوانب السلوك الإدماني . وذلك لأن كل نظرية لها حدودها النظرية والمنهجية التي لا يمكن أن تتجاوزها من ناحية، وكذلك لطبيعة تداخل وتعقيد هذه المشكلة.

ولذلك فإن الهدف العام هو الخروج من هذه النظريات بأساليب تطبيقية لعلاج الإدمان على المخدرات . ومما لاشك فيه أن هذه النظريات قد ألفت الضوء أمام الباحث، حيث اطلع على أغلب التفسيرات التي تناولت موضوع الإدمان على العقاقير مما يساعده على فهم طبيعة المشكلة وعلى تفسير النتائج التي يحصل عليها.

٢ . ١ . ٣ العلاج المعرفي السلوكي

يعتبر العلاج النفسي أقدم أنواع العلاج، فهو قديم قدم البشرية نفسها ولكنه مر في مراحل تاريخية تطورية أدت إلى ما هو عليه الآن، وكل من يمارس العلاج النفسي بطريقة غير رسمية، فالوالد حين يخفف من الغضب أو الانفعال عند الطفل، فإنه بذلك يمارس نوعاً من العلاج النفسي لأنه يحاول أن يفهم طبيعة الاضطراب الذي نتج عنه هذا الانفعال، ويقوم بإعادة التوازن النفسي للطفل، والشخص حين يحل مشكلة زميل، فإنه بذلك يمارس نوعاً من العلاج النفسي حيث يحاول أن يفهم طبيعة الاضطراب ويتيح الفرصة له للتنفيس والتفريغ الانفعالي مما يساعده على تبصيره بكوامن القوة والضعف في شخصيته، إلا أن ذلك لا يقوم على أساس علمي . فالعلاج النفسي يستخدم في عدد من ميادين العلاج، فهو الأساس في ميدان الصحة النفسية

يستخدم في الطب النفسي وخاصة العلاج بالأدوية، ويستخدم في ميدان الخدمة الاجتماعية بالعلاج الاجتماعي، ويستخدم في مجال التربية والتعليم وخاصة التوجيه والإرشاد، ويقوم به رجال الدين وخاصة العلاج الديني أو الأخلاقي (زهران، ١٩٩٨ م، ص ١٩٧).

١ - تعريف العلاج النفسي

وردت تعاريف عديدة للعلاج النفسي فقد عرفه عاقل في معجم علم النفس بأنه فرع من العلوم الطبية أو الطبية النفسية يستهدف علاج الأمراض أو الوقاية منها (عاقل، ١٩٧٩ م، ص ١١٥).

وقد عرفته الجمعية الطبية النفسية الكندية بأنه الوسيلة الطبية التي يقوم بها الطبيب عن طريق جلسات من الحديث أو وسائل اتصال أخرى، بالكشف عن سلوك الفرد المضطرب بهدف التقليل من معاناته. (كمال، ١٩٩٤ م، ص ٨٨).

وعرفه عيسوي بأنه مداواة النفس أي النفس المضطربة بأساليب مختلفة من أهمها أسلوب الاتصال اللفظي. (عيسوي، د. ت، ص ٨).

وقد عرفه زهران بأنه نوع من العلاج تستخدم فيه أية طريقة نفسية لعلاج مشكلات أو اضطرابات أو أمراض ذات صبغة انفعالية يعاني منها المريض وتؤثر في سلوكه، وفيه يقوم المعالج بالعمل على إزالة الأعراض المرضية الموجودة أو تعديلها، مع مساعدة المريض على حل مشكلاته الخاصة والتوافق مع بيئته واستغلال إمكانياته وتنمية شخصيته ودفعها في طريق النمو الشخصي في المستقبل». (زهران، ١٩٩٨ م، ص ١٨٣).

أما عبد الخالق فقد عرفه بأنه عبارة عن تفاعل منظم بين المعالج والمريض أو العميل، ويعمل على استخدام المبادئ السيكلوجية بطريقة تؤثر على أفكار المريض واتجاهاته ومشاعره وسلوكه، بهدف مساعدته على التغلب على هذا السلوك غير السوي أو توافقه للمشاكل التي يواجهها في حياته (عبد الخالق، ١٩٩٧ م، ص ٥٣٣).

ونستخلص من التعريفات السابقة خصائص وأهداف العلاج النفسي والتي منها ما يلي:

- علاج الاضطرابات أو الأمراض أو المشكلات النفسية والسلوكية ذات الصبغة الانفعالية.

- العمل على تحويل الخبرات السالبة والمؤلمة إلى خبرات إيجابية وغير مؤلمة.
- الكشف عن السلوك المضطرب بهدف تعديله وتغييره، ومن ثم إبراز السلوك الإيجابي وتثبيته.
- تحقيق التوافق الذاتي (النفسي) والاجتماعي للفرد.
- العمل على إتمام الشفاء والحيلولة دون حدوث النكسة. (زهران، ١٩٩٧م، ص ٢٠٠ - ٢٠١).

٢ - أبعاد العلاج النفسي

توجد أبعاد متعددة للعلاج النفسي تتضمن طرقاً علاجية كثيرة من طرق العلاج حيث أن كل بُعد يتضمن عناصر من البُعد الآخر:

أ- العلاج الفردي والعلاج الجماعي Group & Individual Therapy

في العلاج الفردي يعالج فيه المعالج النفسي حالة مرضية فردية معينة في كل مرة، وتكمن فاعلية هذا النوع من العلاج في مدى التقبل للعلاقة المهنية والمباشرة بين المعالج والمريض ويستخدم في علاج المشكلات الخاصة مثل المشكلات والانحرافات الجنسية، بينما العلاج الجماعي يقوم فيه المعالج بعلاج مجموعة من المرضى لهم المشكلة نفسها وتعتمد فاعلية العلاج الجماعي على مدى الاهتمام القائم في العلاقة بين المريض والمعالج من جهة وبين المريض والجماعة من جهة أخرى. (عيسوي، ١٩٨٤م، ص ١١٧ - ١١٨).

وقد أفرد الباحث للعلاج الجماعي مبحث يتناول فيه موضوع العلاج الجماعي وتطوره وخصائصه ونظرياته المفسرة له

وقد أوضح زهران أن العلاقة الجماعية التي يتضمنها العلاج الجماعي تيسر الفرصة أمام كل مريض لخبرة الواقع، وتنمية طرق أكثر كفاءة في العلاقات الاجتماعية، وهو أكثر فاعلية في علاج مشكلات الأسرة والإدمان وأمراض الكلام والجناح (زهران، ١٩٧٧م، ص ٢٢٤).

ب - علاج الأسباب وعلاج الأعراض

يركز علاج الأسباب على أسباب المرض النفسي بالقضاء عليه واجتثاث جذوره، بينما علاج

الأعراض يركز على مساعدة المريض على التخلص والتحرر من الأعراض أو الاضطرابات فقط، دون الاهتمام بالأسباب (زهران، ١٩٩٤م، ص ٢٠٨).

ج - علاج الدعم وعلاج إعادة البناء

يهدف علاج الدعم إلى تدعيم شخصية المريض من خلال العمل على تخفيف الأعراض وحل المشاكل النفسية التي تواجهه عن طريق تغيير ظروفه، أما علاج إعادة البناء فيهدف إلى تعديل شخصية المريض وتغيير طريقة تفكيره واتجاهاته وسلوكياته، ومن ثم إعادة الثقة بنفسه وبناء شخصيته. (المرجع السابق، ص ٢٠٨ - ٢٠٩).

د - العلاج المرن (غير الموجه) والعلاج الملتزم (الموجه)

يقصد بالعلاج المرن الاختيار بين طرق العلاج النفسي المختلفة بطريقة مرنة وانتقاء ما يناسب الحالة المرضية من طريقة علاجية واستخدامها دون التمسك والالتزام بطريقة محدودة، بينما العلاج الملتزم يهدف إلى التقيد بطريقة علاجية محددة وعدم الحياد عنها. (سري، ١٩٩٠م، ص ٩٥ - ٩٦).

هـ - العلاج العميق والعلاج السطحي

يركز العلاج العميق على إظهار واكتشاف الإنفعالات المكبوتة التي يتركز حولها الصراع أو الخبرات المؤلمة لدى المريض واكتشافها، أما العلاج السطحي فهو يهدف إلى بث روح الطمأنينة في المريض وتعزيز دفاعاته دون التعمق في صراعاته. (زهران، ١٩٩٨م، ص ٢٠٩).

فهناك العديد من الطرق العلاجية النفسية المختلفة، والتي تختلف نظراً لاختلاف الأعراض والاضطرابات لكل حالة مرضية، وعادة ما تستخدم معظم هذه الطرق العلاجية في العيادة النفسية، كالتحليل النفسي والعلاج السلوكي والعلاج الجماعي والعلاج الممرکز حول العميل والإرشاد العلاجي والعلاج باللعب (زهران، ١٩٩٨م، ص ٢٠٠).

العلاج المعرفي السلوكي

يعد العلاج المعرفي السلوكي من أشكال العلاج النفسي الحديثة نسبياً، ويركز على كيفية إدراك الفرد للمثيرات المختلفة وتفسيراته لها، وإعطاء المعاني لخبراته المختلفة. ويستدل من اسم هذا النوع من العلاج بأنه محاولة دمج الفنيات المستخدمة في العلاج السلوكي مع الجوانب المعرفية والانفعالية للمريض ضمن السياق الاجتماعي. يذكر «كلارك» و«فايربرن» Clark and Fairburn إن مصطلح العلاج المعرفي السلوكي Cognitive Behavior Therapy ظهر في بداية الثلاث الأخير من هذا القرن (القرن الماضي)، وأصبح في وقت قصير، العلاج النفسي الرئيسي في معظم الدول المتقدمة. (المحارب، ٢٠٠٠، ص ١).

نشأة العلاج المعرفي

أصبح تطور العلاج المعرفي السلوكي عبر أربعة عقود أحد أسرع طرق العلاج نمواً، وأكثرها انتشاراً، ويعد ذلك التطور في أطره النظرية والعلاجية والمفهومية نتيجة لجهود تراكمية ترجع إلى أفكار الفلاسفة اليونان والذين اتفقوا على إمكانية ممارسة تدريبات عقلية للتحكم في انفعالات وضبط النفس. حيث تنبه الفلاسفة اليونان إلى أن إدراك الإنسان للأشياء - وليس الأشياء نفسها - تلعب دوراً هاماً في تحديد نوع استجابته وهي التي تسم سلوكه وتصفه بالاضطراب أو السواء، وفي هذا الصدد يقول الفيلسوف الروماني «إيكتيوس» «لا يضطرب الناس من الأشياء ولكن من الآراء التي يحملونها عنها». (إبراهيم، ١٩٩٤ م، ص ٢٧٣).

حيث أشار العلماء المسلمين للدور الذي يلعبه التفكير في توجيه سلوك الإنسان وفي سعادته وفي شقائه. وقد سبقوا بذلك العلماء المحدثين في إبراز أهمية العوامل المعرفية في توجيه استجابات الفرد للظروف المحيطة به. فقد أوضح ابن القيم قدرة الأفكار - إذا لم يتم تغييرها - على التحول إلى دوافع ثم سلوك حتى تصبح عادة يحتاج التخلص منها إلى جهد أكبر. كما أشار الغزالي إلى أن بلوغ الأخلاق الجميلة يتطلب أولاً تغيير أفكار الفرد عن نفسه ثم القيام بالممارسة العملية للأخلاق المراد اكتسابها حتى تصبح عادة ولم يخلو التراث الإسلامي أيضاً من الإشارات الواضحة لأثر التفكير ليس فقط في توجيه السلوك ولكن أيضاً في الحالة الصحية للناس، ويبدو ذلك جلياً في القول المأثور «لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا». (المحارب، ٢٠٠٠ م، ص ٤).

ويفيد «بيك» «أن العلاج المعرفي يقوم على دعائم فلسفية ليست جديدة، بل موغلة في القدم، وتعود بالتحديد إلى زمن الرواقيين Stoics. حيث اعتبر الفلاسفة الرواقيين أن فكرة الإنسان عن الأحداث، وليست الأحداث ذاتها هي المسئولة عن اعتلال مزاجه. إلى هذا المنطق الرواقي يستند هذا العلاج المعرفي. فالمشكلات النفسية ترجع بالدرجة الأساس إلى أن الفرد يقوم بتحريف الواقع ولي الحقائق بناء على مقدمات مغلوطة وافتراضات خاطئة. وتنشأ هذه الأوهام عن تعلم خاطئ في إحدى مراحل نموه المعرفي». (بيك، ٢٠٠٠م، ص٦)

وتفترض النظرية المعرفية أنه من الممكن إحداث تغييرات انفعالية وسلوكية وجسمية من خلال إحداث تغييرات في أفكار واعتقادات المريض.

وجدير بالذكر أن الاهتمام بالعلاج المعرفي بدأ مع بداية النصف الأخير من القرن الماضي. وإن كان البعض من الرواد قد تزامنوا في تقديم نماذجهم في نفس الفترة.

ويشمل مفهوم العلاج المعرفي مناهج عديدة تتشابه في جوهرها وتختلف في فنيات تطبيقها. وعلى الرغم من أن هناك أكثر من عشرين نوعاً منها ولكن أشهرها : منهج «بيك» في العلاج المعرفي، ومنهج «البرت أليس» في العلاج العقلاني الانفعالي، وتأتي بعد ذلك مناهج أخرى أقل شهرة مثل منهج «ميكنبوم» في تعديل السلوك المعرفي، ومنهج «ويسلر وهانكين» Cognitive Appraisal Therapy العلاج التقويمي المعرفي الذي حاول فيه الجمع بين العلاج العقلاني الانفعالي ومكتشفات التعلم الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي المعرفي، ومنهج «كيلى» للتصورات الشخصية، ومنهج «البرت باندورا» في التعليم الاجتماعي، ومنهج «لازاروس» Modal Therapy - Multi في العلاج متعدد النماذج، ومنهج «ماهوني» Cognitive Learning Therapy في علاج التعلم المعرفي، وأسلوب حل المشكلات لـ «قولد فرايد» و «قولد فرايد».

وكان لـ «بيك» السبق فيها بعد أن نشر مقالا عام ١٩٥٢م حول تطبيق العلاج المعرفي على حالة فصام مزمن، أشار فيه إلى أنه قام بإضفاء صبغة مقبولة وطبيعية على هذات ثم طلب منه القيام بفحص منظم لمعرفة دقتها، وقد لاحظ بشيء من الدهشة أن هذات المريض بدأت تختفي بالتدريج.

ثم قدم «كلى» Kelly عام ١٩٥٥م أفكاره حول التصورات الشخصية Psychology of personal constructs. وكان له كبير الأثر على بداية العلاج النفسي المعرفي، لأنه ركز على أهمية

الطرق الذاتية التي ينظر ويفسر من خلالها الفرد لما يدور حوله في تغيير السلوك. حيث يرى في نظريته، نظرية التصورات الشخصية personal construct theory أن الشخص يقوم بصياغة تصورات (توقعات) حول ما يجري من حوله، ثم يتفحص هذه التصورات، وبناء على النتائج التي يتوصل إليها يقوم بتصحيح أو تعديل هذه التصورات، أي أنه يقوم بإعطاء معاني للظواهر لكي يستطيع فيما بعد توقع ما قد يحدث ويحاول التحكم به (الجوهي، ٢٠٠٤، ص ٢٣).

وبذلك يرى «كلي» أن الطريقة التي ينظر بها الناس للعالم من حولهم قد تخلق لهم الاضطرابات النفسية. حيث أن لدى كل فرد مجموعة من التصورات الأساسية التي يكون من خلالها هوية لنفسه واضطراره للابتعاد عن هذه الهوية في سبيل استيعاب خبرات جديدة قد يؤدي إلى شعوره بالذنب، وقد يشعر الفرد بالقلق في حالة عدم قدرته على التوقع بما سيؤول إليه موقف معين وعدم استطاعته بالتالي على القيام بسلوكيات ملائمة.

وقد تظهر المشكلات النفسية عندما يعجز النظام التصوري Construct system لدى الفرد في توقع الحوادث أو احتوائها ضمن الخبرات السابقة بطريقة تكفل القيام بسلوك منظم، الأمر الذي يؤدي إلى أحداث تشويه في النظام التصوري للفرد وهذا بدوره يقود إلى التوتر. ومع كل ذلك لم تلق نظرية «كلي» قبولاً كبيراً من قبل المشتغلين بالعلوم المعرفية لصعوبة فهمها، ولكثرة تفاصيلها مع قلة المنشور حولها من كتب ودراسات.

وتزامن في نفس هذه الفترة ظهور العلاج العقلاني الانفعالي لـ «ألبرت آليس» Albert Ellis قبل التطورات الأساسية في علم النفس المعرفي وكانت نظرية علاج الاكتئاب لـ «بيك» في مراحلها الأولى. حيث كان «آليس» بصدد التخلي عن التحليل النفسي وتطوير نظرية معرفية سلوكية خاصة به. وفي الوقت الذي كان فيه «بيك» Beck يتعد بالتدريج عن التحليل النفسي ويبني نظريته في العلاج المعرفي خطوة بخطوة. كما كان «كلي» Kelly أيضاً يبلور أفكاره حول دور الجوانب المعرفية في تكيف الإنسان مع بيئته. يقول «آليس» بهذا الخصوص تزامنه مع بيك وبصورة مستقلة عما قمت به، بدأ أيضاً معالج تحليل نفسي آخر من فيلادلفيا (يقصد بيك) بالتخلي عن الفنيات التحليلية وتطوير نوع من العلاج المعرفي (Ellis, 1996, pp173)

وقد توصل «آليس» في يناير ١٩٥٥م إلى ما أسماه العلاج العقلاني Rational Therapy وغير اسمه لاحقاً في عام ١٩٦١م إلى العلاج العقلاني الانفعالي Rational Emotive Therapy. ويرجع «آليس» نشوء الأمراض النفسية إلى ما تم تعلمه من الأفكار غير العقلانية من الناس المهمين خلال فترة الطفولة بالإضافة إلى ما يبتدعه الأطفال أنفسهم من اعتقادات غير منطقية وخرافات. وبعد ذلك يقوم الناس بإعادة تنشيط هذه الاعتقادات غير الفعالة من خلال الإيحاء الذاتي والتكرار. وتنتج معظم الانفعالات من التفكير ويشكل اللوم (blame) للنفس وللآخرين حجر الأساس في معظم الاضطرابات الانفعالية.

وهكذا فإن التطبيقات الإكلينيكية للمنظور المعرفي Cognitive perspective بصورة عامة سبقت النظرية والبحوث المنهجية formal المرتبطة بعلم النفس المعرفي.

خصائص العلاج المعرفي السلوكي

يعتبر العلاج المعرفي السلوكي الطريقة الأمثل للعلاج النفسي. وذلك لأسباب عدة من أهمها : مرجعيته العلمية، وفعاليته العلاجية، واختصاره للوقت والجهد. ولقد تقبلته كل الأوساط المعنية بالصحة النفسية خصوصاً إلى درجه جعلته مرادفاً لأسماء مثل العلاج النفسي، والإرشاد النفسي، لأنه يمثلها أفضل تمثيل. ولقد امتد تأثيره إلى درجة جعلته الطريقة العلاجية الأكثر طلباً في البرامج التعليمية والمهنية مثل علم النفس العيادي، والطب النفسي، والإرشاد النفسي، والتمريض، وغيرها من المجالات المهنية التي تعنى بتدريب الأفراد ليكونوا مؤهلين لتقديم الخدمة الصحية النفسية

فقد اعترفت الجمعية النفسية الأمريكية بأن العلاجات المعرفية السلوكية «علاجات ذات أساس إمبريقي»، مدعومة بالدراسات العلمية، وفعالة في علاج الاضطرابات النفسية. (العنزي، ٢٠٠٧م، ص ٢٥-٢٦)

فالنظرية المعرفية تعتمد في تناولها للأمراض النفسية على تفسير الكيفية التي تتم من خلالها معالجة المعلومات. وتفترض هذه النظرية أن الاضطرابات لدى الفرد ناتجة عن وجود أخطاء في معالجة المعلومات لديه، مما يترتب عليها وجود أبنية معرفية (مخططات) كامنة عاجزة عن

التكيف تسيطر على المريض . بناء على ما ينتج عنها من أفكار تلقائية تصاحب الاضطراب وتساعد على استمراره

ونظراً للتطورات السريعة التي تحدث في العلوم المعرفية بصورة عامة وفي نظرية العلاج المعرفي بصورة خاصة. فقد تم تحديد مبادئ خاصة بالعلاج المعرفي السلوكي الذي يمارس ضمن حدود مسلمات النظرية المعرفية

١ - يعتمد العلاج المعرفي السلوكي على صياغة مشكلة المريض وتنقيحها بصورة مستمرة ضمن الإطار المعرفي ويعتمد المعالج في صياغة مشكلة المريض على عوامل متعددة مثل تحديد الأفكار الحالية للمريض (أنا فاشل لا أستطيع عمل أي شيء كما ينبغي)، الأفكار التي تساهم في استمرار الوضع الانفعالي للمريض والتعرف على السلوكيات غير المرغوب فيها. ثم التعرف على العوامل المرسبة التي أثرت على أفكار المريض عند ظهور المرض مثل (حادثة مخزنة، تغير شيء مألوف) وبعد ذلك التعرف على الأسلوب المعرفي الذي يفسر من خلاله المريض الحوادث التي يتعرض لها مثلاً (عزو النجاح للحظ ولوم النفس على الفشل). ثم يقوم المعالج بصياغة المشكلة في الجلسات الأولى ولكنه يستمر في إجراء تعديلات عليها كلما حصل على معلومات جديدة.

٢ - يتطلب العلاج المعرفي السلوكي وجود علاقة علاجية جيدة بين المعالج والمريض تجعل المريض يثق في المعالج ويتطلب ذلك قدرة المعالج على التعاطف والاهتمام بالمريض وكذلك على الاحترام الصادق وحسن الاستماع.

٣ - يشدد العلاج المعرفي السلوكي على أهمية التعاون والمشاركة النشطة. العمل كفريق يشترك في وضع جداول عمل للجلسات وفي إعداد الواجبات المنزلية التي يقوم بها المريض بين الجلسات.

٤ - يسعى المعالج إلى تحديد أهداف معينة، يسعى لتحقيقها وحل مشكلات محددة.

٥ - يركز العلاج المعرفي السلوكي على الحاضر. حيث يتم التركيز على المشكلات الحالية وعلى مواقف معينة تثير القلق لدى المريض. ومع ذلك فقد يتطلب الأمر الرجوع إلى الماضي في حالة:

أ- رغبة المريض الشديدة في القيام بذلك

ب- عدم حدوث تغير يذكر في الجوانب المعرفية والسلوكية والانفعالية

ج- عندما يشعر المعالج بأن هناك حاجة لفهم الكيفية التي تطورت بها الأفكار غير الفعالة لدى المريض.

٦- العلاج المعرفي السلوكي علاج تعليمي، يهدف إلى جعل المريض معالجاً لنفسه كما أنه يهتم كثيراً بتزويد المريض بالمهارات اللازمة لمنع عودة المرض بعد التحسن (الانتكاس).

٧- لعلاج المعرفي السلوكي علاج مكثف قصير المدى. يتم علاج معظم الحالات في مدة تتراوح ما بين ٤ - ١٢ جلسة وقد يستمر إلى فترة أطول من ذلك.

٨- تتم الجلسات في العلاج المعرفي السلوكي وفق جدول عمل محدد يحاول المعالج تنفيذه، للتعرف على الوضع الانفعالي للمريض؛ ويطلب من المريض تقديم ملخص لما حدث خلال الأسبوع الماضي؛ إعداد جدول أعمال الجلسة (بالتعاون مع المريض)؛ التعرف على رد فعل المريض حول الجلسة السابقة؛ مراجعة الواجبات المنزلية؛ تقديم ملخصات لما تم في الجلسة بين الحين والآخر؛ ثم أخذ رأي المريض فيما تم في نهاية الجلسة.

٩- يعلّم العلاج المعرفي السلوكي المريض كيف يتعرف على الأفكار والاعتقادات غير الفعالة وكيف يقومها ويستجيب لها.

١٠- يستخدم العلاج المعرفي السلوكي فنيات متعددة لإحداث تغييرات في التفكير، المزاج، والسلوك. يستخدم في العلاج المعرفي السلوكي بالإضافة إلى الفنيات المعرفية الأساسية مثل الأسئلة الجدلية (السقراطية) والفنيات السلوكية.

١١- يؤكد العلاج المعرفي السلوكي على أن يكون المعالج صريحاً مع المريض ويناقش معه وجهة نظره (المعالج) حول المشكلة (الصياغة) ويعترف بأخطائه ويسمح للمريض بمعارضته. وعدم القيام بذلك يتعارض مع الطبيعة التعاونية بين المعالج والمريض التي يركز عليها العلاج المعرفي السلوكي.

١٢ - يركز المعالج المعرفي السلوكي بصورة عامة على التعامل مع أعراض الاضطراب النفسي الذي يعاني منه المريض أكثر من تركيزه على العوامل التي تعزي إليها هذه الأعراض (المحارب، ٢٠٠٠م، ص ٣٨ - ٣٩).

تطور العلاج المعرفي السلوكي

يعتبر العلاج المعرفي السلوكي اتجاهاً علاجياً حديثاً نسبياً. يعمل على الدمج بين العلاج المعرفي بفنياته المتعددة والعلاج السلوكي بما يضمنه من فنيات، كما يعتمد إلى التعامل مع الاضطرابات المختلفة من منظور ثلاثي الأبعاد. إذ يتعامل معها معرفياً وانفعالياً وسلوكياً، مستخدماً العديد من الفنيات السلوكية.

ولم يكن العلاج المعرفي معرفياً بحتاً منذ بدايته، سواء على المستوى النظري، أو على المستوى التطبيقي. فعلى المستوى النظري يتم التعامل مع الأفكار بقصد تغييرها، حتى يتسنى حدوث تغييرات سلوكية مرغوبة. وعلى المستوى التطبيقي لم يتوقف «بيك» عند استخدام الفنيات المعرفية فقط في العلاج بل استخدم إلى جانبها فنيات سلوكية، وهذا ما أكدته بنفسه في كتابه الذي نشره عام ١٩٧٩م العلاج المعرفي للإكتئاب. ومن هنا بدأت تبرز معالم العلاج المعرفي السلوكي. ويعتمد الإطار النظري للعلاج المعرفي السلوكي على تلك الأساليب التي قدمها كل من «دونالد ميكنوم» D.Meichenbaum و«ألبرت آليس» A.Ellis و«أرون بيك» A.Beck و«فيكتور رايمي» V.Raimy.

وقد أصدر «بيك» كتاباً في عام ١٩٧٠ بعنوان العلاج المعرفي: طبيعته وعلاقته بالعلاج السلوكي Cognitive Therapy : Nature and relation to Behavior Therapy أوضح فيه كيفية تغيير المعارف والأفكار من خلال نماذج إشرطية، وهو ما يعتبر بمثابة إستراتيجيات سلوكية. ويعد النموذج الذي قدمه «بيك» من أبرز النماذج العلاجية في هذا الاتجاه وأكثرها شيوعاً، ففي الوقت الذي يركز فيه على معارف واعتقادات الفرد في الـ هنا - والآن here and now كسبب في اضطراب الشخصية، فإنه يستعين أيضاً ببعض الفنيات السلوكية لتعليم الفرد

المهارات التي يجب أن تتغير بتغير معارفه ومدركاته عن ذاته وعن العالم والمستقبل. ويرى بيك أن الشخصية تتكون من مخططات معرفية Schemas تشتمل على المعلومات والاعتقادات والمفاهيم والافتراضات والصيغ الأساسية لدى الفرد والتي يكتسبها خلال مراحل النمو. ويرى أن الناس تنفعل بالأحداث وفقاً لمعانيها لديهم. ويهتم بيك بالأفكار التلقائية السلبية التي تظهر وكأنها منعسات آلية وتبدو من وجهة المريض بأنها معقولة جداً. ويذهب بيك إلى أن الأفكار الأوتوماتيكية تؤدي إلى التشويه المعرفي الذي يعد نتيجة لها، ومن أمثلة التمثيل الشخصي Personalization أي تفسير الأحداث من وجهة النظر الشخصية للمريض، والتفكير المستقطب Polarized أي المتمركز عند أحد طرفين متناقضين إما أبيض أو أسود، والاستنتاج التعسفي أي الاستدلال اللامنطقي، والمبالغة في التعميم أي تعميم نتيجة معينة على كل المواقف على أساس حدث منفرد، والتضخيم والتجسيم، والعجز المعرفي. وإذا كان العلاج وفقاً لهذا النموذج يهدف إلى التعامل مع التفكير اللامنطقي الخاطيء والتشويهاات المعرفية، والتعامل مع المشكلات المختلفة والسعي إلى تخفيضها، فإنه يعتمد على عدة أسس أو مبادئ هي المشاركة العلاجية، وتوطيد المصادقية مع المريض، وتقليل أو اختزال المشكلة reduction أي تقسيمها إلى وحدات يسهل تناولها، ومعرفة كيفية العلاج وذلك باستخدام فنيات عديدة بعضها معرفي مثل المناقشة، والمراقبة الذاتية، والتباعد الذي يجعل تفكير المريض وتقييمه للواقع موضوعياً، وإعادة التقييم المعرفي، والعلاج البديلي (مناقشة الأسباب). وبعضها تجريبي إمبريقي كالاستكشاف الموجه، والتعريض، وبعضها الآخر سلوكي كالواجبات المنزلية، والإقضاء، والتخيل، ولعب الدور. ويرى «بيك» أن التكنيكات السلوكية ذات فاعلية لأنها تؤدي إلى تغييرات اتجاهية ومعرفية لدى الحالات المريضة.

وخلال عقد السبعينيات تزايد الاهتمام بهذا الاتجاه العلاجي، وتزامن ذلك مع نموذج «دونالد ميكنبوم» D.Meichenbaum الذي طرحه عام ١٩٧٧م تحت مسمى تعديل السلوك المعرفي Cognitive behavior modification المنبثقة من نفس المنهج الذي يستخدمه «بيك» مع التركيز على الحوار الداخلي Internal dialogue وتوجيه الذات Self instructions. وفي

الوقت الذي يضمن فيه العاملين في العلوم النفسية ما لإسهامات «ميكنبوم» الإيجابية في تطوير العلاج المعرفي السلوكي تشير الكثير من الدراسات في هذا المجال إلى فعالية برامج المعرفة السلوكية الخاصة بالتدريب التحصيني ضد الضغوط النفسية Stress Inoculation Training وبينما كانت عدم قناعة كل من «بيك» و «آليس» بالعلاج النفسي التحليلي أحد الدوافع التي أدت بهما إلى تطوير العلاج المعرفي السلوكي، كان عدم رضا «ميكنبوم» بصورة عامة عن المناهج التي تستخدمها المدرسة السلوكية من الأمور التي ساهمت في ظهور التدريب ضد الضغوط النفسية. ويشبه أسلوب «ميكنبوم» الأساليب المعرفية السلوكية الأخرى إلى درجة كبيرة حيث يقابل الحوادث المعرفية (أفكار وخيالات) Cognitive events عند «ميكنبوم» الأفكار التلقائية Automatic thoughts عند «بيك» وهذه الظاهرة أهمية كبيرة عند كليهما وعند بقية المشتغلين بالعلاج المعرفي السلوكي كما أن «ميكنبوم» يعتمد في نظريته على الكثير من المصطلحات التي تستخدم في العلاج المعرفي لـ «بيك» مثل المخطط المعرفي والتحيز في معالجة المعلومات والوعي بالتفكير Metacognition وتحديد الأفكار التلقائية والتعامل معها.

ويرى «باترسون» Patterson أن ما فعله كل من «ميكنبوم» و «رايمي» يعد بمثابة محاولة لم تكتمل في سبيل الوصول إلى نظرية علاجية، ولكنهما مع ذلك قد قطعاً شوطاً كبيراً باتجاه النظرية المعرفية السلوكية في العلاج. إلا أن «باترسون» Patterson يرى في نقده لنظرية «ميكنبوم» أنها مجرد بداية ناجحة لمحاولة لم تكتمل بعد في المستوى التنظيري والمستوى التطبيقي، ولكنه مع ذلك انتقل خطوة للأمام من ذلك الموقف الذي تتبناه مدرسة العلاج السلوكي في تفسيرها للسلوك وفي علاجها لهذا السلوك. (محمد، ٢٠٠٠م، ص ٢٤).

كما يرى «كوري» أن «آليس» يعتبر من رواد العلاج المعرفي السلوكي وهناك من يعتبر أن نظريته «العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي» النظرية الأولى في العلاج المعرفي السلوكي وأن النظريات الأخرى في هذا المجال بما في ذلك نظرية العلاج المعرفي لـ «بيك» ونظرية التعديل المعرفي للسلوك لـ «ميكنبوم» ليست سوى نظريات معدلة من نظرية «آليس» أو حتى مجرد امتداد لها (Corey, 1991, pp234).

وقد عمل «آليس» Ellis أيضاً على الدمج بين الاتجاهين المعرفي والسلوكي بشكل واضح لا لبس فيه، وهو الأمر الذي دفعه إلى إضافة مصطلح « السلوكي » إلى مسمى أسلوبه العلاجي في عام ١٩٩٣ م، ليصبح العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي. حيث يرى أن أسس وقواعد العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي، لا تختلف في جوهرها عن تلك التي وضعها منذ البداية لذلك الاتجاه العلاجي.

لذلك فقد تم ابتكار عدد من الفنيات العلاجية القوية والانفعالية إلى جانب أساليب أخرى تعتمد على القوة والحماس، وأساليب معرفية وأخرى سلوكية يتم استخدامها خلال هذا الأسلوب العلاجي مثل جمل المواجهة العقلانية والتي يمكن تعليمها للفرد أو تسجيلها على شريط كاسيت بحيث يرددها الفرد ويواجه بها أفكاره اللاعقلانية، وهو ما يسهم في تحقيق الأثر المعرفي، وتدوين العيوب أو المساوئ التي قد يلاحظها الفرد في سلوكياته أو عاداته التي يعتبرها سيئة، إلى جانب ترديد تلك العيوب عدة مرات يومياً، وإقتداء السلوكيات الجيدة، وصرف أو تشتيت الانتباه والتي يمكن لنا أن نستخدم خلالها التغذية الراجعة الحيوية، والاسترخاء، وتفنيد الاعتقادات الخاطئة، والواجبات المنزلية، وإعادة التشكيل والذي يرى أن المواقف أو الأشياء التي يراها الفرد على أنها مزعجة تتضمن بالقطع نقاطاً إيجابية وهو ما يجب أن نضعه في اعتبارنا، وأن ننظر للشيء من هذا المنظور، وإلى جانب ذلك يتم استخدام فنيات معرفية كالتدريب على مواجهة الخجل، والتخيل العقلاني الانفعالي الذي يتم من خلاله تغيير المشاعر السلبية غير الصحية إلى مشاعر سلبية صحية. كما يستخدم الحوار الذاتي Self - dialogue الذي يقوم بالاستماع إليه باستمرار ويدع الآخرين يستمعون إليه أيضاً، ويحدد ما إذا كان ذلك الجانب الذي يخبر فيه الكثيرون مشكلات متعددة فيتناول هذا الأسلوب تلك المشكلات، ويعمل على تعليم المرضى كيف يقيمون علاقات طيبة مع الآخرين. ويعتمد أيضاً في هذا الإطار على فنية لعب الدور وذلك بأن يجعل أحد أصدقاء المريض يلعب دوره ويقوم هو أي المريض بتفنيد الاعتقادات، وإلى جانب ذلك يتم لعب الدور العكسي بين المعالج والمريض. أما الفنيات السلوكية التي يتم اللجوء إليها في العلاج فتتضمن فقد الحساسية المنظم، والتعريض ومنع

الاستجابة، والتعزيز خاصة عندما يقوم المريض بأداء الواجبات المنزلية التي يكون مطلوباً منه أن يؤديها. كما يتم أيضاً التدريب على المهارات سواء في مجال الأسرة أو العمل أو المدرسة أو النسق الاجتماعي، والتدريب على حل المشكلات. (محمد، ٢٠٠٠م، ص ٣٤)

ويتضح توجه «آليس» السلوكي في نمودجه، من خلال استخدامه بعض الفنيات السلوكية لتدعيم الطرق العقلانية الانفعالية. مثل استخدام: ١ - الإزالة الحية للحساسية In vivo Desensitization. ٢ - البقاء في المواقف الصعبة Staying in Difficult situation. ٣ - استخدام الطرق التدعيمية Using reinforcement methods. ٤ - استخدام الأساليب العقابية والجزائية Using punishment and penalties وهي في الغالب عبارة عن عقاب ذاتي يتفق عليه كل من المريض والمعالج؛ كأن يقوم المريض بعمل شيء لا يرتاح له في حالة عدم توقفه عن السلوكيات التي يرغب في التخلص منها.. (المحارب، ٢٠٠٠م، ص ٢٠).

وبالإضافة إلى مساهمات كل من «كلي» و «بيك» و «آليس» و «ميكنيوم» في تطور العلاج المعرفي السلوكي كانت هناك أيضاً أعمال أدت بشكل أو بآخر إلى الإسراع بتطور هذا النوع من العلاج. ومن ذلك على سبيل المثال «ارنولد» ١٩٦٠ Arnold و «لازاروس» ١٩٦٦ Lazarrus في التأكيد على أهمية العمليات المعرفية في تغيير الانفعالات والسلوك ودور «آلبرت باندورا» ١٩٧٧ Bandura من خلال نظريته عن التعلم الاجتماعي Social learning theory في إبراز أهمية العمليات المعرفية في تطور السلوكيات الجديدة وكذلك إسهامات «مايكل ماهوني» M.Mahoney و «مارفين» «جولد فرايد» M.Goldfried و «فيكتور رايمي» V.Raimy (Blackburn, 1996, pp2) Blackburn & Twaddle, 1996. p.2.

ويرى «ماهوني» ١٩٨٨ Mahoney أنه منذ نهاية عقد الثمانينيات كاد الأمر يقتصر على وجود نموذجين فقط يضمهما هذا المنحى العلاجي وهما: نموذج «بيك» Beck ونموذج «آليس» Ellis وقد عمل كلاهما على الدمج بين العلاج المعرفي والسلوكي بشكل واضح لا لبس فيه (محمد، ٢٠٠٠م، ص ١٨).

تعتبر أعمال بيك هي الرائدة في تطور العلاج المعرفي السلوكي قياساً على مساهمات المنظرين الآخرين وتعتبر نظريته، النظرية الأكثر جذباً لاهتمام الباحثين والمهتمين بالعلاج المعرفي السلوكي. ويرجع ذلك لمحاولاته ربط نظريته بما يستجد من دراسات في علم النفس المعرفي والعلوم الأخرى ذات العلاقة أكثر مما فعله «آليس» وقد بدا ذلك بشكل أكبر في ما كتبه «بيك» حول الاضطرابات النفسية المتنوعة.

وفي هذا الصدد يتناول محمد (١٩٩٢م) أهم التطورات الحديثة لنموذج «بيك» في العلاج المعرفي السلوكي بالقول «وقد شهدت فترة الثمانينيات وخصوصاً الجزء الأخير منها تطبيقات جديدة وموسعة لهذا النموذج على مدى كبير من الاضطرابات بدءاً من العمل مع كبار السن وحتى العمل مع مشكلات الأطفال وهو ما لم يكن موجوداً من قبل. كما اتسع المجال أيضاً ليشمل التعامل مع العزلة الاجتماعية والانحرافات الجنسية، ووجدت مرونة كبيرة في استخدام إستراتيجيات العلاج السلوكي، كما بدأ الاهتمام يتزايد بعد ذلك بالعلاج المعرفي السلوكي الجماعي. وشهد عام ١٩٨٩م تطوراً جديداً حيث اتخذ العلاج منحى آخر، وبدأت التطبيقات الإمبريقية على عينات من مرضى، كان من الصعب فيما مضى معالجتها بالعلاج السلوكي المعرفي. وظهر كتاب العلاج المعرفي السلوكي لمرضى الفصام الذي أعده «كارلو بيريز» Carlo Perris ورأى فيه أنه من الضروري أن يسير العلاج المعرفي السلوكي لأعضاء هذه الفئة جنباً إلى جنب مع العلاج بالعقاقير. وفي نفس الوقت اتسع مجال استخدام العلاج المعرفي السلوكي ليشمل العديد من الاضطرابات التي لم يتطرق إليها من قبل، فتناول اضطرابات الطعام، وإدمان الهيروين والكحوليات، والهلع، الاكتئاب الحاد، والإعاقات الذهنية. وفي هذه الإطار وجد «بير سونز» وآخرون (١٩٨٨م) Persons et.al وذلك على النقيض من الاعتقاد السائد آنذاك أن هذا الأسلوب العلاجي له فاعليته في التعامل مع المرضى ذوي المستويات المختلفة من التعليم والدخل والخلفية الاجتماعية والثقافية، وحتى غير المتعلمين، أو ذوي التعليم الأقل من المتوسط. وجدير بالذكر أن مثل هذه الفئات كانت من الفئات التي ساد الاعتقاد من قبل بعدم جدوى هذا الأسلوب العلاجي معها (النشواتي، ١٩٩٢م، ص ٧٩).

وشهدت بداية التسعينيات إضافتين نظريتين هامتين قدمهما «بيك» Beck تتمثل الأولى في بحثه عن متغيرات الشخصية الاكتئابية، بينما تتمثل الثانية في إعادة صياغة نظريته عن الاكتئاب في ضوء ذلك. وتعود مساهمته الأولى إلى الاهتمام بأعمال «بولبي» Bowlby عن التعلق وما يقابله من إحساس بالضياع، وهو ما دفع بيك وزملاءه إلى إجراء بحث عن الشخصية وما يجعلها عرضة للاكتئاب.

ومن التطورات الهامة التي شهدتها ميدان العلاج المعرفي السلوكي خلال التسعينيات الاهتمام الزائد باضطرابات الشخصية وتطبيقاتها الإكلينيكية. وقد استلزم ذلك حدوث تغيرات في كيفية استخدام هذا الأسلوب العلاجي في هذا المجال حيث يوجد العديد من المؤثرات التي كشفت عنها نتائج الدراسات المختلفة والتي تؤثر في الشخصية وهي الجانب المعرفي، والخصائص النمائية، والجانب الانفعالي، وكذلك العلاقة العلاجية بين المعالج والمريض والتي تلعب دوراً حيوياً في العلاج. وإلى جانب ذلك امتدت تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي لتشمل مجموعة من الاضطرابات كالغضب والقلق، والاضطرابات النفس اجتماعية، والمشكلات الزوجية، واضطرابات الأكل، والإدمان، وإساءة استخدام المواد، والعديد من مشكلات الأطفال، والتخلف العقلي، والاضطرابات الذهانية. وقد تضمن العلاج خليطاً من التكنيكات المعرفية والسلوكية. ويرى «روزن» Rosen أن عدد الدراسات الإمبريقية التي أكدت فاعلية هذا الأسلوب العلاجي في علاج الاضطرابات المختلفة قد تزايد بشكل كبير

ويرى «بيك» Beck ١٩٩٣ أن من التطورات الجديدة في تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي تناوله لاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) Post - traumatic Stress disorder كحالات الاغتصاب على سبيل المثال، إلى جانب اضطرابات أخرى كتعدد الشخصيات، والغيرة، والمخاوف الاجتماعية، والأرق. كما تتمثل إحدى التطورات الهامة في تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي من وجهة نظر «بيك» في صياغة نموذج معرفي معين لكل اضطراب من تلك الاضطرابات التي تم تناولها حديثاً.

وقد أكدت الدراسات التي أجريت في هذا الإطار تلك النتيجة حيث كشفت دراسات عديدة كدراسات «لارسين» (١٩٩٠) Larsen و«بتلر» وآخرين (١٩٩١) Butler et.al و«ثاكوراي» وآخرين (١٩٩٣) Thackwray et.al و«كوتي» وآخرين (١٩٩٤) Cote et.al و«سترافينسكي» وآخرين (١٩٩٤) Stravynski et.al و«شادويك» و«لاو» (١٩٩٤) و«جرانت» و«روزن» وآخرين (١٩٩٥) Rosen et.al و«كاش» و«جرايتش» و«رايتش» وآخرين (١٩٩٧) Raich et.al و«سترومر» (١٩٩٨) Cash & Grant و«اجونر» (١٩٩٨) Waggoner على سبيل المثال أن العلاج المعرفي السلوكي يعد أقل الأساليب العلاجية في نسبة حدوث انتكاسة، وأن أثره يمتد فترة طويلة بعد انتهاء العلاج (محمد، ٢٠٠٠م، ص ٩٩-١٠٦).

وإجمالاً يمكن القول أن العلاج المعرفي السلوكي يشابه العلاج المعرفي في تأكيده على التحليل الوظيفي للإدمان وتحديد المثيرات المرتبطة به. ولكنه يختلف في مجموعة نقاط هي:

١ - تأكيد العلاج المعرفي على تحديد وفهم وتغيير الاعتقادات حول الذات وعلاقة الذات بالمخدر. بينما العلاج المعرفي السلوكي يكون التركيز فيه على تعلم وممارسة أنواع متعددة من المهارات للتأقلم أو التعايش coping with والتي قد يكون بها جانباً معرفياً. مثل التركيز على الاستراتيجيات الأولية لمواجهة الضغوط (تجنب أو ترك الموقف) بدلاً من التفكير في كيفية الوصول لمخرج من الموقف.

٢ - العلاج المعرفي يتم التركيز على الإدراك وهي طريقة سقراطية وقائمة على قيادة المريض من خلال سلسلة من الأسئلة. بينما في العلاج المعرفي السلوكي يتم التركيز على الطريقة التعليمية.

٣ - العلاج المعرفي ينحى إلى تقليل التعاطي بواسطة تغيير طريقة تفكير المريض. بينما العلاج المعرفي السلوكي يعمل العلاج على تغيير نمط تفكير المريض وأفعاله.

فعالية العلاج المعرفي السلوكي

يتميز العلاج المعرفي السلوكي بميزة التحصين والوقاية من الاضطراب النفسي وكذلك منع حدوث الانتكاس.

أولاً : سهولة الإجراء

يتميز العلاج المعرفي السلوكي بأنه يستخدم فنيات محددة وسهلة الإجراء ضمن خطة علاجية واضحة ومحددة. في وقت محدد بزمان وعدد من الجلسات.

ثانياً : الوقاية من تطور المشكلات الاجتماعية والنفسية

تقول الحكمة درهم وقاية خير من قنطار علاج ويؤيد ذلك «البرت آليس» بالقول «أن الحل الناجع للاضطرابات النفسية يكمن في الوقاية منها. والعلاج المعرفي السلوكي ملائم أكثر من غيره من أنواع العلاج النفسي للبرامج الوقائية التي من الممكن تقديمها في المنازل، المدارس، أماكن العمل ومن خلال وسائل الإعلام للأطفال وللمراهقين ولل كبار بهدف تعليم الناس أساسيات العلاج المعرفي السلوكي وبالتالي جعلهم أكثر قدرة على مجابهة صعوبات الحياة وأقل عرضة للاضطرابات النفسية» (Ellis,1996.pp76).

كما يرى بعض الباحثين أنه من الممكن استخدام العلاج الاستعرافي السلوكي مع الأفراد الأكثر عرضة للاكتئاب لمنع ظهور هذا الاضطراب لديهم (Hollon,1993)، وهناك ما يشير إلى قدرة العلاج الاستعرافي السلوكي على القيام بهذا الدور الوقائي مع العديد من الاضطرابات النفسية. عن (المحارب، ٢٠٠٠م، ص.٧٥).

ثالثاً : منع الانتكاس

ضمن أهداف العلاج المعرفي السلوكي يتم تدريب المريض على التعامل مع ما قد يستجد من أفكار في المستقبل مما يجعله قادراً على التعامل مع هذه الأفكار التي قد تنشأ لديه مستقبلاً

نتيجة لعوامل داخلية أو خارجية، وفي هذا يقول «آليس» العلاج المعرفي يحدث تغييرات معرفية، انفعالية وسلوكية تجعل الفرد أقل اضطراباً في الوقت الحاضر وأقل قابلية للاضطراب في المستقبل. وتشير نتائج الدراسات حول فعالية العلاج المعرفي وبالذات مع الاكتئاب إلى أن أثر هذا النوع من العلاج، مقارنة بالعلاج الدوائي وأنواع العلاج النفسي الأخرى، يمتد إلى شهور أو سنوات بعد تحسن حالة المريض.

وبالإضافة إلى تميز العلاج المعرفي السلوكي بمنع أو تأجيل الانتكاس لدى مرضى الاكتئاب تشير دراسة على عدد من البحوث في القلق العام واضطرابات الفزع والخوف الاجتماعي. كما أن قدرة العلاج المعرفي السلوكي على منع الانتكاس بالنسبة للاكتئاب تنطبق أيضاً على اضطرابات القلق العام والفزع والخوف الاجتماعي ومن الممكن عزو هذا التميز للعلاج المعرفي السلوكي مقارنة بأنواع العلاج الأخرى.

وعلى الرغم من استخدامه المحدود في العالم العربي، يرى الجليبي واليحيى بأن العلاج المعرفي السلوكي هو العلاج الأنسب للتعامل مع المشكلات النفسية في المجتمع العربي من خلال قولهم «إن تميز العلاج المعرفي يجعله من أكثر أساليب العلاج النفسية ملائمة لمجتمعنا وطبيعة المريض عندنا» (الجليبي، ١٩٩٦م، ص ٢٧٢).

العلاج المعرفي السلوكي و تنمية الدافعية

بما أن العلاج السلوكي المعرفي أسلوباً من أساليب العلاج النفسي الذي يحاول أن يقلل من القيام بردود الأفعال الانفعالية والسلوك الهادم للذات والإحباط، عن طريق تعديل التفكير الخاطئ والمشوه والاعتقادات غير التكيفية التي حدثت نتيجة تلك الاستجابات الانفعالية.

وينطبق ذلك على تنمية الدافعية للعلاج لمدمني المخدرات . فالمدخل المعرفي يساعد الأفراد على زيادة مدركاتهم إزاء واقعهم الإدماني من ناحية اللذة أو إزالة الشعور بالانزعاج. بالإضافة إلى الاستراتيجيات المعرفية الخاصة التي تساعد على تقليل رغباتهم وفي نفس الوقت تبني نظاماً قوياً من التحكم الذاتي الداخلي. وأكثر من ذلك فإن العلاج المعرفي يساعد المرضى على التكيف

الصحي مع اكتئابهم وقلقهم أو غضبهم الذي غالبا ما يقودهم إلى السلوك الإدماني.

بالإضافة إلى أن العلاج المعرفي السلوكي للإدمان يساعد المريض من خلال طريقتين:

١ - تضعف شدة المؤثرات التي تنتج السلوك الإدماني وتقلل من تكرارها وذلك بإزالة الاعتقادات الخاطئة والكامنة خلفها.

٢ - تدريب المدمن على أساليب خاصة للسيطرة على دوافعه وخلق فنيات مواجهة لهذه الضغوط.

فالهدف هو تقليل الضغوط على المدمن وزيادة قدرته على التحكم.

فمسار العلاج المعرفي يكون في عدة طرق فالمعالج المعرفي يساعد المريض على إدراك واقعه الإدماني من ناحية ومن ناحية أخرى تنمية شعور المدمن بقدرته على الاضطلاع بمختلف أدوار الحياة بغير خوف أو تردد، وتحمل تبعية ومسؤولية هذه الأدوار بصدق وأمانة والرضا عنها والاستمتاع بها وتحمل نتائج جهدها ومسعاها في هذا الصدد بغير لجوء إلى التبرير عند مواجهة المواقف الضاغطة أو ما قد يصادفه من فشل أو إخفاق .

كذلك زيادة استقلالية المدمن عبر تفعيل قدرته على تدبير شؤون حياته الخاصة وحرصه على تجنب مختلف صور وأشكال التبعية والاعتمادية كالمسايرة الآلية والتقليد الأعمى أو المحاكاة السلبية لأي من الأشخاص المباشرين أو الغير المباشرين في محيطه الاجتماعي .

وزيادة تبصير المدمن بأنه واقع في مشكل وأنه مدمن ويحتاج للعلاج وأنه فاقد للسيطرة على تعاطيه وأنه يعي (أي الإدراك الموضوعي للواقع) الأضرار والمخاطر المترتبة على تعاطي المخدرات على المستوى النفسي والطبي والاجتماعي والديني دون تقليل من المخاطر، حيث يرى «بيك» أن حدوث الإدمان يرجع إلى نظام من الاعتقادات الإدمانية وتكون هذه الاعتقادات الخاطئة نسقا من التفكير يسيطر على المدمن فيرى أن احتياجه للمخدر يحدث قدر من التوازن النفسي والانفعالي وأن أدائه الاجتماعي والوظيفي يتحسن بتعاطي المخدر بالإضافة إلى قدرة المخدر على التغلب على المشاعر المزعجة كالضيق والملل وما يمنحه للمدمن من نشاط و طاقة.

(Abdelmaugoud, 1995,pp38)

و زيادة الدافعية الموجبة لدى المدمن بالجدية والنشاط في مواجهة المهام والأعمال الصعبة، والسعي الإيجابي تجاه تذليل ومغالبة أي صعوبات أو معوقات تعترض مسعاها لبلوغ وتحقيق أهدافه الذاتية التي وضعها لنفسه، مع مثابرة و حرص المدمن على استمرارية العمل والصبر لإتمام أو بلوغ ما يسعى في سبيله من أهداف ومطامح بحيث يواصل جهده بدأب كي يصل إلى ما يريد أو يرتضي من أهداف، وأن يدرك سلبيات التعاطي ويدحض ايجابياته.

وتنمية الشعور بأهمية الزمن من خلال إدراك المدمن لقيمة الوقت وتقديره لأهمية عنصر الزمن، وحرصه على استثمار أوقاته والاستفادة منها إلى أقصى حد في كل ما هو مفيد مع شعوره بقدرته على حسن تنظيم أوقاته بما يحقق أهدافه وتطلعاته المستقبلية ومقاومة أي معوقات أو مغريات يمكن أن تستنفذ أوقاته بغير طائل أو عائد إيجابي .

مع حرص المدمن على أن يستشرف المستقبل في تفكيره وسلوكه وما يضعه لنفسه من أهداف وطموحات بحيث يفكر ويعمل ويخطط في سبيل نواتج بعيدة المدى أدوم وأبقى مفضلاً النواتج الأخيرة على أي مكاسب أو مغنم فورية سريعة ومؤقتة.

والتأكيد على أهمية الفعالية الذاتية عبر إدراك المدمن بأن نجاحه في حياته إنما يتحدد في ضوء كده واجتهاده ومثابرته في تحقيق أهدافه بغير تعليل أو تبرير بمنطق الحظ أو الظروف ، مع عدم تعميم الخبرات السلبية على نفسه أو على الآخرين، مما قد يؤدي به إلى الانتكاسة أو عدم الرغبة في العلاج.

وتنمية التعافي الإيجابي من خلال أقناع المدمن بفعالية البرامج العلاجية وضرورة المشاركة الإيجابية دون تشكيك فيما يقدم سواء عن طريق المشاركة السلبية، أو التركيز على جزء من التفاصيل السلبية أو مشكلة من المشكلات الخارجية أو الداخلية وتجاهل وعزل الموقف الكلي بما يتضمنه البرنامج العلاجي من ايجابيات كثيرة، أو الإلحاح في طلب الخروج من البرامج العلاجية لأسباب ضعيفة، أو الاستخدام المبالغ فيه لميكانيزمات الإنكار، أو لسيطرة مشاعر اليأس وعدم التيقن من الشفاء، أو عدم اتخاذ قرار العلاج بعد أو للتطرف المدمن وتصلبه دون أن يدرك أن العلاج في المستشفى قد يكون فيه أشياء ايجابية، ويعلق «بيك» بالقول أن جوهر

المشكلة التي يواجهها المدمن هي إن مجموعة من الاعتقادات الإدمانية التي يبدو إنها مشتقة من اعتقادات أساسية مثل «أنا عاجز» «أنا غير محبوب» «أنا مستهدف» وهذه الاعتقادات بدورها تتفاعل مع ضغوطات الحياة لتوليد قلق شديد أو الكدر أو الضيق. كما أن المواقف الضاغطة أو الحالات المثيرة لا تسبب التعاطي مباشرة، لكنها تنشط الاعتقادات المتصلة بالمخدر التي تؤدي إلى التعاطي. (Abdelmaugoud, 1995, pp38)

والتأكيد على أهمية الحاجة إلى القبول والرغبة في التغيير وبدء حياة جديدة والتخلص من نظرة المجتمع والآخرين السلبية لتخلص من الألم والمعاناة و مزاوله الحياة بشكل طبيعي.

وتعتبر الفنيات العلاجية التي يستخدمها المعالج في تقييم فوائده وأضرار التعاطي على المدى القريب والبعيد، والتحليل الشامل لنتائج الاستفادة من المخدر، وهو ما يطلق عليه المقارنة بين تحليل الفوائد والأضرار للمخدر. يساعد المعالج والمريض على إيجاد طرق بديلة ومتعددة لتحقيق له التكيف مع المشاكل الواقعية ومشاعره غير السارة دون اللجوء إلى المخدرات كأسلوب للتوافق. والمعالج النفسي المعرفي يوضح كيف يمكن للمريض أن يواجه العقبات كمشكلات يمكن التغلب عليها وليس مشكلات تحول دون تحقيق أهدافهم. وكثير من المرضى الذين يعانون من صعوبات في الدفاع عن حقوقهم بطريقة مناسبة يمكن أن يقفوا تحت سيطرة أو استغلال الآخرين وبالتالي يكونون عرضة للضيق المفاجئ والغضب والإحباط.

وبتعلم مهارات شخصية جديدة يستطيع المرضى أن يدافعوا عن حقوقهم بطريقة فعالة. ونفس النوع من خاصية الدفاع عن الحقوق يساعد المرضى بألا يستجيبوا لإغراء الآخرين ويرفضوا أي محاولة منهم لإعادتهم لتعاطي المخدرات. ويمكن أن يأخذ هذا الرفض معنى آخر فيكسبهم الثبات تجاه الضغوط ويجعلهم يقدمون المنافع المستمرة على غيرها فلا يأبهون بازدياد الآخرين لهم.

وتعتبر الأسئلة التحاورية الجدلية الفلسفية Socratic Questioning إحدى المعالم الأساسية لأساليب العلاج النفسي المعرفي والتي تتطلب مهارة خاصة في إلقاء الأسئلة، ويدفع المعالج

بالمريض إلى اختبار المناطق التي تجعل المريض يقوم بعملية الفحص والتدقيق لأفكاره، وذلك من خلال تكرار الحقائق حول أضرار تعاطي المخدرات، والخسائر الحقيقية الناتجة عن الإدمان والتأثيرات السلبية على العلاقات الشخصية وتقود تلك التساؤلات المرضى إلى مواجهة اختبارات عامة مع إمكانية تقديم حلول لم تكن في الحسبان. وأخيراً يضع هذا الأسلوب المريض في صيغة تساؤلات حيث يوضع كمنقيض لصيغة الاندفاعات الآلية. ويبدو أن عملية تقييم اتجاهاتهم المتعددة واعتقاداتهم ستصبح أكثر موضوعية.

أن التوقف عن تعاطي المخدرات مشكلة معقدة. ويحاول العديد من المدمنين التوقف عدة مرات ولكنهم يفشلوا في ذلك، ويقدم لهم العلاج النفسي المعرفي الأدوات والأساليب التي تساعد على التوقف مع الاستمرارية في الامتناع عن التعاطي. بل وأكثر من ذلك فإنه يمكنهم أن يطبقوا تلك الأساليب الفنية في التعامل مع مشاكلهم اليومية.

مراحل العلاج من منظور معرفي:

يحدد بروكشا Prochsha خمس مراحل يمر خلالها المدمنين في البحث عن العلاج وهي:

- ١ - مرحلة ما قبل التفكير، وتدل على عدم المعرفة الكافية بالمعلومات الخاصة بالإدمان على الرغم من أنهم لديهم مشاكل ناتجة عنه، أو أنهم يعتبرون أن التعاطي مشكلة أكثر أهمية من المشاكل التي تنتج عن التعاطي.
- ٢ - مرحلة التفكير، فأنهم يرغبوا في وضع مشاكلهم محل الاعتبار، إلا أنهم لا يزالوا يرغبوا في التوقف عن التعاطي بطريقتهم الخاصة.
- ٣ - المرحلة التمهيدية ويرغب المدمنين في أن يتخذوا قرار التوقف عن تعاطي المخدرات، ولكنهم غير متأكدين في قدراتهم بشأن تنفيذ تلك القرارات.
- ٤ - مرحلة العمل وفيها يظهر انخفاض ملحوظ على المدمنين في سلوك التعاطي، وكذلك التغيرات العلاجية لاعتقاداتهم بشأن التعاطي وهؤلاء المدمنين غالباً ما ينجحوا في الوصول إلى المرحلة التالية.

٥ - مرحلة الصيانة والمثابرة وفيها يسيروا بخطوات واسعة تجاه الحياة دون مخدر أو خمر، ويعملوا بنشاط في المحافظة على حماية أنفسهم والسعي للتوقف لفترات أطول قد تصل إلى شهور أو سنوات. (Prochaska,1992,pp 1102 - 1114)

وتتعد أسباب اللجوء للعلاج. فالبعض يلجأ للعلاج بسبب قسري «من خلال السلطة». والبعض الآخر يرون أن حياتهم مدمرة نتيجة الأضرار المادية والنفسية والشخصية للتعاطي. بينما البعض يلجأ للعلاج نتيجة ضغط عليهم عن طريق أصدقائهم وأسرهم.

الانتقادات الموجهة للعلاج المعرفي السلوكي

على الرغم مما ذكر من مميزات العلاج المعرفي السلوكي إلا أن هناك بعض الانتقادات الموجه له ومن الممكن حصرها في النقاط التالية:

١ - العقل البشري خلّاق وأن المعاني ليست مجرد انعكاس لما يحدث من حوله

يتميز العقل البشري على أجهزة الكمبيوتر أنه من الصعب التنبؤ بمخرجاته بناء على المعلومات المدخلة فيه. فالعقل البشري يتلقى المعلومات ويعيد صياغتها، ويغير أشكالها ويخلق أشكالاً جديدة. تؤثر في سلوكيات الفرد المستقبلية، و التنبؤ بالسلوك البشري في موقف ما أمر لا يخلو من المجازفة.

٢ - صعوبة تعريف الأفكار العقلانية

من الصعب تحديد معايير محده لما هو عقلائي وما هو غير عقلائي كشيء ثابت في كل الظروف، والمجتمعات. لذا لم يزعم أي منهم أن لديه تعريف محدد لذلك.

٣ - التكيف لا يعني بالضرورة عدم وجود أفكار غير عقلائي

أن وجود أفكار غير عقلانية لدى الفرد لا يعني أنه شخص لديه مشكلات نفسية. فلدى الكثير من الناس الذين يتمتعون بالصحة العقلية بعض الأفكار الوهمية المعتدلة، فالأفكار التي تعزز الذات قد تكون عاملاً إيجابياً بالنسبة لقدرة الفرد على التكيف حتى لو لم تكن دقيقة ١٠٠٪.

٤ - تأثر المريض بالمعالج وقبول ما يقوله ظاهرياً أو قبول المريض لما يقوله المعالج دون أن يفهمه

احتمال تأثر المريض بالمعالج واختلال العلاقة العلاجية الذي قد ينتج عنه قيام المريض بإعطاء استجابات ايجابية كاذبة كأن يشير إلى أنه لم يعد مثلاً يتمسك بفكرة معينة كما كان في السابق. أما احتمال قيام المريض بإعطاء استجابات لا تعكس ما يفكر بها فعلاً.

٥ - العلاقة بين الاعتقادات والانفعالات غير واضحة

أن التأكد تماماً من كون الحالة الانفعالية تسبق الأفكار السلبية أمر بالغ الصعوبة كما أنه من الممكن اعتبار اختفاء الأفكار السلبية لدى مريض الاكتئاب بعد تحسن حالته نتيجة لاستخدامه لمضادات الاكتئاب دون محاولة تعديل أو استبدال الأفكار السلبية مؤشراً آخر على أن الحالة الانفعالية تساعد على ظهور الأفكار السلبية لدى المريض.

٢ . ١ . ٤ العلاج النفسي الجماعي

يتفق العلاج النفسي الفردي مع العلاج النفسي الجماعي في عدة نقاط، كما يتميز عنه في مجالات أخرى أيضاً. حيث يتفقون في الهدف وفي التصورات المشتركة عن طبيعة الشخصية الإنسانية وكيف تتغير، بينما ينشأ الاختلاف بينهما في أن العلاج الفردي يتم بين شخصين فقط هما (المعالج، والعميل)، أما في العلاج النفسي الجماعي يشترك أكثر من ستة أشخاص في العملية العلاجية، ولا تعني الزيادة في العدد تكراراً للعملية الفردية بل إنها تمثل تغيراً نوعياً في الخبرة، كما تمثل إمكانيات علاجية فريدة (فطيم، ١٩٩٣ م، ص ٣٨ - ٣٩).

وقد استندت جميع المداخل الجماعية في العلاج النفسي رغم تفاوتها على مبدأ أساسي يقوم على المشاركة الوجدانية بين أفراد المجموعة من حيث المشاعر والخبرات والأفكار القائمة على الاهتمام والاحترام المتبادل الأمر الذي يساعد كل فرد على فهم نفسه والآخرين، ومن هنا ورد مفهوم العلاج الجماعي بأنه: «علاج جماعي لمشكلات نفسية حيث يتفاعل مريضان أو أكثر بعضهم مع البعض الآخر على المستوى الانفعالي والمستوى المعرفي في وجود معالج نفسي أو أكثر يعملون كحفازين وميسرين، أو مفسرين». (جابر، وكفافي، ١٩٩٠ م، ص ١٤٥٣ - ١٤٥٥).

وقد أوضح حموده بأن العلاج النفسي الجماعي يستخلص من المسلمة التي تُعد الذات نتاجاً للتفاعل مع المجتمع (حموده، ١٩٩١م، ص ٧٢).

وقد ظهرت عبارة العلاج النفسي الجماعي لأول مرة عند «مورينو Moreno» (١٩٣٢م) ليعبر بها عن «أسلوب علاجي يجمع بين تكنيك توزيع الأدوار أو المهام، وبين تكنيك العلاج التلقائي أو المباشر، ورأى أنه يمكن تحسين الأحوال الاجتماعية تلقائياً نتيجة للتفاعلات بين الجماعة». (فطيم، ١٩٩٣م، ص ٤١)

ولقد كانت بداية هذا النوع من العلاج عن طريق الاعتبارات الاقتصادية والتي هي الدافع الرئيسي لابتداعه، ولكن سرعان ما تبين أن فوائد هذا العلاج تتعدى اختصار الوقت وتخفيض التكلفة العلاجية لتشمل بعض الجوانب المتعلقة بمنظور العلاج النفسي ومنهجيته وتطبيقاته العملية (السباعي وعبد الرحيم، د.ت، ص ٦٥).

وقد كان المعالجون النفسيون وإلى وقت قريب يتعدون عن أساليب العلاجات النفسية الجماعية، ولا يعيرونها اهتماماً حيث لا يعتبرونها من العلاج في شيء. أما اليوم فقد وصل العلاج النفسي الجماعي إلى مكانة قد تجعل من العلاج الفردي مجرد تابع له، يقول «كارل روجرز» في كتابه الشهير (جماعات المواجهة): «إن الجماعات وجدت وستظل باقية طالماً وُجد إنسان على ظهر هذا الكوكب، غير أن الجماعة التي أعنيها هي الخبرة المكثفة التي أعدت بتدبير وقصد للعيش في جماعة، وهي في رأيي أعظم إنجاز اجتماعي شاع في هذا القرن. بل لعلها أقوى إنجاز على الإطلاق (فطيم: ١٩٩٣م، ص ٣٩).

ولعل ما يعكس الاهتمام بالعلاج النفسي الجماعي اليوم هو صدور الكثير من الكتب والمقالات، وعقد المؤتمرات الدولية، وكذلك تطبيقه في المستشفيات والعيادات والمؤسسات ومراكز التوجيه، وفي المدارس وغير ذلك من أماكن التجمعات البشرية (عيسوي، ١٩٩٣م، ص ٢١٥).

وأن للعلاج النفسي الجماعي تاريخ ممتد وذا جذور قديمه، كما ظهر ذلك في الدراما الإغريقية ومسرحيات العصور الوسطى وجلسات التنويم المغناطيسي التي عقدها «أنطون ماسمر»، فإننا

نجدها مثلت اللبنة الأولى لحركات العلاج النفسي الجماعي الحديث (فطيم: مرجع سابق، ص ٤٥).

حيث دلت الشواهد التاريخية على أن العلاج النفسي الجماعي هو من نتائج الحرب العالمية الثانية، وذلك عندما طلب من الأخصائيين النفسيين الإكلينيكين في المؤسسات العسكرية، أن يقوموا بالعلاج النفسي الجماعي، وذلك بسبب العجز في أفراد الفئات الأخرى، حيث تكونت مثل هذه الجماعات في السجون، ومراكز النقاهاة، والمستشفيات، ومراكز التدريب، وكان يطلق على هذه الاجتماعات في معظم الأحيان «جلسات التذمر أو الشكوى»، إذ كان الافتراض الأكثر شيوعاً هو أنه إذا استطاع المرضى أن يتخلصوا من العدوانية المكبوتة بالتعبير أو التحدث عنها، فإنهم يصبحون أقل عداوة لمطالب السلطة، أو أكثر إدراكاً لها (روتو، ١٩٨٩م، ص ١٦٦).

وتنسب البداية الحديثة للعلاج النفسي الجماعي كما يراها الكثيرون إلى «جوزيف هيرسي برات - Joseph Hersy Prat» (١٩٠٥م) - وهو طبيب باطني من بوستن، وذلك عند محاولته التي قام بها في علاج مرضى السل الرئوي، فإن الكثير من المصادر تعتبر أن العلاج النفسي الجماعي هو فكرة أمريكية نشأت عن الفلسفة البراجماتية الأمريكية (فطيم، ١٩٩٣م، ص ٤٥). ومن التطبيقات الأولى لهذا المنهج على مرضى العصاب، محاولة «مارش - March (١٩٠٩م)، وفي سنة (١٩١١م) ابتدع «مورينو» منهج الدراما النفسية Psychodrama وهي شكل من أشكال العلاج النفسي الجماعي. وبعد الحرب العالمية الأولى مباشرة بدأ «لازل - Lazel بإجراء التجارب الجماعية على مرضى الفصام في واشنطن، ثم شاعت دراسته على المحاربين القدماء.

ومما سبق نستطيع أن نقول بأن العلاج النفسي الجماعي لم يظهر في صورته الأولى كاملاً، بل إنه كان نتيجة للكثير من الاتجاهات والمعتقدات المتعددة في تلك الحقبة الزمنية لذا فإن المصادر الرئيسية للجماعات العلاجية في وقتنا الحاضر تكمن في الاحتياجات الاجتماعية العملية والبحوث التجريبية، والممارسات الإكلينيكية.

مفهوم العلاج النفسي الجماعي

هناك العديد من التعاريف للعلاج النفسي الجماعي ولقد استنبط الباحث جزءاً منها إن: «العلاج النفسي الجماعي هو نوع من أنواع العلاج النفسي، والذي يتم من خلاله اختيار مجموعة منتقاة من المرضى حسب خصائص معينة». (الشخصية، نوع المرض النفسي ... الخ) ليتم علاجهم بصورة جماعية. (الجلبي، واليحيى، ١٤١٦هـ، ص: ١٩٧).

وطبقاً لتعريف «مورينو ١٩٣٢» الذي عرف العلاج النفسي الجماعي بأنه «أسلوب علاجي يجمع بين تكتيك توزيع الأدوار أو المهام وبين تكتيك العلاج التلقائي المباشر». (فطيم، ١٩٩٣م، ص ٤٨).

وقد عرفه «أبراهام ١٩٥٠م» بأنه عملية من عمليات الجماعة يقودها شخص لا تظهر عليه علائم مرضية ليصلح من مشكلات أعضاء الجماعة في علاقتهم ببعضهم البعض وبالمجتمع (المرجع السابق، ص ٤٨).

وقد عرفه «سانفورد» بأنه شكل من أشكال العلاج النفسي يجتمع فيه عدد من الأفراد المضطربين إنفعالياً في شكل جماعة يجتمعون مع أخصائي العلاج النفسي وعن طريق التفاعل الاجتماعي يكتسبون خبرة علاجية مفيدة. (عيسوي، ١٩٨٤م، ص ١٢٤).

وقد عرفه «سلافسون ١٩٥١» بأنه: «تطبيق خاص لمبادئ العلاج الفردي على شخصين أو أكثر في وقت واحد، فيما يتعلق بظواهر ومشكلات العلاقات بين الأشخاص». (Slavson, 1957, pp131)

وقد عرفه زهران بأنه: «علاج عدد من المرضى الذين يحسن أن تتشابه مشكلاتهم وإضطراباتهم معاً في جماعات صغيرة، يستغل أثر الجماعة في سلوك الأفراد». (زهران، ١٩٧٧م، ص ٣٠٧)

وقد عرفه «إدواردز ١٩٦٨م» بأنه جلسة مع عدد من المرضى، حيث يشجعون على الاشتراك في المناقشات الحرة» (عيسوي: ١٩٩٠م، ص ١٢٥).

ويتضح من التعريفات السابقة أن العلاج النفسي الجماعي يجب أن يتم في إطار مجموعة تتكون من فردين أو أكثر بهدف علاج الاضطرابات النفسية أو غيرها لدى أفراد تلك المجموعة في وقت واحد.

أساليب وتقنيات العلاج النفسي الجماعي

لقد أثرت الحرب العالمية الثانية كثيراً على الناس في ذلك الوقت وأدت إلى إصابة العديد منهم باضطرابات نفسية، وكان لزيادة الحالات المرضية أثره الكبير في نقص المعالجين النفسيين وبالتالي عدم تمكنهم من القيام بدورهم العلاجي لكل حالة مرضية، كما أن معظم الحالات المضطربة متشابهة وتجمعهم ظروف واحدة من جراء تلك الحرب، لذا تم اللجوء إلى طريقة العلاج الجماعي لاستيعاب عدد كبير من المرضى، فكانت الانطلاقة الحقيقية لهذا النوع من العلاج والذي أصبح من أهم أنواع العلاج النفسي ومن أهم الطرق العلاجية الحديثة التي تستثير الفرد على معايشة الواقع ومواجهة مشاكله ومناقشتها بصورة تدعو إلى التفاؤل عن طريق مشاركة الآخرين والتفاعل معهم. (عيسوي، ١٩٨٤م، ص ٢١٣)

وللعلاج النفسي الجماعي فائدة مزدوجة، فإذا كانت الفائدة الأولى تكمن في إتاحة الفرصة للمرضى لمناقشة المشاكل التي تؤثرهم مع الآخرين والتي يصعب عليهم مواجهتها حتى يتم تبادل الأفكار الإيجابية والخبرات، فإن الفائدة الثانية اقتصادية كون العلاج النفسي الجماعي يُطبق على عدة أفراد في وقت واحد، حيث يمكن الاكتفاء بمرافقة معالج نفسي واحد مع أفراد المجموعة العلاجية. (روتز، ١٩٨٩م، ص ١٦٦ - ١٦٧)

وهناك تقنيات عديدة ومختلفة للعلاج النفسي الجماعي ولهذه التقنيات مصطلحات خاصة بها، ومن تلك التقنيات العلاجية.

١- السيكودراما Psychodrama

لقد أسس جاكوب مورينو Moreno هذه الطريقة وهي: «العلم الذي يستشف الحقيقة الإنسانية من خلال استخدامه لطرق دراماتيكية». حيث يقوم المريض من خلال هذه الطريقة

بتمثيل دور خاص به يتصرف فيه بطريقته الخاصة وذلك ضمن تمثيلية أو مسرحية يشترك فيها أفراد المجموعة. (النابلسي، ١٩٩١م، ص ١٨٣ - ١٨٤).

وهذا النوع من العلاج يقتضي مساعدة المريض على التعبير عن مشاعره والتنفيس عن انفعالاته المكبوتة من خلال قيامه بتمثيل الأدوار المختلفة التي يرغب القيام بها. (عيسوي، ١٩٨٤م، ص ٣١).

وللسيكودراما إسهامات عديدة في عملية العلاج النفسي الجماعي، حيث تستخدم كوسيلة علاجية وتعليمية وتدريبية، وكذلك وسيلة تربوية تساعد الفرد على الترويح والترفيه.

ولأنها وسيلة من وسائل العلاج النفسي، فإنها تنظر للمريض على أنه شخص مضطرب نفسياً، يعيش في عزلة بعيداً عن المجتمع المحيط به مما يسبب الاضطرابات النفسية وبالتالي تفاقم المرض لديه.

ولذلك يرى علماء النفس بأن السيكودراما يعد أسلوباً علاجياً فعالاً من أساليب العلاج النفسي الجماعي، لكونه يساعد المريض في التخلص من عزلته. حيث أن المرضى المضطربين نفسياً يساعدون أثناء التجارب كثيراً وخاصة مع من يجدون أن لديه الاهتمام بهم فيما يعبرون عنه، سواء كان ذلك عن طريق الكلمات أو الإيماءات أو غير ذلك.

ومن هنا يكون التجاوب مع بعضهم البعض، فيبدأ بينهم التفاعل مع أي انفعالات قد تولد لديهم معان جديدة (الحسين، ١٩٩٧م، ص ٦٢).

ومما سبق فإن السيكودراما كوسيلة علاجية تجعل المريض يساعد نفسه على اكتشاف قدراته والتعبير عنها بطريقة فعالة تمكنه من تعديل سلوكياته والتفكير في كيفية تغيير اتجاهاته السلبية التي تقوده إلى العزلة والانطواء والاستسلام للمواقف والأحداث المؤثرة في حياته وتكوين الأفكار غير المنطقية خاصة في مجال الإدمان، وذلك لكونه يلعب أدواراً تمثيلية تعبر بطريقة أو بأخرى عن ما يوجد في اللاشعور لديه.

ويرى عيسوي ١٩٨٤م، بأن تمثيل الأدوار يقوم على عدة افتراضات منها:

- أن حياة الإنسان عبارة عن مسرح تمثيلي يقوم فيه كل فرد بلعب دور معين، حيث يوصف الفرد بالنجاح عندما يتقن دوره بطريقة جيدة.

- أن الإنسان يتعلم من المواقف الحياتية التي يشاهدها، وأنه يفهم المشاكل بطريقة جيدة عندما تعرض عليه. (عيسوي، ١٩٨٤م، ص ٢٤١).

٢ - جماعة الحساسية

وفيها يسعى الأفراد المشتركون بالعملية العلاجية إلى التبصر بمشكلاتهم وزيادة الوعي الذاتي لديهم وكذلك فهم ديناميات الجماعة من أجل تقوية الدافعية العلاجية وتحقيق الفائدة المرجوة من ذلك. (كمال، ١٩٩٤م، ص ٤٨٨).

٣ - العلاج الأسري العائلي

ينطلق هذا النوع من العلاج من حيث أن الأسرة وحدة واحدة لا تتجزأ تقوم على أساس التكامل والتفاعل بين أعضائها، وعن طريقها يمكن تحديد الاضطرابات النفسية التي تنشأ بين أي فرد من أفرادها، لذا فإنها العمود الفقري للفرد وهي اللبنة الأولى والرئيسية في العملية العلاجية، ومنها يساعد المعالج النفسي العضو المضطرب على التعبير عن رغباته ومشاعره بشكل مباشر. (عبد الخالق، ١٩٩٧م، ص ٥٨٤).

٤ - التحليل النفسي الجماعي

وفي هذا النوع من العلاج يترك المعالج النفسي للمرضى الحرية الكاملة للتعبير عن مشاعرهم باستخدام طريقة التداعي الحر دون أن يشاركهم في مناقشة مشاكلهم وما يتعرضون له من صراعات، إلا أنه يعمل على ملاحظة سلوكياتهم وما يعاني منه كل فرد داخل المجموعة. (زهران، ١٩٧٧م، ص ٣٢٥).

٥ - العلاج التعليمي

وتعتمد هذه الطريقة العلاجية على إعداد المعالج النفسي للمحاضرات والموضوعات المتنوعة سواء كانت هذه المحاضرات طويلة أو قصيرة، وذلك من أجل إعطاء صورة واضحة عن سلوك الفرد في المجتمع وتعامله مع باقي أعضاء الجماعة وتفاعله معهم، وكذلك إعادة الثقة بنفس المريض وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديه. (عيسوي، ١٩٨٤م، ص ٢٢٦).

ويرى زهران ١٩٩٨م بأن هذا الأسلوب العلاجي يركز على عنصر التعليم حيث يجب أن يسوده المناخ العلمي، وأنه يعود إلى العالم كلامان عام ١٩٤٧م، فقد أجريت العديد من الدراسات التجريبية لمعرفة تأثير المحاضرات التعليمية والمناقشات الاجتماعية على تعديل السلوكيات وتغيير الاتجاهات، كتجارب كيرت ليفين (lewin1947) وتجارب كوش وفرنش والتي توصلت إلى أن المناقشة الجماعية تؤدي إلى تعديل السلوك بدرجة جيدة مما يجعل أعضاء الجماعة العلاجية أكثر صدقاً واتزاناً فيما بينهم. (زهران، ١٩٩٨م، ص ٢٩٥).

وهناك العديد من العلماء الذين استخدموا هذا الأسلوب العلاجي والذين يعتبرون رواداً في هذا المجال كالعالم كلامان Klapman الذي استخدمه مع مرضى العصاب والذهان، والعالم جونز Jones الذي استخدمه في علاج مرضى الحرب العالمية الثانية من الذين اعتقدوا وتوهموا بأنهم مرضى بالقلب (الزاد، ١٩٨٨م، ص ١٢٩ - ١٣٠).

كما أن دراسة صفاء الأعسر عام ١٩٧٠م في أثر المحاضرة والمناقشة الجماعية في تخفيض مستوى القلق، قد أكدت على أن الفرد عندما يكون عضواً في جماعة وفي موقف علاجي جماعي يصبح أكثر فعالية خاصة عندما يشعر بالانتماء للجماعة وأن مشاكلهم واحدة ومتشابهة.

نظريات العلاج النفسي الجماعي

أن معظم المنظرين في مجال العلاج النفسي الجماعي يتفقون على أن كل جلسة علاجية جماعية تعتبر ذات أبعاد متعددة حسب الطريقة التي يتبعها المعالج مع أعضاء الجماعة (المحارب، ١٩٩٣م، ص ٢٢٩).

ومن أهم النظريات التي تبنت موضوع العلاج النفسي الجماعي قد أخذت بالرأي الذي يتركز حول أن الإنسان يملك من خلال قدراته العقلية خصائص فردية مثل ما يملك خصائص اجتماعية وقد كان لهذا الرأي مردوده السلبي في أن الإنسان يملك عقل فردي وعقل اجتماعي (كمال، ١٩٩٤، ص ٤٤٤).

ويرى مليكة ١٩٩٤م بأن العلاج النفسي الجماعي يمكن استنتاجه من ثلاث أطر نظرية اجتماعية هي:

١ - نظرية التبادل الاجتماعي ل (ثيو و كليي) والتي ترى بأن المبالغة في تعظيم الأمور وما ينتج عنها من ثواب يعود إلى درجة التفاعل بين الجماعة حيث أن كل سلوك يترتب عليه ثواب وتكلفة.

٢ - نظرية الدور الاجتماعي التي تقوم على معرفة المتغيرات الظاهرة، الملاحظة من قبل الآخرين، والتي يمكن قياسها، لأن الجماعة تلزم كل عضو فيها بإتباع سلوك مناسب بما يتفق مع مكانته الاجتماعية.

٣ - نظرية التعلم الاجتماعي وفيها يجد الفرد لكونه عضو في جماعة تدعيم والتشجيع مقابل ما يقوم به من أنشطة اجتماعية ظاهرة سواء كان ذلك التدعيم من خارج الجماعة أو من داخلها فإن دوره في تلك الجماعة يساعده على الحصول على الشئ والتقدير (مليكة، ١٩٩٤، ص ١٥٠ - ١٥١).

خطوات العلاج النفسي الجماعي

يقوم العلاج النفسي الجماعي على عملية التقييم التشخيصي، حيث لابد من تحديد أعضاء الجماعة العلاجية من خلال محكين رئيسيين هما:

- ١ - أن يكون لدى المريض الرغبة والدافعية العلاجية للالتحاق بالجماعة والالتزام والتقيّد بنظامها.
- ٢ - أن تتم عملية اختيار المرضى كأعضاء في جماعة بطريقة متوازنة بحيث يكون لهم نفس المشكلة. (عيسوي، ١٩٨٤م: ٢١٨).

وقد حدد كل من (هولاندر وكازاوكا). خطوات العلاج النفسي الجماعي في عدة نقاط منها:

- اختيار أعضاء الجماعة العلاجية، على أن تكون درجة التجانس مختلفة حسب المشكلة وطبيعتها.
- أن يكون للجماعة العلاجية هوية خاصة بها، والعمل على جذب اهتمام الأعضاء لتكوين الجماعة.

- وضع أسس وقواعد عامة لتفعيل المشاركة وتبادل الخبرات بين الأعضاء.

- التحرك ضمن إطار سلوكي معين يحكم علاقة الجماعة العلاجية وتفاعلهم مع بعضهم البعض.

- أن تصبح نظرة أعضاء الجماعة تفاعلية وذات توقع إيجابي تجاه السلوك الصادر من كل عضو.

إعداد نموذج للتغيير والعمل على تنفيذه من خلال النقاط التالية: -

- أن يتم تحديد السلوك الذي ينبغي تعديله.

- أن يتم عمل برنامج التغيير وتنفيذه عند الحصول على المعلومات اللازمة.

- تقييم الجماعة العلاجية عن طريق البيانات والمقاييس اللازمة. (مليكة، ١٩٩٤ م، ص ١٥١ -١٥٢).

ومن النظريات التي يمكن الاستفادة منها في عملية العلاج النفسي الجماعي النظرية السلوكية والتي ترى بأن السنوات الخمس الأولى من عمر الإنسان تؤثر في بقية مراحل العمرية، وأن علاقة الطفل بوالديه وخاصة والدته تؤدي إلى ارتباط شرطي وعلاقة دينامية، حيث أنهم يمثلون جماعة مستقلة لأن تلك العلاقة تهدف إلى تعديل سلوكيات الطفل، وهذا يدل على أن هناك عملية علاجية نفسية، يقوم بها الوالدين.

كما أن النظرية السلوكية ترى بأنه السلوك الإنساني نتيجة تفاعل مستمر ومتواصل بين الفرد وبيئته، لأن السلوك ليس شيئاً ثابتاً بل هو متغير، وهذا السلوك لا يحدث في فراغ وإنما يحدث في بيئة اجتماعية، مما يعني بأن الجماعة تؤثر في سلوك الفرد، وأن هذا السلوك يؤثر في البيئة ويتأثر بها. (الخطيب، ١٩٩٠، ص ٢٠).

ويرى كيلارك أن التعليم عند الإنسان يقوم على اكتساب عادات سلوكية من المجتمع المحيط به مما يساعده على التكيف مع البيئة، وأن هذه السلوكيات المكتسبة ترتبط ارتباطاً شرطياً بين المثيرات والاستجابات المقترنة بالتدعيم (أبو النيل، ١٩٨٥ م، ص ٥٩ - ٦٠).

ويتضح من خلال النظريات السابقة بأن الإنسان يكون شخصيته عن طريق العلاقات الإنسانية التي يرتبط بها الفرد وأن الجماعة لها تأثير مباشر وفعال في فهم الفرد وسلوكه والعمل على تعديل اتجاهاته وتصحيح أفكاره السلبية، لذا يجب بيان أهم الأسس النفسية والاجتماعية للعلاج النفسي الجماعي.

الأسس النفسية والاجتماعية للعلاج النفسي الجماعي

يستند العلاج النفسي الجماعي إلى قواعد نفسية واجتماعية رئيسية، لابد من مراعاتها لتقويم سلوك المريض في العملية العلاجية منها:

أن هناك احتياجات نفسية واجتماعية أساسية لكل إنسان ينبغي إشباعها كالحاجة للأمن والتقدير والشعور بالانتماء، والحاجة لحب الآخرين والتفاعل معهم وكذلك الحاجة للنصح والتوجيه، وغير ذلك من الأمور التي تتيح للفرد الاستقرار النفسي. (زهران، ١٩٩٤ م، ص ٢٨٤ - ٢٨٥).

أن المعايير الاجتماعية السائدة في كل مجتمع تقتضي تحديد الأدوار الاجتماعية حتى يشعر الفرد بالانتماء والتفاعل مع الجماعة، لأن مجرد وجود الآخرين يساعد الفرد على بذل الجهد وزيادة الحصة الإنتاجية. (كمال، ١٩٩٤ م، ص ٤٤٥).

أن الحياة الاجتماعية تعتمد العصرية بشكل كلي على العمل في جماعات، من أجل أن يحظى الفرد بحياة كريمة ومنتجة تجعله قادراً على إقامة علاقات إنسانية ذات فعالية، فيصبح عضواً فاعلاً ومصدراً من مصادر العلاج. (زهران، ١٩٩٤ م، ص ٢٥٨).

من المعلوم بأن الإنسان لا يعيش بمعزل عن بيئته الاجتماعية وأن سلوكياته مكتسبة من تلك البيئة، وأن لكل إنسان شخصيته المستقلة التي تميزه عن الآخرين، لذا فإن تفاعل الإنسان مع

بيئته الاجتماعية وإشباع احتياجاته بالطرق المشروعة يساعده على الابتعاد عن العزلة والانطواء التي تعرضه للوقوع في براثن المرض النفسي.

ويرى كمال ١٩٩٤م بأنه عند اختيار الجماعة العلاجية لابد من إتباع القاعدة الأساسية للعلاج النفسي الجماعي القائمة على أن يكون لدى أعضاء الجماعة نفس الحالة المرضية سواء كانت أمراض نفسية أو عقلية أو سلوكية كإدمان المخدرات مثلاً، وأن يتراوح عدد الجماعة من أربعة إلى تسعة أفراد، وقد يصل إلى المائة فرد حسب الطريقة العلاجية المتبعة.

وأن يعمل المعالج النفسي على تحقيق أكبر قدر من التجانس بين أعضاء المجموعة بعد أن يتم استثناء الأفراد الذين لا يتوافقون مع الجماعة (كمال، ١٩٩٤م، ص ٤٤٩ - ٤٥٠).

وغالباً ما تكون العملية العلاجية في مكان مستقل وهادئ يمكن ممارسة العلاج النفسي الجماعي فيه بارتياح، على أن تستمر الجلسة العلاجية من ساعة إلى ساعة ونصف تقريباً، حيث يمكن للمعالج أن يعقدها من جلسة في الأسبوع الواحد إلى ثلاث جلسات (عيسوي، ١٩٨٤م، ص ٢١٨).

ويرى العديد من المتخصصين في العلاج النفسي الجماعي أنه لابد من الإعداد الجيد للعملية العلاجية سواء كان ذلك من حيث إعداد أعضاء الجماعة أو استعداد المعالج أو غير ذلك. (زهران، ١٩٧٧م، ص ٢٨٧).

حيث أن نجاح العلاج النفسي الجماعي يعتمد على مدى قدرة وكفاءة المعالج على اختيار أعضاء الجماعة وإدارتها، وقدرته على التفسير والملاحظة وتغيير نظرة الفرد نحو ذاته والآخرين (المحارب، ١٩٩٣م، ص ١٨ - ٢٠).

وأنه عند اختيار أعضاء الجماعة لابد للمعالج من القيام بعملية الفحص والتشخيص من خلال إجراء مقابلة شخصية لكل عضو، يراعي فيها مدى حرص الفرد واستعداده لأن يصبح عضواً في الجماعة (زهران، ١٩٩٤م، ص ٢٨٨).

وقد لخص وولف wolf ١٩٦٧م عملية إعداد المريض في عدة نقاط هي:

- أن يتم إعداد المريض على تحمل ضغط الجماعة.

- إعداده على الثقة في بقية أعضاء الجماعة العلاجية.
- العمل على تهيئة المريض على أن يكون عضواً في جماعة.
- تدريبه على عدم المقاومة أثناء العملية العلاجية.
- أن المريض له الحرية المطلقة في الانضمام للجماعة وتركها متى شاء.
- توضيح أهمية المشاركة للمريض بما يعود عليه وعلى أعضاء الجماعة العلاجية بالفائدة (المرجع السابق، ص ٢٨٨).

وعند تكوين الجماعة العلاجية يرى «روزنبوم ١٩٧٨ م» أهمية تقييم أعضاء الجماعة من خلال المقابلة الإكلينيكية لكل فرد ومدى رغبته في إقامة علاقات علاجية داخل الجماعة. هذا ويستخدم العلاج النفسي الجماعي عادة بشكل موسع في كلاً من العيادات النفسية ومستشفيات الأمراض العقلية وبعض المؤسسات الإصلاحية وفي عيادات توجيه الأطفال (زهران، ١٩٩٤ م، ص ٢٨٦).

آثار العلاج النفسي الجماعي

- لقد أُجريت العديد من البحوث من أجل فهم الدينامية العلاجية وكان لها دوراً رئيسياً في تفسير نتائج العلاج النفسي الجماعي وتميزه عن العلاج النفسي الفردي، ومن هذه النتائج ما يلي:
- أن زيادة الإنتاجية لدى الفرد تقترن بشكل مباشر بوجود الآخرين.
- أن الفرد يتأثر بمن حوله لمجرد معرفتهم به.
- أن المواقف التي تؤثر في الجماعة يكون تأثيرها كبيراً على كل مشارك فيها مما يجعل الفرد يكون أكثر حدة في ردة فعله.
- أن كل فرد يكون عضواً في جماعة يصبح أكثر حرصاً على تماسك الجماعة وبقائها لأنه يستمد قوته من تلك الجماعة (كمال، ١٩٩٤ م، ص ٤٤٥).

ومن أمثلة آثار العلاج النفسي الجماعي المصاحب للصدمات الكهربائية، مع أثر العلاج بالصدمات الكهربائية فقط، وذلك على مجموعتين لمريضات الفصام، حيث وجد بأن نتائج المجموعة الأولى كانت أفضل من المجموعة الثانية. (زهران، ١٩٩٤م، ص ٢٨٩).

ويرى كلاً من هولاندر وكازوكا بأن العلاج النفسي الجماعي قد فرض إيقاعه ورسخت أقدامه من خلال الكم الهائل من البحوث التي طبقت في هذا المجال وخاصة في ما يقوم به الأفراد من دور في العلاج النفسي الجماعي، وفي تعميم نتائج العلاج، والعمل على المحافظة على مكاسبه. (مليكة، ١٩٩٤م، ص ١٦٤ - ١٦٥).

قواعد و فنيات العلاج النفسي الجماعي

لقد تم إعداد العديد من الفنيات العلاجية ضمن قوائم خاصة بتفعيل العلاج النفسي الجماعي، حيث اعتمد كلاً من «بلوك» و«كرواتش» عام ١٩٨٥م، قائمة علاجية تحتوي على بعض الفنيات العلاجية، وذلك من خلال مراجعتها للعوامل العلاجية السابقة، ومن هذه الفنيات ما يلي:

١ - الاستبصار، التقبل (التماسك)، الانكشاف الذاتي، التنفيس، العمومية، الإيثار، التعليم بالعبارة.

٢ - حيث أنه يعتبر من الصعوبة بمكان تذكر تلك الفنيات على المعالجين حديثي الخبرة بجانب العوامل الأساسية في العلاج النفسي الجماعي (المحارب، ١٩٩٣م، ص ٦٨).

كما أن هناك بعض العلماء الذين يحرصون على أن تكون الجماعة العلاجية جاذبة لأعضائها، حيث توصل بعضهم إلى وضع برنامج خاص لزيادة جاذبية الجماعة من خلال عدة خطوات منها:

- تخفيض درجة القلق والتوتر لدى أعضاء الجماعة أثناء الجلسات الأولى.
- العمل على تشجيع أعضاء الجماعة وتعزيز مشاركتهم في العملية العلاجية كتقديم نوع من المرتبات أو الشاي في الجلسة الأولى.

- تفعيل دور الفرد داخل الجماعة وذلك من خلال اقتراح المعالج لموضوع معين يتم فيه المشاركة حتى ولو كانت ثنائية.

- استخدام بعض الأساليب العلاجية لإيجاد نوع من التنافس بين أعضاء الجماعة مثل أسلوب توليد الأفكار الذي يقوم على تحقيق التماسك داخل الجماعة العلاجية، حيث استخدم هذا الأسلوب أوسبورن في جلسات الإبداع (إبراهيم، ١٤٠٠هـ، ص ٢٨٣ - ٢٨٤).

ويرى عيسوي ١٩٨٤م بأن هناك أشكال مختلفة للعلاج النفسي الجماعي يمكن تصنيفها كأساليب مستخدمة في العملية العلاجية، حيث تقسم إلى اتجاهات تحليلية أو اتجاهات كتيبة إيجابية، أو استخدام أساس اللغة أو غير اللغة كالتالي:

١- علاج جماعي لفظي verbal.

٢- علاج جماعي غير لفظي وينقسم إلى:

(أ) سطحية (ب) عميقة

كما ان (كورسين) قسم العلاج النفسي الجماعي على أساس ثلاثة أبعاد هي:

١ - التوجيه وينقسم إلى: (أ) توجيهي (ب) غير توجيهي

٢ - الأسلوب وينقسم إلى: (أ) لفظي (ب) عملي

٣ - العمق وينقسم إلى: (أ) سطحي (ب) عميق

ولقد اقترح (وروزنبرج) بعداً آخر يقوم على احتواء العلاج على أساس عقلي أو انفعالي، حيث أن تلك التقسيمات السابقة تفيد المعالج النفسي من الناحية النظرية كأساس علمي للعلاج النفسي الجماعي. (عيسوي، ١٩٨٤م، ص ٢٢٥).

العوامل الأساسية لنجاح الجماعة العلاجية

يرى فطيم عام ١٩٩٣م بأن الجماعة العلاجية تستطيع أن تحسن من أدائها، وتحصل على النتائج المثالية المرجوة، عندما يعمل أعضاء الجماعة على قواعد خمسة أساسية لتحقيق أهداف الجماعة وهي:

- جو الجماعة: ويتضمن دعم الجماعة العلاجية مادياً ومعنوياً من خلال تهيئة المكان المناسب للجلسة العلاجية من جميع النواحي، التي تساعد الفرد على بذل الجهد والعطاء، وبالتالي تنمية روح الجماعة والتقبل لديه.

- انشغال أعضاء الجماعة بها: حيث أن الفرد يصبح متمسكاً بالجماعة وقادراً على تحقيق الإنتاجية كلما وجد التشجيع والتعزيز، وهذا يساعده على تعديل سلوكياته وتغيير اتجاهاته السلبية لأنه يجد في الجماعة نفسه.

- التفاعل: من أهم العوامل الرئيسية لنجاح الجماعة العلاجية واستمرارها حيث تنمو العلاقات الإنسانية والاجتماعية بطريقة مثالية.

- التماسك: ويطلق عليه أحياناً مسمى الاتحاد أو التضامن، فإن تماسك الجماعة يعتمد على مدى قوة الترابط بين أعضائها وفهمهم لبعضهم البعض.

- الإنتاجية: وهي النتيجة التي تسعى إليها الجماعة لتحقيق أهدافها وغاياتها ودوافعها، حيث كلما كانت الجماعة تعمل وفق أسس وقواعد كلما كان هناك زيادة وتقدم في الإنتاج. (فطيم، ١٩٩٣م، ص ٨٢ - ٨٤).

مزايا العلاج النفسي الجماعي وعيوبه

إن العلاج النفسي الجماعي يتميز كأسلوب علاجي نفسي بالعديد من المميزات التي تساعد المعالج على إتمام العملية العلاجية بنجاح، ومن هذه المميزات ما يلي:

- يتميز العلاج النفسي الجماعي عن العلاج الفردي بأنه يُقدم لأكبر قدر ممكن من الأفراد الذين

يعانون من نفس المشكلة بأقل جهد وأقل تكلفة، حيث أن الفرد يستطيع أن يعبر عن انفعالاته وإسقاطها على الآخرين من أعضاء الجماعة العلاجية دون أن يواجه بالنقد، مما يكون له أكبر الأثر في تخفيف حدة القلق والتوتر لديه، فيصبح قادراً على اكتساب الثقة بنفسه وإثبات شخصيته.

- مساعدة الفرد على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن نفسه وعن الآخرين، وتبصيره بنقاط الضعف في شخصيته، مما ينمي لديه الشعور بالقيمة الذاتية والتطلع إلى القضاء على السلوك السلبي.

- إقامة العلاقات الاجتماعية الإنسانية، ومواجهة المواقف والأحداث في عملية علاجية جماعية شبيهة بالحياة الواقعية.

- مساعدة المريض في تعديل سلوكياته وتغيير اتجاهاته، من خلال تعليمه بعض المهارات الاجتماعية المطلوبة.

- تدريب المريض على اكتساب الخبرات والاعتاظ من أخطاء الآخرين والتغلب على الحيرة والقلق في المواقف والأحداث اليومية (زهران، ١٩٩٤م، ص ٣٠٧-٣٠٨).

عيوب العلاج النفسي الجماعي

حيث يمكننا ذكر بعض العيوب للعملية العلاجية الجماعية على النحو التالي:

- أن العلاج النفسي الجماعي عملية فيها نوع من الصعوبة والتعقيد.

- أنه قد يحدث نوع من التوافق والتكيف لدى المريض ولكنه لا يحدث تغيرات جذرية في شخصية الفرد.

- أنه قد لا يفيد بعض المرضى الذين يعانون من صراعات داخلية عنيفة (المرجع السابق، ص ٣٠٩).

٢ . ٢ الدراسات السابقة

انشغل العديد من الباحثين في دراسة الدافعية وكيفية تطويرها وتنميتها باعتبارها وسيلة ومحفز لتحقيق أهداف الفرد، لما لها من أهمية في مجالات متعددة من حياة الإنسان والمجتمع؛ حيث أن هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بمفهوم الدافعية وعلاقتها بعدد من المتغيرات الشخصية والأكاديمية، لذلك يمكن تصنيف الدراسات السابقة في ضوء ما توفر من تراث سيكولوجي على النحو التالي:

أولاً: الدراسات التي بحثت في أثر برنامج تدريبي على الدافعية وعلاقته بمتغيرات أخرى.

ثانياً: الدراسات التي بحثت في أثر برنامج معرفي سلوكي في علاج مرضى الإدمان.

ثالثاً: الدراسات التي بحثت في علاقة عدد من المتغيرات بالدافعية .

أولاً: الدراسات التي بحثت في أثر برنامج تدريبي على الدافعية وعلاقته مع متغيرات أخرى

في دراسة لاختبار فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الدافعية لمحمود (١٩٩١م) لدى عينة تكونت من (٦٢) طالبا وطالبة في الصف الأول الإعدادي في مصر، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية الدافعية لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للبرنامج، وأيضا نمواً في متغيرات الضبط وتقدير الذات ومفهوم الذات، في حين لم تظهر أي تغييرات في استجابات أفراد المجموعة الضابطة على نفس المتغيرات.

كما أجرت الصياح (١٩٩٧م) دراسة بعنوان « فاعلية برنامج تدريبي لزيادة الدافعية لدى المتعلمين». وتكونت عينة الدراسة من (١٢٠) طالباً وطالبة من طلبة الصف الثاني الإعدادي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائية في مستوى الدافعية بين أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح أفراد المجموعة التجريبية.

وفي دراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج إرشاد نفسي جمعي عقلائي - انفعالي معرفي في تحسين فاعلية الذات المدركة والدافعية والمعدل التراكمي الطراونه (٢٠٠٥م) لدى طلبة جامعة

مؤتة ذوي التحصيل المتدني. وتكونت عينة الدراسة من (٢٤) طالبا وطالبة. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية في فاعلية الذات المدركة والدافعية والمعدلات التراكمية بين المجموعة التجريبية والضابطة.

وأجرى شحروري (٢٠٠٦م) دراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي مبني على المهارات المعرفية وما وراء المعرفة والانفعالية في إثارة الدافعية الموجهة ذاتيا لدى طلبة المرحلة الثانوية في الأردن. تكونت عينة الدراسة من (٨٠) طالباً وطالبة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح أفراد المجموعة التجريبية. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات لمتغيرات الجنس والفرع والمعدل الدراسي على بعد الفاعلية الأكاديمية، مما يعني عدم فاعلية البرنامج تبعاً للمتغيرات على هذا البعد. وبيّنت النتائج أيضاً عدم وجود فروق دالة بين المتوسطات لمتغيرات الجنس والمعدل الدراسي، ووجود فروق ذات دلالة بين متوسطات درجات الفرع العلمي والإدارة المعلوماتية ولصالح الفرع العلمي، وأيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات لمتغيرات الجنس والفرع والمعدل الدراسي.

ثانياً: الدراسات التي بحثت في أثر برنامج معرفي سلوكي في علاج مرضى الإدمان

وفي دراسة لمتابعة العلاج المعرفي السلوكي ومقارنته بالعلاج الإكلينيكي لـ (Carroll, 1994b) ظهرت بعض النتائج المثيرة التي غالباً ما تظهر بعد عام واحد من المتابعة للعلاج المعرفي السلوكي أو العلاج الإكلينيكي، ووفقاً لما ذكرته الدراسة فإن نسبة الكوكايين للمرضى كمجموعات أو أشخاص تقل بشكل عام أو تكون ثابتة مقارنة بمستويات ما بعد العلاج. وبعد سنة من المتابعة تبين، بتأجيل ظهور الأعراض في العلاج المعرفي مقارنة بالعلاج الإكلينيكي، ويستمر هؤلاء المرضى الذين تعرضوا للعلاج المعرفي السلوكي في تقليل استخدام المخدر بينما تظل مجموعة مرضى العلاج الإكلينيكي كما هي، وهذه النتائج يمكن أن ترتبط بالتأجيل الطارئ لتأثير العلاج المعرفي السلوكي، وخلال مراحل العلاج المعرفي السلوكي

والعلاج الإكلينيكي الحرجة يتلقى المرضى في كل المجموعات مجموعة من التدخلات العلاجية غير المحددة مثل مراقبة تحليل البول، تقييم متكرر للكوكايين المستخدم وغيرها من الأعراض، كذلك التدعيم والتشجيع من المعالجين والباحثين وتوقعات التأثير الايجابي للعلاج، هذه الحقائق الشائعة قد تكون فعالة علاجياً. ومن ناحية أخرى نجد أن العلاج المعرفي السلوكي يهدف بشكل عام إلى تأكيد مهارات تأقلم عامة يمكن تطبيقها بعد فترة طويلة من العلاج في حين إن العلاج التدعيمي قد يمنح المرضى مصادر قليلة حسب رأي صاحب الدراسة.

ونجد في دراسة هدفت إلى اختبار مدي فاعلية العلاج المعرفي في علاج إدمان الهيروين في المملكة العربية السعودية . لعلي الفقية (١٩٩٦م) وقد تكونت عينة الدراسة من حالتين من المرضى المنومين بمستشفى الأمل بجدة . وقد استخدم الباحث نموذج بيك المعرفي Beck الذي لا يتعارض مع الوسائل المعرفية الأخرى بقدر ما يتكامل مع تلك الوسائل العلاجية في صياغة نسق اعتقادات المريض الفردية من خلال العلاج المعرفي السلوكي يتواءم بصورة جيدة مع العلاج الدوائي وبرنامج الخطوات الاثنى عشر أو النموذج النفسي البيولوجي الاجتماعي . وقد استخدم الباحث عدد من الأدوات التالية : أولاً مقياس الاتجاه نحو المعالجة والشفاء التقييم الاكلينيكي ثانياً مقياس الاتجاه نحو المعالجة والشفاء . (التقييم العلاجي) ثالثاً مقياس الاعتقادات حول المواد المخدرة . رابعاً مقياس اعتقادات الرغبة الملحة والاشتياق إلى التعاطي . خامساً مقياس التنبؤ بالانتكاسة . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي علي مقياس الاتجاه نحو لمعالجة والشفاء بصورتيه . كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي حول مقياس الاعتقاد حول المواد المخدرة ومقياس اعتقادات الرغبة والاشتياق قبل العلاج وبعده مما يشير إلى فاعلية العلاج المعرفي للإدمان . وتؤكد الدراسة انخفاض مستوى أعراض الإدمان والامتناع عن التعاطي نتيجة تأثيرات العلاج المعرفي السلوكي . بالإضافة إلى أن فاعلية العلاج المعرفي مضافاً إليه العلاجات المقدمة من مستشفى الأمل كان لها الأثر الأكبر في التعامل مع النظام المعرفي وبنيته والتي بدورها تحسن من مستوى السلوك الادماني للمدمن وتقليل مستوى الاشتياق والرغبة إلى التعاطي .

وفي دراسة هدفت لمراجعة عدد من الدراسات ووجدت أن هناك دليل واضح على فاعلية العلاج المعرفي السلوكي مقارنة مع الوسائل الأخرى في علاج التدخين. (Carroll, 1996) وقد كانت المقارنة بين العلاج المعرفي السلوكي وبين الوسائل العلاجية الأخرى إشكالية بحثية، حيث أشارت بعض الدراسات إلى تفوق العلاج المعرفي السلوكي في علاج الإدمان، بينما أظهرت بعض الأبحاث أن العلاجات الأخرى تتشابه في نتائجها مع العلاج المعرفي السلوكي وان العلاج المعرفي ليس أكثر فاعلية من الطرق الأخرى. وتركز دراسة كارولين بشكل خاص على العلاج المعرفي السلوكي لتعاطي الكوكايين، حيث قامت بمراجعة موجزة لسلسلة من الدراسات في وحدة علاج الإدمان في بجامعة (يال) Yale والتي تم خلالها تقييم الوسائل العلاجية للعلاج المعرفي السلوكي. وعليه قامت كارولين بعمل مقارنة لدراسة مدي فاعلية العلاج المعرفي السلوكي مع العلاج النفسي البين شخصي personal Psychotherapy - Inter، حيث استخدم هذا العلاج بطريقه منهجية منتظمة في العيادات الخارجية. واستغرقت الدراسة ١٢ أسبوع للمرضى الخارجيين، وشملت العينة العشوائية للدراسة (٢٤) مدمن كوكايين تم تشخيصهم بناء علي معايير الدليل التشخيصي والإحصائي الأمريكي الثالث المراجع DSM - IIIR. وقد أظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا للعلاج المعرفي السلوكي كانوا أكثر كفاءة من المرضى الذين خضعوا للعلاج النفسي البين شخصي، حيث أكمل العلاج (٦٧٪) للعلاج المعرفي السلوكي مقابل (٣٨٪) للعلاج النفسي البين شخصي) وحققوا ٣ أسابيع من الامتناع التام عن التعاطي (٥٧٪) للعلاج المعرفي السلوكي مقابل (٣٣٪) للعلاج النفسي البين شخصي) الامتناع بشكل مستمر لأربع أسابيع أو أكثر بعد الانتهاء من العلاج (٤٣٪) للعلاج المعرفي السلوكي مقابل (١٩٪) للعلاج النفسي البين شخصي). بالرغم من أن حجم عينة الدراسة كان صغير ولم تصل الاختلافات إلى مستوي دلالة إحصائية، إلا أن تلك الاختلافات كانت هامة من حيث فاعلية العلاج الذي يقلل من شدة الاعتمادية علي الكوكايين وتؤكد هذه النتائج أن مدمني الكوكايين الأكثر اعتمادية قد يتطلب تركيز أكثر من قبل العلاج المعرفي السلوكي الذي يركز على أن التعليم والتدريب على استراتيجيات خاصة لإيقاف التعاطي والسيطرة عليه، في حين نوعية العلاج المقدم قد يكون أقل أهمية لمتعاطي الكوكايين الأقل اعتمادية

وفي دراسة لتقييم العلاج المعرفي السلوكي وغيره من العلاجات النفسية والدوائية لعدد كبير من المرضى «كارول» وزملائها في الجوهي (٢٠٠٤م). وقد قارنت الدراسة، العلاج المعرفي السلوكي بنوعين آخرين من العلاج هما العلاج الإكلينيكي والخطوات الإثني عشر. وأضافت كارول ضمن هذه الدراسة أيضاً، علاج الإدمان الكحولي باستخدام (مضاد الكحول disulfiram). وقد أوضحت النتائج الأولية أن العلاجين وهما المعرفي السلوكي والاثني عشر خطوة، أكثر فعالية من العلاج الإكلينيكي في تعزيز فترات التوقف المتتالية للكوكايين والتوقف المتزامن لكل من الكوكايين والكحول. بالإضافة إلى ذلك هناك علاقة بين العلاج المعرفي السلوكي والاثني عشر خطوة والعلاج الإكلينيكي في كمية الكوكايين والانخفاض ذو الدلالة في الاستخدام لفترة زمنية وتدرجه خاصة عند الأشخاص الذين يتعرضون لعلاج أقل فاعلية. كما أوضحت المقارنة أن العلاج المعرفي والاثني عشر خطوة أكثر فعالية من العلاج النفسي الذي يتحكم في الحالة والذي يؤكد على أهمية الدور التعريفي، التدخلات النفسية الاجتماعية المؤهلة والمستخدم في علاج إدمان الكوكايين، ولأن العلاج الإكلينيكي يوفر آليات تحكم عامة، غير محدد لعناصر العلاج النفسي بما في ذلك (العلاقة التدعيمية مابين الطبيب والمريض).

ونجد في دراسة تناولت محاولة استخدام برامج غير تقليدية ومستحدثة في علاج مرضى إدمان الهروين. ومعرفة مدى فاعليتها. من خلال استخدام النموذج المعرفي السلوكي الذي طورته «كارول كاتلين» عام ١٩٩٧٩م. الجوهي (٢٠٠٤م) واستهدفت الدراسة على بعض الإشكاليات العلاجية وهي: ١ - هل يمكن استخدام نموذج علاجي معرفي سلوكي حقق نتائج ايجابية في علاج مرضى إدمان الكوكايين في علاج مرضى إدمان الهروين؟ ٢ - هل يمكن استخدام النموذج موضوع الدراسة وهو من ثقافة غربية في علاج مرضى من ثقافة مغايرة، وهي ثقافة المجتمع العربي السعودي؟ وللإجابة على هذه الإشكاليات اتبع الباحث المنهج التجريبي من خلالها اختبار اثر نموذج العلاج المعرفي السلوكي لدى عينة مكونة من ٨٠ مريضاً مقسمين لمجموعتين بالتساوي من مدمني الهروين، بمجمع الأمل للصحة النفسية. وقد أظهرت الدراسة بعد تطبيقها وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل فروض الدراسة على المحاور الرئيسية المرتبطة بالعملية الإدمانية، حيث ظهر وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من التطبيق القبلي و التطبيق البعدي لدى المجموعة الضابطة، وكذلك فروق ذات دلالة إحصائية

بين كل من التطبيق القبلي و البعدي لدى المجموعة التجريبية، و أيضاً أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التطبيق البعدي بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية مما يشير لأثر النموذج المعرفي السلوكي. على عينة من ٨٠ مريضاً منوماً بمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام. مقسمين إلى مجموعتين متساويتين مجموعة تجريبية وعددها ٤٠ مريضاً وأخرى ضابطة بنفس العدد باستخدام أسلوب الأزواج المتناظرة وذلك لضبط متغيراتها الوسيطة. وتراوحت أعمار عينة الدراسة من سن ١٨ - ٥٠ سنة. وقد طبقت الدراسة في ضوء الأدوات التالية: أولاً النموذج المعرفي السلوكي. التي قامت «كاروول كاتلين» وزملاؤها بتطوير النموذج المعرفي السلوكي (١٩٩٧م). وهو برنامج معرفي سلوكي فعال، صمم في البداية لعلاج مدمني الكوكايين. وأثبتت البحوث مدى فاعليته في علاج هؤلاء المرضى. ثانياً قائمة الاعتقادات الإدمانية. ثالثاً قائمة اعتقادات الشوق. رابعاً قائمة التنبؤ باحتمالية الانتكاسة. خامساً قائمة تشخيص سوء الاستخدام والاعتماد على العقاقير والكحول.

ثالثاً: الدراسات التي بحثت في علاقة عدد من المتغيرات بالدافعية

في دراسة عن الدافعية العامة وأبعادها لمحيي الدين (١٩٨٨م) والتي كان الهدف منها: الوقوف على المظاهر النفسية التي تشكل قوام الدافعية العامة عند الذكور. والوقوف على الأبعاد التي تنظم المظاهر المختلفة للدافعية العامة. وتكونت العينة من ١٧٨ فرداً من موظفي الدوائر الحكومية الذكور الجامعيين في مدينة الرياض، وكان متوسط أعمارهم ١٣, ٢٩ عاماً. وأسفرت النتائج عن: أنه أمكن الوقوف على تسع عشر خاصية تنظم المظاهر المختلفة للدافعية العامة، كما أمكن الوقوف على بعدين ينظمان مظاهر الدافعية العامة، وهما في الدافع للمثابرة والدافع للإنجاز.

وفي دراسة عن أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالدوافع لسعود (١٤١٠هـ) على عينة قوامها ٢٨٦ طالب من طلاب الثانوية من مدارس مكة المكرمة. وكان هدف الدراسة الكشف عن أنماط أساليب المعاملة السائدة في مجتمع العينة والتعرف على طبيعة العلاقة بين نوع أسلوب المعاملة الوالدية من وجهة نظر الآباء وما يرتبط به من الدوافع، ومعرفة أفضل أساليب المعاملة الوالدية التي تؤدي إلى أفضل درجات الدافعية. وأوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة بين

أسلوب المعاملة الوالدية السوية ودوافع الإنجاز المتعلقة بالثقة بالنفس وقلق المستقبل إيجابيا بينما ارتبطت سلبيا بدوافع الانجاز المتعلقة بالجزاءات الخارجية ودوافع الانتماء المتعلقة بصعوبة التفاعل الاجتماعي، وكذلك ارتبطت أساليب المعاملة الوالدية اللاسوية إيجابيا بدوافع الانتماء والإنجاز الخاصة بالإحساس بالنبذ والجزاءات الخارجية والخوف من الفشل وضعف الثقة بالنفس ولكنها لم ترتبط بصعوبة التفاعل الاجتماعي ولا بقلق العمل، ووجد إن هناك فروق في ترتيب الأهمية المرتبطة بأساليب المعاملة الوالدية من حيث علاقتها (بدوافع النجاح ودوافع تجنب الفشل ودوافع الإنجاز الخارجية ودوافع الفشل) . لذا فإن تشكيل الدوافع يتأثر بكل من الوالدين بصور مختلفة .

وفي دراسة هدفت إلى بحث العلاقة بين كل من سمات الشخصية وقلق السمة والجنس والفرع الأكاديمي بالدافعية الهلسا (١٩٩٦م) لدى طلبة الثانوية في مدارس محافظة الكرك في الأردن، وقد تألفت عينة الدراسة من (١٠٢٧)، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على الدافعية تعزى لاختلاف بعد الشخصية (الاتزان - الانفعال) لصالح الاتزان، وقد كشفت الدراسة أيضا عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على الدافعية تعزى لاختلاف بعد الشخصية (الانبساط - الانطواء) لصالح الانطواء، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على الدافعية تعزى لتفاعل الجنس ومستوى قلق السمة وبعد الشخصية (الانبساط - الانطواء) على الدافعية، ولتفاعل الجنس والفرع الأكاديمي وبعد الشخصية (الانبساط - الانطواء) على الدافعية وعلاقة الدافعية بمستوى التحصيل الدراسي في إطار كل من الثقافتين (البدور، ٢٠٠٦م)

وفي دراسة عن الدافعية للعلاج لدى المدمنين (دراسة نفسية مقارنة) غانم (٢٠٠٠م) حيث هدفت دراسته إلى مقارنة الدوافع التي تدفع المدمن سواء في جمهورية مصر العربية أم المملكة العربية السعودية إلى العلاج ودلالة ذلك في العملية العلاجية. وقد تكونت عينة البحث من (٨٠) مدمنًا جميعهم من الذكور مقسمة إلى مجموعتين: عينة الإدمان السعودية وتكونت من (٥٠) مدمنًا من المترددين للعلاج أكثر من ثلاث مرات في مستشفى حكومي لعلاج الإدمان.

وعينه الإدمان المصرية وتكونت من (٣٠) مدمنا من المترددين للعلاج أكثر من ثلاث مرات. وقد تراوحت أعمار العينة للمجموعتين من عشرين لخمس وأربعين عام بمتوسط قدره (٨, ٣٠). وقد كانت نتائج البحث على النحو التالي: فقد تبين أن مجموعتي المدمنين السعودية والمصرية قد اشتركتا في سبع دوافع تكمن خلف تردد العلاج وبنسب مئوية مختلفة وهي: إرضاء الأسرة، والأهل أجبروني، والانتكاسة، وهروب من مشاكل خارج المستشفى، وللعلاج، وأريد أن أبدأ حياة جديدة، ولا أعرف. في حين أن المجموعة السعودية قد زادت لديها خمس دوافع أخرى للتردد عما يكون لدى المجموعة المصرية وهي عدم توفر المادة المخدرة، ومحول من العمل، وأستريح، ومحول من قبل الشرطة ولم أجد مأوى. كذلك اتضح أن دافع إرضاء الأسرة كان دالا بالنسبة لمجموعة المدمنين السعوديين. في حين أن دافع الأهل أجبروني على العلاج، كان دالا لدى المجموعة المصرية. وكذلك دافع لأجل العلاج كان دالا لدى مجموعة الإدمان المصرية.

وفي دراسة بعنوان العمليات الدافعية والأداء أجرى هافن (Haven, 2003) دراسة اهتمت بثلاث قضايا تتمثل بمعرفة تأثير الضمير الحي والعصابية على العمليات الدافعية والأداء، ومعرفة الصدق المرتبط بالمعايير للمقاييس الظاهرية (Facet) للضمير الحي والعصابية كعوامل تنبئ بالدافعية والأداء، وأخيرا تحديد فيما إذا كان الضمير الحي والعصابية ومظاهرها تؤثر على التغيرات في العمليات الدافعية للأداء. وقد تألفت عينة الدراسة من (٢٢٠) طالبا جامعا من قسم علم النفس في ولاية فلوريدا (Florida). وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الضمير الحي والعصابية كانا يتنبئان بعمليات الدافعية بل ويقفان وراء التباين الفريد في الأداء، حيث أن الضمير الحي كان له تأثير أقوى من العصابية، كما قدمت النتائج أدلة تدعم فائدة استخدام مظاهر الشخصية كالسعي نحو الإنجاز والمقدرة والقلق كعوامل للتنبؤ بالدافعية والأداء بالمقارنة مع المقاييس الكلية أو العامة، وأخيرا فقد كانت البنى المرتبطة بالضمير الحي وليست المرتبطة بالعصابية تنبأ بالمعتقدات الخاصة للفعالية الذاتية.

وفي دراسة للوقوف على حجم مشكلة العودة للإدمان في المجتمع المحلي والعربي للغريب (الغريب، ٢٠٠٧م) حيث قام بدراسة استطلاعية حديثة على عينة من المؤسسات العلاجية في بعض الدول العربية، وقد تم تطبيق الدراسة في عدد من المؤسسات العلاجية في ١٤ مؤسسة

من المؤسسات العلاجية في الدول العربية، من ٨ دول عربية، فوجد أن هناك ارتفاعاً في أعداد المدمنين بالمؤسسات العلاجية في كل سنة عن السنة السابقة لها في معظم الدول العربية عينة الدراسة. وجاء في المرتبة الأولى من كانت عودتهم أربع مرات، وجاء في المرتبة الثانية خمس مرات، وفي الثالثة من كانت عودتهم لمرتين، والرابعة من عادوا مرة واحدة. وهذا يعني زيادة عدد مرات العودة لدى المدمنين في المؤسسات العلاجية المشمولة بالدراسة حيث أشار الباحث أن من الحقائق الهامة وراء عودة المدمن إلى التعاطي بعد خروجه من المراكز العلاجية، هي عدم وجود الدافعية لدى المدمن للعلاج.

من خلال استعراض الدراسات السابقة التي أجريت، يمكن القول أن تلك الدراسات قد تمثلت بعرض ثلاث مجموعات من البحوث والدراسات على النحو الآتي:

ففي الدراسات المتضمنة في المجموعة الأولى فقد اتجهت إلى دراسة فعالية البرامج التدريبية على الدافعية، وقد خلصت نتائج هذه الدراسات إلى فعالية البرامج التدريبية في إثارة وتنمية الدافعية لدى الأفراد، حيث دعمت التوجهات النظرية في اعتبار التدريب على تلك البرامج متطلباً أساسياً لتنمية الدافعية كما هو الحال في محمود (١٩٩١م)، ودراسة الصياح (١٩٩٧م)، ودراسة الطراونه (٢٠٠٥م)، ودراسة شحروري (٢٠٠٦م).

وأما الدراسات في المجموعة الثانية التي بحثت في أثر برنامج معرفي سلوكي في علاج مرضى الإدمان، فقد خلصت نتائج هذه الدراسات إلى فاعلية البرامج العلاجية المعرفية السلوكية في علاج الإدمان كما هو الحال في دراسة كل من (Carroll, 1994b) و الفقيه (١٩٩٦م) و (Carroll, 1996) و الجوهي (٢٠٠٤م).

وأخيراً بحثت المجموعة الثالثة في علاقة الدافعية بالسمات الشخصية، حيث أكدت نتائج غالبية الدراسات على وجود ارتباطات دالة إحصائية بين سمات الأفراد ودافعيتهم كما هو الحال في دراسة محي الدين (١٩٨٨م)، ودراسة الهلسا (١٩٩٦م)، ودراسة كازادي (٢٠٠٠م)، ودراسة هافن (٢٠٠٣م). كما أظهرت دراسة سعود (١٤١٠هـ) دور المعاملة الوالدية السوية في ارتباطها إيجابياً بزيادة الدافعية. وعن أهمية الدافعية في مجال الإدمان أظهرت دراسة كل من الغريب (٢٠٠٧م) وغانم (٢٠٠٠م) والتي أشارت إلى أن من الحقائق الهامة وراء عودة المدمن

إلى التعاطي بعد خروجه من المراكز العلاجية هي عدم وجود الدافعية لدى المدمن للعلاج، كما اتضح أن الدوافع التي تكمن خلف التردد للعلاج هي : إرضاء الأسرة، والأهل أجبروني، والانتكاسة، وهروب من مشاكل خارج المستشفى، وللعلاج، وأريد أن أبدأ حياة جديدة، ولا أعرف . في حين أن المجموعة السعودية قد زادت لديها خمس دوافع أخرى للتردد عما يكون لدى المجموعة المصرية وهي عدم توفر المادة المخدرة، ومحول من العمل، وأستريح، ومحول من قبل الشرطة ولم أجد مأوى .

أما فيما يتعلق بعلاقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية، فيمكن القول أن الدراسة الحالية اتفردت عن الدراسات السابقة باحتوائها على برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية لدى مدمني المخدرات، حيث أن النقص الواضح في الدراسات العربية والأجنبية حول عدم وجود برامج علاجية لتنمية الدافعية موجهة لفئة المدمنين كان دافعا للباحث على سد هذا النقص بتقديم دراسة لهذه الفئة المهمة من خلال برنامج علاجي معرفي سلوكي يبين « فعالية برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى مدمني المخدرات ».

وبما أن معظم الدراسات السابقة التي تم إدراجها ضمن حدود هذا البحث قد ركزت في اختيارها للعينات على طلبة الجامعات وطلبة المرحلة الأساسية، فيما لم يحظ المدمنين باعتبارهم فئة خاصة إلا بالقليل منها في هذا المجال، ونظرا للأهمية التي تحظى بها هذه الفئة من واقع كونها تمر بأزمة تمس الفرد وبيئته الاجتماعية فإنه سيكون لها مكانة خاصة في هذه الدراسة.

كما يمكن القول أن الدراسات السابقة قد قدمت للباحث القاعدة النظرية الواسعة التي يستدل من خلالها على الأبعاد المختلفة للدافعية وأهمية بعض الأبعاد لفئة الإدمان. كما أنها تساعد في معرفة أهمية علاقة بعض المتغيرات الشخصية بالدافعية وذلك يساهم في الاستفادة منه في إعداد البرنامج العلاجي. وبما إن هناك اتفاقاً عاماً بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة مفاده أن البرامج التدريبية قد تؤدي إلى تنمية الدافعية ؛ لذا فقد وجد الباحث أن تصميم برنامج علاجي قائم على استراتيجيات العلاج المعرفي السلوكي يساعد المدمنين على تنمية دافعتهم للعلاج من الإدمان والمواصلة في البرامج العلاجية بفعالية تساعد في الاستمرار في تعافيتهم .

الفصل الثالث

الإجراءات المنهجية للدراسة

٣ . ١ المنهج المستخدم والتصميم التجريبي

٣ . ٢ مجتمع الدراسة

٣ . ٣ عينة الدراسة

٣ . ٤ أدوات الدراسة

الفصل الثالث

الإجراءات المنهجية للدراسة

٣ . ١ المنهج المستخدم والتصميم التجريبي

يقول «مورفي» Murphy إن أهم حدث في علم النفس الحديث هو إدخال المنهج التجريبي والاعتماد عليه بشكل واضح. ففي هذا المنهج لا يقف الباحث عند مجرد وصف موقف، أو تحديد حالة أو التأريخ للحوادث الماضية. وبدلاً من أن يقتصر نشاطه على ملاحظة ما هو موجود، ووصفه، يقوم عامداً بمعالجة عوامل معينة، تحت شروط مضبوطة ضبطاً دقيقاً، لكي يتحقق من كيفية حدوث شرط أو حادثة معينة، ويحدد أسباب حدوثها. (الجوهي، ٢٠٠٤م)

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج شبه التجريبي وهذا نظراً لصعوبة التحكم في كل المتغيرات الثانوية حيث تهدف الدراسة إلى اختبار فعالية برنامج للعلاج المعرفي السلوكي يتم من خلاله توظيف استراتيجيات العلاج المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية لدى عينه من مدمني المخدرات . ومن حيث التصميم التجريبي فسوف تعتمد الدراسة الحالية على نمط التصميم شبه التجريبية الذي يمتاز بتخصيص أفراد العينة وتوزيعهم على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عشوائياً الأمر الذي يساعد على التأكد من تكافؤ الأفراد في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، حيث سيتم أخذ جميع أفراد العينة في قسم المكافحة والذي يبلغ عددهم ٣٥ مدمن يستبعد منهم الذهانيين والغير مستقرين بسبب الأعراض الانسحابية والذين لا يستطيعون إكمال البرنامج بأكمله، حيث أستخدم الباحث تصميم المجموعة الضابطة : اختبار قبلي واختبار بعدي مع مزاجعة (Pretest - Pasttest Control Group with Matching) وذلك للحصول على المزيد من الدقة عند التحليل الإحصائي للبيانات، والمزاجعة في هذا التصميم تشير إلى اختيار الأفراد للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بشكل يمكن من مقارنتهما على الاختبار القبلي الذي يقيس المتغير التابع (الدافعية) والوظيفة الأساسية لعملية المزاجعة هي التقليل ما أمكن من الاختلافات بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث المتغير التابع (الدافعية) . (التل وآخرون، ٢٠٠٧م)

أما الخطوات التي اتبعاها الباحث وفق هذا التصميم، فتتمثل فيما يلي :

- تطبيق اختبار يقيس المتغير التابع (الدافعية) على الأفراد في عينة الدراسة، وترتيبهم حسب درجاتهم في هذا الاختبار .

- العمل على مزوجة الأفراد في المجموعتين التجريبية والضابطة على أساس الدرجات التي حصلوا عليها في مقياس الدافعية، بحيث يخصص المفحوص الأول في القائمة المرتبة للظرف التجريبي، والثاني للظرف الضابط، والثالث للظرف الضابط، والرابع للظرف التجريبي وهكذا.

- تعريض الأفراد في المجموعة التجريبية للمعالجة التجريبية (البرنامج العلاجي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان) .

- تطبيق اختبار بعدي لقياس المتغير التابع لكل من المجموعة الضابطة والتجريبية من مدمني المخدرات .

- إجراء المقارنة بين أداء الأفراد في المجموعتين التجريبية والضابطة على الاختبار البعدي باستخدام اختبار كل من ويلكوكسن ومان وتني

- والمخطط التالي يوضح هيكل تصميم المجموعة الضابطة اختبار قبلي واختبار بعدي مع مزوجة .

O	A	M	R	X	O
B	O	M	R	-	O

حيث تشير A إلى المجموعة التجريبية و B إلى المجموعة الضابطة و O إلى الاختبار للمجموعتين التجريبية والضابطة و M إلى المزوجة و R إلى العشوائية في التوزيع و X على المعالجة وهي البرنامج العلاجي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان .

٣ . ٢ مجتمع الدراسة

يشمل مجتمع البحث للدراسة الحالية على جميع حالات المدمنين بقسم مكافحة المخدرات بجددة.

٣ . ٣ عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة من مدمني المخدرات بمكافحة المخدرات بجددة حيث قام الباحث باختيار جميع المدمنين بالقسم (أ) الخاص بالمدمنين المحولين من مكافحة المخدرات والملائين لطبيعة وأهداف الدراسة، بحيث تم ترتيب العينة تصاعديا وفقا لدرجة الدافعية ثم اختيار الأرقام الفردية لتمثل العينة الضابطة واختيار الأرقام الزوجية لتمثل العينة التجريبية، وذلك بعد استبعاد العينات التي لا تتناسب مع شروط التطبيق والتي تتضمن الشروط التالية:

- سلامة الحالة من أية أعراض ذهانية.

- أن يبقى المشارك لأكثر من ثلاثة أسابيع لاستكمال تطبيق البرنامج.

- قدرة المشارك على فهم ما يطلب منه .

ولتنفيذ تلك الشروط قام الباحث بالفحص النفسي لجميع الحالات الموجودة والتي شملت على عدد (٣٠) حالة تم مقابلتهم ومن ثم فرز الحالات التي يمكنها المشاركة وفقا للشروط السابقة حيث قدر عدد الحالات بنحو (١٥) حالة، وبعد انسحاب ثلاث حالات بقي (١٢) حالة موزعة بالتساوي على المجموعتين الضابطة والتجريبية.

٣ . ٤ أدوات الدراسة

قام الباحث باستخدام أداتين في دراسته الحالية من إعداداته وهي كالتالي:

١ - تصميم أداة لقياس الدافعية للعلاج من الإدمان.

٢ - بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.

وفىما يلي توضيح للإجراءات التي اتبعت في إعداد تلك الأدوات:

١ - تصميم أداة لقياس الدافعية للعلاج من الإدمان

إن الهدف من وضع المقياس هو إيجاد أداة لقياس درجة الدافعية للعلاج من الإدمان بالإضافة إلى تحديد مصادر النقص في الدافعية للعلاج من الإدمان والتي ستسهم في التعرف على أسباب النقص في الدافعية ومن ثم التعامل معها من قبل المعالجين لوضع الخطة المناسبة لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.

وقد لجأ الباحث إلى إعداد هذا المقياس للدراسة الحالية، وذلك لبعض الاعتبارات منها: أنه بعد البحث في التراث السيكلولوجي العربي والمحلي لم يجد الباحث -في حدود علم الباحث- مقياس يقيس درجة الدافعية للعلاج من الإدمان. لذا قام الباحث بإعداد مقياس يقيس درجة الدافعية للعلاج من الإدمان يتفق ويتناسب مع أهداف الدراسة.

وقد مر تصميم المقياس المستخدم في مجال الدافعية للعلاج من الإدمان بعدة مراحل وهي كالتالي:

١ - مراجعة الكتابات والبحوث والدراسات النظرية والتنظيرية العربية والأجنبية في مجال الدافعية والتي حاولت على تعدد مناحيها إلقاء الضوء على طبيعة الدافعية الإنسانية وما تتضمنه من معاني ودلالات وما يصاحبها أو يترتب عليها من تصرفات ونشاطات سلوكية وتوجهات حياتية بصفة عامة.

٢ - مراجعة المحاولات العربية والأجنبية التي بذلت بهدف وضع أدوات للقياس الدافعية لدى عينات من شرائح عمرية مختلفة وما تتضمن كل من هذه الأدوات من جوانب وأبعاد فرعية وما ينبثق عن هذه الجوانب والأبعاد من عبارات. وكان من أهم هذه الدراسات ما يأتي:

فيما يتعلق بالدراسات: ومنها على سبيل المثال (محي الدين أحمد حسين، ١٩٨٨م). حيث أمكن الاستفادة من مقياسه للدافعية العامة في إطار مشروع بحث الإناث والذكور: صورة الذات لدى كل منهما عن نفسه وعن الآخر. فيما يتعلق بأحد أبعاد الدافعية وهو بعد الشعور

بأهمية الزمن حيث تم الاستفادة من بنود هذا المقياس والذي يتكون في الأصل من ١٥ بنداً تم الاختيار منها مع مراعاة أعلاها ثباتاً . وفي دراسة لخليفة، عبد اللطيف حول الدافعية للإنجاز لدى الطلاب المصريين والسودانيين، تم الاستفادة من المكونات التالية للمقياس وهو الشعور بالمسؤولية والذي يقيسه بعشرة بنود و الثابرة والذي يقيسه بعشرة بنود، تم الاستفادة من أعلاها ثباتاً .

مقابلة مجموعة من أبرز المتخصصين في العلاج النفسي وعلاج الإدمان في عدد من مستشفيات الأمل للصحة النفسية بالرياض وجدة، وعدد من الأساتذة الجامعيين بجامعة الملك عبد العزيز بكلية التربية، حيث تم طرح سؤال مفتوح عن أهم العوامل والأسباب التي تؤدي إلى زيادة الدافعية للعلاج من الإدمان . كما قام الباحث بإجراء استبيان استطلاعي على المدمنين بلغ عددهم (٥٥) مدمن من المنومين بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض يهدف للآتي :

- معرفة الأسباب التي تجعل المدمن لا يرغب في العلاج .

- معرفة العوامل التي تساعد المدمن على طلب ومواصلة العلاج .

وقد كشفت تلك الدراسة الاستطلاعية عن بعض المؤشرات والدلالات التي وجهت الباحث في أثناء عملية إعداد المقياس .

وبناء على توصل الباحث إلى تحديد ما يمكن أن يتضمنه مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان من جوانب وأبعاد فرعية صاغها الباحث في (٨٧) عبارة تمثلت في تسعة أبعاد على النحو التالي:

تحمل المسؤولية: هو شعور المدمن بقدرته على الاضطلاع بمختلف أدوار الحياة بغير خوف أو تردد، وتحمل تبعية ومسؤولية هذه الأدوار بصدق وأمانة والرضي عنها والاستمتاع بها وتحمل نتائج جهدها ومسعاها في هذا الصدد بغير لجوء إلى التبرير عند مواجهة المواقف الضاغطة أو ما قد يصادفه من فشل أو إخفاق .

الاستقلال: هو شعور المدمن بالقدرة على تدبير شؤون حياته الخاصة وحرصه على تجنب مختلف صور وأشكال التبعية والاعتمادية كالمسايرة الآلية والتقليد الأعمى أو المحاكاة السلبية لأي من الأشخاص المباشرين أو الغير المباشرين في محيطه الاجتماعي .

الاستبصار بمشكلة الإدمان: هو شعور المدمن بأنه واقع في مشكل وأنه مدمن ويحتاج للعلاج وأنه فاقد للسيطرة على تعاطيه وكذلك مدى وعيه بالأضرار المترتبة على تعاطي المخدرات على المستوى النفسي والطبي والاجتماعي والديني .

الدافعية الموجبة: هو شعور المدمن بالجدية والنشاط في مواجهة المهام والأعمال الصعبة، والسعي الإيجابي تجاه تذليل ومغالبة أي صعوبات أو معوقات تعترض مسعاها لبلوغ وتحقيق أهدافه الذاتية التي وضعها لنفسه .

التوجه للمستقبل والمثابرة : هو حرص المدمن على أن يستشرف المستقبل في تفكيره وسلوكه وما يضعه لنفسه من أهداف وطموحات بحيث يفكر ويعمل ويخطط في سبيل نواتج بعيدة المدى أدوم وأبقى مفضلاً النواتج الأخيرة على أي مكاسب أو مغنم فورية سريعة ومؤقتة وحرص المدمن على استمرارية العمل لإتمام أو بلوغ ما يسعى في سبيله من أهداف ومطامح بحيث يواصل جهده بدأب كي يصل إلى ما يريد أو يرتضي من أهداف .

الشعور بأهمية الزمن: هو إدراك المدمن لقيمة الوقت وتقديره لأهمية عنصر الزمن، وحرصه على استثمار أوقاته والاستفادة منها إلى أقصى حد في كل ما هو مفيد مع شعوره بقدرته على حسن تنظيم أوقاته بما يحقق أهدافه وتطلعاته المستقبلية ومقاومة أي معوقات أو مغريات يمكن أن تستنفذ أوقاته بغير طائل أو عائد إيجابي .

الفعالية الذاتية: هو إدراك المدمن بأن نجاحه في حياته إنما يتحدد في ضوء كده واجتهاده ومثابرته في تحقيق أهدافه بغير تعليل أو تبرير بمنطق الحظ أو الظروف .

التعافي الإيجابي: وهو أدراك المدمن بفعالية البرامج العلاجية وضرورة المشاركة الإيجابية دون تشكيك فيما يقدم سواء عن طريق المشاركة السلبية، أو التركيز على مشكلة من المشكلات الخارجية، أو الإلحاح في طلب الخروج لأسباب ضعيفة، أو الاستخدام المبالغ فيه لميكانيزمات الإنكار، أو لسيطرة مشاعر اليأس وعدم التيقن من الشفاء، أو عدم اتخاذ قرار العلاج بعد .

الحاجة إلى التقبل: وهو الرغبة في التغيير وبدء حياة جديدة والتخلص من نظرة المجتمع والآخرين السلبية التخلص من الألم والمعاناة و مزاوله الحياة بشكل طبيعي (دافعية خارجية) .

وللتأكد من صدق المحكمين :

قام الباحث بتوزيع مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان على مجموعة من المحكمين، وهم من أبرز أساتذة علم النفس العيادي والعلاجي والإرشاد النفسي، وينتمون إلى جامعات محلية ودولية (ملحق رقم ٢)، وذلك للحكم على مناسبة مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان من حيث انتماء كل عبارة من العبارات للبعد الخاص بها والمقياس الذي تقيسه ومدى وضوح العبارات ومناسبتها لعينة البحث الحالي، كما طلب الباحث منهم إضافة أية تعديلات على الأبعاد أو العبارات التي يرون ضرورة وجودها وفق المعايير العلمية المتبعة في التحكيم، وبعد إعطائهم الوقت الكافي تم جمع استجاباتهم بعد الانتهاء من التحكيم، وقد ترتب على ذلك مقابلة العديد منهم لمناقشة بعض التفاصيل العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث وفي ضوء المراحل السابقة قام الباحث بإعداد الصورة الأولية لمقياس الدافعية للعلاج من الإدمان والمعدة للتحكيم والمكونة من (٨٩) عبارة و(١٠) أبعاد في صورتها الأولية جدول رقم (١) يوضح نسب اتفاق المحكمين على مدى صدق عبارات مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان. كما تم الاجتماع من خلال ورشة عمل وتقديم عرض تفصيلي للمقياس ومناقشته مع نخبة من الإكلينيكين في مجال العلاج من الإدمان بمستشفى الأمل بالرياض وأثمر الاجتماع على التأكيد على بعض الملاحظات والتي من أبرزها إعادة صياغة بعض العبارات، وإضافة عبارات أخرى ودمج بعضين هما التوجه للمستقبل والمثابرة والصبر لاتفاقهما على نفس الأهداف، والتي سيتم استعراضها فيما بعد. ليصبح بذلك المقياس مكون من (٩) أبعاد و(١١٣) عبارة، وقد وضع الباحث نسبة اتفاق لقبول العبارة واعتبارها صادقة وتقيس ما وضعت لقياسه (٨٠٪) والجدول التالي يوضح النتائج المتعلقة بذلك .

الجدول رقم (١) يوضح نسب اتفاق المحكمين على مدى صدق عبارات
مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان ويوضح صياغة عبارات المقياس قبل وبعد التعديل

البعد	م	العبارات قبل التعديل	نسبة الاتفاق	العبارات بعد التعديل
تحمل المسؤولية	١	أشعر أنني قادر على مواجهة المواقف	٨٠٪	أشعر أنني قادر على مواجهة المواقف الضاغطة من دون تردد
	٦		م	أدرك جميع متطلبات ومهام أدوارى الحياتية
	٧		م	أواجه المشكلات التي تعترض حياتي بدون مساعدة أحد
	٩	لا أستطيع النجاح في كثير من أمور الحياة	٨٠٪	أشعر أنني لا أستطيع النجاح في كثير من أمور الحياة
	١٤	أشك في قدرتي على الاستمرار في التوقف عن المخدرات	٨٠٪	أشعر أن الاستمرار في التوقف عن المخدرات يحتاج جهدا كبيرا يفوق قدراتي
الاستقلال	١٥			
	١٦	يتتابني الحزن عندما لا أستطيع القيام بالأعمال التي توكل إلي	٨٠٪	أشعر بالضيق وعدم الرضا عندما لا أستطيع القيام بالأعمال التي توكل إلي
	٢٢	أشعر بالراحة عندا لا أتخذ القرارات التي تخصني	٨٠٪	أشعر بالراحة عندما يتخذ آخرون قرارات في أمور تخصني
	٢٤	أصر على القيام بالإعمال الصعبة	٨٠٪	كلما وجدت العمل الذي أقوم به صعبا ازددت إصرار على إتمامه
	٢٦	أواجه أخطائي بشجاعة وأستفيد منها	٨٠٪	أحرص على أن أواجه مواقف فشلي بشجاعة كي أستفيد من أخطائي
الاستبصار	٣٠	إدماني يسبب لي المشاكل	٨٠٪	أدرك أنني بإدماني على المخدرات أقع في مشكلة
	٣٢	أتضايق عند تعاطي المخدرات	٨٠٪	أجد أن مزاجي يتقلب عندما أكون في حالة تعاطي للمخدر
	٣٢		م	أستطيع أن أسيطر على نفسي وأنا متعاطي
	٣٣		م	أستطيع أن أتوقف عن التعاطي من دون مساعدة الآخرين
	٣٤		م	ذهابي إلى أماكن وجود المخدرات والأشخاص الذين يتعاطون لا يؤثر في انتكاستي على المخدرات

				الدافعية الموجبة
٤١	أريد أن أكون مشهور	٨٠٪	أسعى لأن أكون شخصية مشهورة في المستقبل	
٤٢	حظي يساعدني في الأمور الصعبة	٨٠٪	أشعر أن الحظ يساعدني كثيرا في تخطي المصاعب	
٥٣	أحاسب نفسي على ما قمت به	٨٠٪	أحاسب نفسي على عما قمت به سابقا وما سوف أقوم به مستقبلا	
٥٤	أحاول أن أستفيد من كل ما يقدم لي من خدمات علاجية	١٠٠٪	أحاول أن أستفيد من كل ما يقدم لي من خدمات علاجية	
٥٥		م	يساعدني التعاطي على نسيان مشاكل	
٥٦		م	يسبب التعاطي مشاكل جسمية تضر بصحتي	
٥٧		م	يساعدني التعاطي على القيام بعملتي بشكل أفضل	
٥٨		م	يجعلني التعاطي منعزلا عن الآخرين	
٥٩		م	أشعر بالسعادة وأنا في حالة تعاطي	
٦٠		م	أعتقد أن أسرتي لا تتضرر من استخدامي	
٦١		م	يساعد التعاطي في تقوية الجانب الجنسي لدي	
٦٢		م	يقلل التعاطي من علاقاتي الاجتماعية	
٦٣		م	أشعر بالضيق وأنا متعاطي	
٦٤		م	تتأبني بعض الشكوك والأفكار بسبب التعاطي	
٦٥	لم يحن الوقت للتوقف عن المخدرات	٨٠٪	أعتقد أن الوقت لازال مبكرا لتوقي عن التعاطي	الشعور بأهمية الزمن
٧٦	نجاح الفرد في حياته يعتمد على أن يختار الإنسان موقفا مناسباً في الوقت المناسب	٨٠٪	أشعر أن النجاح في الحياة إنما يعتمد على أن يختار الإنسان موقفاً مناسباً في الوقت المناسب	
				المثابرة والتوجه للمستقبل
٨٢	أجد صعوبة كبيرة في تحمل معاناة العلاج	٨٠٪	أجد صعوبة كبيرة في الصبر على متطلبات العلاج	
٨٤	أجد أنني دائم التفكير في أمور تخص مستقبلي	٨٠٪	كثيراً ما انشغل في أمور تخص مستقبلي	
٨٥	عادة ما أخطط نشاطاتي تجاه تحقيق أهداف للمستقبل	٨٠٪	غالبا ما أخطط لكي أحقق أهدافي في المستقبل	

٩٢	قرار العلاج من المخدرات قرارى وحدي ولا يتخذ شخص من أفراد أسرتي	٨٠٪	قرار العلاج من المخدرات قرارى وحدي ولا يتخذ شخص آخر نيابة عني	الفعالية الذاتية
٩٣		م	أن المشاكل التي أتعرض لها لا تعيق رغبتني في استكمال علاجي أمر بها لا تجعلني أستطيع المواصلة في العلاج	
٩٤		م	خسارتي لأشياء مهمة في حياتي تجعلني لا أرغب في العلاج من الإدمان	
٩٥		م	أشعر أنه لا فائدة مني وذلك يحبط من معنوياتي تجاه العلاج من الإدمان	
				التعافي الإيجابي
٩٧		م	أعتقد أن البرامج العلاجية المقدمة هي المسؤولة عن عدم اقتناعي بالتوقف عن المخدرات	
٩٨		م	مشكلتي في عدم الاقتناع بالعلاج أنه ليس هناك أحد يفهمني	
٩٩		م	لا أستفيد من الجلسات العلاجية لأنها غير فعالة	
١٠٢		م	أدرك أنني لن أستفيد من البرامج العلاجية المقدمة	
١٠٣		م	توقفي عن التعاطي لن يكون بسبب وجودي في المستشفى	
١٠٤		م	إن عدم توفير بعض الخدمات لي في المستشفى يجعلني لا أرغب في مواصلة البرنامج العلاجي	
١٠٥		م	عدم توفير السجائر لي يجعلني غير راغب في إكمال العلاج	
				الاجتماعية والتقبل
١٠٨	نظرة الناس عني تحبط تقدمي في العلاج	٨٠٪	أرغب في تغيير حياتي من أجل تغيير نظرة الناس عني	
١٠٩	لا يحترمني أفراد جماعتي وأنا مدمن	٨٠٪	أشعر بأنني ليس لي قيمة بين أفراد جماعتي	
١١٢		م	مشاركتي للمجتمع تحد من نظرهم السلبية لي	
١١٣		م	أدرك بأن تغيير عاداتي السلبيه القديمة أثر كبير في تقبل المجتمع لي	

(م)=العبارات المضافة

حيث أن الباحث قد ارتضى نسبة (٨٠٪) كحد أدنى لقبول العبارة، فقد تم قبول جميع بنود المقياس لحصولها على نسب اتفاق (٨٠٪) فأكثر، وقد أبدى المحكمون ملاحظات حول صياغة العديد من عبارات المقياس، وإضافة بعض العبارات لعدد من الأبعاد، وكذلك الدمج بين بعضين هما التوجه للمستقبل والمثابرة والصبر بحيث أصبح عنوان البعد المثابرة والتوجه للمستقبل.

محتويات أداة الدراسة :

هذا ويتألف المقياس من تسعة أبعاد فرعية .. كما يلي :

الجدول رقم (٢) يوضح أبعاد مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان

م	أبعاد مقياس الدافعية للعلاج
١	تحمل المسؤولية
٢	الاستقلال
٣	الاستبصار
٤	الدافعية الموجبة
٥	الشعور بأهمية الزمن
٦	المثابرة والتوجه للمستقبل
٧	الفعالية الذاتية
٨	التعافي الإيجابي
٩	الحاجة إلى التقبل

طريقة التصحيح:

اعتمد الباحث على مقياس ليكرت الخماسي ، وقد أشتمل المقياس على (٣١١) بند توزعت ما بين ايجابية وسلبية ، أما البنود الإيجابية فطريقة تصحيحها كالتالي :

دائما	غالبا	أحيانا	نادرا	أبدا
٥	٤	٣	٢	١

وأما البنود السلبية فتمثلت في البنود التالية:

٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٥، ٢٧، ٢٨، ٣٣، ٣٤، ٣٥،
٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥٦، ٥٨، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٦،
٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٨٣، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩٢، ٩٤، ٩٥، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠٢،
١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٩.

وطريقة تصحيحها كالتالي :

دائماً	غالباً	أحياناً	نادراً	أبداً
١	٢	٣	٤	٥

خصائص أداة الدراسة :

قام الباحث بتطبيق مقياس الدافعية (وفقاً لاتفاق آراء المحكمين) على عينة من المدمنين بلغت ٤٣ مدمناً كانت خصائصهم كالتالي:

الجدول رقم (٣) بيان بالمقاييس الموزعة والمستلمة والمعتمدة

عينة الدراسة	المقاييس الموزعة	المقاييس المستلمة	المقاييس المستبعدة	المقاييس المعتمدة
المدمنين	٥٥	٤٧	٤	٤٣

وصف خصائص أفراد عينة الدراسة

تمّ تحديد خصائص أفراد عينة الدراسة في المتغيرات التالية : المستوى التعليمي، السن، عدد سنوات الإدمان والجدول التالي يوضح ذلك

الجدول رقم (٤) يوضح خصائص عينة تقنين مقياس الدافعية من المدمنين

الانحراف المعياري	المتوسط	
٧، ٨	٣٠، ٧	العمر (بالسنوات)
٨، ٩	١٢، ٧	عدد سنوات الإدمان
١، ٠١	٣، ١	*مستوى التعليم

*حيث يشير إلى أن مستوى التعليم لعينة التقنين فوق المرحلة المتوسطة . وفقاً للتالي : مستوى التعليم أمي = (١)، مستوى التعليم ابتدائي = (٢)، مستوى التعليم متوسط = (٣)، مستوى التعليم ثانوي = (٤).

أولاً: الثبات

١ - ثبات الاتساق الداخلي:

وقد كشفت استجابات العينة عن معامل الاتساق الداخلي cronbach - alpha التي تشير أساساً إلى اتساق استجابات العينة ومدى الترابط الداخلي بين فقرات المقياس على المستوى الكلي حيث بلغ الاتساق الداخلي الكلي (٠,٩٢٢) وهو يدل على أن تباين الخطأ في المدى المقبول سيكون مترياً.

٢ - ثبات التجزئة النصفية

وبحساب معامل ثبات التجزئة النصفية: فقد قام الباحث بحساب الثبات بين النصفين وجاءت النتائج كالآتي :

الجدول رقم (٥) يوضح معامل ثبات التجزئة النصفية للمقياس

عدد العبارات	الاتساق الداخلي	معامل سبيرمان - براون	معامل جوتمان ثبات المقياس
الجزء (أ)	٥٧	٠,٨٦٩	٠,٩١٥
الجزء (ب)	٥٦	٠,٨٣٨	

يتضح أيضاً من الجدول السابق أن المقياس مستقر فمعامل ثباته بلغ ٠,٩١٥ وهو ثبات مرتفع ويصلح للتطبيق وتحقيق أهداف الدراسة الحالية.

ثانياً : الصدق

١ - الصدق التكويني (المضمون)

قام الباحث بدراسة معامل الارتباط بين المقاييس الفرعية وبين المقياس الكلي والأبعاد الفرعية وذلك للبرهنة على صدق المقياس من ناحية ارتباط أبعاده مع الدرجة الكلية للمقياس

الجدول رقم (٦) يوضح معاملات الارتباط البينية للمقياس والإبعاد الفرعية

الدرجة الكلية	الحاجة إلى القبول	التعافي الإيجابي	الفعالية الذاتية	التوجه للمستقبل	الشعور بأهمية الزمن	الدافعية الموجبة	الاستبصار	الاستقلال	تحمل المسؤولية	
تحمل المسؤولية	٠,٠٣٤	**٠,٣٦٠	*٠,٢٦٨	*٠,٢٨٢	**٠,٥٢٣	**٠,٦٤٢	٠,١٠٨	**٠,٦٣٦	١	
الاستقلال	٠,٠٧٠	*٠,٢٥٥	٠,٠٤٧	٠,١٩٢	*٠,٣٣٠	**٠,٣٦٠	٠,٠١٨	١	**٠,٦٣٦	
الاستبصار	*٠,٢٦١	**٠,٤٦٦	*٠,٢٨٨	*٠,٣١٦	٠,٠٨١	*٠,٣١٦	١	٠,٠١٨	٠,١٠٨	
الدافعية الموجبة	*٠,٢٨٦	**٠,٧٠٥	**٠,٤١١	*٠,٢٦٦	**٠,٦٥٧	١	*٠,٣١٦	**٠,٣٦٠	**٠,٦٤٢	
الشعور بأهمية الزمن	*٠,٣٧٣	**٠,٤٤٦	**٠,٤٨٤	*٠,٤١٦	١	**٠,٦٥٧	٠,٠٨١	*٠,٣٣٠	**٠,٥٢٣	
التوجه للمستقبل	*٠,٤٥٧	٠,٢٢٦	٠,١٨٤	١	**٠,٤١٦	*٠,٢٦٦	*٠,٣١٦	٠,١٩٢	*٠,٢٨٢	
الفعالية الذاتية	٠,١٤٧	**٠,٤٠٩	١	٠,١٨٤	**٠,٤٨٤	**٠,٤١١	*٠,٢٨٨	٠,٠٤٧	*٠,٢٦٨	
التعافي الإيجابي	*٠,٥٠٦	١	**٠,٤٠٩	٠,٢٢٦	**٠,٤٤٦	**٠,٧٠٥	**٠,٤٦٦	*٠,٢٥٥	**٠,٣٦٠	
الحاجة إلى القبول	١	*٠,٥٠٦	٠,١٤٧	*٠,٤٥٧	**٠,٣٧٣	*٠,٢٨٦	*٠,٢٦١	٠,٠٧٠	٠,٠٣٤	
الدرجة الكلية	**٠,٥٠٦	**٠,٧٩٤	**٠,٥١١	**٠,٥١٩	**٠,٧٥٨	**٠,٨٩٠	**٠,٤٥٧	**٠,٥٠٠	**٠,٧٠٢	١

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

وقد كشف تحليل الجدول السابق عن صدق المقياس من حيث ارتباط الدرجات على الأبعاد الفرعية بالدرجة الكلية على المقياس، ونلاحظ أن معاملات الارتباط جاءت دالة عند ٠,٠١. ماعدا كل من الأبعاد التالية: بعد الاستبصار في علاقته مع بعد تحمل المسؤولية (٠,٠١) والاستقلال (٠,٠١). وبعد الشعور بأهمية الزمن في علاقته مع بعد الاستبصار (٠,٠٨). وبعد التوجه للمستقبل وعلاقته ببعد الاستقلال (٠,١٩). وبعد الفعالية الذاتية وعلاقته مع كل من الأبعاد التالية الاستقلال (٠,٠٤٧) وبعد التوجه للمستقبل (٠,١٨). وبعد التعافي الإيجابي وعلاقته مع التوجه للمستقبل (٠,٢٢). وبعد الحاجة إلى القبول وعلاقته مع كل من الأبعاد التالية: بعد تحمل المسؤولية (٠,٠٣٤) وبعد الاستقلال (٠,٠٧٠) وبعد الفعالية الذاتية (٠,١٤٧). حيث لم تكن معاملات الارتباط داله أي أنه لا يوجد بينها تباين مشترك، مما

يشير إلى أن هذه الأبعاد ذات طبيعة مستقلة، وتجدد الإشارة هنا أن الأبعاد الفرعية كانت دالة في علاقتها بالمقياس الكلي للدافعية للعلاج من الإدمان .

٢- بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان

أ- مصادر بناء البرنامج

قام الباحث بإعداد البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان مستفيداً من خبرته العيادية وممارسته للعلاج النفسي في مستشفى الأمل للصحة النفسية بالرياض، ومن خلال عمل الباحث في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض - وهو أحد المراكز المتخصصة في علاج الإدمان على المخدرات في المملكة العربية السعودية سابقاً - لاحظ الباحث أن مشكلة الانتكاسة من أبرز المشاكل التي تبدو على رأس هرم المشكلات الإدمانية، وأنه ومن خلال ما لاحظته الباحث فإن من بين أسباب تكرار الإدمان في كل مرة هو عدم وجود رغبة وقناعة من قبل المدمن نفسه في ترك التعاطي وعدم وجود دافعية للعلاج من الإدمان، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاهتمام بمثل تلك الفئة من المرضى لعدم وجود برنامج مخصص لتنمية دافعيتهم للعلاج وعدم وجود مقياس يقيس درجة الدافعية للعلاج من الإدمان وهذا ما دعا المسؤولين في مجال الخدمات النفسية بالمجمع إلى ضرورة إيجاد برنامج يزيد من دافعية المرضى في العلاج، الأمر الذي دعا الفرق العلاجية بالتوصية بضرورة وجود قسم خاص بالمرضى الذين ليس لديهم دافعية لعمل برنامج خاص بهم ينمي من دافعيتهم، إلا أن تنفيذ ذلك البرنامج أصطدم بعدم وجود برنامج ومقياس للدافعية، مما أحبط تلك الخطط العلاجية وقتلها في مهدها، لهذا قام الباحث بكتابة التصور الأولي للبرنامج العلاجي من خلال خبرته العيادية في علاج المدمنين على المخدرات واستناداً على الأطر النظرية وبعض المراجع المتخصصة في البرامج العلاجية التي تناولت موضوع الدافعية النفسية والعلاج المعرفي السلوكي وعلاج الإدمان وبعض الدراسات السابقة ثم قام الباحث بإعداد البرنامج في تصوره النهائي ليكون أحد المشاريع الفنية التي يمكن أن تخدم المتخصصين في العلاج النفسي لدى مدمني المخدرات .

ب - أهداف البرنامج العلاجي

- قام الباحث بتحديد أهداف البرنامج العلاجي، وروعي في وضع الأهداف التالي:
- أن تكون الأهداف أكثر تحديدا وتفصيل بحيث تحدد التوقعات المنتظرة لنتائج العملية العلاجية .
 - أن توجه الأهداف المعالج بكيفية تطبيق البرنامج .
 - تحديد الأوصاف المميزة لنتائج العملية العلاجية .
 - تحديد ما ينبغي على المشاركين فعله عند انتهاء البرنامج العلاجي .
 - أن تعبر الأهداف عن السلوك الحتمي للمشاركين بالبرنامج
 - أن تركز الأهداف على سلوك المشارك، فتوجه الانتباه نحو الأنماط السلوكية التي يتوقع أن يقوم بها المشارك نتيجة لخبر تعلم أو علاج .
 - أن تصف الأهداف نواتج العلاج وليس أنشطة العلاج التي تؤدي إلى نتيجة العلاج .
 - أن تكون الأهداف واضحة في معناها، بحيث يكون السلوك الموصوف في الهدف ظاهرا وواضحا حتى يتمكن المشارك من أن يتحقق من حدوثه فعلا .
 - يجب أن تشمل الأهداف في صياغتها على فعل يصف عملا أو سلوكا يقوم به المشارك .
 - أن تكون الأهداف قابله للملاحظة والقياس (فتح الله، ٦٠٠٢، ص ١٢٠).
- حيث تمحورت أهداف البرنامج العلاجي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان في الأبعاد التالية :

تحمل المسؤولية: هو شعور المدمن بقدرته على الاضطلاع بمختلف أدوار الحياة بغير خوف أو تردد، وتحمل تبعية ومسؤولية هذه الأدوار بصدق وأمانة والرضي عنها والاستمتاع بها وتحمل نتائج جهدها ومساعيها في هذا الصدد بغير لجوء إلى التبرير عند مواجهة المواقف الضاغطة أو ما قد يصادفه من فشل أو إخفاق .

ويمكن تحديد أهداف البعد في الأهداف التالية :

- أن يتعرف المشارك على دوره في الحياة.
- أن يحدد المشارك مهام دورة في الحياة.
- أن يواجه المشارك كل ما يعترض ويعيق دورة في الحياة من خلال تعلم إستراتيجية حل المشكلات.

الاستقلال: هو شعور المدمن بالقدرة على تدبير شؤون حياته الخاصة وحرصه على تجنب مختلف صور وأشكال التبعية والاعتمادية كالمسايرة الآلية والتقليد الأعمى أو المحاكاة السلبية لأي من الأشخاص المباشرين أو الغير المباشرين في محيطه الاجتماعي .

ويمكن تحديد أهداف البعد في الأهداف التالية :

- أن يتجنب المشارك التبعية كالمسايرة الآلية وأن يكون مستقلا بأفكاره وأفعاله.
- أن يعبر المشارك عن مشاعره السلبية والإيجابية.
- أن يرفض المشارك المطالب غير المعقولة.
- أن يحدد المشارك تأثيرات المحيط الخارجي (رفقاء سوء، علاقات شاذة ، ...) على سلوكه تجاه الإدمان.

الاستبصار بمشكلة الإدمان: هو شعور المدمن بأنه واقع في مشكل وأنه مدمن ويحتاج للعلاج وأنه فاقد للسيطرة على تعاطيه وكذلك مدى وعيه بالأضرار المترتبة على تعاطي المخدرات على المستوى النفسي والطبي والاجتماعي والديني .

ويمكن تحديد أهداف البعد في الأهداف التالية :

- أن يعترف المشارك بمشكلته الإدمانية ويحددها.
- أن يعلن المشارك حاجته للعلاج.
- أن يحدد المشارك مدى سيطرته على توقفه وتعاطيه (الإدراك الموضوعي للوقائع).

- أن يوضح المشارك أضرار وتأثيرات الإدمان الصحية والنفسية والاجتماعية والدينية بحيث لا تقل الإضرار عن عدد خمس تأثيرات لكل نوع .

- أن يحدد المشارك أساليب التفكير الخاطئة المسؤولة عن السلوك الادماني والانتكاسات المتكررة. الدافعية الموجبة: هو شعور المدمن بالجدية والنشاط في مواجهة المهام والأعمال الصعبة، والسعي الإيجابي تجاه تذليل ومغالبة أي صعوبات أو معوقات تعترض مسعاها لبلوغ وتحقيق أهدافه الذاتية التي وضعها لنفسه .

ويمكن تحديد أهداف البعد في الأهداف التالية :

- أن يواجه المشارك المواقف والأعمال الصعبة التي تؤثر على سير العملية العلاجية بجدية ونشاط .
- أن يذكر المشارك سليات التعاطي وإيجابياته بحيث تكون أكثر من عشر نقاط لكل نوع .
- أن يستكشف المشارك أهمية المثابرة والصبر في بلوغ الأهداف.
- أن يوافق المشارك على أهمية التفاؤل والإقدام بإيجابية تجاه تذليل الصعوبات وعدم الانكسار لها.

التوجه للمستقبل والمثابرة : هو حرص المدمن على أن يستشرف المستقبل في تفكيره وسلوكه وما يضعه لنفسه من أهداف وطموحات بحيث يفكر ويعمل ويخطط في سبيل نواتج بعيدة المدى أدام وأبقى مفضلاً النواتج الأخيرة على أي مكاسب أو مغنم فورية سريعة ومؤقتة و حرص المدمن على استمرارية العمل لإتمام أو بلوغ ما يسعى في سبيله من أهداف ومطامح بحيث يواصل جهده بدأب كي يصل إلى ما يريد أو يرتضي من أهداف .

ويمكن تحديد أهداف البعد في الأهداف التالية :

- أن يكتشف المشارك أهمية التخطيط للمستقبل .
- أن يستنبط المشارك مجموعة المبادئ التي تتحكم في عدم قدرته على الصبر للوصول إلى النواتج الأخيرة مكثفياً بالمكاسب المؤقتة .
- أن يتمكن المشارك من وضع الأهداف القصيرة والبعيدة المدى .

- أن يبرهن ويستنتج المشارك على أهمية الصبر والصعوبة في العلاج للوصول إلى النواتج والمكاسب الحقيقة .

الشعور بأهمية الزمن: هو إدراك المدمن لقيمة الوقت وتقديره لأهمية عنصر الزمن، وحرصه على استثمار أوقاته والاستفادة منها إلى أقصى حد في كل ما هو مفيد مع شعوره بقدرته على حسن تنظيم أوقاته بما يحقق أهدافه وتطلعاته المستقبلية ومقاومة أي معوقات أو مغريات يمكن أن تستنفذ أوقاته بغير طائل أو عائد إيجابي .

ويمكن تحديد أهداف البعد في الأهداف التالية:

- أن يكتشف المشارك مجموعة الأفكار التلقائية المسؤولة عن نفاذ الوقت بغير عائد إيجابي .

- أن يحدد المشارك الأوقات الغير مفيدة له ويشكل نموذج مثالي يكون من خلاله يوم مثالي يستثمر فيه وقته ويراقب من خلاله سلوكه .

- أن ينظم المشارك وقته بما يحقق أهدافه .

- أن يستكشف المشارك ويقاوم أي معوقات أو مغريات تستنفذ وقته بغير عائد إيجابي .

الفعالية الذاتية: هو إدراك المدمن بأن نجاحه في حياته إنما يتحدد في ضوء كده واجتهاده ومثابرته في تحقيق أهدافه بغير تعليل أو تبرير بمنطق الحظ أو الظروف .

ويمكن تحديد أهداف البعد في الأهداف التالية :

- أن يكتشف المشارك من أن النجاح لا يتحقق إلا بالاجتهاد والمثابرة في تحقيق الأهداف .

- أن يستنبط المشارك بأن الحظ والظروف لا تعطل الإنسان عن تحقيق أهدافه .

التعافي الإيجابي: وهو أدراك المدمن بفعالية البرامج العلاجية وضرورة المشاركة الإيجابية دون تشكيك فيما يقدم سواء عن طريق المشاركة السلبية، أو التركيز على مشكلة من المشكلات الخارجية، أو الإلحاح في طلب الخروج لأسباب ضعيفة، أو الاستخدام المبالغ فيه لميكانيزمات الإنكار، أو لسيطرة مشاعر اليأس وعدم التيقن من الشفاء، أو عدم اتخاذ قرار العلاج بعد .

ويمكن تحديد أهداف البعد في الأهداف التالية :

- أن يحدد المشارك الأفكار السلبية المسؤولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية.
- أن يستنبط المشارك أهمية المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية من دون تشكيك، عبر تنمية التناقضات لديه.

الحاجة إلى التقبل: وهو الرغبة في التغيير وبدء حياة جديدة والتخلص من نظرة المجتمع والآخرين السلبية التخلص من الألم والمعاناة و مزاوله الحياة بشكل طبيعي (دافعية خارجية).
ويمكن تحديد أهداف البعد في الأهداف التالية :

- أن يميز المشارك سبب نظرة المجتمع عنه .
- أن يكتشف ويحدد المشارك السلوكيات الخاطئة والعادات القديمة المسؤولة عن نظرة المجتمع له.

ج - حدود البرنامج العلاجي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان :

- الحدود الزمنية لكل جلسة :

حدد الباحث المدة الزمنية لكل جلسة ما بين (٦٠) دقيقة إلى (٨٥) دقيقة.

- الحدود الزمنية للجلسات :

حدد الباحث الجلسات العلاجية بمعدل جلسة في كل يوم .

- حدود الجلسات العلاجية :

حدد الباحث عدد جلسات البرنامج ب(٩١) جلسة .

- الحدود الزمنية لمدة البرنامج العلاجي :

يمتد البرنامج العلاجي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان إلى ثلاثة أسابيع بحسب مدة البقاء والتي لا تتعدى ٢١ يوما ابتداء من تاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٣١ هـ ولمدة ثلاثة أسابيع، في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٣٢ / ٣١ هـ .

- الحدود المكانية للبرنامج العلاجي :

حدد الباحث مكان تطبيق البرنامج بمكافحة المخدرات بالقسم (أ) بجدة .

- الفئة المستهدفة في البرنامج :

بني هذا البرنامج لتطبيقه على مجموعة تجريبية من المدمنين، وذلك لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.

د- التخطيط للبرنامج

سوف يتم تنفيذ البرنامج من خلال (١٩) جلسة، وبذلك سيستغرق البرنامج ثلاثة أسابيع، بمعدل جلسة يوميا، في الفصل الدراسي الأول ١٤٣٠ هـ، على النحو التالي :

الجدول رقم (٧) يوضح تخطيط البرنامج العلاجي

م	البعد (عنوان الجلسة)	عددتها	ترتيب الجلسة
١	التهيئة والتعارف والقياس القبلي	١	الأولى
٢	تقوية روح الجماعة	١	الثانية
٣	الدافعية الموجبة	١	الثالثة
٤	التعافي الإيجابي	٢	الرابعة والخامسة
٥	الاستبصار	٣	السادسة والسابعة والثامنة
٦	الاستقلال	٢	التاسعة والعاشر
٧	تحمل المسؤولية	٢	الحادية عشرة والثانية عشرة
٨	الشعور بأهمية الزمن	٢	الثالثة عشرة والرابعة عشرة
٩	المثابرة والتوجه للمستقبل	٢	الخامسة عشرة والسادسة عشرة
١٠	الفاعلية الذاتية	١	السابعة عشرة
١١	الحاجة إلى التقبل	١	الثامنة عشرة
١٢	إنهاء البرنامج والقياس البعدي	١	التاسعة عشرة

هـ- تحكيم البرنامج العلاجي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان

قام الباحث بتوزيع البرنامج على مجموعة من أبرز المتخصصين في العلاج النفسي وعلاج الإدمان في الوطن العربي ليقوموا بتحكيمة ووضع ملاحظاتهم وآرائهم حوله وقد أجمع المحكمين على صلاحية البرنامج وإمكانية الاستفادة منه وأشاروا ببعض الملاحظات التي يمكن إجمال أهمها على النحو التالي :

- أهمية اختصار عدد الجلسات بحيث تكون أقل من ثمانية عشر جلسة على الأكثر تفاديا لما قد يحدث من ملل وتسرب من قبل المشاركين، مع ملاحظة أن يتم تطبيق الجلسات على مدار ١٢ يوم وهي الأيام المعدة لعلاج المدمنين وبعدها يتم خروج المرضى على حسب أنظمة الدخول والخروج بمراكز علاج الإدمان، وتم مراعاة ذلك حيث اقتصر البرنامج على تسعة عشر جلسة تنتهي بجلسة تطبيق الاختبار البعدي.

- أهمية أن يكون لكل جلسة موضوع يتناسب مع محتوى الجلسة، وتم تطبيق ذلك على جميع الجلسات.

- أهمية ترتيب الجلسات بحيث تكون مرتبة حسب أهميتها، وتم تنفيذ ذلك.

- أهمية وجود فقرات ترفيهية في البرنامج بحيث تكون موزعة بالتساوي بين الجلسات لكسر الروتين والملل وجذب المشاركين، وتم تنفيذ ذلك حيث تم إضافة ثلاث فقرات ترفيهية هادفة.

- أهمية الإشارة إلى الفنيات العلاجية المستخدمة في كل جلسة بصورة مختصرة، مع ملاحظة عدم التكرار، وتم إضافة الفنيات في كل جلسة .

- أهمية توزيع الزمن على جميع فقرات الجلسة العلاجية بطريقة متناسبة وواضحة، وتم تنفيذ ذلك وتوضيح الزمن المستغرق للتنفيذ لكل خطوة من الخطوات العلاجية في كل جلسة.

- أهمية وجود محتوى ديني يتناسب مع البرنامج العلاجي، وتم ذلك في أغلب جلسات البرنامج بما يحتويه من محتويات نظرية كالتثقيف النفسي ومحتويات تطبيقية تتمثل في الوصف التفصيلي للعب الدور.

- أهمية صياغة بعض الأهداف بحيث تكون إجرائية قابلة للقياس، وقد تم تنفيذ ذلك على جميع الأهداف.

- أهمية إطلاق مسمى (مشارك) أو (مسترشد) بدلا من (مريض) في جميع جلسات البرنامج، وقد تم اختيار مسمى (مشارك) وتم تنفيذ ذلك على جميع الجلسات بالإضافة إلى دليل تطبيق البرنامج الخاص بالمشارك.

- ضرورة الإشارة إلى الفنيات العلاجية المستخدمة في الجلسات العلاجية بشكل مختصر. وتم تنفيذ ذلك على جميع الجلسات .

و- الفنيات العلاجية المستخدمة

تجدر الإشارة هنا أن الفنيات العلاجية التالية استخدمت ضمن الجلسات العلاجية في البرنامج العلاجي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان، علما بأن العديد من الفنيات تم تكرار استخدامها في أغلب الجلسات العلاجية حسب الحاجة إليها وفيما يلي عرض للفنيات العلاجية المستخدمة:

- يبدي المعالج دفئا صادقا في العلاقة وتقبلا غير مشروط للمشاركة حسب معايير الجلسات النفسية وطريقة بناء الألفة، ولكن هذا الدفء والعلاقة العلاجية لا تحول دون تطبيق إجراءات الجلسة بشكل جيد .

- يستخدم المعالج فنية التنفيس الانفعالي والتي من خلالها يتم تقوية العلاقة بين الأعضاء ببعضهم البعض ومع المعالج حيث ينفس كل عضو عن الخبرات التي لحقت بكل فرد جراء إدمانه متناولا الأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية من خلال استخدام فنية تحليل الخسائر والمكاسب بحيث يضع المريض قائمة بمحاسن ومساوئ سلوك الإدمان ثم يزن المريض المحاسن مقارنة بالمساوئ على مقياس من ١٠٠١ .

- يستخدم المعالج فنية لعب الدور وهو قيام المشارك بتمثيل أدوار معينة أمام المعالج حيث يكشف المشارك من خلال التمثيل مشاعره فيسقطها على شخصيات الدور التمثيلي وينفس عن انفعالاته ويستبصر بذاته ويعبر عن اتجاهاته وصراعاته ودوافعه. كما أن لعب الأدوار

يسهل عملية تقبل المشاكل لأننا نفهم المشاكل بطريقة أفضل إذا عرضت علينا وأننا نتعلم في الحياة من المثل والنماذج التي نشاهدها. ويوفر لعب الدور للفرد فرصة للتعلم والتدريب على الحلول الممكنة في موقف معين ولعب الدور العكسي يهدف الكشف للمشاركين عن أهمية التثاؤم والسلبية ودورة في عدم نيل الهدف المراد حيث يتم تكرار لعب الدور بهدف الكشف عن أهمية التفاوض والإقدام بإيجابية ودورة في الوصول إلى الهدف المنشود

- يستخدم المعالج فنية لعب دور المحرض فيلعب المعالج دور الشخص الذي يبت الأفكار التي تغري المريض بالتعاطي ويجب على المريض الرد على هذه الأفكار ويمكن تبادل الأدوار.

- يستخدم المعالج فنية الاسترخاء العضلي والمعرفي التخيلي وهي فنية تهدف إلى مساعدة المشاركين في كيفية التعامل الايجابي مع المواقف المختلفة وتبني القرارات الصحيحة للعلاج من الإدمان .

- يستخدم المعالج فنية الإنصات النشط، وهي استجابة تلقائية تتضمن التغذية الراجعة والإنصات العاطفي اللفظي وغير اللفظي .

- يستخدم المعالج فنية إعادة العبارات وذلك بهدف الزيادة في الإيضاح.

- يستخدم المعالج فنية الصمت لتحفيز المشارك على المشاركة الفعالة ورصد أكبر كم من التعبيرات لدى المشاركين .

- يستخدم المعالج فنية الأبعاد والتركيز بحيث يتم استبعاد الأفكار التلقائية والتركيز على تحديدها والتعرف عليها ومن ثم التخلص منها.

- يستخدم المعالج فنية التساؤل الموجه والأسئلة السقراطية لتنمية وفحص التناقضات لدى المشاركين فيما يخص مدى جدية المشارك في العلاج وعدم المشاركة الايجابية في البرامج العلاجية عبر استعراض أبرز السلوكيات الغير ايجابية ومناقشة المشاركين حول فعاليتها في العلاج ومحاولة تنمية التناقضات لديهم والتركيز على الأعضاء السلبيين من خلال المناقشة الجماعية مع بقية المشاركين الإيجابيين، وهي إحدى الفنيات التي تعتمد على المنطق حيث يسأل المعالج المريض سلسلة من الأسئلة التي تقود المشارك لاكتشاف التناقض الذي تنطوي عليه فكرة تلقائية سلبية لديه . على سبيل المثال، «عندما تحدث نفسك بأنك فاشل في حياتك، هل

تعني انك فاشل في بعض جوانب حياتك في بعض الأوقات، أو انك فاشل في كل الجوانب في بعض الأوقات؟» إذا أجاب المريض «بعض الجوانب في بعض الأوقات»، يمكنك إن تشير أي إن هذا هو حال كل البشر. إما إذا قال المريض «إننا فاشل في كل أوجه حياتي في كل الأوقات»، فيمكنك إن تشير إلى إن ذلك ليس صحيحا في أي حال من الأحوال لدى أي إنسان».

- يستخدم المعالج فنيات التساؤل خاصة ما يتعلق بالأسئلة المفتوحة والأسئلة غير المباشرة بحيث تكون صياغة السؤال جيدة ومحتوى السؤال جيد وطريقة تركيب السؤال جيدة، ويراعى ذلك في جميع ممارسته لفنية التساؤل.

- يستخدم المعالج فنية لعب الدور ولعب الدور العكسي بهدف الكشف دور الأساليب الخاطئة في التفكير ودورها في الإدمان والانتكاسة، بأن يتناول كل اثنين من المشاركين أخذ أسلوب خاطئ في التفكير وتمثيل دور عليه ثم تلخيص النتائج .

- يستخدم المعالج فنية لعب الدور لإظهار وجهي فكر متناقضين، وذلك عن طريق لعب الدور بالتناوب بين المريض والمعالج بتقمص دور الراعي والمسئول ودور الابن المدمن الذي لا يعتقد بأنه يحتاج للعلاج حتى بعد تأثير الإدمان عليه وذلك بهدف أن يقنع المدمن بأنه مدمن من خلال الأعراض التي عليه وأنه يحتاج للعلاج للمبررات والوصول بعد ذلك مع المشاركين إلى إلى أبرز الاستنتاجات.

- يستخدم المعالج فنية لعب الدور ولعب الدور العكسي للعب دور شخص غير مؤكد لذاته وكيفية خضوعه لرفقاء التعاطي الذين يؤثرون عليه تأثير سلبي، ثم يتم عكس الدور بحيث يكون المريض مؤكدا لذاته في تعامله مع رفيق التعاطي، ويتم ذلك على باقي المجموعة العلاجية بين كل مشاركين .

- استخدام فنية لعب الدور وذلك بهدف تقوية الاستقلالية الفكرية لدى المرضى بحيث يتم لعب دور المريض المحرض على عدم العلاج ومريض آخر يحرص على الرد المنطقي على تلك التحريضات السلبية، ويتم ذلك على جميع الأعضاء ثم تلخيص ما تم والخروج بالنتائج.

- يستخدم المعالج فنية الأبعاد والتركيز بحيث يتم استبعاد الأفكار التلقائية المسؤلة عن مسايرة

المريض لرفقائه وعدم قدرته على رفض المطالب الغير معقولة والتركيز على تحديدها والتعرف عليها ومن ثم التخلص منها.

- يستخدم المعالج فنية التنفيس الانفعالي والتي من خلالها يتم التعبير عن إخفاقات المرضى في تحقيق أدوارهم الحياتية وما هي السبل الممكنة لتفادي تلك الإخفاقات مستقبلاً.

- يستخدم المعالج إستراتيجية حل المشكلات ومواجهتها حيث يتم تنمية ميل قوي لدى المشارك أولاً بقبول الواقع في أن مواقف المشكلات تمثل جزءاً عادياً في الحياة وأنه من الممكن مواجهة معظم هذه المواقف بفاعلية وثانياً : التعرف على المواقف المشكلة عندما تحدث وثالثاً : كبح الميل للاستجابة سواء الاندفاع التلقائي أو التقاعس عن القيام بشيء ما، بذلك فإنه يتم توجيه المشارك ليرى المشكلات كحتمية وكمواقف تواجه مباشرة وبوضوح ونشاط. وذلك من خلال تدريب عملي يضم تثقيف نفسي واستعراض للخبرات مع توفير مادة علمية للمشاركين

- يستخدم المعالج فنية الإنصات النشط، وهي استجابة تلقائية تتضمن التغذية الراجعة والإنصات العاطفي.

- يستخدم المعالج كل من فنية التلقين اللفظي للاستجابة الصحيحة عبر استعراض المقولات المهمة حول أهمية الزمن والوقت، عبر حوار جماعي يشارك فيه جميع المشاركين وينتهي بالتوصل للمقولات الايجابية حول أهمية الوقت وجعل المشاركين يرددونها حتى يقتنعوا بها ومن ثم استخدام فنية الإطفاء لإزالة أثر التلقين ليقوم المشارك بالإستجابة الصحيحة باستقلالية.

- يستخدم المعالج فنية الأبعاد والتركيز بحيث يتم استبعاد الأفكار التلقائية المسؤولة عن نفاذ الوقت بغير عائد ايجابي، ومن ثم تحديدها عبر فنية ملء الفراغ والتي تستهدف أن يعرف المريض الرابط بين المثير والاستجابة وهي الأفكار التلقائية المسؤولة عن نفاذ الوقت وبالتالي يركز المريض على تلك الأفكار التي تحدد استجابته ثم التخلص منها وبالتالي ملء الفجوة المعرفية.

- يستخدم المعالج فنية التعليم والتدريب والذي يتضمن إعطاء المشارك مادة معرفية تتناول خطوات مرحلية لإدارة الوقت ويتبعها إعطاء المشارك واجب للتأكد من تعلمه لتلك المهارة.

- يستخدم المعالج فنية النمذجة والتي يقوم فيها المشارك بتشكيل نموذج مثالي يكون من خلاله يوم مثالي يستثمر فيه وقته ويراقب من خلاله سلوكه حتى يتمكن المشارك من تحديد الأوقات الغير مفيدة له

- يستخدم المعالج فنية التخلي عن المطالب والتي يتم فيها حث المشارك على التخلي عن مجموعة المبادئ السلوكية التي تتحكم في سلوكه والتي تتخذ صياغات لفظية ثم تحديد تلك الصياغات ومساعدة المشارك على استبدالها بعبارات ومبادئ مرنة وتشجع على أهمية الأهداف والمكاسب الحقيقية الأخيرة المستقبلية وإعطاء المشارك واجب للتأكد من أنه فهم عبر تحديد أبرز المبادئ السلوكية التي تحد وعطل من توجه المريض للمستقبل

- يستخدم المعالج فنية النمذجة وهي عملية موجهة تهدف إلى تعليم الفرد كيف يسلك، و ذلك من خلال الإيضاح، أو هي التغيير الذي يحدث في سلوك الفرد نتيجة لملاحظته لسلوك الآخرين، من خلال النمذجة الحية: وذلك لضرب بعض الأمثال والنماذج الحقيقية التي صبرت وعانت في العلاج بغية الوصول للهدف الحقيقي والمكسب الحقيقي وهو التعافي من الإدمان حيث يقوم النموذج بتأدية السلوكيات المستهدفة بوجود الشخص الذي يراد تعليمه تلك السلوكيات وفي هذا النوع من النمذجة لا يطلب من الشخص تأدية سلوكيات النموذج وإنما مجرد مراقبتها فقط. وغالباً ما يتأثر سلوك الفرد بملاحظة سلوك الآخرين، فالإنسان يتعلم العديد من الأنماط السلوكية مرغوبة كانت أو غير مرغوبة من خلال ملاحظة الآخرين وتقليدهم، وتسمى عملية التعلم هذه بمسميات مختلفة منها: التعلم بالملاحظة، التعلم الاجتماعي، التقليد، التعلم المتبادل.

- يستخدم المعالج فنية التعليم والتدريب والذي يتضمن إعطاء المشارك مادة معرفية تتناول كيفية وضع الأهداف القصيرة والبعيدة المدى.

- يستخدم المعالج فنية التعليم والتدريب والذي يتضمن إعطاء المشارك مادة معرفية تتناول تدريب المشارك على الحصول على المعلومات الدقيقة وإخضاعها للمنطق والنقد للخروج باستنتاجات واقعية يدرك من خلالها المريض بأن النجاح لا يأتي إلى من خلال العمل والجهد والصبر لا عن طريق الحظ، وإعطاء المشارك واجب يحل من خلاله حالة متعافي من الإدمان

وكيف أن اجتهاده وإرادته كان له دور في حصوله على هدفه المنشود.

- يستخدم المعالج فنية التغذية الراجعة : وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة . والخروج بالتائج.

الفصل الرابع

الفصل الرابع

عرض وتحليل بيانات الدراسة وتفسير نتائجها

٤ . ١ خصائص العينة

٤ . ٢ نتائج الدراسة التجريبية

٤ . ٣ التحليل الكيفي

٤ . ٤ التعليق العام على النتائج

عرض وتحليل بيانات الدراسة وتفسير نتائجها

يتناول هذا الفصل عرض خصائص العينة وعرض نتائج الدراسة وتفسيرها في ضوء المعالجات الإحصائية المستخدمة، والتي تم تحليلها بواسطة الحاسب الآلي، باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. كما يشمل عرض التحليل الكيفي وأخيراً التعليق العام على النتائج وفقاً لما يلي:

٤. ١ خصائص العينة

١- خصائص عينة الدراسة حسب العمر

الجدول رقم (٨)

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

يوضح الجدول رقم (١٧) خصائص أفراد الدراسة وفقاً للفئات العمرية وتبين من خلاله

المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		الفئات العمرية
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
—	—	٨,٣٪	١	٢١ سنة
—	—	٨,٣٪	١	٢٣ سنة
٨,٣٪	١	—	—	٢٤ سنة
—	—	٨,٣٪	١	٢٦ سنة
٨,٣٪	١	٨,٣٪	١	٢٨ سنة
—	—	٨,٣٪	١	٣٣ سنة
٨,٣٪	١	—	—	٣٨ سنة
—	—	٨,٣٪	١	٤٣ سنة
١٦,٧٪	٢	—	—	٤٥ سنة
٨,٣٪	١	—	—	٤٦ سنة
٥٠٪	٦	٥٠٪	٦	المجموع

أن جميع أفراد الدراسة في المجموعة الضابطة قد توزعوا بالتساوي على مختلف الفئات كالتالي : (٢١ سنة، و٢٣ سنة، و٢٦ سنة، و٢٨ سنة، و٣٣ سنة، و٤٣ سنة). في حين نجد أن نصف المجموعة التجريبية توزع على الفئات العمرية التالية (٢٤ سنة، و٢٨ سنة، و٣٨ سنة). كما نجد النصف الآخر من المجموعة توزع على الفئتين التالية: (٤٥ و٤٦ سنة)

٢ - خصائص عينة الدراسة حسب مدة التعاطي

الجدول رقم (٩)

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدة التعاطي

المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		مدة التعاطي
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
—	—	٨,٣ %	١	ستة شهور
—	—	٨,٣ %	١	ستة سنوات
٨,٣ %	١	—	—	سبع سنوات
—	—	١٦,٧ %	٢	ثمان سنوات
—	—	٨,٣ %	١	عشر سنوات
٨,٣ %	١	—	—	١١ سنة
—	—	٨,٣ %	١	١٥ سنة
٨,٣ %	١	—	—	٢٠ سنة
٨,٣ %	١	—	—	٢٢ سنة
١٦,٧ %	٢	—	—	٢٥ سنة
٥٠ %	٦	٥٠ %	٦	المجموع

يوضح الجدول رقم (١٨) خصائص أفراد الدراسة وفقاً لمدة التعاطي وتبين من خلاله أن جميع أفراد الدراسة في المجموعة الضابطة قد كانت مدة تعاظيهم من (١٥) سنة فأقل. أما المجموعة التجريبية فنجد غالبيتهم مدة تعاظيهم ٢٥ سنة وذلك بنسبة بلغت (١٦,٧ %)، كما نجد هناك نسبة بلغت (٨,٣ %) لكل ممن أفادوا بأن مدة تعاظيهم (٧ سنة، و١١ سنة، و٢٠ سنة، و٢٢ سنة).

٣ - خصائص عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي

الجدول رقم (١٠)

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي

المستوى الدراسي	المجموعة الضابطة		المجموعة التجريبية	
	العدد	النسبة	العدد	النسبة
ابتدائي	١	٨,٣٪	٢	١٦,٧٪
متوسط	٢	١٦,٧٪	٣	٢٥٪
ثانوي	٣	٢٥٪	١	٨,٣٪
المجموع	٦	٥٠٪	٦	٥٠٪

يوضح الجدول رقم (١٩) خصائص أفراد الدراسة وفقاً للمستوى الدراسي وتبين من خلاله أن غالبية أفراد الدراسة في المجموعة الضابطة مستواهم التعليمي ثانوي وذلك بنسبة بلغت (٢٥٪)، يليهم الذين مستواهم التعليمي متوسط وذلك بنسبة بلغت (١٦,٧٪)، ثم الذين مستواهم التعليمي ابتدائي وذلك بنسبة بلغت (٨,٣٪). أما المجموعة التجريبية فنجد غالبيتهم مستواهم التعليمي متوسط وذلك بنسبة بلغت (٢٥٪)، يليهم الذين مستواهم التعليمي ابتدائي وذلك بنسبة بلغت (١٦,٧٪)، ثم الذين مستواهم التعليمي ثانوي وذلك بنسبة بلغت (٨,٣٪).

٤ . ٢ نتائج الدراسة التجريبية

سيتناول الباحث عرض نتائج الدراسة وتفسيرها في ضوء المعالجات الإحصائية المستخدمة، والتي تم تحليلها بواسطة الحاسب الآلي، باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، والتي أمكن من خلالها التحقق من صحة فروض الدراسة، وقد أسفرت تلك المعالجات عن النتائج الآتية:

الفرض الرئيس

وينص على: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي».

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث الأسلوب الإحصائي المتبع عادة لمثل هذا الغرض وهو الأسلوب اللابارامتري باستخدام اختبار ويلكوكسون (Wilcoxon Test)) للكشف عن الفروق بين العينات المرتبطة (غير المستقلة). حيث أن هذا الاختبار يختبر الفرق بين متوسطي رتب مجموعتين غير مستقلة وذلك لاختبار دلالة الفروق بين متوسطات رتب الدرجات في القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، وفيما يلي نتائج ذلك:

الجدول رقم (١١)

اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
المجموعة التجريبية	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢,٢٠	٠,٠٢٧
	b الرتب الموجبة	٦	٣,٥	٢١,٠		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدي. b القياس البعدي أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدي

يوضح الجدول رقم (١١) اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test لمعرفة الفرق في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان في القياسين القبلي والبعدي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢,٢) دالة إحصائياً عند مستوى أقل من (٠,٠٥)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٣,٥) للقياس البعدي، مقابل (٠,٠) للقياس القبلي.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض المتمثل في: وجود فرق ذو دلالة إحصائية في متوسطات درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي (بعد تطبيق البرنامج العلاجي).

وذلك يتفق مع نتائج الدراسات السابقة حيث خلصت نتائج هذه الدراسات إلى فعالية البرامج العلاجية في إثارة وتنمية الدافعية لدى الأفراد، حيث دعمت التوجهات النظرية في اعتبار التدريب على تلك البرامج متطلبا أساسيا لتنمية الدافعية كما هو الحال في محمود (١٩٩١م)، ودراسة الصياح (١٩٩٧م)، ودراسة الطراونه (٢٠٠٥م)، ودراسة شحروري (٢٠٠٦م). كما تتفق مع نتائج الدراسات التي أثبتت فاعلية البرامج العلاجية المعرفية السلوكية في علاج الإدمان كما هو الحال في دراسة كل من (Carroll, 1994b) و الفقيه (١٩٩٦م) و (Carroll, 1996) و الجوهي (٢٠٠٤م).

ويتفرع من الفرض الرئيس الفروض التالية:

أولاً : الفرض الأول

وينص على : « توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد تحمل المسؤولية لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي ». وفيما يلي نتائج ذلك:

الجدول رقم (١٢)

اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في بعد درجة تحمل المسؤولية للمجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
تحمل المسؤولية	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢,٢٠	٠,٢٧.
	b الرتب الموجبة	٦	٣,٥	٢١,٠		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدي. b القياس البعدي أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدي

يوضح الجدول رقم (١٢) اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test لمعرفة الفروق في رتب متوسط درجات بعد تحمل المسؤولية على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢, ٢٠) دالة إحصائية عند مستوى أقل من (٠, ٠٥)، أي أن هناك فروق دالة إحصائية في درجة تحمل المسؤولية على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٣, ٥) للقياس البعدي، مقابل (٠, ٠) للقياس القبلي.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض الممثل في: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسطات درجات المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والبعدي على بعد تحمل المسؤولية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

ثانياً: الفرض الثاني

وينص الفرض الثاني على: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد الاستقلال لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي». وفيما يلي نتائج ذلك.

الجدول رقم (١٣)

اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في بعد الاستقلال للمجموعة

التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
بعد الاستقلال	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢, ٢٠	٠, ٠٢٧
	b الرتب الموجبة	٦	٣, ٥	٢١, ٠		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدي. b القياس البعدي أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدي

يوضح الجدول رقم (١٣) اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test لمعرفة الفروق في متوسط رتب درجات بعد الاستقلال على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢٠, ٢) دالة إحصائياً عند مستوى أقل من (٠, ٠٥)، أي أن هناك فروق دالة إحصائياً في درجة بعد الاستقلال على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٥, ٣) للقياس البعدي، مقابل (٠, ٠) للقياس القبلي.

ويتفق ذلك مع نتائج اختبار (T.Test) لمعرفة الفرق في متوسط درجات المجموعة الضابطة والتجريبية على بعد الاستقلال في القياس البعدي، وتبين من خلاله أن قيمة (ت) البالغة (٥٣, ٩) دالة إحصائياً عند مستوى (٠, ٠١)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في درجة بعد الاستقلال على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٤٦, ٠) للقياس البعدي، مقابل (٨٣, ٣٦) للقياس القبلي. كما يوضحها الجدول رقم (٢٥) في الملاحق.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض المتمثل في: يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسطات درجات المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والبعدي على بعد الاستقلال لصالح المجموعة التجريبية القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

ثالثاً : الفرض الثالث

وينص الفرض الثالث على: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد الدافعية الموجبة لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي». وفيما يلي نتائج ذلك.

الجدول رقم (١٤)

اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في بعد الدافعية الموجبة للمجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
الدافعية الموجبة	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢,٢٠	٠,٠٢٨
	b الرتب الموجبة	٦	٣,٥	٢١,٠		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدي. b القياس البعدي أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدي

يوضح الجدول رقم (١٤) اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات بعد الدافعية الموجبة على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢,٢٠) دالة إحصائياً عند مستوى أقل من (٠,٠٥)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في درجة بعد الدافعية الموجبة على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٣,٥٠) للقياس البعدي، مقابل (٠,٠) للقياس القبلي.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض الممثل في: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد الدافعية الموجبة لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

رابعاً : الفرض الرابع

وينص الفرض الرابع على: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد الاستبصار لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي». وفيما يلي نتائج ذلك.

الجدول رقم (١٥)

اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في بعد الاستبصار للمجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
الاستبصار	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢,٢٠	٠,٢٧.
	b الرتب الموجبة	٦	٣,٥	٢١,٠		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدي. b القياس البعدي أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدي

يوضح الجدول رقم (١٥) اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات بعد الاستبصار على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢,٢٠) دالة إحصائياً عند مستوى أقل من (٠,٠٥)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في درجة بعد الاستبصار على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٣,٥) للقياس البعدي، مقابل (٠,٠) للقياس القبلي.

حيث تشير القيمة (٠,٠) في كل من متوسط الرتب ومجموع الرتب وعدد العينة في القياس القبلي إلى التالي: بما أن الافتراض الإحصائي ينص على أن القياس القبلي أكبر من القياس البعدي لبعء الاستبصار، فعند طرح رتب القياس البعدي من رتب القياس القبلي تظهر لنا رتب إيجابية، لذلك فإنه لا تظهر القيمة السالبة نتيجة لأن القياس القبلي أقل من القياس البعدي.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض المتمثل في: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد الاستبصار لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

خامساً : الفرض الخامس

وينص الفرض الخامس على: « توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد الماثارة والتوجه للمستقبل لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي». وفيما يلي نتائج ذلك.

الجدول رقم (١٦)

اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في بعد الماثارة والتوجه للمستقبل للمجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
الماثارة والتوجه للمستقبل	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢,٢٠	٠,٠٢٧
	b الرتب الموجبة	٦	٣,٥	٢١,٠		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدي. b القياس البعدي أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدي

يوضح الجدول رقم (١٦) اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات بعد التوجه للمستقبل على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢,٢٠) دالة إحصائياً عند مستوى أقل من (٠,٠٥)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في درجة بعد التوجه للمستقبل على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٣,٥) للقياس البعدي، مقابل (٠,٠) للقياس القبلي.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض الممثل في: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي و البعدي على بعد الماثارة والتوجه للمستقبل لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

سادساً : الفرض السادس

وينص الفرض السادس على:

« توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد الشعور بأهمية الزمن لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي». وفيما يلي نتائج ذلك:

الجدول رقم (١٧)

اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في بعد الشعور بأهمية الزمن

للمجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
الشعور بأهمية الزمن	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢,٢٠	٠,٠٢٧
	b الرتب الموجبة	٦	٣,٥	٢١,٠		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدي. b القياس البعدي أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدي

يوضح الجدول رقم (١٧) اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات بعد الشعور بأهمية الزمن على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢,٢٠) دالة إحصائياً عند مستوى أقل من (٠,٠٥)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في درجة بعد الشعور بأهمية الزمن على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٣,٥) للقياس البعدي، مقابل (٠,٠) للقياس القبلي.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض الممثل في: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد الشعور بأهمية الزمن لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

سابعاً : الفرض السابع

وينص الفرض السابع على: « توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدى على بعد الفعالية الذاتية لصالح القياس البعدى بعد تطبيق البرنامج العلاجي ». وفيما يلي نتائج ذلك:

الجدول رقم (١٨)

اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في بعد الفعالية الذاتية للمجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدى

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
الفعالية الذاتية	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢,٢٠	٠,٢٧.
	b الرتب الموجبة	٦	٣,٥	٢١,٠		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدى. b القياس البعدى أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدى

يوضح الجدول رقم (١٨) اختبار ويلكوكسون Wilcoxon Test لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات بعد الفعالية الذاتية على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢,٢٠) دالة إحصائياً عند مستوى أقل من (٠,٠٥)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في درجة بعد الفعالية الذاتية على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدى إذ بلغ متوسط ذلك (٣,٥) للقياس البعدى، مقابل (٠,٠) للقياس القبلي.

وبالتالى تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض المتمثل في: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدى على بعد الفعالية الذاتية لصالح القياس البعدى بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

ثامناً : الفرض الثامن

وينص الفرض الثامن على: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدى على بعد التعافى الإيجابى لصالح القياس البعدى بعد تطبيق البرنامج العلاجى». وفيما يلي نتائج ذلك:

الجدول رقم (١٩)

اختبار ويلكيسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في بعد التعافى الإيجابى للمجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدى

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
التعافى الإيجابى	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢,٠٢	٠,٠٤٣
	b الرتب الموجبة	٥	٣	١٥		
	c تساوى الرتب	١	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدى. b القياس البعدى أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوى القياس البعدى

يوضح الجدول رقم (١٩) اختبار ويلكيسون Wilcoxon Test لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات بعد التعافى الإيجابى على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجى، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢, ٢٠) دالة إحصائياً عند مستوى أقل من (٠, ٠٥)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في درجة بعد التعافى الإيجابى على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجى، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدى إذ بلغ متوسط ذلك (٣, ٥) للقياس البعدى، مقابل (٠, ٠) للقياس القبلي.

وبالتالى تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض الممثل في: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدى على بعد التعافى الإيجابى لصالح القياس البعدى بعد تطبيق البرنامج العسطلاجى.

تاسعاً : الفرض التاسع

وينص الفرض التاسع على: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد الحاجة إلى التقبل لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي». وفيما يلي نتائج ذلك:

الجدول رقم (٢٠)

اختبار ويلكيسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في بعد الحاجة إلى التقبل للمجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
الحاجة إلى التقبل	a الرتب السالبة	٠	٠	٠	٢,٢٠	٠,٠٢٧
	b الرتب الموجبة	٦	٣,٥	٢١,٠		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدي. b القياس البعدي أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدي

يوضح الجدول رقم (٢٠) اختبار ويلكيسون Wilcoxon Test لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات بعد الحاجة إلى التقبل على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢,٢٠) دالة إحصائية عند مستوى أقل من (٠,٠٥)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في درجة بعد الحاجة إلى التقبل على مقياس الدافعية للعلاج للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٣,٥) للقياس البعدي، مقابل (٠,٠) للقياس القبلي.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض الممثل في: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي على بعد الحاجة إلى التقبل لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

عاشراً: الفرض العاشر

وينص الفرض العاشر على: «لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي على مقياس الدافعية بعد تطبيق البرنامج العلاجي». وفيما يلي نتائج ذلك:

الجدول رقم (٢١)

اختبار ويلكيسون Wilcoxon Test للكشف عن الفروق في متوسط درجة المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي

المتغير	الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة Z	مستوى الدلالة
المجموعة الضابطة	a الرتب السالبة	٤	٤, ٢٥	١٧	١, ٦٣	٠, ١٧٣
	b الرتب الموجبة	٢	٢	٤		
	c تساوي الرتب	٠	٠	٠		

a القياس القبلي أكبر من القياس البعدي. b القياس البعدي أكبر من القياس القبلي. c القياس القبلي يساوي القياس البعدي

يوضح الجدول رقم (٢١) اختبار ويلكيسون Wilcoxon Test لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان للمجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (١, ٦٣) غير دالة إحصائياً، أي أنه لا يوجد فرق دال إحصائياً في درجات المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية للعلاج قبل وبعد تطبيق البرنامج العلاجي.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض المتمثل في: لا توجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي على مقياس الدافعية بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

إحدى عشر: الفرض الحادي عشر

وينص الفرض على: «لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات

أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية قبل تطبيق البرنامج العلاجي». وفيما يلي نتائج ذلك:

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث الأسلوب الإحصائي المتبع عادة لمثل هذا الغرض وهو الأسلوب اللابارامتري باستخدام اختبار «مان ويتني» (اختبار U) للعينات المستقلة . حيث أن هذا الاختبار يختبر الفرق بين متوسطي رتب مجموعتين مستقلتين وذلك لاختبار دلالة الفروق بين متوسطات الرتب في القياس القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية، وفيما يلي نتائج ذلك:

الجدول رقم (٢٢)

اختبار مان وتني Mann - Whitney Test للكشف عن الفروق في متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في القياس القبلي

المتغير	المجموعة الضابطة والتجريبية	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة μ	قيمة Z	مستوى الدلالة
المجموعة الضابطة والتجريبية	ضابطة قبلي	٦	٧	٤٢,٠٠	١٥,٠٠	٠,٤٨	٠,٧
	تجريبية قبلي	٦	٦	٣٦,٠٠			

يوضح الجدول رقم (٢٢) اختبار مان وتني (Mann - Whitney Test) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة والتجريبية على مقياس الدافعية للعلاج في القياس القبلي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (١٥,٠٠) غير دالة إحصائياً، أي أنه لا يوجد فرق دال إحصائياً في درجات المجموعة الضابطة والتجريبية على مقياس الدافعية للعلاج في القياس القبلي.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض المتمثل في: لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية قبل تطبيق البرنامج العلاجي. وبالتالي يؤكد ذلك على تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية.

اثنا عشر : الفرض الثاني عشر

وينص الفرض الثاني عشر على: «توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج العلاجي».

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث الأسلوب الإحصائي المتبع عادة لمثل هذا الغرض وهو الأسلوب اللابارامتري باستخدام اختبار «مان ويتني» (اختبار U) للعينات المستقلة وذلك لاختبار دلالة الفروق بين متوسطات رتب الدرجات في القياس القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية، وفيما يلي نتائج ذلك:

الجدول رقم (٢٣)

اختبار مان وتني (Whitney Test - Mann) للكشف عن الفروق في متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في القياس البعدي

المتغير	المجموعة الضابطة والتجريبية	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة μ	قيمة Z	مستوى الدلالة
المجموعة الضابطة والتجريبية	ضابطة بعدي	٦	٣,٨٣	٢٣,٠٠	٢,٠٠	٢,٥٦	٠,٠٠٩
	تجريبية بعدي	٦	٩,١٧	٥٥,٠٠			

يوضح الجدول رقم (٢٣) اختبار مان وتني (Mann - Whitney Test) لمعرفة الفرق في متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة والتجريبية على مقياس الدافعية في القياس البعدي، وتبين من خلاله أن قيمة (Z) البالغة (٢,٥٦) دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠٠٩)، أي أن هناك فرق دال إحصائياً في درجات المجموعة الضابطة والتجريبية على مقياس الدافعية للعلاج، وكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي إذ بلغ متوسط ذلك (٩,١٧) للمجموعة التجريبية، مقابل (٣,٨٣) للمجموعة الضابطة.

وبالتالي تؤكد هذه النتيجة صحة الفرض الممثل في: توجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج العلاجي.

٤ . ٣ التحليل الكيفي لنتائج الدراسة

يعرض الباحث هنا التفسير الكيفي بعد أن تم تطبيق البرنامج العلاجي وسيكون هذا التفسير شاملا لجميع المشاركين و لكل الجلسات العلاجية بحيث يشمل عرضا لكل من :

أهداف البرنامج العلاجي

من خلال تطبيق البرنامج العلاجي فإنه تم تحقيق جميع أهداف البرنامج العلاجي، إلا أن البعض من الأهداف كان يستلزم من الباحث التكرار لإعادة التطبيق لبعض من المشاركين حيث انحصرت في الأهداف التالية:

- جلسة التعافي الإيجابي: (تحديد الأفكار السلبية المسئولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية) و (أهمية المشاركة في البرامج العلاجية من دون تشكيك).
- جلسة الإستبصار: (تحديد مدى سيطرتك على التوقف والتعاطي).
- جلسة الإستقلال: (قدرتك على تحديد تأثيرات المحيط الخارجي على سلوكك تجاه الإدمان).
- جلسة التوجه للمستقبل والمثابرة: (استنباطك لمجموعة المبادئ التي تتحكم في عدم قدرتك على الصبر للوصول إلى النواتج الأخيرة مكتفيا بالكاسب المؤقتة).
- جلسة الفعالية الذاتية: (اقتناعك بأن الحظ والظروف لا تعطل الإنسان عن تحقيق أهدافه).
- جلسة الحاجة إلى التقبل: (قدرتك على اكتشاف وتحديد السلوكيات الخاطئة والعادات القديمة المسئولة عن نظرة المجتمع لك).

ويؤكد الباحث على ضرورة المرونة في تطبيق البرنامج بما لا يؤثر على سير البرنامج العلاجي حيث أن بعض أهداف الجلسات من الممكن إعادة تطبيقها، حتى يتسنى للمشاركين الاستفادة من البرنامج العلاجي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة رضا المشاركين عن تحقيق الأهداف تراوح ما بين (١٠٠

(%) في أغلب الأهداف و (٨٣٪) في كل من الأهداف التالية حسب تقويم المشاركين للجلسات العلاجية وفق النماذج المعدة لذلك:

- ففي جلسة التعافي الإيجابي كان رضا المشاركين بتحقيق كل من الأهداف التالية: (تحديد الأفكار السلبية المسؤولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية) و (أهمية المشاركة في البرامج العلاجية من دون تشكيك) بنسبة ٣٨٪.

- وفي جلسة الاستبصار كان رضا المشاركين بتحقيق الهدف التالي: (تحديد مدى سيطرتك على التوقف والتعاطي) بنسبة ٣٨٪.

- في جلسة الاستقلال كان رضا المشاركين بتحقيق الهدف التالي: (قدرتك على تحديد تأثيرات المحيط الخارجي على سلوكك تجاه الإدمان) بنسبة ٣٨٪.

- في جلسة التوجه للمستقبل والمثابرة كان رضا المشاركين بتحقيق الهدف التالي: (استنباطك لمجموعة المبادئ التي تتحكم في عدم قدرتك على الصبر للوصول إلى النواتج الأخيرة مكتفيا بالمكاسب المؤقتة) بنسبة ٣٨٪.

- في جلسة الفعالية الذاتية كان رضا المشاركين بتحقيق الهدف التالي: (اقتناعك بأن الحظ والظروف لا تعطل الإنسان عن تحقيق أهدافه) بنسبة ٣٨٪.

- في جلسة الحاجة إلى التقبل كان رضا المشاركين بتحقيق الهدف التالي: (قدرتك على اكتشاف وتحديد السلوكيات الخاطئة والعادات القديمة المسؤولة عن نظرة المجتمع لك) بنسبة ٣٨٪.

ويرى الباحث أنه من الممكن أن نفسر أسباب انخفاض رضا بعض المشاركين في تحقيق الأهداف السابقة لكل من:

- نقص التفاعل أثناء التطبيق لبعض المشاركين.

- مقاومة بعض المشاركين و تدمره من المؤسسة العلاجية والمسؤولين.

الفنيات العلاجية

تجدر الإشارة هنا أن الفنيات العلاجية التي استخدمت ضمن الجلسات العلاجية في البرنامج العلاجي قد حققت الهدف منها، إلا أن هناك البعض من الفنيات لم تلقى التجاوب المطلوب في البداية من قبل المشاركين وهي كالتالي :

- فنية التنفيس الانفعالي : حيث أن المشاركين لم يتجاوبوا مع هذه الفنية في بداية الجلسات إلا أنهم بعد قيام المعالج بزيادة التفاعل فيما بينهم عبر عدة ألعاب جماعية وزيادة المناقشة الجماعية بين المشاركين وبالتالي أصبحت أكثر فاعلية من دون تحفظات من قبل المشاركين، وبالتالي فيوصى عند استخدامها بأن تكون المجموعة أكثر تفاعلاً، وذلك بالتركيز على زيادة التفاعل بين المشاركين وتقوية روح الجماعة بينهم، وهنا يوصي الباحث بأن تمتد جلسة تقوية روح الجماعة إلى جلستين.

- فنية لعب الدور : حيث أن المشاركين في بداية الجلسات لم يتقنوا أداء لعب الدور بسبب عدم التهيؤ المسبق لتنفيذ متطلبات الدور، مما جعل الباحث يعمل على التهيئة المسبقة لأي فنية للعب الدور قبل استخدامها بيوم بحيث يتم إشعار المشاركين قبل الجلسة بضرورة الإطلاع على متطلبات الدور، وكان لذلك أثر إيجابي لاستخدام فنية لعب الدور في بقية الجلسات، لذا يوصي الباحث بضرورة التهيئة المسبقة للمشاركين بالإطلاع على متطلبات لعب الدور قبل الجلسة العلاجية المزمع تنفيذ تلك الفنية بها .

- فنية الإبعاد والتركيز : حيث أن بعض المشاركين لم يتجاوب معها مما اضطر الباحث إلى تكثيف التثقيف النفسي لأثنين من المشاركين ليستوعبوا آلية تلك الفنية، وهنا يوصي الباحث بأهمية التثقيف النفسي الفردي للمشاركين قبل استخدام هذه الفنية ليتم استخدام هذه الفنية من دون مواجهة أية صعوبات.

مستوى التفاعل

من خلال ملاحظة الباحث للمشاركين من حيث مستوى تفاعلهم لاحظ الباحث أن أغلب المشاركين كان مستوى تفاعلهم (ممتاز) إلى (جيد جداً) إلا بعض من المشاركين (ن ١٠)

كان تفاعله أقل من زملائه على أغلب جلسات البرنامج العلاجي، على الرغم من تشجيعه من قبل الباحث وزملائه المشاركين.

الأحداث المتكررة

من خلال ملاحظة الباحث أثناء تطبيق البرنامج العلاجي، لوحظ الآتي:

١ - أهمية مراعاة عدم مجارة المشاركين في المناقشات الغير مرتبطة بتحقيق أهداف الجلسة، حيث لاحظ الباحث كثرة المشاركات الخارجة عن مواضيع الجلسة من قبل المشاركين رغبة منهم في التنفيس عما في داخلهم - مشاكل شخصية، تدمير من المسؤولين، مطالب أخرى - ولكن ذلك يصطدم مع أولويات الجلسة، لذلك وجب على المعالجين مراعاة ذلك بأن يتم إدارة الجلسة بكل احترافية مع عدم التقليل من أي من المشاركين، والتذكير بقواعد الجلسات العلاجية. (٢) التفاعل الإيجابي للمشاركين في لعب الأدوار، والطلب من قبلهم بزيادة الوقت المعد لذلك، لذا يوصي الباحث بأهمية مراعاة ذلك بزيادة الوقت المخصص للعب الدور لما لوحظ على المشاركين من تشويق واستفادة عملية جراء تطبيق فنية لعب الدور.

٤ . ٤ التعليق العام على النتائج

حاول الباحث تفسير النتائج في حدود الدراسات المتاحة و ملاحظاته الإكلينيكية. حيث أوضحت نتائج الدراسة بصفة عامة إلى فاعلية البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان وبالتالي أثبت البرنامج جدواه في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان. حيث أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي لدى العينة التجريبية وقد كانت قيمة (Z) دالة عند مستوى ٠,٠٥ لكل من القياس الكلي للدافعية للعلاج من الإدمان والأبعاد الفرعية للمقياس، مما يؤكد صحة الفروض.

وتوضح هذه النتيجة فاعلية البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.

كذلك تتفق النتيجة الحالية مع ما توصلت إليه (Carrol, 1994) حيث أفادت بأن للعلاج المعرفي السلوكي قدرة على تعزيز فترات التوقف لدى مرضى الإدمان ولا شك أن استخدام مثل هذا النوع من العلاج قد ساهم في التحسن الملحوظ لدى العينة التجريبية والتي انخفضت متوسطات درجاتهم بشكل دال عن العينة الضابطة.

و تتفق أيضاً هذه النتيجة مع ما توصل إليه فقيه ١٩٩٦ في دراسته حيث أفاد بأن للعلاج المعرفي فاعلية في انخفاض الأعراض الإدمانية .

كما تتفق هذه النتيجة أيضاً مع ما توصلت إليه (Carroll, 1996) من حيث فاعلية العلاج المعرفي السلوكي في استمرار الانقطاع عن التعاطي مقارنة بالعلاجات النفسية الأخرى مما يؤكد على قدرة ذلك النموذج و ضرورة الاعتماد عليه مع بقية العلاجات المستخدمة.

وتتفق النتيجة الحالية مع ما توصلت إليه Carroll et al, ٢٠٠٤ أيضاً في دراستها و الخاصة بفاعلية العلاج المعرفي السلوكي في التعامل مع مرضى الإدمان والذي يمددهم بطرق ومهارات جديدة للمواجهة مما يساعدهم على الاستمرار في التعافي.

كما تتفق مع نتائج كلا من محمود (١٩٩١)، ودراسة الصياح (١٩٩٧)، ودراسة الطراونه (٢٠٠٥)، ودراسة شحروري (٢٠٠٦). حيث خلصت نتائج هذه الدراسات إلى فعالية البرامج العلاجية في إثارة وتنمية الدافعية لدى الأفراد، حيث دعمت التوجهات النظرية في اعتبار التدريب على تلك البرامج متطلبا أساسيا لتنمية الدافعية.

ويؤكد (Monti et al, 1989) انه لا غرابه في أن العلاج المعرفي السلوكي يحسن العديد من جوانب المدمن ويستطرد بالقول بأن تلك الآفاق الواسعة للعلاج المعرفي السلوكي تتسع لتشمل بشكل مباشر علاج جميع المشكلات الأخرى في حياة المدمن والتي تنعكس أثارها على الوظائف التي ترتبط بتعاطي المخدرات. علي سبيل المثال مهارات القدرة علي حل المشكلات وإستراتيجية التكيف مع الانفعالات السلبية والقدرة علي تحمل النقد ومهارات البحث عن عمل.

ويرى (Holder et al, 1991) أن الأبحاث الحديثة لتقييم نتائج علاج الإدمان، أظهرت أن فنية التدخلات البديلة Contingency management والعلاج النفسي المعرفي السلوكي من أكثر

الوسائل العلاجية فاعلية من حيث مستوي المصدقية الموضوعية والتجريبية في علاج المدمنين وأن النماذج السلوكية بشكل عام والعلاجات السلوكية المعرفية بشكل خاص، أكثر فاعلية في علاج إدمان المخدرات . لذلك فإن الفنيات العلاجية السلوكية المعرفية لديها مصداقية تجريبية وإكلينيكية في فاعلية علاج إدمان المخدرات.

موجز عام على نتائج الدراسة

من خلال نتائج الفروض الدراسة يتضح مايلي:

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من التطبيق القبلي و البعدي لصالح التطبيق البعدي على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان والأبعاد الفرعية له مما يؤكد صحة الفروض . وهذا يشير لفاعلية البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان .
- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسطات درجات المجموعة الضابطة بين القياس القبلي والبعدي على مقياس الدافعية قبل تطبيق البرنامج العلاجي وهذا يشير إلى تكافؤ الأفراد في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.
- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج العلاجي وهذا يشير لأثر برنامج العلاج المعرفي السلوكي في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى المجموعة التجريبية، وهو ما يؤكد فاعلية البرنامج العلاجي .

الصورة العامة للنتائج

- بالنظر للنتائج التي توصل إليها الباحث يتبين عدد من النقاط المتعلقة بفاعلية البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان و نلخص ذلك فيما يلي:
- إن التحسن الحادث لدى العينة التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة إنما يعكس أهمية الجوانب المعرفية السلوكية و ضرورة التعرض لها في أي برنامج من برامج علاج الإدمان وهذا ما

أكدت عليه كل الدراسات السابقة التي تم عرضها (Carroll,1994، علي فقيه ٦٩٩١، Carroll, 1996. Carroll et al, 2004).

- استخدام برنامج العلاج المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان كمدخل علاجي ضمن برامج العلاج في مراكز علاج الإدمان.
من خلال النتائج السابقة يتضح انه قد تم التحقق من صحة فروض الدراسة التي تم تحديدها .

الفصل الخامس

الخلاصة والنتائج والتوصيات

١ . ٥ الخلاصة

٢ . ٥ التوصيات

٣ . ٥ مقترحات الدراسة

الفصل الخامس

الخلاصة والنتائج والتوصيات

سيتناول الباحث في هذا الفصل خلاصة الدراسة. ثم يعرج الباحث على كتابة التوصيات وأخيرا ينتهي الباحث بكتابة المقترحات.

٥ . ١ الخلاصة

تعد مشكلة الانتكاسة من أبرز المشاكل التي تبدو على رأس هرم المشكلات الإدمانية، وأنه ومن خلال ما لاحظته الباحث فإن من بين أسباب تكرار الإدمان في كل مرة - هو عدم وجود رغبة وقناعة من قبل المدمن نفسه في العلاج من الإدمان، وعدم وجود برنامج علاجي متخصص لتنمية الدافعية، وبناء عليه تم بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان وقياس فاعليته وتصميم مقياس لقياس الدافعية للعلاج من الإدمان لدى عينة من مدمني المخدرات، وتم استخدام المنهج التجريبي للتعرف على فاعلية البرنامج .

وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.

٥ . ٢ التوصيات

- بناء على النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال دراسته الحالية فإنه يوصي بشكل خاص بما يلي :
- تبني البرنامج العلاجي الذي استخدمه الباحث على جميع مراكز علاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية.
 - تبني طريقة العلاج المعرفي السلوكي نظرا لفاعليتها في تنمية الدافعية للعلاج من الإدمان.
 - تبني مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان كأحد أساليب التقييم في مراكز علاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية.

- الاستفادة من البرنامج العلاجي في عمل دورات تدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة بالدراسة .
- العمل على تقسيم البرنامج بمحتواه الحالي إلى ثلاث مراحل علاجية بحيث يكون لكل مرحلة مسمى يثير الدافعية لدى المدمن لتخطيه والوصول إلى المرحلة الثانية من العلاج حتى ينتهي البرنامج العلاجي .
- العمل على زيادة التعزيزات ضمن البرنامج العلاجي بحيث يتم إضافة تعزيزات مادية (مكافآت) ومعنوية (شهادات) بعد كل مرحلة علاجية يتقدم بها المشارك .
- العمل على تلافي بعض الصعوبات المتمثلة في عدم التيسير للباحثين التجريبيين من قبل المؤسسات الحكومية متمثلة في قطاعات وزارة الصحة .

٥ . ٣ مقترحات الدراسة

- استنادا إلى الإطار النظري، والدراسات السابقة، ونتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية في المجتمع السعودي التي أثارها الدراسة الحالية، وتعد مكملتها :
 - إجراء دراسة تتبعه لقياس فاعلية البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان عبر الزمن .
 - إجراء دراسة تجريبية للوقوف على فاعلية البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان مقارنة بعدد من الأساليب العلاجية المعروفة .
 - إجراء دراسة نفسية لتحديد الأفكار، والتصورات الخاطئة المسؤولة عن انخفاض الدافعية للعلاج من الإدمان على مستوى مراكز علاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية .
 - إجراء دراسة لتوضيح العلاقة بين انخفاض الدافعية للعلاج من الإدمان واضطرابات الشخصية .

المصادر والمراجع

إبراهيم، عبد الستار. (١٩٩٤م). العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث. القاهرة، دار الفجر.
إبراهيم، عبد الستار (١٤٠٠هـ)، العلاج النفسي الحديث قوة للإنسان، الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون:.

أبو جادو، صالح محمد (٢٠٠٣م). علم النفس التربوي. ط٣، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

أبو رياش، حسين والصافي، عبد الكريم وعمّور، أميمة وشريف، سليم (٢٠٠٦م). الدافعية والذكاء العاطفي، ط١، عمان: دار الفكر.

أبو عطية سهام درويش (٢٠٠٥م). مبادئ الإرشاد النفسي، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر.
أبو النيل، محمد السيد (١٩٨٥ م). علم النفس الاجتماعي - دراسات عربية وعالمية، القاهرة، دار النهضة العربية .

أحمد، نجاح أحمد (٢٠٠٠). العوامل المؤثرة على تنمية الدافعية لدى الطلبة في المدارس
أرنوف، ويتنج (١٩٧٧م) مقدمة في علم النفس، ترجمة: عادل عز الدين الأشول وآخرون، القاهرة، دار ماكجروهيل.

بابكر، كمال عمر (٢٠٠٣م) معال كشف المخدرات والمؤثرات العقلية. الخرطوم، دار عزة للنشر.
البار، محمد (١٩٩٠م) الأفيون ومشتقاته. دمشق، دار القلم.
البار، محمد. (١٩٩٠م) الأضرار الصحية للمسكرات والمخدرات. جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع.

البدور، نجا (٢٠٠٦م) مستوى الضغوط النفسية وعلاقته بمستوى الدافعية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية.

بني يونس، محمد محمود (١٤٢٧هـ) سيكولوجيا الدافعية والانفعالات. الطبعة الأولى - عمان: الأردن دار المسيرة للنشر والتوزيع .

بيك، أرون. (٢٠٠٠م). العلاج المعرفي والاضطرابات الانفعالية. (ترجمة مصطفى، عادل). القاهرة، دار الأفق العربية.

تركي، آمنة عبد الله (١٩٩٠ م) دراسة دافعية الإنجاز، تطورها وتباينها وعلاقتها ببعض المتغيرات لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة قطر، (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، جامعة عين شمس، القاهرة : مصر.

التل، سعيد، وآخرون (٢٠٠٧ م) مناهج البحث العلمي تصميم البحث والتحليل الإحصائي. الطبعة الأولى - عمان : الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع .

توق، محي الدين (٢٠٠٣ م). أسس علم النفس التربوي، ط٣، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. جابر، عبد الحميد و علاء كفا في (١٩٨٨ م) معجم علم النفس والطب النفسي الجزء الاول، القاهرة دار النهضة العربية .

جابر، عبد الحميد جابر، وكفا في، علاء الدين (١٩٩٠ م)، معجم علم النفس والطب النفسي: القاهرة دار النهضة العربية.

الجوهي، عبد الله عمر (٢٠٠٤ م) أثر النموذج المعرفي السلوكي في علاج عينة من مرضى الإدمان. رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة المنيا، مصر .

الجلبي، قتيبة و اليحيا، فهد. (١٩٩٦ م). العلاج النفسي وتطبيقاته في المجتمع العربي. الرياض، الإعلامية للنشر.

الحجار، محمد (١٤٠٩ هـ) التدريب العلاجي الطبي السلوكي في موضوع الإدمان على المواد المبدلة للمزاج، الكحول والمواد المخدرة . المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

الحجار، محمد. (١٩٩٢ م). العلاج النفسي الحديث للإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية. الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.

الحسين، أسماء عبد العزيز (١٩٩٧ م)، فاعلية العلاج النفسي السلوكي الجماعي في خفض درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات الإقامة الداخلية في جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير في علم النفس (غير منشورة)، الرياض: جامعة الملك سعود.

حسين، محي الدين، أحمد (١٩٨٨ م) الدافعية العامة وأبعادها عند الذكور : دراسة عامليه في إطار المجتمع السعودي . دراسات في الدافعية والدوافع، الطبعة الأولى -، القاهرة، دار المعارف.

حريم، حسين (١٩٩٧ م) السلوك التنظيمي - سلوك الأفراد في المنظمات، عمان : الأردن، دار
زهرا للنشر والتوزيع.

حموده، صفاء غازي (١٩٩١ م) : « فاعلية أسلوب العلاج الجماعي (السيكودراما) والممارسة
السلبية لعلاج بعض حالات اللجلجة » رسالة دكتوراة في علم النفس (غير منشورة)،
جامعة عين شمس - كلية التربية

الخطيب، جمال (١٩٩٠ م)، تعديل السلوك - القوانين والأجراءات، الطبعة الثانية: الرياض.
خليفة، عبد اللطيف (١٩٩٠ م)، الانفعالات في عبد الحليم محمود وآخرون، علم النفس العام،
القاهرة، مكتبة غريب .

دايفيدون، لندا (١٩٨٣ م)، مدخل علم النفس، ترجمة سيد طواب وآخرون. القاهرة، ماكجروهيل.
درويش، أحمد محمد، (٢٠٠٠ م)، الذكاء والشخصية بين الأحداث المتعاطين للمخدرات
والأحداث غير المتعاطين، مجلة كلية الآداب، جامعة أسيوط، العدد الخامس، الجزء الثاني.
دسوقي، كمال. (١٩٩٠ م). ذخيرة علوم النفس. القاهرة، وكالة الأهرام.

ربيع، محمد شحاته (١٩٧٧ م) أصول الصحة النفسية. القاهرة .
الرشدان، عبد الله، والهمشري، عمر أحمد (٢٠٠٢ م) المدخل إلى التربية والتعليم، عمان: الأردن،
دار الشروق للنشر والتوزيع .

الرشيدي، بشير وآخرون (٢٠٠٠ م). سلسلة تشخيص الاضطرابات النفسية . المجلد الرابع .
الكويت: مكتبة الكويت الوطنية للنشر.

روتر، جوليان (١٩٧١ م)، علم النفس الإكلينيكي: ترجمة، عطية محمود، هنا (١٩٨٩ م)، مكتبة
أصول علم النفس الحديث، عمان الاردن، دار الشروق
الزراد، فيصل محمد خير (١٩٨٨ م)، علاج الأمراض النفسية و الاضطرابات السلوكية، بيروت،
دار العلم للملايين.

الزهراني، أحمد سعيد (٢٠٠٦ م) فعالية برنامج علاجي نفسي مقترح لخفض درجة بعض
الاضطرابات النفسية التالية للصدمة . رسالة دكتوراة غير منشورة، الرياض : السعودية
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

زهرا، حامد (١٩٧٧ م)، الصحة النفسية والعلاج النفسي: الطبعة الثانية.

زهران، حامد (١٩٩٤ م). الصحة النفسية و العلاج النفسي . ط ٢، القاهرة: عالم الكتب.

زهران، حامد (١٩٩٨ م)، التوجيه والإرشاد النفسي، الطبعة الثالثة، الرياض.

الزعبي، دلال (٢٠٠٣ م)، ضغوط العمل وعلاقتها بالدافعية نحو العمل لدى رؤساء الأقسام الأكاديمية في الجامعات الأردنية، (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، عمان، الأردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

السباعي، زهير أحمد، وشيخ إدريس، عبد الرحيم (١٤١٧ هـ)، القلق وكيف تتخلص منه، بيروت: دارالقلم.

سري، إجلال محمد (١٩٩٠ م)، علم النفس العلاجي، القاهرة: عالم الكتب.

سعود، مصطفى عبد الرحمن (١٤١٠ هـ) أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالدوافع لدى طلاب الطلاب الصف الأول ثانوي بمكة المكرمة . سلسلة البحوث التربوية والنفسية، جامعة أم القرى .

سويف، مصطفى (٢٠٠٠ م) مشكلة تعاطي المخدرات بنظرة علمية القاهرة : مصر، الدار المصرية اللبنانية .

السيد، عبد الحليم محمود وآخرون، (١٩٩٠ م). علم النفس العام . القاهرة، مكتبة غريب .

الشبانات، عبد الرحمن ناصر (١٩٩٦ م)، تقييم فاعلية العلاج العقلاني الإنفعالي لحالات الرهاب الاجتماعي دراسة (عيادة)، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، المعهد العالي للعلوم الأمنية، قسم العلوم الاجتماعية، برنامج الرعاية والصحة النفسية.

الشهري، يزيد محمد (١٤٢٦ هـ) السلوك التوكيدي لدى مدمني المخدرات، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .

الشناوي محمد، والسيد عبد الرحمن (١٩٩٨ م) العلاج السلوكي الحديث، القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر.

عاقل، فاخر (١٩٧٩ م)، معجم علم النفس، بيروت: دار العلم للملايين.

عبابنة، محمد فلاح (١٩٩٩ م) مستوى دافعية الإنجاز وعلاقتها ببعض سمات الشخصية.

(رسالة ماجستير غير منشورة)، عمان: الأردن الجامعة الأردنية.

عبد الخالق، أحمد محمد (١٩٩٧ م)، أسس علم النفس، الطبعة الثالثة: دار المعرفة الجامعية.

عبدالله، معتز (١٩٩٠م) الدافعية، في: عبد الحليم محمود السيد وآخرون، علم النفس العام، القاهرة: مكتبة غريب.

العنزي، يوسف (١٤٢٤هـ) دراسة مقارنة بين مدمني الحشيش ومدمني الإيفتامين والعاديين في بعض خصائص الشخصية. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: السعودية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

العليان، عبدالعزيز. (١٩٩٦م). المملكة العربية السعودية والجهود الدولية لمكافحة المخدرات. الرياض، مكتبة العبيكان.

عيسوي، عبد الرحمن (١٩٨٤م)، العلاج النفسي، بيروت: دار النهضة العربية.

عيسوي، عبد الرحمن (بدون تاريخ)، العلاج النفسي، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي.

عيسوي، عبد الرحمن (١٩٩٠م) الإرشاد النفسي، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي.

عيسوي، عبد الرحمن (١٩٩٣م). علم النفس علم وفن. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.

غانم، محمد حسن محمد (٢٠٠٠م) الدافعية للعلاج لدى المدمنين - دراسة نفسية مقارنة. المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد العاشر، العدد ٢٥ - الجمعية المصرية للدراسات النفسية، القاهرة: مصر.

غباري، ثائر (٢٠٠٨م). الدافعية النظرية والتطبيق. عمان، دار المسيرة.

المدني، فاطمة (٢٠٠٠م). دافعية الانجاز في علاقتها بالتحصيل الأكاديمي رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك عبد العزيز كلية التربية بالمدينة.

فتح الله، مندور عبد السلام (٢٠٠٦م) التقويم التربوي دار النشر الدولي، الرياض: المملكة العربية السعودية.

الفسفوس، عدنان أحمد (٢٠٠١م) أساليب تعديل السلوك الإنساني، الطبعة الأولى، فلسطين.

فطيم، لطفي (١٩٩٣م)، العلاج النفسي الجمعي: القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.

الفقيه، علي حسن. (١٩٩٦م). فاعلية العلاج المعرفي في علاج حالات الإدمان على الهروين. مكة المكرمة. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة أم القرى.

قشقوش، إبراهيم وطلعت منصور (١٩٧٩م). (دافعية الانجاز وقياسها). القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية .

قطامي، يوسف و قطامي، نايفة (٢٠٠٠م) سيكولوجيا التعلم الصفي . عمان : الأردن، دار الشروق للنشر والتوزيع .

قطامي، يوسف، (١٩٩٨م) سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي . ط ١، الكويت: دار الشروق للنشر والتوزيع .

قطامي، يوسف (٢٠٠٣م). أسس علم النفس التربوي، ط ٣، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

كمال، علي (١٩٩٤م)، العلاج النفسي قديماً وحديثاً: الطبعة الأولى.
المحارب، ناصر إبراهيم (١٩٩٣م)، ممارسة العلاج الجمعي - المرشد للأخصائي النفسي، جامعة الملك سعود.

المحارب، ناصر ابراهيم. (٢٠٠٠م). المرشد في العلاج الاستعرافي السلوكي. الرياض، دار الزهراء.

محمد، عادل عبدالله. (٢٠٠٠م). العلاج المعرفي السلوكي أسس وتطبيقات. القاهرة. دار الرشاد.

محمود، نائلة (١٩٩١م) دراسة تجريبية في تنمية الدافعية. (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، كلية البنات، جامعة عين شمس، القاهرة : مصر .

محي الدين احمد حسين (١٩٩٨م). دراسات في الدافعية والدوافع. القاهرة، دار المعارف.
فهيمي، مصطفى (١٩٦٠م). الدوافع النفسية. القاهرة، مكتبة مصر.

ملحم، سامي محمد (٢٠٠٦م). سيكولوجية التعلم والتعليم: الأسس النظرية والتطبيقية، ط ٢، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

مليكه، لويس كامل (١٩٩٤م)، العلاج السلوكي وتعديل السلوك: الطبعة الثانية.

منصور، عبد المجيد و سيد أحمد (١٩٨٦م) الإدمان أسبابه ومظاهره الوقاية والعلاج . سلسلة

كتب مكافحة الجريمة الكتاب الخامس مركز أبحاث مكافحة الجريمة وزارة الداخلية

الرياض المملكة العربية السعودية .

النايلسي، محمد (١٩٩١م)، الإدمان وحش يهدد المجتمع، مجلة الثقافة النفسية العدد الخامس، المجلد الثاني، بيروت، دار النهضة العربية.
النشواتي، محمد. (١٩٩٢م). التصدي لأمراض العصر. دمشق، دار المعاجم.

المراجع الانجليزية

- Abramas, D.B. & Niaura, R.S (1987), Social Learning theory. In H.T.Blane & K.E. Leonard (Eds) Psychological theories of drinking and alcoholism: (P.P 131 – 180) Guilford
- Abdelmaugoud, M. & Moftah, A. (1995). Effect Of Psychotherapy and Behavioral Disturbances among drug addicts in Saudi Arabia. Current Psychiatry, 2, (1), 31 -39.
- Alksne, Harold. (1980). The life cycle of Addiction. A conceptual framework for the examination of careers in drug abuse. PhD. Dissertation, the City University of New York.
- Beck, A., Wright, F., Newman, C. & Liese, B. (1993). Cognitive therapy of substance abuse. the Guilford presses, New York, London.
- Blackburn, I & Twaddle, V. (1996). Cognitive therapy in action. A practitioner's casebook. London: Souvenir Press.
- Brannon, L., & Feist, J. (1992) Health Psychology. Belmont, California: Wadsworth Pub.Co., p. 366.
- Biernacki, P. (1986) Pathways from Heroin Addiction. Philadelphia : Temple University Press.
- Blane, H. T (1990) The Personality of the alcoholic. In M.E. chafetz (Ed) Frontiers of alcoholism. New York. Aronson.
- Abate, L, et al (1992): Handbook of Differential Treatments for Addictions. London: Ally and Bacon
- Cassidy, T. and Richard, L. (1991) Achievement Motivation, Educational Attainment, Cycles of Disadvantage and Social Competence Some Longitudinal Data. British Journal of Educational Psychology.

- Cappell, H. & Greeley, J. (1987) Alcohol and tension Reduction: An update on research and theory. In H.T.Blane & K. Leonard (Eds) Psychological theories of drinking and alcoholism. (P.P 15 – 44) New York. Guilford.
- Carroll, K. M. Nich, C.; Ball, S.A.; McCance, E.; & Rounsaville, B.J. (in press). Treatment of cocaine and alcohol dependence with psychotherapy and disulfiram. *Addiction*.
- Carroll, K.M.; Rounsaville, B.J.; Nich, C.; Gordon, L.T.; Wirtz, P.W.; and Gawin, F.H. (1994a). One year follow - up of psychotherapy and pharmacotherapy for cocaine dependence: Delayed emergence of psychotherapy effects. *Arch Gen Psychiatry* 51(12):989 -997.
- Carroll, K. M.; Rounsaville, B.J. Gordon, L.T.; Nich, C.; Jatlow, P.M. Bisighini, R.M.; & Gawin, F.H. (1994b). Psychotherapy and pharmacotherapy for ambulatory cocaine abuser. *Arch Gen Psychiatry*, 51(3):177 -187.
- Carroll, K.M.(1996). Relapse prevention as a psychosocial treatment approach, Areview of controlled clinical trials. *Exp Clin Psychopharmacol* 4:46 -54.
- Carrol, K. M. 1, Samuel A. B, ; Nich C; Tami L. Frankforter, BS; Julia Shi, ; B J. Rounsaville,(2004). Efficacy of Disulfiram and Cognitive Behavior Therapy in Cocaine-Dependent Outpatients A Randomized Placebo - Controlled Trial, *Arch Gen Psychiatry*. 2004;61:264 -272.
- Connie, frith (1997).Motivation to learn .University of saskatchwen, www.usask.ca/education.
- Corey, G. (1991) Case approach to counseling and psychotherapy (Third Edition). Pacific Grove:Brooks/Cole.
- Dupont, R. L. Getting Tough on Gateway DruGs. Washington, D.C. : American Psyhiatric Press, 1984.
- Deci, E.L.,Intrinsic. Motivtion, new York :plenum press, 1975
- Edgerton. J.E., & Campbell, R. J., 1994. Op. Cit. PP. 3 -4.
- Edwards, G., Arif, A., & Hofgson, R. Nomenclature and Classification of Drug and Alcohol Related Problems: a W.H.O. Memorandum. Bulleting World Health Organization, 1981, 59,225 -242.

- English, H.B. & English, A.C., (1985) *A comprehensive Dictionary of psychology and psychoanalytical terms*, New York: Longmans, Green Co. Inc.
- Ellis, A. (1996) *Better, deeper, and more enduring brief therapy. The rational emotive behavior therapy approach*. New York: Brunner/Mazel.
- Gossop, M. (1982) Bradley, B., & Brewis, R. Amphetamine Withdrawal and Sleep disturbance. *Drug and Alcohol Dependence*, 10, 177 -183.
- Gossop, M. *Relapse and Addictive Behavior*. London: Routledge, 1989
- Gossop, M. *Drug and Alcohol Problems*. In S.J.E. Lindsay & G.E. Powell (Eds.). (1994) *The Handbook of Clinical Adult Psychology*. London and New York: Routledge, p. 363 -368.
- Hodgson, R. (1980) The alcohol Dependence Syndrome: A step in the Wrong Direction. *British Journal of Addiction*, 75, 225 -263.
- Holder, H. Longabaugh, R. Miller, W, et al (1991). The cost effectiveness of treatment for alcohol problems. A first approximation. *Journal of studies on alcohol*; 52:517 -40.
- Helzer, J.E. Psychoactive Substance Abuse and Its relation to dependence. In Thomas A. Widiger, et al. (Eds.), *DSM - IV Sourcebook*, Vol. 1. Washington, D.C. : American Psychiatric Association, 1994, P.25.
- Hula, J.G. (1987) self – awareness model, in H.T. Blane & K.E. Leonard (Eds) *psychological theories of drinking and alcoholism* (pp 272 -304) New York: Guilford.
- Himmelsbach, K. and L.F. Small. (1937). *Clinical Studies of Drug Addiction*. Supplement NO. 125 to the Public Health Reports. Washington, D.C: U.S. Government Printing Office.
- Phares, E. J. (1984). *Clinical psychology: concepts, methods and professions*. Homewood. The Dorsey Press.
- Prochaska, J.O., DiClemente, C.C., & Norcross, J.C. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviors. *American Psychologist*, 47, 1102 -1114.

- Vogel, V.H. Isbell & K.W. Chapman. (1948). The present State of Narcotic Addiction with Particular Reference to Medical Indications and Comparative Addiction Liability of the Newer and Older Analgesic Drugs. Journal of the American Medical Association, Vol.138. 1 December.
- Slavson, S.R. (1957): Are there dynamics in the repy groups” International Journal Of Group Psychotherapy.
- Korman, A.k., (1974) The psychology of motivation. New York :prentice_Hall Inc.
- Jung, J., understanding, Human Motivation: A cognitive Approach, new York :macmillan pub .co., Inc., 1978
- Lawson, G.W., Ellis, D.C., & Rivers, P.C. (Eds.), Essentials of Chemical Dependency Counseling. Rockville MD: aspen Sys. Corp, m 1984, P.37.
- Lrner, W.D. & Fallon, H.J. The Alcohol Withdrawal Syndrome. New England Journal of Medicine, 1985.313, 951 -952.
- Meeks. J.D (1987) Adolescent substance abuse. Etiology and dynamics. In J.D Nospitz (Eds) Basic handbook of child psychiatry (Vol V.pp 388 393 _). New York. Basic Books.
- Marx, m.A., (1976). I ntroduction to psychology. london, mcmillan.
- Mc cielland, d.c., The Achieving so ciety, Princeton new jer _sey: van nostrand, 1961.
- Mc cielland, d.c. atkinson, j.w, clark, R.A. a & Lowell, E.L. The Achierement Motive, new York :Appleton _cen _tury _crofts, 1976
- Monti, P. Abrams, D. Kadden, R, et al. (1989). Treating Alcohol dependence: A coping skills training guide in the treatment of alcoholism. New York, Guilford Press
- Rokeach, M., Beliefs, Attitudes and values :A Theory of or ganization and change, san Francisco :Jossy _Bess pub, 1976.
- Oetting, E.R. & Beauvais, F. peer Cluster Theory : Drugs and the Adolescent. Journal of counceling and Development, 1991, 65, 17 -22.
- Wieder, H. & Kaplan, E.H. (1969) Drug use in adolescents Psychodynamic meaning and pharmacologic effect. Psychanalytic study of the child, 24, 399.

- Wilson, J.D., personality and social Behavior, in: H.J. Eysenck (ed.) (1981). A model of personality, New York: Springer-Verlag, 210-254.
- World Health Organization Expert Committee on Drug Dependence. Twentieth Report (1974) (Tec. Rep. Series No. 551). Geneva, Switzerland.
- Feather, N.T. values, Expectancy and Action, Australian psychologist, 1979:14,3,243-260.
- Sibulkin, A.E., What's to them? the value of consideration to children, in: D.O. Bridgeman (ed.) (1983) The nature of pro-social Development: Interdisciplinary Theories and strategies, New York: Academic Press, 139-162.
- Zinberg, N.E. (1981) Social Interactions, Drug Use, and Drug Research. In: J.H. Lawinson & P. Ruiz (Eds.). Substance Abuse: Clinical Problems and Perspectives. Baltimore: Williams & Wilkins, 91 -108.

المراجع الإلكترونية

- الترتوري، محمد (٢٠٠٦م). دافعية الانجاز والتحصيل الدراسي، مقالة منشورة على الانترنت www.minshaw.com
- الجريوي، محمد عبد الله (٢٠٠١م) المخدرات خطر ومواجهة. (www.suhuf.net).
- رضوان، (٢٠٠٧م). السلوك الانساني. المنتدى السعودي للتربية الخاصة .
(<http://www.khass.com/vb/forumdisplay.php?f=30>)
- شحروري (٢٠٠٦م) استقصاء فاعلية برنامج تدريبي مبني على المهارات المعرفية والانفعالية في إثارة الدافعية، دراسة منشور على الإنترنت . الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن. <http://www.mansaf.org/amana/tanous2.htm>
- الصياح (١٩٩٧م) فاعلية برنامج تدريبي لزيادة الدافعية لدى المعلمين، دراسة منشور على الإنترنت . الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن.
<http://www.mansaf.org/amana/tanous2.htm>

الطراونة (٢٠٠٥م) فاعلية برنامج إرشادي نفسي جمعي عقلاني انفعالي معرفي في تحسين الذات المدركة والدافعية والمعدل التراكمي، دراسة منشور على الإنترنت . الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن.

<http://www.mansaf.org/amana/tanous2.htm>

عمران، محمد (٢٠٠٤م). الدافعية: تعريفها أسبابها استثارته، منشور على موقع

(www.almualwm.net)

الغريب، عبد العزيز (٢٠٠٧م) مشكلة العود للإدمان . دراسة منشورة على الإنترنت.

(<http://www.glaksa.com/vb/archive/index.php/t12489.html> _

ناصر الدين، سعد (١٤٢٨هـ) دروس وإشراف ومشاكل التعليم . مقالة منشورة على الانترنت المنتدى العربي الموحد منتدى التربية والتعليم .

الملاحق

الملحق رقم (١) مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان

الملحق رقم (٢) محكمين مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان

الملحق رقم (٣) البرنامج العلاجي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان

الملحق رقم (٤) محكمين البرنامج العلاجي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان

الملحق رقم (٥) المخاطبات الرسمية

الملحق الأول: مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان

من إعداد

يزيد بن محمد الشهري

إشراف

الأستاذ الدكتور / عبد الحفيظ مقدم

وفقك الله

أخي العزيز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

فيما يلي مجموعة من العبارات التي قد تعبر عن مشاعرك واتجاهاتك وتصرفاتك .
أرجو قراءة كل عبارة بتمعن، ثم وضع علامة (✓) أمام الإجابة التي تتفق معك .
مع ملاحظة أن الإجابة الصحيحة هي التي تعبر عن رأيك الشخصي بدقة وأمانة .
وتوجد خمس إجابات أمام كل عبارة لاختيار واحدة منها :

فإذا وافقت عليها تماما ورأيت أنها تعبر عن رأيك فأرجو وضع علامة (✓) تحت الخانة (دائما).
وإذا رأيت أن العبارة تنطبق عليك كثيرا فأرجو وضع علامة (✓) تحت الخانة (غالبا).
أما إذا كانت العبارة تنطبق عليك إلى حد ما فأرجو وضع علامة (✓) تحت الخانة (أحيانا).
وإذا كانت العبارة لا تنطبق عليك ويندر حدوثها فأرجو وضع علامة (✓) تحت الخانة (نادرا).
أما إذا كانت العبارة لا تنطبق عليك تماما فأرجو وضع علامة (✓) تحت الخانة (أبدا)
مع ملاحظة ما يلي :

أتمنى عدم ترك أي عبارة من دون إجابة عنها .

أنه لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ولا تقص وقتا طويلا في أي عبارة منها . .
أن هذه المعلومات محاطة بسرية تامة، ولا تخدم إلا أغراض البحث العلمي .

العمر : مدة التعاطي :

التعليم :

١ - () أمي ٢ - () ابتدائي ٣ - () متوسط
٤ - () ثانوي ٥ - () جامعي ٦ - () فوق الجامعي

شاكر لك حسن تعاونك واستجابتك الصادقة

م	العبارات	دائماً	غالباً	أحياناً	نادراً	أبداً
١	أشعر أنني قادر على مواجهة المواقف الضاغطة من دون تردد					
٢	أتحمل مسؤولية ما أقوم به من أفعال					
٣	أدرك أن الفرد لا بد أن يتحمل تبعات أخطائه					
٤	أشعر بالضيق عندما لا أستطيع مواجهة العقبات					
٥	أنجز بها أكلف به من أدوار ومسؤوليات					
٦	أدرك جميع متطلبات ومهام أدوارى الحياتية					
٧	أواجه المشكلات التي تعترض حياتي بدون مساعدة أحد					
٨	ألجأ إلى التبرير عند فشلي في مواجهة المواقف المختلفة					
٩	أشعر أنني لا أستطيع النجاح في كثير من أمور الحياة					
١٠	أضع لنفسي خطط وأهداف معقولة وأعجز عن تحقيقها					
١١	أشعر بالعجز في تدبير أمور حياتي والتحكم بها					
١٢	يبدو أن بعض الناس قد خلقوا للنجاح وبعضهم خلق للفشل بصرف النظر عما يبذله كل منهم من جهد					
١٣	أشعر بالخوف عندما أضطر إلى تحمل مسؤولية عمل ما					
١٤	أشعر أن الاستمرار في التوقف عن المخدرات يحتاج جهداً كبيراً يفوق قدراتي					
١٥	أشعر أنني قادر على الاستقلال عن الآخرين وتدبير شؤون حياتي					
١٦	أشعر بالضيق وعدم الرضا عندما لا أستطيع القيام بالأعمال التي توكل إلي					
١٧	يؤثر فيني الآخرون لدرجة أنني أميل إلى تقليدهم					
١٨	لا أستطيع أن أتجنب رفقائي عندما يلحون على مسائرتهم					
١٩	يؤثر ما يقوله لي أصدقائي في أكمال مسيرة علاجي من الإدمان .					
٢٠	تأثير أصدقائي قادمي لارتكاب أفعال لا أجدها مناسبة					
٢١	أفضل أن أعالج أموري بنفسي					
٢٢	أشعر بالراحة عندما يتخذ آخرون قرارات في أمور تخصني					
٢٣	أميل للدفاع عن وجهة نظري حتى لو وجدت معارضة كبيرة حولي					
٢٤	كلما وجدت العمل الذي أقوم به صعباً ازددت إصرار على إتمامه					
٢٥	أشعر بكثير من التردد والحيرة في اتخاذ قراراتي حتى في الأمور البسيطة					

٢٦	أحرص على أن أواجه مواقف فشلي بشجاعة كي أستفيد من أخطائي				
٢٧	لا أعتقد بأنني مدمن على المخدرات				
٢٨	أشعر بأنني فاقد للسيطرة على توقفي من تعاطي المواد المخدرة				
٢٩	أجد أنني كمدمن أحتاج للعلاج من إدماني على المخدرات				
٣٠	أدرك أنني بإدماني على المخدرات أقع في مشكلة				
٣١	يؤثر تعاطي المواد المخدرة على صحتي الجسمية والنفسية				
٣٢	أجد أن مزاجي يتقلب عندما أكون في حالة تعاطي للمخدر				
٣٣	أستطيع أن أسيطر على نفسي وأنا متعاطي				
٣٤	أستطيع أن أتوقف عن التعاطي من دون مساعدة الآخرين				
٣٥	ذهابي إلى أماكن وجود المخدرات والأشخاص الذين يتعاطون لا يؤثر في انتكاستي على المخدرات				
٣٦	عندما أقوم بنشاط معين أشعر بأنني غير نشيط للقيام به				
٣٧	عند مواجهة الأعمال الصعبة أجد أنني غير جدي وغير مهتم بأدائها				
٣٨	أجد أنني أنسحب من المواقف الصعبة ولا أحاول السعي لتحقيقها				
٣٩	عند محاولتي للتوقف عن تعاطي المواد المخدرة أجد أنني غير جدي في التوقف				
٤٠	في حال واجهتني صعوبات أو إغراءات تمنعني عن التوقف عن التعاطي فإنني أسعى بكل جد لتجاوزها .				
٤١	أشعر بأنني غير مكترث بالأنشطة العلاجية المقدمة للعلاج من الإدمان				
٤٢	أسعى لأن أكون شخصية مشهورة في المستقبل				
٤٣	أشعر أن الحظ يساعدني كثيرا في تخطي المصاعب				
٤٤	أحرص على أن يكون لي دور إيجابي بين أخوتي ومحيط أسرتي				
٤٥	أشعر أنني لا أستطيع أكمال ما خططت له من أهداف ومطامح				
٤٦	أشعر بالملل وعدم الرغبة في أكمال العلاج من الإدمان				
٤٧	ينتابني ضيق في الصدر وعدم رغبة في إكمال العلاج من الإدمان				
٤٨	أعتقد أن من أسباب مشكلاتي أنني غير مثابر				
٤٩	أعتقد أن عدم صبري يؤدي بي إلى المشاكل				
٥٠	لم استطع أن أحقق أي من أهدافي بسبب عدم صبري في سبيل الحصول عليها				
٥١	أشعر دائما أنني في سباق مع الزمن لتحقيق أهدافي				

٥٢	لا أترك وقت فراغي يفوتني دون أن أستثمره فيما هو مفيد				
٥٣	لا أشعر بملل من العمل المتواصل لحل مشكلة حتى أجد لها حلا مناسباً				
٥٤	أحاسب نفسي على عما قمت به سابقاً وما سوف أقوم به مستقبلاً				
٥٥	أحاول أن أستفيد من كل ما يقدم لي من خدمات علاجية				
٥٦	يساعدني التعاطي على نسيان مشاكلي				
٥٧	يسبب التعاطي مشاكل جسمية تضر بصحتي				
٥٨	يساعدني التعاطي على القيام بعملٍ بشكل أفضل				
٥٩	يجعلني التعاطي منعزلاً عن الآخرين				
٦٠	أشعر بالسعادة وأنا في حالة تعاطي				
٦١	أعتقد أن أسرتي لا تتضرر من استخدامي				
٦٢	يساعد التعاطي في تقوية الجانب الجنسي لدي				
٦٣	يقلل التعاطي من علاقتي الاجتماعية				
٦٤	أشعر بالضيق وأنا متعاطي				
٦٥	تتأنيبني بعض الشكوك والأفكار بسبب التعاطي				
٦٦	أعتقد أن الوقت لا زال مبكراً لتوقي عن التعاطي				
٦٧	أجد أنني أستثمر وقتي في أشياء مفيدة				
٦٨	أشعر أنني قادر على تنظيم وقتي				
٦٩	أستطيع أن أتخلص من المغريات التي تستنفذ وقتي بدون فائدة				
٧٠	يضايقني رفقائي عندما يلهونني عن أعمالي وعن أسرتي				
٧١	يتأنيبني إحساس بأنني غير قادر على التحكم في الوقت خلال حياتي اليومية				
٧٢	أحب أن أقضي وقتاً طويلاً في السهر والسمر				
٧٣	أشعر أنني أقضي وقتاً طويلاً في أمور وأشياء تافهة وبسيطة				
٧٤	كثيراً ما أجد نفسي غير قادر على استثمار وقت فراغي في شيء مفيد				
٧٥	أفضل ساعات يومي هي التي أقضيها بين أصدقائي				
٧٦	أنظم جدول لما ينبغي أن أقوم به طوال اليوم				
٧٧	أشعر أن النجاح في الحياة إنما يعتمد على أن يختار الإنسان موقفاً مناسباً في الوقت المناسب				
٧٨	أخطط لما أقوم به من أعمال				

٧٩	تنتابني أفكار حول مستقبل حياتي				
٨٠	أفكر في حالة حياتي وأنا غير متعاطي للمخدرات				
٨١	أشعر بالسعادة حينما أفكر في مستقبل حياتي وأنا متعاافي من المخدرات				
٨٢	أتجاهل بعض المكاسب السهلة في سبيل الحصول على مكاسب ومغانم أعلى				
٨٣	أجد صعوبة كبيرة في الصبر على متطلبات العلاج				
٨٤	أهتم بالمستقبل أكثر من اهتمامي بالحاضر				
٨٥	كثيرا ما انشغل في أمور تخص مستقبلي				
٨٦	غالبا ما أخطط لكي أحقق أهدافي في المستقبل				
٨٧	أدرك أن نجاحي في العلاج يتطلب مني اجتهاد وتعب				
٨٨	أعتقد أن حظي وظروفي هي المسؤولة عن عدم علاجي من الإدمان				
٨٩	أعتقد أن النجاح في الحياة يتطلب الحظ				
٩٠	أعتقد أن أمور الحياة لا تسير بدون الاعتماد على الآخرين				
٩١	أشعر بالسرور عندما أقوم بأعمالي بدون مساعدة أحد				
٩٢	قرار العلاج من المخدرات قرار ي وحدي ولا يمكن أن يتخذه شخص آخر نيابة عني				
٩٣	أن المشاكل التي أتعرض لها لا تعيق رغبتني في استكمال علاجي أمر بها لا تجعلني أستطيع المواصلة في العلاج				
٩٤	خسارتي لأشياء مهمة في حياتي تجعلني لا أرغب في العلاج من الإدمان				
٩٥	أشعر أنه لا فائدة مني وذلك يحبط من معنوياتي تجاه العلاج من الإدمان				
٩٦	أدرك بأهمية البرامج العلاجية الحالية في علاجي من إدمان المخدرات				
٩٧	أعتقد أن البرامج العلاجية المقدمة هي المسؤولة عن عدم اقتناعي بالتوقف عن المخدرات				
٩٨	مشكلتي في عدم الاقتناع بالعلاج أنه ليس هناك أحد يفهمني				
٩٩	لا أستفيد من الجلسات العلاجية لأنها غير فعالة				
١٠٠	أشعر بعدم القدرة على التوقف على المخدرات بسبب حياتي التعيسة				
١٠١	أشعر برغبة في المشاركة في جميع الأنشطة العلاجية المقدمة لي				
١٠٢	أدرك أنني لن أستفيد من البرامج العلاجية المقدمة				
١٠٣	توقفي عن التعاطي لن يكون بسبب وجودي في المستشفى				

					١٠٤ إن عدم توفير بعض الخدمات لي في المستشفى يجعلني لا أرغب في مواصلة البرنامج العلاجي
					١٠٥ عدم توفير السجائر لي يجعلني غير راغب في إكمال العلاج
					١٠٦ أعتقد أن توقفي عن المخدرات يساعد في تقبل أسرتي لي
					١٠٧ أشعر بالحزن عندما ينظر الناس لي بأنني مدمن
					١٠٨ أرغب في تغيير حياتي من أجل تغيير نظرة الناس عني
					١٠٩ أشعر بأنني ليس لي قيمة بين أفراد جماعتي
					١١٠ أدرك بأنني أسأت لسمعة أسرتي بتعاطي المخدرات
					١١١ علاجي من الإدمان يساعد في تقبل المجتمع لي
					١١٢ مشاركتي للمجتمع تحد من نظرتهم السلبية لي
					١١٣ أدرك بأن تغيير عاداتي السلبية القديمة أثر كبير في تقبل المجتمع لي

الملحق الثاني: قائمة بأسماء محكمين مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان

م	الاسم
١	د. حسين الحميد استشاري الطب النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
٢	أ. خالد العنزي أخصائي نفسي إكلينيكي أول بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
٣	أ. سعيد سالم الأسمرى أخصائي نفسي إكلينيكي أول بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
٤	د. صلاح فؤاد الشعراوي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز
٥	د. عبد الرحمن عيد السناني أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة الطائف
٦	د. عبد الرحمن العمري أخصائي نفسي إكلينيكي أول بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
٨	أ. عبد الله أحمد الوائلي أخصائي نفسي إكلينيكي أول بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
١١	د. محمد القرني استشاري العلاج النفسي ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
١٢	د. محمد علي الماحي استشاري الطب النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
١٣	د. مروان علي المحمدي أستاذ علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
١٤	د. مصطفى كمال خضر أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
١٥	د. يوسف سطاتم العنزي أخصائي نفسي إكلينيكي أول ورئيس قسم الخدمات النفسية بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض

الملحق الثالث: البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية للإدمان

من إعداد

يزيد بن محمد الشهري

إشراف

الأستاذ الدكتور / عبد الحفيظ مقدم

الجلسة : الأولى

المدة: (٧٠) دقيقة

موضوع الجلسة : التهيئة والتعارف وإجراء الاختبار القبلي

الهدف من الجلسة :

- من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :
 - أن يتعرف المشارك بالمعالج وبقية الأعضاء المشاركين .
 - أن يقدم المشارك نفسه للمجموعة العلاجية المشاركة بالبرنامج العلاجي .
 - أن يتعرف المشارك على البرنامج ويكتشف خطواته وأهدافه .
 - أن يستجيب المشارك للاختبار القبلي وذلك بهدف التعرف على درجة الدافعية على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان .
 - أن يتعرف المشارك على مواعيد الجلسات ومواضيعها وترتيبها وتاريخها .
 - أن يتمكن المشارك من تعلم كلا من قواعد الجلسات وكيفية أداء الواجبات .
- الفنيات العلاجية المستخدمة :

التعليم والتدريب، المناقشة

الطريقة والإجراءات :

١ - يعرف المعالج نفسه بطريقة موجزة يتضمن ذلك آخر مؤهل علمي حصل عليه وعدد سنوات الخبرة في الممارسة العلاجية، ويتقبل المعالج المشارك كما عرف نفسه ويناديه بالاسم أو الكنية التي اختارها لنفسه، كما يعرف كل مشارك عن نفسه أمام زملائه الآخرين ويرحب بهم، يتضمن ذلك توزيع المشروبات على المشاركين لزيادة التفاعل، على أن يستمر ذلك لبقية الجلسات التالية. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ١٥ دقيقة)

٢ - ثم يطبق المعالج النفسي أداة القياس التي قام بإعدادها لقياس درجة الدافعية للعلاج من الإدمان ويشرح للمشاركين تعليمات التطبيق والتأكيد على أهمية إعطاء أول إجابة تتبادر إلى الذهن وأهمية الصدق في الإجابة. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة)

٣- ثم يقوم المعالج بوصف العلاج المعرفي السلوكي بأسلوب موجز وبلغة عربية مبسطة وسهلة مع تجنب المصطلحات الفنية، وتعريفه لهم بأنه أحد الأساليب الحديثة في العلاج النفسي ويعرف بأنه: علاج مباشر تستخدم فيه فنيات معينة لمساعدة الفرد على تصحيح أفكاره السلبية التي يصاحبها خلل إنفعالي وسلوكي، وتحويلها إلى معتقدات يصحبها ضبط انفعالي وسلوكي .

وهو طريقة للتحدث حول :

- كيفية تفكيرك بنفسك والعالم من حولك والناس الآخرين .

- كيفية تأثير ما تفعل على أفكارك ومشاعرك .

- ويتم طرح السؤال التالي للمشاركين كيف يساعدك العلاج المعرفي السلوكي ؟

وبعد النقاش عن آرائهم يتم الإجابة على السؤال بأنه يمكن أن يساعد العلاج المعرفي السلوكي على تغيير كيف تفكر (معرفي) وكيف تعمل (سلوكي) .

هذه التغييرات يمكن أن تساعدك على الشعور بشكل أفضل، على عكس بعض العلاجات الكلامية الأخرى فإنه يركز على المشاكل والصعوبات الآنية . عوضاً عن التركيز حول أسباب مشكلتك وأعراضها في الماضي، فإن هذا النوع من العلاج يبحث في طريقة تحسين حالتك الذهنية الحالية .

كما يطرح المعالج التساؤل التالي : كيف يعمل العلاج المعرفي السلوكي ؟

وبعد أخذ رأي المشاركين يتم الجواب بأنه يمكن أن يساعدك على فهم المشاكل المسيطرة عليك عن طريق تقسيمها إلى أجزاء صغيرة، وهذا يسهل عليك رؤية كيفية اتصال هذه المشاكل ببعضها البعض وكيفية تأثيرها عليك .

هذه الأجزاء هي :

حالة معينة، مشكلة ما، حدث أو موقف معين أو وضع صعب : تؤدي إلى :

أفكار - أحاسيس - مشاعر جسدية - أفعال وسلوك

كل هذه الأجزاء يمكن أن تؤثر على بعضها البعض، فكيفية تفكيرك حول مشكلة ما وطريقة تفسيرها يمكن أن يؤثر على كيفية شعورك جسدياً وحسياً ويمكن أيضاً أن يغير كيفية تعاملك معها .

مثال : يوجد طرق مفيدة لتفاعل مع معظم الحالات وهذا يعتمد على كيفية تفكيرك حولها وطريقة تفسيرك للأمور :

الحالة: مررت بيوم عصيب، وشعرت بالضجر ثم ذهبت للتسوق ، وبينما أنت تمشي على الطريق فإذا بشخص تعرفه يمر بجانبك وقد تجاهلك بوضوح.

إذن نفس الحال أدت إلى نتيجتين مختلفتين اعتماداً على طريقة تفكيرك حولها وتفسيرك لها . كيفية تفكيرك أثرت على كيف شعرت وماذا فعلت.

في الطريقة غير المفيدة : تجد نفسك حكمت على الموضوع بدون دليل وهذا مهم لأنه أدى إلى :

١ - عدد من المشاعر غير المريحة. ٢ - سلوك غير مساعد

إذا ذهبت للبيت وأنت تشعر بالاكتئاب فاحتمال كبير أنك ستطيل التفكير بما حدث وتشعر أكثر سوءاً، لكنك لو اتصلت بهذا الشخص فهناك فرصة جيدة بأن تشعر بشكل أفضل . وإذا لم تفعل سوف لن يكون لديك الفرصة لتصحيح أي سوء فهم حول ما بدر من هذا الشخص واحتمال كبير أن تشعر بسوء أكثر.

هذه طريقة مبسطة للنظر فيما يحدث ويتم تطبيقها على تغيير الأفكار السلبية المسؤولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية بحيث تستنبط أنت بنفسك وأن تستنتج طرقك الخاصة للتعامل مع مثل هذه المشاكل، إذن هذه الحلقة المفرغة يمكن أن تجعلك تشعر بالسوء، فربما تخلق حالات جديدة تجعلك تشعر بسوء أيضاً . ربما تبدأ بالاعتقاد بأشياء غير واقعية حول نفسك، هذا يحدث لأنه عندما نكون بحالة شدة نفسية وتوتر فإننا أكثر احتمالاً للتسرع بالحكم وأن نفسر الأشياء بطريقة متشددة وغير مفيدة.

فالعلاج المعرفي السلوكي يمكن أن يساعدك على كسر هذه الحلقة المفرغة من التفكير المشوش والمشاعر والسلوك المرافق. عندما ترى أجزاء هذا التسلسل بوضوح فباستطاعتك تغييرها وبهذا تغير شعورك حولها .

فالعلاج المعرفي السلوكي يهدف لأن يوصلك إلى حد معين بحيث تؤدي العلاج أنت بنفسك.

٤ - ثم يقوم المعالج بتوضيح عدد الجلسات وهي (١٩) جلسة بمعدل جلسة باليوم كأقصى حد قابله للتكرار في بعضها، كما يشرح المعالج أهداف البرنامج للمشاركين، يتضمن ذلك عرض بصري يتناول شرح موجز لجلسات البرنامج بشكل عام . (الوقت المستغرق للتنفيذ: ١٠ دقائق)

٥ - ثم يعطي المعالج الفرصة للمشاركين لإبداء رأيهم في البرنامج وطرح استفساراتهم، ثم يقوم المعالج برصدها والرد عليها، كما يحدد المعالج مواعيد الجلسات القادمة بالاتفاق مع المشاركين على أن تكون جلسة كل يوم . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ١٠ دقائق)

٦ - ثم يوضح المعالج للمشاركين قواعد المناقشة في الجلسات العلاجية عبر عرض بور بوينت يتناول قواعد السلوك في الجلسات العلاجية، كما يؤكد المعالج للمشاركين بأهمية متابعة الجلسات وأهمية تطبيق التمارين بكل جدية . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ١٠ دقائق)

الوسائل المستخدمة :

عرض بصري باستخدام (باور بوينت) Power point

المحاضرة والحوار

استخدام السبورة

الجلسة : الثانية

المدة: (٦٠) دقيقة

موضوع الجلسة : تقوية روح الجماعة

الهدف من الجلسة :

من المتوقع من المشاركون عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادراً على أن :

- أن يعبر المشاركون عن مشاعرهم ويصف خبراتهم حول الإدمان.

- أن تزداد الألفة بين المشاركين والمعالج وبين بقية المشاركين، عبر لعبه جماعية تزيد من التفاعل بين أعضاء المجموعة.

- أن يكون المشاركون تحالف علاجي مع بقية الأعضاء.

الغيات العلاجية المستخدمة:

اللعبة الجماعية، التنفيس الانفعالي، المناقشة

الطريقة والإجراءات :

١ - يقوم المعالج بتنشيط عملية التفاعل بين المجموعة بإتاحة الفرصة الكافية أمام أفراد المجموعة لتشجيع بعضهم البعض، عبر لعبه جماعية يتم فيها تمثيل مجموعة من الحكم والأمثال الهادفة، يتعرف عليها فريق الممثل، وذلك بعد تقسيم المشاركين إلى فريقين متنافسين على حصد النقاط، والفائز من المجموعتين يحصل على جائزة تشجيعية. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٣٠ دقيقة)

٢ - يشرح المعالج أهمية التنفيس الانفعالي، هو أسلوب هام في عملية العلاج ويقصد به تنفيس وتفرغ المشاركين عن المواد المشحونة انفعالياً حتى يتمكن من التعامل مع الناس ويشق طريقه في الحياة. ويقوم هذا الأسلوب على تعليم المشاركين أن يعبر عن المشاعر التي يحس بها وبصورة تلقائية وبكل حرية وأن يعبر أيضاً عن صراعاته وإحباطاته وحاجاته ومشكلاته

ومخاوفه بطريقة كلامية ويشجعه المعالج على تذكر التجارب الصادمة التي تعرض لها وبيان أحداثها بدقة وتفصيل والبوح عن العواطف الحالية والأهداف المستقبلية لكي يتمكن من إدراكها والوعي بها. ويقوم المعالج بتسهيل معرفة المشارك لأجزاء النفس الداخلية ليدركها بوضوح، والوعي بما سيفعله وكيفية فعله، ليصبح في وضع يمكنه من اختيار السلوك المناسب والمقبول.، كما لا بد من توثيق العلاقة العلاجية بين المعالج والمشارك في جو نفسي صحي ومناسب وقد يستعين المعالج بوسائل مساعدة في عملية التنفيس الانفعالي، ومما يعرقل عملية التنفيس الانفعالي الانفعالات المؤلمة التي يشعر بها المشارك كالشعور بالخزي والعار أو الشعور بالذنب مما يضطره إلى اللجوء إلى حيل الدفاع النفسي لمواجهة هذه الانفعالات المؤلمة مثل الإنكار والإلغاء وغيرها، كما أن للتنفيس الانفعالي فوائد عديدة تتمثل في تخفيف ضغوط الكبت لدى المشارك والتخلص من التوتر الانفعالي، كما يفيد في التخلص من الحمولة النفسية والشحنة الانفعالية الزائدة عن طاقة التحمل. من حيث كونه وسيلة يعبر بها الفرد عن مشاعره نظرا لخطورة كبت تلك المشاعر خصوصا السلبي منها، حتى لا تتفاقم تلك المشكلات أو ينتج عنها مشكلات أخرى. كذلك يشرح المعالج إمكانية تعبير أحد المشاركين المتطوعين عن مشاعره ومعاناته والمواقف المؤلمة التي قد تعرض لها، وتحريك وتقوية الدافع العلاجي لدى المجموعة من خلال تشجيعهم وتهيئة الجو المناسب وإيجاد جو من الطمأنينة وصدق التعامل يلي ذلك إعطاء الفرصة لبقية المشاركين للتعبير عن مشاعرهم. وفي النهاية يحاول المعالج التأكد من فهم المجموعة لما تم شرحه، ومناقشتهم فيها والرد على أي استفسار حول ما تم. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة)

يشرح المعالج أهمية المشاركة الفعالة في تقوية روح الجماعة وأهمية ذلك في سير العملية العلاجية من دون تكلف أو إحراج لأي عضو في المجموعة العلاجية، يلي ذلك الاتفاق مع المشاركين على مبدأ المشاركة الفعالة في البرنامج. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٥ دقائق)

الجلسة : الثالثة والرابعة

المدة: (٨٥ + ٨٠) دقيقة

موضوع الجلسة : الدافعية الموجبة

وهو شعور المدمن بالجدية والنشاط في مواجهة المهام والأعمال الصعبة، والسعي الإيجابي تجاه تذليل ومغالبة أي صعوبات أو معوقات تعترض مسعاها لبلوغ وتحقيق أهدافه الذاتية التي وضعها لنفسه.

التمهيد :

الترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة من قبل المشاركين. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٥ دقائق)

الهدف من الجلسة :

- من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :
- أن يواجه المشارك المواقف والأعمال الصعبة التي تؤثر على سير العملية العلاجية بجدية ونشاط.
- أن يذكر المشارك سليات التعاطي وإيجابياته بحيث تكون أكثر من عشر نقاط لكل نمط .
- أن يستكشف المشارك أهمية المثابرة والصبر في بلوغ الأهداف.
- أن يوافق المشارك على أهمية التفاؤل والإقدام بإيجابية تجاه تذليل الصعوبات وعدم الانكسار لها.
- أن يتعرف المشارك على أهمية الاسترخاء في القدرة على التركيز وتبني القرارات الصحيحة للعلاج من الإدمان.
- أن يطبق المشارك الاسترخاء العضلي والمعرفي.

الفنيات العلاجية المستخدمة:

التعليم والتدريب، الحوار، التنفيس الانفعالي، تحليل الخسائر المكاسب، لعب الدور، الاسترخاء، التغذية الراجعة

الطريقة والإجراءات :

١ - يقوم المعالج بتقديم تثقيف نفسي مباشر يتناول موضوع النجاح والإرادة الصلبة عبر محاضرة يتم فيها استخدام البور بوينت فقد تكون المشكلة الأساسية للمعالج نقص أو عدم توفر المعلومات المناسبة التي يمكن أن يبنى عليها المشارك اختياراً من الاختيارات المتاحة أمامه وفي مثل هذه الحالات فإن المعالج يعتبر المحرك الأول لعملية الحصول على المعلومات بأن يكون مديراً لعملية الحصول على معلومات وأن يكون مصدراً مناسباً لمصادر المعلومات .

ومهام المعالج في هذا المجال تتمثل في :

- تحديد مدى الحاجة للمعلومات.

- تحديد المعلومات اللازمة.

- اختيار المعلومات المناسبة والتي تتوفر فيها الدقة والحدثة.

- عرض المعلومات للمشارك في صورة مناسبة.

- الاستفادة من المعلومات في تحقيق الأهداف العلاجية.

وقد تكون المعلومات المطلوبة معلومات معرفية لا يترتب عليها اتخاذ قرار وإنما يحتاجها المشارك في مواقف حياته أو في بعض جوانب مشكلته مثل المعلومات الاجتماعية والدينية والصحية وغيرها. وتزويد المشارك بالمعلومات يمثل جانباً مهماً من جوانب العلاج وقد يحقق الهدف العلاجي، ويدخل في هذا الجانب إتاحة المعلومات عن المشارك نفسه وتفسيرها له ليستفيد منها في تحقيق الأهداف العلاجية، يتبعها حوار مع المشاركين يتم التركيز فيها على مراحل وخطوات النجاح . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٠٢ دقيقة)

٢ - يقوم المعالج بتذكير المشاركين بأهمية التعبير عن المشاعر الداخلية وذلك باستخدام فنية التنفيس الانفعالي والتي من خلالها يتم تقوية العلاقة بين الأعضاء ببعضهم البعض ومع المعالج حيث ينفس كل عضو عن الخبرات التي لحقت بكل فرد جراء إدمانه متناولا الأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية من خلال استخدام فنية تحليل الخسائر والمكاسب،

وهي أحد فنيات الدافعية : فهناك علاقة قوية متبادلة بين الدافعية والسلوك، حيث يقوم العلاج المعرفي السلوكي على مبدأ إثارة الدافعية الداخلية، فبدونها ستبدو محاولات التغيير النفسي (العلاج) جهد ضائع، ولذلك يوظف المعالج المعرفي السلوكي فنيات عدة في كل مراحل العلاج تزيد الدافعية الداخلية عند المشارك. ويتطلب من المشارك أن يضع قائمة بمحاسن و مساوئ شعور سلبي معين . شكل رقم (١) (كالغضب أو القلق) أو فكرة سلبية (مثل : إنا سيئ)، أو اعتقاد هازم للذات (مثل : «يجب إن أكون كاملاً)، أو سلوك هازم للذات (التعاطي للمخدرات). يزن المريض المحاسن مقارنة بالمساوي على مقياس من ١٠٠ (على سبيل المثال ٥٠ - ٥٠، ٥٠ - ٥٠، الخ). ثم يضع المشارك قائمة بمحاسن و مساوئ أو فكرة أو سلوك سلبي. ولكن يركز إلى إبراز محاسن الاتجاه أو السلوك السلبي، واجعل المشارك يكون على وعي بالتأثيرات القوية التي تبقية متورط (أو غاضب، الخ) شكل رقم (١).

ثم، بدلاً من تعداد المساوي، اسأل سؤال مثل : «مع كل هذه المحاسن في هذه الفكرة (أو الاتجاه أو السلوك)، لماذا عليك إن تتغير ؟. تستخدم هذه الطريقة القوية مع المرضى المقاومين أو المعارضين، ويجب إن تستخدم بلطف وحذر. وذلك من شأنه أن ينمي جانب النقد والتقويم الذاتي لدى المريض ليكتشف ويعي التأثيرات القوية التي تبقية متورطاً في سلوك الإدمان، يعطى المشاركين تمرين يقومون فيه بالتدرب على تلك المهارة . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٠ دقيقة)

خسائر		مكاسب	
١		١	

الشكل رقم (١)

قائمة بمحاسن وخسائر سلوك الإدمان

٣- يستخدم المعالج فنية لعب الدور وهو قيام المشارك بتمثيل أدوار معينة أمام المعالج أو تمثيل أدوار أمام جماعة من المشاركين حيث يكشف المشارك من خلال التمثيل مشاعره فيسقطها على شخصيات الدور التمثيلي وينفس عن انفعالاته ويستبصر بذاته ويعبر عن اتجاهاته وصراعاته ودوافعه. كما أن لعب الأدوار يسهل عملية تقبل المشاكل لأننا نفهم المشاكل

بطريقة أفضل إذا عرضت علينا وأنا نتعلم في الحياة من المثل والنماذج التي نشاهدها، ويوفر لعب الدور للمشاركة فرصة للتعلم والتدريب على الحلول الممكنة في موقف معين. ويهدف الدور الذي يقوم به إلى الكشف عن أهمية التشائم والسلبية ودورها في عدم نيل الهدف المراد مع تكرار لعب الدور بهدف الكشف عن أهمية التفائل والإقدام بإيجابية ودورة في الوصول إلى الهدف المنشود، بحيث يعطى المشارك وصف تفصيلي للدور المطلوب تنفيذه، ثم يقوم المعالج بالطلب من المشاركين بتلخيص لما تم وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الإيجابي وتثبيت الاستجابة. والخروج بالتائج والوصول لاستنتاجات لكل عضو من المشاركين بالمجموعة. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٠ دقيقة).

وصف للدور الذي يقوم به المشارك :

يقوم المشارك بلعب دور المتشائم والسلبي في نظره للحياة عموما ونظره في العلاج خصوصا وما قد يسببه ذلك التشاؤم من إحباط يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف المنشود، بحيث يقدم المشارك مجموعة من الانتقادات والآراء التي من شأنها تحبط العزيمة نحو المضي قدما في سبيل تحقيق الهدف النهائي. ثم يقوم نفس المشارك بأداء دور عكسي للدور السابق يقوم فيه بلعب دور المتفائل الإيجابي والذي ينظر للمواقف التي تواجهه بإيجابية ويعكسها لصالحه بدلا من التذمر والوقوف وعدم مواجهتها مما يساعده في تجاوز الصعاب والوصول للهدف النهائي الذي يطمح إليه

وصف تفصيلي للدور :

المتشائم

المعالج أو أحد المشاركين : كيف أحوالك اليوم

المشارك (المتشائم) : سيئة كالعادة

المعالج : لماذا

المشارك : الحياة صعبة ولا يوجد أحد يقدرك والنفسية متضايقة

المعالج : طيب لماذا لم تحاول أن تغير من حياتك

المشارك : لم يعد ينفع في هذه الدنيا شيء

المعالج : طيب هل حاولت محاولات جادة وفشلت

المشارك : أنا أؤكد لك أن حظي سيء والدنيا دائما مقفلة في وجهي وما في أمل منها

المعالج : إلى الدرجة هذه محبط

المشارك : ليس إحباط ولكن هذا هو الواقع ومستحيل يتغير

المعالج : طيب كيفك مع التوقف عن التعاطي

المشارك : لا أستطيع أن أتوقف عنها لأنها تنسيني مشاكل

المعالج : طيب ما جربت تتوقف وتشوف تأثير التوقف عليك

المشارك : أنا أعرف أنه لن يتغير شيء، ثم أن المخدرات لم تؤثر فيني، لأنني أستخدمها لتعديل

المزاج

المعالج : إذن أنت تقول أنك تستعملها عشان تنسيك المشاكل والهموم، وهذا يدل على أن

لديك مشاكل ولم تحاول حلها وتتهرب من مواجهة المشاكل بالتعاطي

المشارك : أنا لو أشوف أنه سوف تنحل المشاكل كان واجهتها وحليتها بس الأمور معقدة

جدا ومستحيل تنحل .

(ب) المتفائل

المعالج : كيف أحوالك

المشارك المتفائل : الحمد لله بخير وللاحسن ان شاء الله ودعواتك لي بالتوفيق

المعالج : الله يوفقك ويسر أمرك

المشارك: جزاك الله خيرا

المعالج: كيف الحياة معاك

المشارك: جالس أبحث عن عمل وربك يفرجها ويرزقني

المعالج: يعني لديك مشاكل مادية

المشارك: الإنسان مبتلى وربى لا يتلى إلا المؤمن ويختبر هل سيصبر أو يقنط من رحمة الله، وأبشرك أنني صابر ومتفائل وأمل في الله كبير وأدعوه بالليل والنهار وفي كل صلاه وربك ييسر الأمر

المعالج: شكل حظك سيء في الدنيا

المشارك: التوفيق بيد الله والمسألة مسألة وقت ليس إلا

المعالج: أكيد أنك تأثرت نفسيا وتشعر أنك محبط

المشارك: لا يأس مع الحياة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (تفاءلوا بالخير تجدوه) وأنا دائما متفائل وأما ضيقة النفس فأحاول أن أزيلها بالكثير من قراءة القرآن والصلاة في وقتها

المعالج: طيب كيفك مع التوقف عن التعاطي

المشارك: أبشرك أنني في الخطوات الأولى لتركها وأسأل الله أن يعصمني عنها ويجنبني مخالطة أصحابها

المعالج: طيب على كذا أثرت عليك المخدرات

المشارك: أكيد وتأثيرها سلبي في أغلبه

المعالج: أذن تستطيع أن تتوقف عن التعاطي

المشارك: أكيد بإذن الله عندي الرغبة القوية في التوقف وأنا مؤمن بأن الله راح يوفقني متى ما عملت الخير وتركت الشر يقول الله تعالى ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴾ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ﴿ صدق الله العظيم قال الرسول ﷺ : «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب».

٤ - ثم يقوم المعالج باستخدام فنية لعب الدور وذلك بهدف لعب دور المحرض في لعب المعالج أو أحد المشاركين دور الأفكار التي تغري المريض بالتعاطي ويجب على المريض الرد على هذه الأفكار ويمكن تبادل الأدوار بحيث يعطى المشارك وصف تفصيلي للدور المطلوب تنفيذه، ثم يقوم المعالج بالطلب من المشاركين بتلخيص لما تم من قبل المشاركين والوصول لاستنتاجات لكل عضو من المشاركين بالمجموعة . نهاية الجلسة (الوقت المستغرق للتنفيذ: ٢٠ دقيقة)

وصف الدور الذي يقوم به المشارك : يقوم كل من المعالج أو أحد المشاركين بلعب دور الطرف المحرض على تعاطي المخدرات وذلك بإغراء المشارك بالتعاطي عن طريق إغراءه عبر تذكيره بالأفكار التي تساعد على التعاطي، ومن ثم فإن المشارك يقوم بالرد على تلك التحريضات ودحضها والتخلص من الموقف بفعالية . ثم يقوم المشارك بقلب الدور ويلعب دور المحرض والطرف الآخر دور الضحية المستهدفة .

وصف مفصل للدور:

المحرض : كيف مزاجك اليوم

المشارك : ممتاز والله الحمد

المحرض : أنا سعيد أني رأيته

المشارك : مشكور

المحرض : تتذكر أيام الروقان والبسطه

المشارك : الله لا يعيدها أيام

المحرض : يا أخي لا تبالي وأنسى الطفش وخليك رايق

المشارك : الحمد لله رايق من دون مخدرات

المحرض : لازم نشوفك اليوم فيه سهرة خاصه فقط للمميزين

المشارك : أنا والله الحمد تبت إلى الله من هذه الأشياء

المحرض : ليله ما تفرق وبعدين ليس بالضرورة انك تستخدم، أحضر فقط للتسليه

المشارك : أنا حرمتها على نفسي ولو سمحت لا تكلمني في الموضوع

المحرض : يا أخي ليس مطلوب منك أن تدفع ريال واحد بس ونسنا بحضورك معي

المشارك : أنا قلت لك (لا) يعني (لا) وبها أنك لا زلت على حالك البطل فأنا من طريق وأنت من طريق .

التمارين : يعطى كل مشارك واجب يقوم فيه بالتدرب من خلال استخدام فنية تحليل الخسائر والمكاسب بحيث يضع المريض قائمة بمحاسن ومساوئ سلوك الإدمان ثم يزن المريض المحاسن مقارنة بالمساوئ على مقياس من ٠٠١ ويتم مناقشته في بداية الجلسة القادمة .

٥ - يرحب المعالج بالمشاركين ويشكرهم على الحضور، ويسألهم عن استفساراتهم وأسئلتهم عن الجلسة السابقة، ثم يوضح المعالج طبيعة البرنامج التدريبي للاسترخاء من كونه يساعد المشارك على التركيز وتبني القرارات الصحيحة للعلاج من الإدمان، حيث يعتبر الاسترخاء واحد من أهم الأساليب المضادة للتوتر والقلق، وهناك عدد من أساليب الاسترخاء التي عرفتها معظم الشعوب منذ وقت طويل، وتقوم أساليب الاسترخاء الحديثة على جملة من التمارين والتدريبات البسيطة التي تهدف إلى إراحة الجسم والنفس وذلك عن طريق التنفس العميق وتمارين الجسم كله على الارتخاء وزوال الشد العضلي.

وهناك ثلاثة عوامل مهمة جدا يجب ذكرها والتركيز عليها، وهي تحدد مدى الاستفادة من تمارين الاسترخاء كما ذكرها العالم بيتل: ١. الرغبة: أن توجد لدى المشارك رغبة للحصول على الاسترخاء. وتعلم وسائل الاسترخاء وطرقها إن كانت هذه الرغبة موجودة فانا سأحصل على درجة استرخاء عالية. ٢. الفهم: يجب أن يفهم المشارك الأسباب التي دفعته للقيام بهذه التمارين وما هي الفائدة منها والفلسفة من القيام بهذه التمارين. ٣. الالتزام: يجب أن يلتزم المشارك بالاستمرار بممارسة التمارين، ويجب أن يحدد فترة زمنية يومية يقوم من

خلالها بهذه التمارين وتكون عملية ممارسة التمارين منتظمة ومستمرة . هناك شروط يجب إتباعها والالتزام بها في الاسترخاء الذهني: ١. اخذ وضع مريح سواء جلوس أو استلقاء أو حتى وقوف. ٢. يجب أن يقوم الفرد بها أثناء مكان يسوده الهدوء التام. ٣. استخدام التنفس العميق وتنظيم التنفس يثير حالة الاسترخاء. ٤. التركيز على موضوع شيء معين طوال فترة التأمل الفكري.

فوائد الاسترخاء الذهني: ١. خفض حدة دقات القلب. ٢. التقليل من كمية العرق. ٣. تنظيم ذبذبات المخ. ٤. تقليل تأثير الأصوات العالية على الإنسان. ٥. يحسن الذاكرة. ٦. يحسن أداء العمل والتحصيل الدراسي. ٧. يقلل حدة الاكتئاب. ٨. ترفع مفهوم الذات. ٩. يقلل الصداع النصفي والتوتري. ١٠. تحسن طبيعة النوم.

فالاسترخاء يعني التوقف الكامل لكل الانقباضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر، والذي يؤثر على الإنسان جسميا وانفعاليا ومعرفيا وسلوكيا.

وقبل البدء بالاسترخاء يقوم المعالج بنمذجة خطوات تمرين التنفس أمام الأعضاء ثم يكلف كل مجموعة تنفذه لوحدها بقيامهم بلعب الدور، ويقوم المعالج بالتغذية الراجعة لهم ، ثم يفتح النقاش حول تمرين التنفس.

يبدأ المعالج بعرض أسلوب الاسترخاء (تعلم كيف تسترخي) والذي يعد من أنجح الوسائل لتصفية العقل من كافة الأفكار، والاسترخاء ليس مجهودا يبذل بل هو امتناع تام عن كل مجهود، وللاسترخاء العديد من الفوائد منها:

صرف الأفكار بعيدا عن التشكك والارتياب في مقاصد الغير والغضب المصاحب لهذه الأفكار. يساعد الاسترخاء على الوصول إلى استجابة منطقية لمثيرات الغضب وخفض التوتر العصبي والقلق .

يستبعد التغيرات الفسيولوجية السالبة المصاحبة للغضب والتوتر العضلي يعيد تركيز الانتباه بعيدا عن المثيرات الخارجية الخاصة المهيجة ويعيدها إلى الضبط الداخلي .

يعطي وقتا كافيا قبل أن يختار الإنسان كيف يستجيب للمثيرات (العقاد، ١٠٠٢: ٨٥١).

ثم يبين المعالج للمشاركين انه يمكنك الاسترخاء أينما كنت، فدع عضلات جسمك تتراخي اجلس أو ارقد في استرخاء، أغمض عينيك أن أردت أو اتركهما مسبلتين، أنت الآن تجلس في سكينه واسترخاء تنفس بانتظام وببطء، لا قلق لا توتر لا شد، كل القلق يتسرب ويخرج من جسمك تدريجيا، إحساس بالراحة والهدوء ينتشر جسمك كله، خذ نفسا عميقا ببطئا وأخرجه ببطء وهدوء.

ثم يهيئ المعالج المشاركين لممارسة التدريب على الاسترخاء من خلال توضيح الآتي:
أنهم مقبلون على تعلم خبرة جديدة أو مهارة لا تختلف عن أي مهارة قد تعلموها في حياتهم قبل ذلك: كتعلم السباحة أو قيادة السيارة .

انه نتيجة أسلوب الاسترخاء قد يشعر البعض ببعض المشاعر الغريبة كالتميل في أصابع الأطراف أو إحساس اقرب للسقوط، وانه يجب أن لا يخشى ذلك لان هذا « شيء عادي ودليل على أن العضلات بدأت تتراخي».

أن تكون أفكارهم كلها مركزة في اللحظة للمساعدة على تعمق الإحساس بالاسترخاء .
التنبيه بالمحافظة على كل العضلات في حالة تراخ تام أثناء الاسترخاء خاصة تغميض العينين لمنع المشتتات البصرية والتي قد تعوق الاسترخاء التام (إبراهيم، ٤٩٩١: ٣٦١) .

ولكي يساعد المعالج المشاركين على تحقيق اكبر قدر من النجاح في أسلوب الاسترخاء يطلب المعالج من المشاركين تخيل بعض اللحظات والمواقف المناسبة التي تهدئ مشاعرهم كنومهم بعد الظهيرة بعد تناولهم وجبة محبة لهم.

يطلب المعالج من المشاركين ممارسة تكنيكات الاسترخاء العضلي التدريجي، ثم يبدأ تمرين الاسترخاء مستعينا بكتيب التعليمات المصاحب لهذه التكنيكات، ويتابع المعالج ادوار المشاركين وممارستهم لخطوات الاسترخاء العضلي التدريجي من خلال شد وإرخاء العضلات وملاحظة الفرق بين التوتر العضلي والاسترخاء العضلي . ويشمل الاسترخاء الجسمي التالي: (الفسفوس، ٧٢٤١هـ):

أولاً: التنفس العميق: من المعروف أن عملية التنفس هي عملية ميكانيكية يتحكم بها الجهاز العصبي وهذه العملية تبدأ منذ اللحظات الأولى من عمر الإنسان وهي تتأثر بنفسية الفرد ويمكن من خلال طريقة التنفس للفرد المتوتر أن ندرك مدى توتره أو كآبته أو قلقه. وهذا يعني أن الإنسان الذي يعاني من توتر أو قلق أو اكتئاب سوف لا يحصل على كمية الأكسجين الضرورية التي يحتاجها الجسم بسبب طريقة تنفسه التي قد تكون سريعة فلا يمكن الجسم من الحصول على الكمية المطلوبة من الأكسجين وإخراج كمية ثاني أكسيد الكربون. وذكر أن تمرين التنفس العميق يوفر كمية الأكسجين المناسبة التي يحتاجها الجسم في إخراج أكبر قدر من الفضلات وثاني أكسيد الكربون وينقل العقل والجسم إلى حالة استرخاء ويحسن من الدورة الدموية في منطقة البطن. تمرين التنفس العميق: يكون على الخطوات التالية:

١ - الجلوس بشكل مستقيم والقدمين متباعدتين بعض الشيء، أو أثناء الاستلقاء على الأرض أو المرتبة. ٢. إغلاق العينين، وتخيل عالم آخر خيالي جميل أو تذكر مكان تحبه، وذلك لتقليل من المؤثرات الخارجية. ٣. ضع أحد اليدين على منطقة الصدر والأخرى على منطقة البطن (مكان السرة). «الهدف هو استشعار ارتفاع اليد الموضوعة على البطن أكثر من الصدر فهذا دليل أن كمية الهواء جيدة وتصل جميع أنحاء الرئة». ٤. يأخذ الإنسان الهواء بشكل بطيء من خلال الأنف حتى يشعر أن يده الموضوعة على منطقة البطن ارتفعت قليلاً.. قليلاً وليس كثيراً أي لا تعتمد ذلك بل يكون بشكل طبيعي. ٥. إذا شعر الفرد بارتفاع اليد على البطن يقوم بحبس الهواء في الرئتين لفترة زمنية حسب قدرات الفرد نفسها وشعور الفرد بالارتياح وقد يأخذ ٣ ثوان أو خمس ثوان أو تمتد لفترة العد من (١ الى ٣). ٦. العملية التي تليها يقوم الفرد بإخراج الهواء بشكل بطيء من منطقة الفم حتى يشعر أن يده الموضوعة على البطن قد عادت إلى وضعها الطبيعي. تكرر هذه العملية (الاستنشاق من الأنف وحبس الهواء ثم زفره من الفم) ٣ مرات وبعد المرة الثالثة نطبق ما يلي: نأخذ نفساً عميقاً من الأنف ولا نحبسه ثم نخرجه من الأنف، نقوم بهذه الخطوة مرتين أي أن التمرين يتكون من وحدتين أساسيتين هي حبس الهواء ٣ مرات ثم ٢ دون حبس ثم نعيد المرات الثلاثة مع الحبس ثم

المرتين دون حبس إلى أن يمر علينا من الوقت خمس دقائق. من الأفضل استخدام ساعة منبه لتنبهنا على انتهاء الوقت حيث أننا يجب أن لا نشغل تفكيرنا في شي آخر غير الخيال المرسوم أمامنا . يفضل تطبيق هذا التمرين ٣ مرات في اليوم فهو سريع وجيد جدا ويعتبر من أفضل أنواع تمارين الاسترخاء ويمكن ممارسته بكل سهوله على كرسي الامتحان أو في سيارتك قبل الدوام وغيرها . وستلاحظ بعد الاسترخاء أن عضلات وجهك قد ارتخت وان نبرة صوتك تغيرت وتهدأ وتنخفض . ثانيا: الاسترخاء العضلي: نلاحظ عندما تنقبض كل عضلة من الجسم وينتج من الانقباض والانبساط آلام من الشحنات الكهربائية وهذه الشحنات تنتقل إلى جزء في المخ وهو الهايبوثالاموس، مسؤول عن تقديم الاستجابات المناسبة للضغوط سواء كانت هذه الاستجابات نفسية أو سلوكية بينما تقوم الأجهزة الفزيولوجية بنقل الشحنات الكهربائية إلى الهايبوثالاموس يصبح الهايبوثالاموس في توتر شديد فأى تغير جديد في حياة الإنسان تحول إلى عامل من عوامل الضغوط والاسترخاء يعمل على تقليل هذه الشحنات المتتالية من الكهرباء برجع الجسم والهايبوثالاموس إلى حالة الاتزان ولهذا يقوم الفرد بعملية الاسترخاء بعد مواجهة ضغوط الحياة بأنواعها. لكي تترك عملية الاسترخاء الأثر الفعال يجب أن تتوفر الشروط التالية: ١. الوقت: الاسترخاء العضلي يحقق اكبر فائدة إذا مورس مرتين في اليوم بفارق زمني (٨) ساعات، ويجب تحاشي الاسترخاء بعد الطعام مباشرة أو قبل النوم مباشرة. ويفضل قبل النوم بثلاثة ساعات. ٢. المكان: احرص على أن يكون المكان الذي ستمارس به التمرين هادئ بعيد عن الضوضاء بأنواعها حتى لا يقاطعك احد الأفراد أثناء ممارستك الاسترخاء. ٣. وضع الجسم: ممكن ممارسة الاسترخاء العضلي العميق على شكل وضعين الأول الاستلقاء على سرير مريح أو على الأرض شرط أن يكون الجسم في وضع استقامة أو ونحن في وضع جلوس على كرسي مريح ويفضل أن يحتوي على ذراعين وظهر عالي، في حالة الاستلقاء على الأرض ممكن وضع وسادة تحت الرقبة لسند الرأس ويجب تجنب أي شيء يسبب الشد للجسم ويفضل إغلاق العينين والابتداء بالتنفس العميق.

خطوات الاسترخاء العضلي: ١. خذ نفسا عميقا ثم احبس الهواء لمدة ١٠ ثواني، بعد ذلك

أخرج الهواء. ٢. ارفع يديك قليلا و أنت تتنفس بشكل طبيعي ثم أعد يديك إلى وضعها السابق على الكرسي. ٣. ابعد يديك إلى الجانبين وضمهما في قبضة قوية جدا، حاول أن تشعر بالضغط والجهد على يديك، ساعد من ١ إلى ٣ وعندما تصل إلى ٣ أريدك أن تخفض يديك . ١. ٢. ٣. ٤. ارفع يديك إلى أعلى ثانية، واثن أصابعك إلى الداخل (ناحية الجسم)، الآن اخفض يديك واسترخ. ٥. ارفع ذراعيك ثم اخفضهما واسترخ. ٦. ارفع ذراعيك ثانية، هذه المرة حرك يديك بشكل دائري (رفرقة) حسنا ... استرخ ثانية. ٧. ارفع ذراعيك ثانية ثم استرخ. ٨. ارفع يديك ثانية فوق المقعد ثم شد عضلات جسمك حتى ترجف، تنفس بشكل طبيعي وابق يديك مرتخية (أرخي يديك لاحظ دفء الإحساس بالاسترخاء) ٩. ارفع يديك أمامك ثم شد عضلات جسمك (تأكد من انك تتنفس بشكل طبيعي) ، ارخ يديك الآن. ١٠. الآن ادفع كتفك للخلف، ابق على هذا الوضع، تأكد أن ذراعيك في حالة استرخاء الآن استرخ. ١١. ادفع كتفيك إلى الأمام، ابق على هذا الوضع، تأكد من أنك تتنفس بشكل طبيعي وابق يديك مسترخية (حسنا استرخ لاحظ الإحساس بالارتياح عند إرخاء العضلات بعد شدها) ١٢. الآن أمل رأسك إلى اليمين وشد رقبتك. استرخ وأعد رأسك إلى وضعه الطبيعي. ١٣. الآن أمل رأسك إلى اليسار وشد رقبتك ثم أعد رأسك إلى وضعه الطبيعي. ١٤. عد برأسك قليلا للوراء ناحية المقعد. ابق على هذا الوضع . حسنا الآن ببطء أعد رأسك إلى وضعه الطبيعي. ١٥. هذه المرة اخفض رأسك ناحية الصدر. أبق على هذا الوضع. الآن استرخ وأعد رأسك إلى وضعه الطبيعي المريح. ١٦. افتح فمك إلى أقصى ما تستطيع، افتح فمك أكثر، حسنا استرخ الآن، (يجب أن يكون الفم مفتوحا قليلا في النهاية). ١٧. الآن اضغط على شفتيك وأغلق فمك. (حسنا استرخ حاول ان تشعر بالاسترخاء). ١٨. الآن اضغط على شفتيك وأغلق فمك. اضغط بشدة ... توقف، استرخ واسمح للسانك أن يكون بوضع مريح داخل الفم. ١٩. الآن ضع لسانك في أسفل فمك، اضغط لأسفل بشدة، استرخ واجعل لسانك في وضع مريح داخل فمك. ٢٠. الآن استلق (اجلس) واسترخ، حاول أن لا تفكر بأي شيء. ٢١. الآن أغلق عينيك واضغط عليهما

بشدة ثم تنفس بشكل طبيعي، حاول أن تحس بشد العضلات حول العين، الآن استرخ (حاول أن تشعر كيف يذهب الألم عندما تسترخ). ٢٢. الآن دع عينيك تسترخ وابق فمك مفتوحا بعض الشيء. ٣٢. افتح عينيك إلى أقصى حد ممكن. ابق هكذا. دع عينيك تسترخ الآن. ٤٢. الآن جهد جبهتك قدر المستطاع. ابق هكذا. حسن استرخ. ٥٢. الآن خذ نفسا عميقا ولا تخرجه ثم استرخ. ٦٢. الآن ازفر، حاول الآن أن تخرج كل الهواء واسترخ (حاول أن تحس بروعة التنفس ثانية). ٧٢. تخيل أن أثقالا تضغط على كل عضلات جسمك مما يجعلها مترهلة ومسترخية، ادفع بذراعيك وجسمك إلى المقعد. ٨٢. شد عضلات بطنك جميعا، اضغط بشدة، حسنا استرخ الآن. ٩٢. الآن أجهد عضلاتك كأنك تقاتل لنيل جائزة، اجعل بطنك صلب، استرخ الآن، (أنت الآن تسترخ أكثر فأكثر). ١٠٣. الآن استكشف الجزء العلوي من جسمك وأرح كل جزء مجهد، أولا عضلات الوجه (توقف من ٣ إلى ٥ ثوان) ثم عضلات الجهاز الصوتي (توقف من ٣ إلى ٥ ثوان) كتفيك، أرح أي جزء مجهد. (توقف) الآن الذراعين والأصابع أرحهم ستصبح مسترخيا جدا. ١٣. عند الوصول إلى هذه الحالة من الاسترخاء ارفع رجلك إلى الأعلى (بزواية ٥٤ درجة تقريبا) الآن استرخ (اعلم أن هذا سيزيد من الاسترخاء). ٢٣. الآن أثن قدميك إلى أن تشير أصابع قدميك إلى وجهك، أرح قدميك، اثن قدميك بشدة، استرخ. ٣٣. اثن قدميك إلى الجهة المعاكسة، بعيدا عن جسمك، ليس بعيدا جدا، حاول أن تشعر بالضغط. حسنا استرخ. ٤٣. استرخ (توقف) الآن لف أصابع قدميك على بعضهما، إلى أقصى ما تستطيع، اضغط أكثر حسنا. استرخ (هدوء... وصمت لمدة ٠٣ ثانية تقريبا). ٥٣. هذا يتم الإجراء الأساسي للاسترخاء، الآن استكشف جسمك من قدميك إلى قمة رأسك، تأكد أن جميع عضلاتك مسترخية... أولا أصابع القدمين، ثم قدميك ثم رجلك، ثم بطنك وكتفيك، ثم رقبتك فعينيك وأخيرا جبهتك، جميع أعضائك يجب أن تكون مسترخية الآن (هدوء وصمت لمدة ٠١ ثوان تقريبا) استلق وحاول أن تشعر بالاسترخاء، ودفء الاسترخاء (توقف) أريدك أن تبقى على هذا الوضع لمدة دقيقة تقريبا، وسأعد حتى ٥. عندما أصل في العد الى ٥ افتح عينيك بهدوء شديد

وانتعاش (هدوء، صمت لمدة دقيقة تقريباً) ... حسناً، عندما أصل لخمسة افتح عينيك وأنت تشعر بالهدوء والانتعاش ... واحد ... الشعور بالهدوء، اثنان ... شعور بالهدوء والانتعاش، ثلاثة أكثر انتعاشاً، أربعة وخمسة.

بعد الانتهاء من التدريب على خطوات الاسترخاء العضلي يقدم المعالج التغذية الراجعة للمشاركين حول أدائهم ويفتح باب النقاش حول من خلال الأسئلة التالية :

كيف شعرت عندما مارست الاسترخاء العضلي؟

ماذا أعجبك بممارسة الاسترخاء العضلي؟

ماذا لاحظت على نفسك بعد الاسترخاء العضلي؟

وبعد انتهاء المشاركين من الاسترخاء العضلي وهم مسترخون الآن تماماً، يطلب منهم المعالج استخدام وسائل الاسترخاء البسيطة كالتنفس العميق أو الاسترخاء التخيلي والذين يساعدان على تهدئة مشاعر الغضب، ومن تلك الخطوات البسيطة التي يمكنك محاولتها :
تنفس بعمق من الحجاب الحاجز، فتتصور أن نفسك يصعد من أعماقك.

كرر ببطء كلمة تهدئة أو عبارات مثل : « استرخ » وعبرة « خذ الأمر ببساطة » وكلمات روحية كـ « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وعبرة « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وعبرة « استغفر الله » ويتم إنهاء الجلسة بتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الإيجابي وتثبيت الاستجابة. والخروج بالنتائج. (الوقت المستغرق للتنفيذ ٥٠ دقيقة)

٦ - يقوم المعالج بتدريب المشاركين على الاسترخاء المعرفي (التخيل) يعتبر الاسترخاء الذهني من أقدم أنواع الاسترخاء ويتميز كل شعب بنوع معين من الاسترخاء الذهني وهي تشبه اليوجا فعند اليابانيين هناك ما يسمى الزن وهو يعتبر استرخاء ذهني كما أن الصينيين يمارسون

رياضة التو وهي أيضا تعتبر استرخاء ذهني وكذلك ما كان يقوم به الصوفية سابقا وتعتبر عبادة لديهم وتندرج تحت الاسترخاء الذهني كما يعتبر التسبيح لله سبحانه وتعالى إلى جانب انه عباده استرخاء ذهني، واهم ما يميز الاسترخاء الذهني هو الانفصال بذهنك عن العالم الخارجي والتركيز على شكل معين في مخيلتك أو صورة أو كلمة وترددها ببالك ومخيلتك بتركيز دون أن تشغل تفكيرك بشيء غيرها وتستمر بذلك لمدة لا تقل عن ٥١ دقيقة فان زدت الوقت فهذا أفضل. وهو عبارة عن طريقة مفيدة لتعديل المعلومات الخاطئة لدى الفرد، فالتخيل هو الذي سيساعد المشاركين على استبدال الأفكار السلبية بأخرى ايجابية، تساعد الفرد تصحيح طريقة تفكيره الخاطئة نحو العلاج من الإدمان، ويستخدم الخيال فيتصور تجربة مريحة من ذاكرته، هو ويعني تغيير طريقة تفكيرك، فالناس المنفعلون يميلون للشتم والسب والحلف والإنكار، فعندما تنفعل يمكن لتفكيرك أن يصبح مبالغاه فيه بشكل كبير، حاول أن تستبدل الأفكار بأفكار أكثر عقلانية : فمثلا : بدلا من أن تقول « لست مدمن، لست مجنون، كرهت نفسي، تحطم كل شيء، لا أريد أن يتدخل أحد في شؤوني، أنا حر» قل بدلا عنها لنفسك «سأفكر، هذا غير مفهوم، أنا منزعج من ذلك الشيء المحدد، لكنها ليست نهاية العالم، والانفعال لن يصلح ذلك الشيء، ممكن أنني مقصر، أعترف بخطئي»، كذلك يجب الحذر من كلمات «أبدا و دائما و يجب و ينبغي و حتما» فهي ليست دقيقة وكذلك تجعلك تشعر التوتر والانفعال دون مبرر وتفسد أي محاولة لحل مشكلة، كما أن فنية إيقاف التفكير هامة هنا، وتذكر أن الانفعال لن يصلح أي شيء ولن يمنحك شعورا أفضل بل شعورا أسوأ، وذكر نفسك دائما بان «العالم لا يسعى للنيل منك» وإنما أنت فقط تواجه بعضا من المواقف القاسية في الحياة اليومية وهذا يساعدك على أن تحصل على نظرة أكثر اتزاناً .

هناك شروط يجب إتباعها والالتزام بها في الاسترخاء الذهني : ١ . اخذ وضع مريح سواء جلوس أو استلقاء أو حتى وقوف . ٢ . يجب أن يقوم الفرد بها أثناء مكان يسوده الهدوء التام . ٣ . استخدام التنفس العميق وتنظيم التنفس يثير حالة الاسترخاء . ٤ . التركيز على موضوع شيء معين طوال فترة التأمل الفكري .

ويشير ميكنبوم (٣٠٠٢) في توضيح الأساليب التي تساعد في تجنب الانفعال وضبطه أو التحكم به من خلال التوجيهات التالية :

- لا تنظر لتوافه الأمور وأهمليها.

- لا تندم على ما فاتك.

- لا تجعل نفسك مسئولا عما يجب أو عما يمكن .

- لا تتأثر بقضايا الآخرين كثيرا.

- لا تتوقع الأسوأ.

- لا تحتاج في الأمور التي لا يمكن تغييرها .

- لا ترى أن الآخرين يقصدونك أو يعنونك شخصا (ابوعيطه، ٢٠٠٥)

في نهاية الجلسة يقوم المعالج بتلخيص الجلسة، وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي: عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزيه لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة . والخروج بالنتائج والتذكير بما دار فيها، والنقاط الأساسية في المهارة، ثم التأكيد على الجوانب التطبيقية منها . نهاية الجلسة (الوقت المستغرق ٣٠ دقيقة)

التمارين :

يطلب المعالج من المشاركين تطبيق الاسترخاء والتمارين الأخرى المساعدة، والطريقة المثلى في ذلك من خلال الممارسة والتجريب أكثر من مرة، ومناقشتهم في الجلسة القادمة.

موضوع الجلسة : التعافي الإيجابي

وهو أدراك المدمن بفعالية البرامج العلاجية وضرورة المشاركة الإيجابية دون تشكيك فيما يقدم سواء عن طريق المشاركة السلبية، أو التركيز على مشكلة من المشكلات الخارجية، أو الإلحاح في طلب الخروج لأسباب ضعيفة، أو الاستخدام المبالغ فيه لميكانيزمات الإنكار، أو لسيطرة مشاعر اليأس وعدم التيقن من الشفاء، أو عدم اتخاذ قرار العلاج بعد .

التمهيد :

الترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة والتأكد من أداء التمارين المطلوبة من قبل المشاركين . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٥ دقائق)

الهدف من الجلسة :

- من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :
- أن يحدد المشارك الأفكار السلبية المسؤولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية.
- أن يستنبط المشارك أهمية المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية من دون تشكيك، عبر تنمية التناقضات لديه.

الفنيات العلاجية المستخدمة:

التعليم والتدريب، الإبعاد والتركيز، المناقشة، فحص التناقضات الداخلية

الطريقة والإجراءات :

يقوم المعالج بعمل تثقيف نفسي مباشر يستخدم فيه العرض البصري يتناول التوضيح للمشاركين على كيفية التعرف على الأفكار وعلى طرق تحديد الأفكار السلبية، ثم يقوم المعالج

بتلقي الاستفسارات من المشاركين ويرد عليها، ويتأكد من فهمهم لتلك المعلومات (عرض بوربوينت). (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٠ دقيقة)

ثم يقوم المعالج بشرح كيفية اكتشاف و تغيير الأفكار السلبية المسؤولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية، عبر استخدام فنية الأبعاد والتركيز، حيث يتم تذكير المشاركين بكيفية اكتشاف وتغيير الأفكار السلبية وتعريفها لهم بأنه أحد الأساليب الحديثة في العلاج النفسي ويعرف بأنه : علاج مباشر تستخدم فيه فنيات معينة لمساعدة الفرد على تصحيح أفكاره السلبية التي تصاحبها خلل انفعالي وسلوكي، وتحويلها إلى معتقدات يصحبها ضبط انفعالي وسلوكي .

ويتم طرح السؤال التالي للمشاركين كيف يساعدك العلاج المعرفي السلوكي ؟

وبعد النقاش عن آرائهم يتم الإجابة على السؤال بأنه يمكن أن يساعد العلاج المعرفي السلوكي على تغيير كيف تفكر (معرفي) وكيف تعمل (سلوكي) .

هذه التغييرات يمكن أنة تساعدك على الشعور بشكل أفضل، على عكس بعض العلاجات الكلامية الأخرى فإنه يركز على المشاكل والصعوبات الآنية . عوضا عن التركيز حول أسباب مشكلتك وأعراضها في الماضي، فإن هذا النوع من العلاج يبحث في طريقة تحسين حالتك الذهنية الحالية .

هذه طريقة مبسطة للنظر فيما يحدث ويتم تطبيقها على تغيير الأفكار السلبية المسؤولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية بحيث

تستنبط أنت بنفسك وأن تستنتج طرقك الخاصة للتعامل مع مثل هذه المشاكل أذن هذه الحلقة المفرغة يمكن أن تجعلك تشعر بالسوء، فربما تخلق حالات جديدة تجعلك تشعر بسوء أيضا . ربما تبدأ بالاعتقاد بأشياء غير واقعية حول نفسك، هذا يحدث لأنه عندما نكون بحالة شدة نفسية وتوتر فإننا أكثر احتمالا للتسرع بالحكم وأن نفسر الأشياء بطريقة متشددة وغير مفيدة.

فالعلاج المعرفي السلوكي يمكن أن يساعدك على كسر هذه الحلقة المفرغة من التفكير المشوش والمشاعر والسلوك المرافق . عندما ترى أجزاء هذا التسلسل بوضوح فباستطاعتك تغييرها وبهذا تغير شعورك حولها .

فالعلاج المعرفي السلوكي يهدف لأن يوصلك إلى حد معين بحيث تؤدي العلاج أنت ثم يطلب المعالج من احد المشاركين بالتطوع لاكتشاف الأفكار التلقائية المسؤولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية لديه بحيث يتم استبعاد تلك الأفكار التلقائية والتركيز على تحديدها والتعرف عليها ومن ثم التخلص منها، وكيفية تنفيذ ذلك على جداول التفريغ المخصصة لذلك، ثم يقوم المعالج بتلخيص ما تم وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الإيجابي وتثبيت الاستجابة . والخروج بالنتائج ويرد على الاستفسارات من قبل المشاركين، ثم يكلف المعالج المشاركين بتمرين على تحديد الأفكار المسؤولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية ومناقشتها عبر تسجيل الأفكار ومن ثم تغيير الأفكار، ومناقشتهم في الجلسة اللاحقة . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٠ دقائق).

الجدول رقم (١) تسجيل الأفكار المسؤولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية

المثير :	الأفكار التلقائية السلبية :	فحص الأفكار وتحديدها :	أفكار تلقائية بديلة :	النتائج :
ما لشيء الذي أثار لديك الشعور أو السلوك السلبي ؟	حدد الأفكار أو الصور التي برزت في ذلك الوقت قدر درجة تصديقك بكل فكرة في ذلك الوقت (٠-١٠٠)	حدد نوع خطأ التفكير هل الفكرة صحيحة (الأدلة المساندة والمضادة)؟ هل تمثل الفكرة قانون لا يتغير ؟ هل هي بالضرورة منطقية ؟	قم بصياغة بدائل عقلانية ، تود أن تفكر فيها عندما تواجه موقف مشابه .	ما درجة اعتقادك الآن بالفكرة التلقائية السلبية الأولى ؟ (٠-١٠٠)
١- _____	١- _____	١- _____	١- _____	١- _____
٢- _____	٢- _____	٢- _____	٢- _____	٢- _____
٣- _____	٣- _____	٣- _____	٣- _____	٣- _____
الشعور أو الانفعال الذي شعرت به وقته (٠-١٠٠) :	التصرف / السلوك غير المفيد الذي قمت به :	السلوك الجديد :		
١- _____	١- _____	١- _____		
٢- _____	٢- _____	٢- _____		
٣- _____	٣- _____	٣- _____		

ثم يقوم المعالج باستخدام أحد الفنيات المعرفية وهي فحص التناقضات الداخلية لاكتشاف هل لدى المشارك أفكار متناقضة مثل (أريد أن أستمتع بشبابي ثم أتوقف عن المخدرات ولكنني أريد أن أكون مقبول من كل الناس) وهذه الطريقة تبين للمعالج مدى جدية المشارك في العلاج وعدم المشاركة الايجابية في البرامج العلاجية، ثم يقوم المعالج باستعراض حالة مريض غير مبالي ودائم النقد الغير موضوعي للبرامج العلاجية والقائمين عليها مثل : المشارك الذي يريد كل شيء على حسب ما يراه ومدى تأثير ذلك في عدم النظام. وينتهي المعالج مع المشاركين بالخروج باستنتاجات مكتوبة من قبل المشاركين وعرضها على المعالج والخروج بمحصله لما تم. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ١٥ دقيقة).

التمارين :

إعطاء المشاركين واجب للتعرف على وتحديد الأفكار المسئولة عن ضعف المشاركة الإيجابية في البرامج العلاجية ومناقشتها عبر تسجيل الأفكار ومن ثم تغيير الأفكار، ومناقشتهم في الجلسة اللاحقة .

الجلسة السادسة والسابعة والثامنة المدة: (٦٠+٦٥+٨٠) دقيقة

موضوع الجلسة : الاستبصار

هو شعور المدمن بأنه واقع في مشكل وأنه مدمن ويحتاج للعلاج وأنه فاقد للسيطرة على تعاطيه وكذلك مدى وعيه بالأضرار المترتبة على تعاطي المخدرات على المستوى النفسي والطبي والاجتماعي والديني .

التمهيد :

الترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة من قبل المشاركين . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ١٠ دقائق).

الهدف من الجلسة :

- من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :
- أن يعترف المشارك بمشاكلته الإدمانية ويحددها.
- أن يعلن المشارك حاجته للعلاج.
- أن يحدد المشارك مدى سيطرته على توقفه وتعاطيه (الإدراك الموضوعي للوقائع).
- أن يوضح المشارك أضرار وتأثيرات الإدمان الصحية والنفسية والاجتماعية والدينية بحيث لا تقلل الإضرار عن عدد خمس تأثيرات لكل نوع .
- أن يحدد المشارك أساليب التفكير الخاطئة المسؤولة عن السلوك الإدماني والانتكاسات المتكررة.

الفنيات العلاجية المستخدمة:

اللعب الجماعي، التعليم والتدريب، لعب الدور، الإبعاد والتركيز.

الطريقة والإجراءات :

يقوم المعالج بتنشيط عملية التفاعل بين المجموعة، عبر لعبه جماعية ترفيهية بأن كل مشارك يضع فكره ثم يأتي الدور على المشارك الذي يليه ليبيدي رأيه حول الفكرة المطروحة علما بأن بعض الأفكار تكون مرحلة وي طرح المعالج كذلك بعض الأفكار الهادفة مثلا : سواقة المرأة السيارة في السعودية : أنت معها أو ضدها ثم يأتي دور المشارك الذي أجاب ليضع فكرة أخرى مرحلة للمشارك الذي يليه . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة).

ثم يقوم المعالج بعمل تثقيف نفسي مباشر يتناول عرض طبيعة الإدمان وتعريف الإدمان عبر استخدام عرض البور بوينت، ثم يقوم المعالج بإعطاء مادة علمية للمجموعة، ويتم تكليف المشاركين بواجب يقومون فيه بتلخيص المادة العلمية المقدمة ومناقشتهم في الجلسة اللاحقة . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة) نهاية الجلسة السادسة.

يقوم المعالج بالترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة من قبل المشاركين عبر استعراض الواجبات المكلفين بها،

ثم يقوم المعالج بإظهار وجهي فكر متناقضين، بحيث يتناوب المعالج والمريض اخذ دور «الأفكار السلبية» ودور «الأفكار الايجابية». ويقوم الشخص الذي يلعب دور الأفكار السلبية بالهجوم والشخص الذي يلعب دور الأفكار الايجابية بالدفاع. يكرر تبادل الأدوار عدة مرات. تؤدي هذه الفنية غالبا إلى تحويل الفهم العقلي إلى تغيير انفعالي في مستوى العاطفي التلقائي. ويتم ذلك عن طريق لعب الدور بالتناوب بين المشارك والمعالج بتقمص دور الراعي والمسؤول ودور الابن المدمن الذي لا يعتقد بأنه يحتاج للعلاج حتى بعد تأثير الإدمان عليه وذلك بهدف أن يقنع المدمن بأنه مدمن من خلال الاعراض التي عليه وأنه يحتاج للعلاج للمبررات... وضرورة توصيل فكرة للمدمن بأن الاقتناع والاعتراف بالمشكلة هو بداية العلاج والحل، ثم يلخص المعالج والمشاركين ما حصل ويصلون إلى النتيجة المستخرجة من تلك العملية وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزه لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة. والخروج بالتائج. (الوقت المستغرق للتنفيذ: ٤٥ دقيقة).

وصف الدور الذي يقوم به المشارك :

يقوم كل من المعالج أو أحد المشاركين بلعب دور الابن أو الأخ غير المسئول وغير المستبصر بحالته وأنه مسيطر على مشكلة تعاطيه ولا يحتاج المساعدة من أي شخص ولا يحتاج دخول المستشفى للتنويم والعلاج رغم وجود الأعراض الشديدة التي تدل على أنه مدمن وغير قادر على التوقف وما يتبعها من ظهور أعراض صحية ومشاكل اجتماعية وأسرية ومشاكل تتعلق بالعمل، ثم يقوم المشارك بلعب دور الراعي أو المسئول عن ذلك الابن أو الأخ عبر محاولة إقناعه بأنه في مشكله ويحتاج للعلاج من خلال أقناعاته وتبصيره بخطورة الوضع الذي هو عليه وما قد يحول إليه عدم العلاج في الوقت المناسب عبر استعراض كل الأعراض التي تدل على أنه مدمن ويحتاج للعلاج.

وصف مفصل للدور :

الأب (ولي الأمر) : سلامتك يا أبنائي أشوف حالك متغير ونومك مضطرب ومزاجك متقلب.

الابن (الغير مستبصر) : لا ما فيني شيء الحمد لله بصحة وعافية وبس تعبت اليوم ولم أنم جيدا البارحة.

الأب : يا أبنني حالك ليس من اليوم وليس من أسبوع لك فترة من الزمن وأنت متغير والكل ملاحظ عليك.

الابن : ما فيني إلا الصحة والعافية ولو أشوف أني تعبان كان رحت للمستشفى.

الأب : يا أبنني أنا خائف عليك ولا أريد أن تتعرض لمكروه لا سمح الله.

الابن : كم مرة أقول أنه ما فيني شيء.

الأب : لازم يا أبنني تتعالج والعلاج الحمد لله مجاني وفيه سرية كبيرة وكلها كم يوم وترجع ولدي الذي أعرفه وتتخلص من هذه السموم.

الابن : أنا لا أحتاج علاج وبعدين أنا لست مدمن في الأصل.

الأب : طيب يا أبنني والأعراض التي عليك ماذا تدل عليه.

الابن : هذه من التعب والسهر.

الأب : والحبوب التي حصلت عليها والحشيش الذي رأيته.

الابن : ليست لي.

الأب : يا أبنني أنا خائف عليك لأنك أبنني ولا أريد أن يضرك أي شيء، لازم تكون صريح، أنا لست هنا لكي أعاقبك ولا لكي أفضحك، هذه المشكلة ليست لديك فقط و للأسف الشديد منتشرة بين الشباب ودمرت حياتهم وأسرههم لأنهم تماردوا في ذلك ولم يبادروا في العلاج، لذا يا أبنني أريد منك أن تبدأ بداية صحيحة وتضع قدمك على أو درجة في سلم السعادة والصحة والنجاح.

الابن : يا والدي أنا فعلا أعترف لك أني استخدم هذي المواد ولكنني لست مدمن عليها.

الأب : أشكرك يا ولدي على شجاعتك وصراحتك والتي جعلتك تكبر في نظري، ولكن هذا لي بكافي لازم يا ولدي نذهب أنا وأنت لنعالجك.

الابن : أنا يا والدي لست بمدمن ولست بمریض وأنا أستطيع أن أوقفها متى ما أردت.

الأب : أعرف أنك تستطيع أن توقفها ولكن تعاطي المخدرات له أبعاد كثيرة تسبب التعاطي والانتكاس حتى بعد التوقف، لذا أريد منك يا أبنني تجلس مع المختصين وتتابع معهم وأنا أريدك توعدي يا أبنني بأنك تبدأ مرحلة العلاج وأنا سأقف معك جنباً إلى جنب.

الابن : أوعدك يا والدي أن أتابع مع المختصين وأن أتخلص من هذه المشكلة وأن أرضي الله وأرضيك يا والدي ووالدي .

ثم يقوم المعالج بعمل تثقيف نفسي مباشر يتناول الكشف عن دور أساليب التفكير الخاطئة في الإدمان والانتكاسة، مستخدماً عرض البور بوينت، ثم يقوم المعالج بعمل حوار مع المشاركين لكي يتأكد من فهمهم للمحاضرة ويطلب منهم إعطاء أمثلة على كل أسلوب من الأساليب الخاطئة . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٠ دقيقة) نهاية الجلسة السابعة.

يقوم المعالج بالترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة من قبل المشاركين، ثم يقوم المعالج باستخدام فنية لعب دور ولعب الدور العكسي حول دور الأساليب الخاطئة في التفكير وعلاقتها بالإدمان والانتكاسة وذلك بأن يكلف المعالج كل اثنين من المشاركين بأخذ أسلوب خاطئ في التفكير وتمثيل دور عليه ثم تلخيص النتائج وفيما يلي وصف لكل أسلوب من الأساليب الخاطئة التي سيقوم كل مشارك من لعب دور عليها :

فرط التعميم : وهي إدراك الأشياء السلبية التي وقعت على أساس سبب واحد مثل / أنا فاشل عشان كذا مستمر في التعاطي، لن أستطيع مواجهة الحياة من دون مخدر، لن أحصل على السعادة من دون الحصول على مخدر) وبالتالي فإنه يكون هناك إفراط في التعميم على الرغم من أن المدمن سابقاً كان لديه أبواب كثيرة للسعادة غير المخدر ولكن تلك الفكر كان لها دورها السلبي في السلوك الإدماني أو الانتكاسات المتكررة.

اللوم : وهو أن تركز على الشخص الآخر كمصدر لمشاعرك السلبية، وترفض تحمل مسؤولية تغيير نفسك (أن والدي هو المولوم على الطريقة التي يعاملني بها، لقد سبب والدي كل مشاكلي).

قراءة العقل : بحيث تفترض انك تعرف ما يفكر به الآخرون دون دليل واضح على أفكارهم (أنهم يعتقدون أنني فاشل، أكيد أنهم مهمشينني من الأسرة).

الفترة السلبية : وهي أن تركز كلياً على السلبيات، ويندر أن تلاحظ الإيجابيات (انظر إلى أخواني إنهم كلهم لا يريدونني).

التحليل الانفعالي : حيث تترك مشاعرك تقود تفسيراتك للواقع (أشعر أنني مكتئب لذلك مشكلتي في التعاطي تزداد).

العجز عن الدحض : فترفض أي دليل أو حجة قد تتعارض مع أفكارك السلبية مثل (اذا جاءت فكرة على بالك بأنك غير محبوب، فإنك ترفض أي دليل على أن الناس يحبونك، وتصفه بأنه لا علاقة له بها) وتبعا لذلك فأفكارك لا يمكن دحضها . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٣٥ دقيقة).

ثم يقوم المعالج بتوزيع منشورات حول آثار الإدمان الصحية والنفسية، ومن ثم يكلف المعالج المشاركين بواجب يقوم فيه المشاركون بذكر أبرز الأعراض التي تتشابه مع أعراضه ومناقشتها مع باقي أعضاء الجلسة والوصول إلى اتفاق بأن الاعتراف بالإدمان هو أول وأهم خطوات العلاج . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ١٠ دقائق).

وأخيرا يقوم المعالج مع المشاركين بالتعرف على وتحديد الأفكار التلقائية التي تؤكد على أن المريض لا يحتاج لعلاج ومناقشتها عبر تسجيل الأفكار لكل مريض ومناقشة ذلك ومن ثم تغيير تلك الأفكار، بحيث يتم تذكير المشاركين بكيفية اكتشاف وتغيير الأفكار السلبية وتعريفها لهم بأنه أحد الأساليب الحديثة في العلاج النفسي ويعرف بأنه : علاج مباشر تستخدم فيه فنيات معينه لمساعدة الفرد على تصحيح أفكاره السلبية التي تصاحبها خلل انفعالي وسلوكي، وتحويلها إلى معتقدات يصحبها ضبط انفعالي وسلوكي .

وهذه الطريقة مبسطة للنظر فيما يحدث ويتم تطبيقها على تغيير الأفكار وتحديد الأفكار التلقائية التي تؤكد على أن المريض لا يحتاج لعلاج بحيث تستنبط أنت بنفسك وأن تستنتج طرقك الخاصة للتعامل مع مثل هذه المشاكل أذن هذه الحلقة المفرغة يمكن أن تجعلك تشعر بالسوء، فربما تخلق حالات جديدة تجعلك تشعر بسوء أيضا . ربما تبدأ بالاعتقاد بأشياء غير

واقعية حول نفسك، هذا يحدث لأنه عندما نكون بحالة شدة نفسية وتوتر فإننا أكثر احتمالا للتسرع بالحكم وأن نفس الأشياء بطريقة متشددة وغير مفيدة.

فالعلاج المعرفي السلوكي يمكن أن يساعدك على كسر هذه الحلقة المفرغة من التفكير المشوش والمشاعر والسلوك المرافق . عندما ترى أجزاء هذا التسلسل بوضوح فباستطاعتك تغييرها وبهذا تغير شعورك حولها .

فالعلاج المعرفي السلوكي يهدف لأن يوصلك إلى حد معين بحيث تؤدي العلاج أنت.

ثم يطلب المعالج من احد المشاركين بالتطوع لاكتشاف الأفكار التلقائية المسؤولة التي تؤكد على أن المريض لا يحتاج لعلاج بحيث يتم استبعاد تلك الأفكار التلقائية والتركيز على تحديدها والتعرف عليها ومن ثم التخلص منها، وكيفية تنفيذ ذلك على جداول التفرغ المخصصة لذلك، ثم يقوم المعالج بتلخيص ما تم وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة . والخروج بالنتائج ويرد على الاستفسارات من قبل المشاركين، ويتأكد المعالج من فهم المشاركين باستعراض مثال من أحد المشاركين المتطوعين، ثم يقوم المعالج بتكليف المشاركين بتمرين ومناقشتهم فيه بعد ذلك منها بذلك الجلسة . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٣٥ دقيقة) نهاية الجلسة الثامنة.

الجدول رقم (٢)

تسجيل الأفكار التلقائية التي تؤكد على أن المريض لا يحتاج لعلاج

المثير :	الأفكار التلقائية السلبية :	فحص الأفكار وتحديدتها :	أفكار تلقائية بديلة :	النتائج :
ما لشيء الذي أثار لديك الشعور أو السلوك السلبي ؟	حدد الأفكار أو الصور التي برزت في ذلك الوقت	حدد نوع خطأ التفكير هل الفكرة صحيحة (الأدلة المساندة والمضادة)؟ هل تمثل الفكرة قانون لا يتغير؟ هل هي بالضرورة منطقية ؟	قم بصياغة بدائل عقلانية ، تود أن تفكر فيها عندما تواجه موقف مشابه .	ما درجة اعتقادك الآن بال فكرة التلقائية السلبية الأولى؟ (١٠٠-٠)
قدر درجة تصديقك بكل فكرة في ذلك الوقت (١٠٠-٠)			قدر درجة تصديقك للفكرة الجديدة (١٠٠-٠)	كيف تشعر الآن بعد أن كونت فكرة جديدة ومعقولة ؟ (١٠٠-٠)
- ١	- ١	- ١	- ١	- ١
- ٢	- ٢	- ٢	- ٢	- ٢
- ٣	- ٣	- ٣	- ٣	- ٣
الشعور أو الانفعال الذي شعرت به وقته (١٠٠-٠) :	التصرف / السلوك غير المفيد الذي قمت به :	السلوك الجديد :		
- ١	- ١	- ١		
- ٢	- ٢	- ٢		
- ٣	- ٣	- ٣		

تمرين الجلسة السادسة :

تلخيص مادة علمية تتناول عرض طبيعة الإدمان وتعريف الإدمان للمرضى يتم تلخيصها ومناقشتها في الجلسة اللاحقة.

تمرين الجلسة الثامنة :

يكلف المعالج المشاركين بواجب يقوم فيه المشاركون بذكر أبرز الأعراض التي تشابه مع أعراضه ومناقشتها مع باقي أعضاء الجلسة والوصول إلى اتفاق بأن الاعتراف بالإدمان هو أول

وأهم خطوات العلاج، ثم إعطاء المشاركين واجب للتعرف على وتحديد الأفكار التلقائية التي تؤكد على أن المريض لا يحتاج لعلاج ومناقشتها عبر تسجيل الأفكار ومن ثم تغيير الأفكار، ومناقشتهم في الجلسة اللاحقة .

المدة: (٧٥ + ٨٠) دقيقة

الجلسة التاسعة و العاشرة

موضوع الجلسة : الاستقلال

هو شعور المدمن بالقدرة على تدبير شؤون حياته الخاصة وحرصه على تجنب مختلف صور وأشكال التبعية والاعتمادية كالمسايرة الآلية والتقليد الأعمى أو المحاكاة السلبية لأي من الأشخاص المباشرين أو الغير المباشرين في محيطه الاجتماعي .

التمهيد: الترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة والتأكد من أداء التمارين المطلوبة من قبل المشاركين . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٥ دقائق).

الهدف من الجلسة :

- من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :
 - أن يتجنب المشارك التبعية كالمسايرة الآلية وأن يكون مستقلا بأفكاره وأفعاله.
 - أن يعبر المشارك عن مشاعره السلبية والإيجابية.
 - أن يرفض المشارك المطالب غير المعقولة.
 - أن يحدد المشارك تأثيرات المحيط الخارجي (رفقاء سوء، علاقات شاذة ، ...) على سلوكه تجاه الإدمان.

الفنيات العلاجية المستخدمة:

التعليم والتدريب، لعب الدور، الإبعاد والتركيز

الطريقة والإجراءات :

يقوم المعالج بعمل تثقيف نفسي مباشر حول ملامح وخصائص الشخص المؤكد لذاته وخصائص الشخص الغير مؤكد لذاته مستخدماً العرض البصري البور بوينت، ثم يقوم المعالج بفتح حوار مع المشاركين ويقوم فيه بالرد على استفساراتهم، ويتم توفير مادة علمية لكل مشارك. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٠ دقيقة)

ثم يقوم المعالج باستخدام فنية لعب الدور المحرض الشرير، وهذه إحدى فنيات لعب الدور، حيث يلعب المعالج دور الأفكار التي تغري المريض بالشرب، الخ. على سبيل المثال، يطلب المعالج أو المحرض الشرير (أحد المشاركين المتطوعين) من المشارك الآخر إن يتخيل انه في مكان تباع فيه المشروبات الروحية. يمكن إن يقول المعالج: «يا الله، لماذا لا تطلب واحدة من هذه المشروبات اللذيذة مع الثلج... إلخ. ويجب على المشارك أن يرد على هذه الأفكار. ويمكن إن يكرر تبادل الأدوار عدة مرات. ثم يبين المعالج أو أحد المتطوعين والمشارك للعب دور شخص غير مؤكد لذاته وكيفية خضوعه لرفقاء التعاطي الذين يؤثرون عليه تأثير سلبي، ثم يتم عكس الدور بحيث يكون المشارك مؤكدا لذاته في تعامله مع رفيق التعاطي، ويتم ذلك على باقي المجموعة العلاجية بين كل مشاركين، ثم يتم فتح حوار مع المشاركين يتم فيه تلخيص أبرز الاستنتاجات المهمة لمواجهة مثل ذلك الموقف منتهياً بتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبرات تعزيزية لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة. والخروج بالنتائج (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٤٥ دقيقة)

وصف الدور الذي يقوم به المشارك :

يقوم المعالج أو أحد المشاركين بلعب دور الشخص الذي يحاول فرض مطالب غير معقول على الطرف الآخر، ويقوم المشارك غير المؤكد لذاته بالرد على تلك المطالب. ثم يقوم نفس المشارك بلعب دور الشخص المؤكد لذاته ويرد على تلك المطالب غير المعقولة المفضية إلى التعاطي.

وصف مفصل للدور :

المعالج (المحرض) : كيف أخبارك

غير المؤكد : بخير الحمد لله كيفك أنت

المؤكد : الحمد لله (رد سريع وثابت دون تردد أو تلعثم والنظر بثبات)

المحرض : حبيت أتحدث معك قليلا إذا لم يكن لديك مانع

غير المؤكد : عادي ما فيها شي

المؤكد : لا أستطيع (رد بكل قوة ووضوح حتى لا يترك أي باب مفتوح لأي عرض آخر)

المحرض : لم أعد أراك تأتي إلينا

غير المؤكد : أشغال الدنيا

المؤكد : الحمد لله أنا تبت من التعاطي وأي طريق يوصل إليه

المحرض يا أخي لا تكبرها بس أريد منك أن توصلني مشوار

غير المؤكد : حاضر

المؤكد : لا أنا لا أستطيع أن أوصلك

المحرض : اليوم فيه سهره ما رأيك تمرني الساعه عشره توصلني واذا تريد تحضر لا مانع

غير المؤكد : سأرى إذا أنني مشغول أم لا

المحرض : أعطني رقمك لكي أذكرك

غير المؤكد : حاضر

المحرض : تسمح لي أدخن السيجارة هذي

غير المؤكد : عادي

المحرض : ما رأيك في تجربتها

غير المؤكد : ليس لي نفس بها الآن

المعرض : يا أخي ما يضر ك لو شفته واحدة بس أهم شي تشاركني الوناسه

غير المؤكد : طيب شفته واحدة بس

وأخيرا يقوم المعالج بتكليف المشاركين بواجب عبر إعطائهم مادة علمية حول تأثير رفقاء السوء والمطلوب منهم تلخيصها وإعطاء أبرز الفوائد المستخلصة منها، منهايا بذلك الجلسة. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ١٠ دقائق) نهاية الجلسة التاسعة .

يقوم المعالج بالترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة من قبل المشاركين يقوم المعالج باستخدام فنية لعب الدور لتقوية الاستقلالية الفكرية لدى المشاركين بحيث يتم لعب دور المريض المعرض على عدم العلاج ومريض آخر يحرص على الرد المنطقي على تلك التحريضات السلبية، ويتم ذلك على جميع الأعضاء ثم يقوم المعالج مع المشاركين بتلخيص ما تم وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة . والخروج بالتائج . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٤٥ دقيقة)

وصف الدور:

يقوم المعالج أو أحد المشاركين بلعب دور الصديق المعرض على عدم أهمية العلاج والتشكيك فيما يقدم من برامج علاجية أو التشكيك في الفريق العلاجي القائم على تلك البرامج، ومن ثم يتولى المشارك الآخر لعب دور الشخص صاحب الاستقلالية الفكرية والذي لا يتأثر بتلك التحريضات بل يرد عليها رد منطقي يتخذ أسلوب حوارى مقنع بعيدا عن الإساءة لأي طرف .

وصف مفصل للدور الذي يقوم به المشارك :

المشارك المعرض : والله طفش وضعنا في هذا المكان

المشارك المستقل : لماذا يا أخي أحمد الله أنك لازلت بصحه ولست مصابا بحادث أو ميت

نتيجة جرعة زائدة أو أنك ميت في أقذر الأماكن بسبب ما يستخدم من سموم

المحرض : يا شيخ والله المعاملة هنا سيئة

المستقل : الحمد لله على كل حال تذكر أنك في مكان أنقذك من شر نفسك وتماديها الذي كان سيوصلك لأمر لا يحمد عقباها، وبالنسبة للمعاملة لا بد أن تكون معاملتك حسنة لهم حتى يعاملوك بنفس الطريقة

المحرض : في الأصل وجودي هنا مؤقت وسوف أخرج وأفعل ما أريده ولن يستطيعون أن يجعلوني أتوقف رغما عني

المستقل : كلامك صحيح وهو أنك أنت المسؤول عن صحتك وعن توقعك عن التعاطي ولكن لو تفكر في قول الله تعالى (عسا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم) ممكن يغير في كلامك خصوصا وأنا جميعنا هنا نقر بأن المخدرات لها أضرار كثيرة ولم تفيد أحد ولن تفيد

المحرض : حتى لو أفترضت أنني سأجلس وأتعالج وأحاول أستفيد بس لا يدعونك تستفيد المستقل : تأكد أن الذي يريد المعلومة ويريد النصيحة والاستفادة يستطيع أن يأخذها حتى لو كان من عامل النظافة فلا بد لك أخي من الصبر والمحاولة الجادة بغية الوصول إلى إيجاد حلول لمشكلتك

المحرض : لن يفهمني أحد

المستقل : لا تتشائم وإذا لم يفهمك واحد أو اثنان فإن الثالث سيفهمك، أهم شيء أنك تفتح قلبك ولا تجلس فقط صامت، فأنت الذي يبحث عن المعلومة فينبغي لك أن تبحث عنها في كل مكان وبأي طريقة

المستقل : وأخيرا لا بد أن تستغل وجودك هنا وتعرف أن الله مقدر لك هذا الشيء وتعرف أن أمامك الفرصة فلا تفوتها.

ثم يقوم المعالج مع المشاركين بتحديد الأفكار السلبية المسؤولة عن مسايير المريض لرفقائه وعدم قدرته على رفض المطالب الغير معقولة ومن ثم دحض تلك الأفكار وإحلال أفكار ايجابية بدلا عنها، ويتم تذكير المشاركين بكيفية اكتشاف وتغيير الأفكار السلبية، ثم يطلب المعالج من احد المشاركين بالتطوع لاكتشاف الأفكار التلقائية المسؤولة عن مسايير المريض لرفقائه وعدم قدرته على رفض المطالب الغير معقولة بحيث يتم استبعاد تلك الأفكار التلقائية والتركيز

على تحديدها والتعرف عليها ومن ثم التخلص منها، وكيفية تنفيذ ذلك على جداول التفريغ المخصصة لذلك، ثم يقوم المعالج بتلخيص ما تم ويرد على الاستفسارات من قبل المشاركين، ثم يقوم المعالج بطلب من جميع المشاركين فكرة أو أكثر يقومون بتلخيصها وترتيبها من الأخطر إلى الأقل خطورة، ثم يقوم المعالج بإعطاء المشاركين واجب عن الأفكار التلقائية ومناقشتها في الجلسة اللاحقة وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة . والخروج بالتائج .

(الوقت المستغرق للتنفيذ : ٥٣ دقيقة) نهاية الجلسة العاشرة

الجدول رقم (٣)

تسجيل الأفكار التلقائية المسؤولة عن مسايرة المريض لرفقائه وعدم قدرته على رفض المطالب غير المعقولة

المثير :	الأفكار التلقائية السلبية:	فحص الأفكار وتحديد ها:	أفكار تلقائية بديلة:	النتائج :
ما لشيء الذي أثار لديك الشعور أو السلوك السلبي ؟	حدد الأفكار أو الصور التي برزت في ذلك الوقت قدر درجة تصديقك بكل فكرة في ذلك الوقت (٠-١٠٠)	حدد نوع خطأ التفكير هل الفكرة صحيحة (الأدلة المساندة والمضادة)؟ هل تمثل الفكرة قانون لا يتغير؟ هل هي بالضرورة منطقية؟	قم بصياغة بدائل عقلانية، تود أن تفكر فيها عندما تواجه موقف مشابه. قدر درجة تصديقك للفكرة الجديدة (٠-١٠٠)	ما درجة اعتقادك الآن بالفكرة التلقائية السلبية الأولى؟ (٠-١٠٠) كيف تشعر الآن بعد أن كونت فكرة جديدة ومعقولة؟ (٠-١٠٠)
- ١	- ١	- ١	- ١	- ١
- ٢	- ٢	- ٢	- ٢	- ٢
- ٣	- ٣	- ٣	- ٣	- ٣
الشعور أو الانفعال الذي شعرت به وقته (٠-١٠٠):	التصرف / السلوك غير المفيد الذي قمت به :	السلوك الجديد :		
- ١	- ١	- ١		
- ٢	٢	- ٢		

تمرين الجلسة التاسعة:

تكليف المشاركين بواجب عبر إعطائهم مادة علمية حول تأثير رفقاء السوء والمطلوب منهم تلخيصها وإعطاء أبرز الفوائد المستخلصة منها .

التمرين الجلسة العاشرة:

إعطاء المرضى واجب عن تحديد الأفكار التلقائية المسؤولة عن مسايرة المريض لرفقائه وعدم قدرته على رفض المطالب الغير معقولة

المدة: (٨٠ + ٨٠) دقيقة

الجلسة : الحادية عشرة والثانية عشرة

موضوع الجلسة : تحمل المسؤولية

هو شعور المدمن بقدرته على الاضطلاع بمختلف أدوار الحياة بغير خوف أو تردد، وتحمل تبعية ومسؤولية هذه الأدوار بصدق وأمانة والرضي عنها والاستمتاع بها وتحمل نتائج جهودها ومسعاهها في هذا الصدد بغير لجوء إلى التبرير عند مواجهة المواقف الضاغطة أو ما قد يصادفه من فشل أو إخفاق .

التمهيد : الترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة والتأكد من أداء التمارين المطلوبة من قبل المشاركين .
(الوقت المستغرق للتنفيذ : ٥ دقائق)

الهدف من الجلسة :

- من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :
 - أن يتعرف المشارك على دوره في الحياة.
 - أن يحدد المشارك مهام دورة في الحياة.
 - أن يواجه المشارك كل ما يعترض ويعيق دورة في الحياة من خلال تعلم إستراتيجية حل المشكلات.

الفنيات العلاجية المستخدمة :

التعليم والتدريب، التنفيس الانفعالي

الطريقة والإجراءات :

يقوم المعالج بتقديم تثقيف نفسي مباشر حول الأدوار الحياتية، وأن لكل إنسان دور يقوم به في الحياة ، يستخدم فيه المعالج العرض البصري البور بوينت، ثم يكلف المعالج المشاركين

بواجب يتم فيه تلخيص مادة علمية حول الموضوع ومناقشتها في الجلسة اللاحقة. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة)

ثم يقوم المعالج بتكليف المشاركين بعمل قائمة بأدوارهم في الحياة وعمل مهام لكل دور، ويشرح المعالج كيفية التنفيذ من خلال اختيار أحد المتطوعين من المجموعة وعمل قائمة بأدواره في الحياة وعمل مهام لكل دور، ثم يتأكد المعالج من فهم المشاركين عبر إتاحة الفرصة لهم للاستفسار والرد عليه من قبل المعالج منهيًا بذلك الجلسة. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٣٥ دقيقة).

ثم يقوم المعالج باستخدام فنية التنفيس الانفعالي وذلك للتعبير عن إخفاقات المشاركين في تحقيق أدوارهم في الحياة. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٠ دقيقة) نهاية الجلسة الحادية عشرة يقوم المعالج بالترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة والتأكد من أداء التمارين المطلوبة من قبل المشاركين، ثم يقوم بتقديم تثقيف نفسي واستعراض خبرات وتوفير مادة علمية حول إستراتيجية حل المشكلات ومواجهتها، بحيث يوضح المعالج أن كل شخص لديه مشاكل متكررة يمكن أن تعالج بفعالية، وإن الحل الأول المتسرع ليس بالضرورة هو الأفضل، لذا يجب أن يراجع المعالج الخطوات الأساسية لكل المشاكل الملخصة، ومن المهم للمرضى المدفعين كتابة المشكلة واختيار طريقة لكي لا يتم نسيان الخطوات عندما يحين الوقت لتطبيقها. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٠ دقيقة).

ثم يقوم المعالج بتدريب المشاركين على ممارسة مهارات حل المشكلات حيث يطلب المعالج من المشاركين تحديد مشكلتين حديثتين، واحدة تكون وثيقة الصلة بالتعاطي والأخرى صلتها أقل بالتعاطي. ثم يقوم المعالج على تدريب المشاركين على استعمال خطوات حل المشكلة. ثم ممارسة التمرين حيث يمكن النظر إلى أسلوب حل المشكلات على أنه :

- يمثل أسلوباً لتدريب المشارك على استخدامه فيما يواجهه من مشكلات الآن وخارج إطار العلاج.

- ويمكن القول أن حل المشكلات هو عملية يحاول بها الشخص أن يخرج من مأزق معين. ويرى «جاي» (٧٧٩١) أن حل المشكلات هو نوع من السلوك المحكوم بقواعد.

كما يرى هالي (١٩٧٧) أيضاً أن حل المشكلات في العلاج النفسي يعتبر نوعاً من تحليل النظم وفي تصوره أن عملية حل المشكلة ينبغي أن تأخذ في اعتبارها نظام التفاعل الاجتماعي للمريض بما ذلك الأشخاص الآخرون المشتركون في هذا النظام مع المريض مثل الأخوة، الآباء، الزملاء، المعالج نفسه وبذلك فإن هالي يركز بشكل أكبر على الموقف الذي تحدث فيه المشكلة.

هناك العديد من النماذج لحل المشكلات نقتصر هنا على نموذج واحد منها وهو:

نموذج دي زوريلا وجولد فرايد (١٩٧١) لحل المشكلة :

يشمل النموذج على خمسة مراحل لحل المشكلات لاستخدامه في تعديل السلوك وهي:

١ - توجيه عام:

وتشير مرحلة التوجيه العام إلى تنمية ميل قوي لدى المشارك أولاً بقبول الواقع في أن مواقف المشكلات تمثل جزءاً عادياً في الحياة وأنه من الممكن مواجهة معظم هذه المواقف بفاعلية وثانياً: التعرف على المواقف المشكلة عندما تحدث وثالثاً: كبح الميل للاستجابة سواء الاندفاع التلقائي أو التقاعس عن القيام بشيء ما، بذلك فإن التوجيه العام يرى المشكلات كحتمية وكمواقف تواجه مباشرة وبوضوح ونشاط.

٢ - تحديد المشكلة وصياغتها:

تتكون هذه المرحلة من: أ- تحديد كل جوانب الموقف في صورة إجرائية. ب- صياغة وتصنيف عناصر الموقف بطريقة ملائمة لفصل المعلومات المناسبة عن غير المناسبة، وتحديد أهداف الفرد الأساسية وتحديد المشكلات العليا والقضايا والصراعات وبذلك فإن تحديد المشكلة وصياغتها وتمحيصها وتحليلها إلى عناصر محدودة يؤدي إلى اختيار أهداف لحل موقف المشكلة.

٣ - توليد البدائل:

تشير هذه المرحلة إلى مهمة إعداد قائمة بالحلول الممكنة المناسبة للمواقف الخاصة بالمشكلة.

٤ - اتخاذ القرارات:

يشير اتخاذ القرارات إلى اختيار طريق واحد من بين عدة طرق أو بدائل وتركز هذه المرحلة على احتمال اختيار أكثر الاستجابات فاعلية من بين بدائل مختلفة ويزداد الاحتمال خلال الأساليب المنتظمة مثل النظر إلى النتائج القريبة والبعيدة المدى والأخذ في الاعتبار النتائج الشخصية والاجتماعية وتقدير التوقع الشخصي لنجاح بديل من هذه البدائل.

٥ - التحقق من الحل :

تحدث هذه المرحلة بعد تطبيق أسلوب الحل، وتقارن النتائج الحقيقية بالنتائج المتوقعة وهذا يحدد الدرجة التي أمكن لها حل المشكلة بفاعلية بواسطة البديل الذي تم اختياره.

أسلوب حل المشكلات:

- إن المعالج لا يحل للمشاكل مشكلته ولا يقدم له حلول سحرية جاهزة ولكن تكمن مهمته في مساعدته على حل المشكلة بنفسه ويتبع المعالج الخطوات التالية لتحقيق ذلك:
- بعد التشخيص وتحديد المشكلة يبدأ المشارك بحصر المشكلة والسيطرة عليها ومن ثم حلها.
- تدرس المشكلة بكل أبعادها وجوانبها المختلفة وبتفهم عميق وتبحث أسبابها من الجذور وتزال أعراضها حتى لا تظهر مشكلات جديدة.
- يتم عرض المحاولات السابقة لحل المشكلة وأسباب اختفائها دون النجاح الذي تحقق.
- يتم توجيه المشارك من قبل المعالج لعدد من الحلول الرئيسية المقترحة والحلول البديلة الاحتياطية بحيث تكون هذه الحلول مقبولة اجتماعياً ويمكن تحقيقها وتناسب مع المشارك.
- يتم تحديد الحلول المقبولة وترتب حسب أولويتها ومن ثم توضع الخطط لتنفيذها.
- تقتصر مهمة المعالج على المساعدة فقط ويحرص من خلالها على توجيه كل شيء نحو الوصول إلى حل المشكلة وتشجيع المعالج للمشارك عندما يعتقد أن المشارك غير قادر على المحاولة وعلى التعلم حيث يقر أنه لا يعرف وعلى التجريب إذا تذرع بأن الحل مستحيل.

يقوم المشاركون بتنفيذ الخطة الموضوعية لحل المشكلة.

ثم يطلب المعالج من المشاركين ممارسة مهارات حل المشكلة خارج الجلسات مستخدمين نموذج تذكيري لحل المشكلة وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة والخروج بالتائج. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٦٠ دقيقة) نهاية الجلسة الثانية عشرة.

تمارين الجلسة الحادية عشرة :

يكلف المشاركون بواجب يتم فيه تلخيص مادة علمية حول الأدوار الحياتية، وأن لكل إنسان دور يقوم به في الحياة، ومناقشتها في الجلسة اللاحقة
تكليف المشاركون بعمل قائمة بأدوارهم في الحياة وعمل مهام لكل دور.

تمارين الجلسة الثانية عشرة :

يطلب المعالج من المشاركين ممارسة مهارات حل المشكلة خارج الجلسة مستخدمين نموذج تذكيري لحل المشكلة، ومناقشتهم في الجلسة القادمة.

الجلسة : الثالثة عشرة والرابعة عشرة المدة: (٩٠ + ٦٠) دقيقة

موضوع الجلسة :الشعور بأهمية الزمن

هو إدراك المدمن لقيمة الوقت وتقديره لأهمية عنصر الزمن، وحرصه على استثمار أوقاته والاستفادة منها إلى أقصى حد في كل ما هو مفيد مع شعوره بقدرته على حسن تنظيم أوقاته بما يحقق أهدافه وتطلعاته المستقبلية ومقاومة أي معوقات أو مغريات يمكن أن تستنفذ أوقاته بغير طائل أو عائد إيجابي .

التمهيد :الترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من

استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة والتأكد من أداء التمارين المطلوبة من قبل المشاركين .
(الوقت المستغرق للتنفيذ : ٥ دقائق).

الهدف من الجلسة :

- من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :
- أن يكتشف المشارك مجموعة الأفكار التلقائية المسؤولة عن نفاذ الوقت بغير عائد ايجابي .
- أن يحدد المشارك الأوقات الغير مفيدة له ويشكل نموذج مثالي يكون من خلاله يوم مثالي يستثمر فيه وقته ويراقب من خلاله سلوكه .
- أن ينظم المشارك وقته بما يحقق أهدافه .
- أن يستكشف المشارك ويقاوم أي معوقات أو مغريات تستنفذ وقته بغير عائد ايجابي .

الفنيات العلاجية المستخدمة:

اللعب الجماعي، التعليم والتدريب، الإبعاد والتركيز، النمذجة

الطريقة والإجراءات :

- ١ - يقوم المعالج بتنشيط عملية التفاعل بين المجموعة، عبر لعبه جماعية ترفيهية بأن يضع كل مشارك بيت شعري ثم يأتي الدور على المشارك الذي يليه ليضع بيت شعري يبدأ بالحرف الذي انتهى به بيت الشعر المشارك الذي سبقه. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٠٢ دقيقة).
- ٢ - ثم يقوم المعالج بعمل تثقيف نفسي مباشر حول أهمية الزمن واستعراض المقولات المهمة حول أهمية الزمن والوقت، ثم يقوم المعالج بعمل حوار جماعي يشارك فيه جميع المشاركين وينتهي بالتوصل للمقولات الايجابية حول أهمية الوقت وجعل المشاركين يرددونها حتى يقتنعوا بها والتأكد من ذلك في الجلسة اللاحقة. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٠٣ دقيقة)
- ٣ - ثم يقوم المعالج مع المشاركين بتحديد مجموعة الأفكار التلقائية المسؤولة عن نفاذ الوقت بغير عائد ايجابي، ومن ثم تحديدها عبر الإبعاد والتركيز والتي تستهدف أن يعرف المشارك الرابط بين المثير والاستجابة وهي الأفكار التلقائية المسؤولة عن نفاذ الوقت وعم استثماره

وبالتالي يركز المشاركون على تلك الأفكار التي تحدد استجابته وبالتالي ملء الفجوة المعرفية، بحيث يتم تذكير المشاركين بكيفية اكتشاف وتغيير الأفكار السلبية، ويتم تطبيقها على تغيير الأفكار وتحديد الأفكار التلقائية المسؤولة عن نفاذ الوقت بغير عائد ايجابي بحيث تستنبط أنت بنفسك وأن تستنتج طرقك الخاصة للتعامل مع مثل هذه المشاكل أذن هذه الحلقة المفرغة يمكن أن تجعلك تشعر بالسوء، فربما تخلق حالات جديدة تجعلك تشعر بسوء أيضا. ربما تبدأ بالاعتقاد بأشياء غير واقعية حول نفسك، هذا يحدث لأنه عندما نكون بحالة شدة نفسية وتوتر فإننا أكثر احتمالا للتسرع بالحكم وأن نفسر الأشياء بطريقة متشددة وغير مفيدة. فالعلاج المعرفي السلوكي يمكن أن يساعدك على كسر هذه الحلقة المفرغة من التفكير المشوش والمشاعر والسلوك المرافق. عندما ترى أجزاء هذا التسلسل بوضوح فباستطاعتك تغييرها وبهذا تغير شعورك حولها

فالعلاج المعرفي السلوكي يهدف لأن يوصلك إلى حد معين بحيث تؤدي العلاج أنت. ثم يطلب المعالج من احد المشاركين بالتطوع لاكتشاف الأفكار التلقائية التلقائية المسؤولة عن نفاذ الوقت بغير عائد ايجابي بحيث يتم استبعاد تلك الأفكار التلقائية والتركيز على تحديدها والتعرف عليها ومن ثم التخلص منها، وكيفية تنفيذ ذلك على جداول التفرغ المخصصة لذلك، ثم يقوم المعالج بتلخيص ما تم ويرد على الاستفسارات من قبل المشاركين، ويتأكد المعالج من فهم المشاركين باستعراض مثال من أحد المشاركين المتطوعين، ثم يكلف المعالج المشاركين بواجب يحددون فيه تلك الأفكار ومناقشته في الجلسة اللاحقة وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة. والخروج بالتائج منها بذلك الجلسة. (الوقت المستغرق للتنفيذ: ٤٥ دقيقة) نهاية الجلسة الثالثة عشرة.

الجدول رقم (٤)

تسجيل الأفكار التلقائية المسؤلة عن نفاذ الوقت بغير عائد ايجابي

المثير :	الأفكار التلقائية السلبية :	فحص الأفكار وتحديد لها:	أفكار تلقائية بديلة:	النتائج :
ما لشيء الذي أثار لديك الشعور أو السلوك السلبي ؟	حدد الأفكار أو الصور التي برزت في ذلك الوقت	حدد نوع خطأ التفكير هل الفكرة صحيحة (الأدلة المساندة والمضادة)؟ هل تمثل الفكرة قانون لا يتغير؟ هل هي بالضرورة منطقية؟	قم بصياغة بدائل عقلانية ، تود أن تفكر فيها عندما تواجه موقف مشابه .	ما درجة اعتقادك الآن بالفكرة التلقائية السلبية الأولى؟ (١٠٠-٠)
قدر درجة تصديقك بكل فكرة في ذلك الوقت (٠-١٠٠)			قدر درجة تصديقك للفكرة الجديدة (٠-١٠٠)	كيف تشعر الآن بعد أن كونت فكرة جديدة ومعقولة؟ (١٠٠-٠)
- ١	- ١	- ١	- ١	- ١
- ٢	- ٢	- ٢	- ٢	- ٢
- ٣	- ٣	- ٣	- ٣	- ٣
الشعور أو الانفعال الذي شعرت به وقته (١٠٠-٠) :	التصرف / السلوك غير المفيد الذي قمت به :	السلوك الجديد :		
- ١	- ١	- ١		
- ٢	- ٢	- ٢		
- ٣	- ٣	- ٣		

٤ - ثم يقوم المعالج بالترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة والتأكد من أداء التمارين المطلوبة من قبل المشاركين، ثم يقوم بتدريب المشاركين على إدارة الوقت من خلال التعلم والتدريب والذي يتضمن إعطاء المشارك مادة معرفية تتناول خطوات مرحليه لإدارة الوقت ويتبعها إعطاء المشارك واجب للتأكد من تعلمه لتلك المهارة والانتهاؤ بتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في

تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية لمواصلة السلوك الإيجابي وتثبيت الاستجابة . والخروج بالنتائج. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٣٠ دقيقة).

٥ - ثم يقوم المعالج مع المشاركين بتحديد الأوقات الغير مفيدة له وذلك عبر واجب يقوم فيه المشارك بتحديد جدول يومي له يحدد من خلاله الأوقات الغير مفيدة ومناقشته مع المعالج، ثم يقوم المعالج باستخدام فنية النمذجة الرمزية والتي يقوم فيها المشارك بتشكيل نموذج مثالي يكون من خلاله يوم مثالي يستثمر فيه وقته ويراقب من خلاله سلوكه (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٣٠ دقيقة) نهاية الجلسة.

تمارين الجلسة الثالثة عشرة :

أن يحدد المشاركين مجموعة الأفكار التلقائية المسؤلة عن نفاذ الوقت بغير عائد ايجابي

تمارين الجلسة الرابعة عشرة :

تكليف المشاركين بتنفيذ خطوات لإدارة الوقت على نفسه متخذا النموذج المعطى كخطة للتنفيذ، ومناقشته في الجلسة القادمة. تكليف المشارك بتحديد جدول يومي له يحدد من خلاله الأوقات الغير مفيدة ومناقشته مع المعالج الجلسة القادمة .

الجلسة : الخامسة عشرة والسادسة عشرة المدة: (٦٠ + ٦٠) دقيقة

موضوع الجلسة : التوجه للمستقبل والمثابرة

هو حرص المدمن على أن يستشرف المستقبل في تفكيره وسلوكه وما يضعه لنفسه من أهداف وطموحات بحيث يفكر ويعمل ويخطط في سبيل نواتج بعيدة المدى أديم وأبقى مفضلا النواتج الأخيرة على أي مكاسب أو مغنم فورية سريعة ومؤقتة و حرص المدمن على استمرارية العمل لإتمام أو بلوغ ما يسعى في سبيله من أهداف ومطامح بحيث يواصل جهده بدأب كي يصل إلى ما يريد أو يرتضي من أهداف .

التمهيد:

الترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة والتأكد من أداء التمارين المطلوبة من قبل المشاركين . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٥ دقائق)

الهدف من الجلسة :

- من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :
 - أن يكتشف المشارك أهمية التخطيط للمستقبل.
 - أن يستنبط المشارك مجموعة المبادئ التي تتحكم في عدم قدرته على الصبر للوصول إلى النواتج الأخيرة مكتفيا بالمكاسب المؤقتة.
 - أن يتمكن المشارك من وضع الأهداف القصيرة والبعيدة المدى.
 - أن يبرهن ويستنتج المشارك على أهمية الصبر والصعوبة في العلاج للوصول إلى النواتج والمكاسب الحقيقية.

الفيئات العلاجية المستخدمة:

التعليم والتدريب، الأسئلة السقراطية، فنية التخلي عن المطالب، المناقشة

الطريقة والإجراءات :

- ١ - يقوم المعالج بعمل تثقيف نفسي مباشر لتوضيح أهمية التخطيط للمستقبل عبر مجموعة من الأسئلة السقراطية يسأل المعالج المشارك سلسلة من الأسئلة التي تقود المشارك لاكتشاف التناقض الذي تنطوي عليه فكرة تلقائية سلبية لديه . على سبيل المثال، «عندما تحدث نفسك بأنك فاشل في حياتك، هل تعني أنك فاشل في بعض جوانب حياتك في بعض الأوقات، أو أنك فاشل في كل الجوانب في بعض الأوقات؟» إذا أجاب المشارك «بعض الجوانب في بعض الأوقات»، يمكنك أن تشير أي إن هذا هو حال كل البشر . إما إذا قال المشارك «إننا فاشل

في كل أوجه حياتي في كل الأوقات «، فيمكنك إن تشير إلى إن ذلك ليس صحيحا في أي حال من الأحوال لدى أي إنسان «إلخ، واستخدام فنية التفاعل لرفع مستوى الدافعية الداخلية للمشاركين الإيجابيين، وضبط المشاركين السلبيين بما تتضمنه من أسئلة مفتوحة، وتوكيد (تأكيد تعبيرات والأفكار الإيجابية للمشارك)، والاستماع الانعكاسي (من المشارك ولكن ليس بسلبية، ثم اجعل تعليقاتك انعكاسا لما يقوله المشارك، أو يعبر عنه من أفكار أو مشاعر) وتتعدد مستويات وأنواع الاستماع الانعكاسي بناء على ما يلي: العكس البسيط (وهو ترديد أو إعادة صياغة لما قاله المشارك حرفيا)، والعكس المكبر (وهو التعبير عما قاله المشارك ولكن بدرجة مضخمه مثال هل لا تستطيع التحكم في نفسك نهائيا ؟)، العكس مزدوج الوجهة (وهو تعبير عن جانب سلبي ذكره المشارك وجانب إيجابي سبق أن عبر عن المشارك وهي تهدف كذلك إلى تنمية التناقض لديه)، وتغيير مركز الاهتمام (وهو التعبير عن جانب سبق ذكره لتغيير مركز الاهتمام الحالي إذا كان يعمل ضد أهداف الجلسة)، ومسايرة المقومة (عوضا عن مواجهه، ساير المقاومة السلبية مثل شخص منزوي، فتقول له يبدو أنك تحب أن تستقل بنفسك .. إلخ) وأخيرا إعادة التأطير أي إعطاء معنى جديد وإيجابي لمعلومة أو حدث ذكره المشارك، وذلك من خلال دعوته إلى التفكير في احتمالات جديدة حول نفس الحدث. ويتم ذلك عن طريق أسلوب التفسير الاستكشافي وذلك لإخراج المشارك من الدائرة المغلقة في الحلول لمشكلته، وذلك عبر توصل المشارك نفسه في مساعدة نفسه للوصول للقرارات المناسبة للوصول إلى أكبر كم من المعلومات بهدف التوصل إلى أن يدرك المشارك أهمية التخطيط للمستقبل . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة)

٢ - يقوم المعالج باستخدام فنية التخلي عن المطالب وذلك بأن يعي المشارك مجموعة المبادئ السلوكية التي تتحكم في عدم قدرة المشارك على الصبر للوصول إلى النواتج الأخيرة مكتفيا بالمكاسب المؤقتة وذلك عبر استخدام فنية التخلي عن المطالب والتي يتم فيها حث المشارك على التخلي عن مجموعة المبادئ السلوكية التي تتحكم في سلوكه والتي تتخذ صياغات لفظية مثل (مجموعة العبارات التي تؤكد على أن دخولي كان فقط لإرضاء أهلي، أو بسبب العمل، أو لكي أنظف دمي ... إلخ) ثم تحديد تلك الصياغات ومساعدة المشارك على استبدالها بعبارات ومبادئ مرنة وتشجع على أهمية الأهداف والمكاسب الحقيقية الأخيرة المستقبلية

وإعطاء المشارك واجب للتأكد من أنه فهم عبر تحديد أبرز المبادئ السلوكية التي تحد وتعطل من توجه المريض للمستقبل منتهيا بذلك الجلسة (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٣٠ دقيقة) نهاية الجلسة الخامسة عشرة

٣- يقوم المعالج بالترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة والتأكد من أداء التمارين المطلوبة من قبل المشاركين، ثم يقوم المعالج بالاستعانة بنماذج حقيقية صبرت وعانت في العلاج بغية الوصول للهدف الحقيقي والمكسب الحقيقي وهو التعافي من الإدمان، وذلك لعرض معاناته وصبره في سبيل العلاج. (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٣٠ دقيقة)

ثم يقوم المعالج بتدريب المشاركين على كيفية وضع الأهداف القصير والبعيدة المدى انظر (عرض بور بوينت)، ثم يقوم المعالج بإعطائهم واجب للتأكد من فهمهم ومناقشة الأهداف التي وضعوها وتقديم تغذية راجعة للمشاركين وهي عملية تزويد المشارك بمعلومات حول استجابته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل الاستجابات التي تكون بحاجة إلى تعديل وتثبيت الاستجابات التي تكون صحيحة وشرح أسباب الأخطاء، بالإضافة إلى تزويده بعبرات تعزيزية لمواصلة السلوك الايجابي وتثبيت الاستجابة . (الوقت المستغرق للتنفيذ: ٢٥ دقيقة) نهاية الجلسة

تمرين الجلسة الخامسة عشرة :

وإعطاء المشارك واجب للتأكد من أنه فهم عبر تحديد أبرز المبادئ السلوكية التي تحد وتعطل من توجه المريض للمستقبل.

تمرين الجلسة السادسة عشرة :

تكليف المشارك بوضع الأهداف القصير والبعيدة المدى للتأكد من فهمهم ومناقشة الأهداف التي وضعوها .

وتكليفهم بواجب يقدمون من خلاله على تلخيص مادة معرفية مقدمة لهم عن التدريب على الصبر واستعراض خبرة كل مشارك عن موقف تعرض له واحتاج فيه إلى الصبر.

الجلسة : السابعة عشرة

المدة: (٦٠) دقيقة

موضوع الجلسة :الفعالية الذاتية

هو إدراك المدمن بأن نجاحه في حياته إنما يتحدد في ضوء كده واجتهاده ومثابرته في تحقيق أهدافه بغير تعليل أو تبرير بمنطق الحظ أو الظروف .

التمهيد : الترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة والتأكد من أداء التمارين المطلوبة من قبل المشاركين .
(الوقت المستغرق للتنفيذ : ١٠ دقائق)

الهدف من الجلسة :

- من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :
- أن يكتشف المشارك من أن النجاح لا يتحقق إلا بالاجتهاد والمثابرة في تحقيق الأهداف
- أن يستنبط المشارك بأن الحظ والظروف لا تعطل الإنسان عن تحقيق أهدافه

الغنيات العلاجية المستخدمة:

التعليم والتدريب، المناقشة

الطريقة والإجراءات :

يقوم المعالج بتدريب المشاركين على الحصول على المعلومات الدقيقة وإخضاعها للمنطق والنقد للخروج باستنتاجات واقعية يدرك من خلالها المشارك بأن النجاح لا يأتي إلى من خلال العمل والجهد والصبر لا عن طريق الحظ، يكلف المعالج كل مشارك بواجب يحلل من خلاله عرض مباشر لحالة متعافي من الإدمان وكيف أن اجتهاده وإرادته كان له دور في حصوله على هدفه المنشود . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة).

ثم يقوم المعالج بتقديم تثقيف نفسي عن شروط النجاح وإعطاءها المشاركين واستخراج أهم الفوائد التي استفادوا منها ومناقشة ذلك . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة)

تمارين الجلسة السابعة عشرة :

يكلف المعالج كل مشارك بواجب يحلل من خلاله عرض مباشر لحالة متعافي من الإدمان وكيف أن اجتهاده وإرادته كان له دور في حصوله على هدفه المنشود

يقوم المعالج بإعطاء واجب عبر توفير مادة علمية عن شروط النجاح وإعطاءها المشاركين لاستخراج أهم الفوائد التي استفادوا منها ومناقشة ذلك في الجلسة اللاحقة.

الجلسة : الثامنة عشرة المدة: (٦٠) دقيقة

موضوع الجلسة : الحاجة إلى التقبل

وهو الرغبة في التغيير وبداء حياة جديدة والتخلص من نظرة المجتمع والآخرين السلبية والتخلص من الألم والمعاناة و مزاوله الحياة بشكل طبيعي .

التمهيد : الترحيب بالمشاركين واستعراض لما تم انجازه الجلسة السابقة، والتأكد من استيعاب وتحقيق أهداف الجلسة السابقة . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ١٠ دقائق)

الهدف من الجلسة :

من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادرا على أن :

- أن يميز المشارك سبب نظرة المجتمع عنه .
- أن يكتشف ويحدد المشارك السلوكيات الخاطئة والعادات القديمة المسؤولة عن نظرة المجتمع له .

الفنيات العلاجية المستخدمة:

المناقشة، التعليم والتدريب

الطريقة والإجراءات :

يقوم المعالج بعمل جلسة مناقشة جماعية تستهدف أبرز السلوكيات الإدمانية التي أفرزت نظرة المجتمع السلبية حول كل مشارك والوصول إلى استنتاجات شاملة لكل الأعضاء المشاركين . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة)

يقوم المعالج بحث المشاركين على التخلي عن مجموعة العادات القديمة التي تهيأ للانتكاسة وتحديدتها عبر مناقشة جماعية يتم من خلالها الوصول إلى خلاصه لأبرز العادات السلبية المهيأة للانتكاسة، ومن ثم مساعدة المشارك على استبدالها بعادات اجتماعية مفيدة . (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة).

المدة: (٦٠) دقيقة

الجلسة : التاسعة عشرة

موضوع الجلسة : إنهاء البرنامج والقياس البعدي

الهدف من الجلسة :

من المتوقع من المشارك عند الانتهاء من تطبيق هذه الجلسة أن يكون قادراً على أن :

- أن يستجيب المشارك للاختبار البعدي وذلك بهدف التعرف على درجة الدافعية على مقياس الدافعية للعلاج من الإدمان .

الطريقة والإجراءات :

يطبق المعالج النفسي أداة القياس التي قام بإعدادها لقياس درجة الدافعية للعلاج ويعطيه تعليمات التطبيق والتأكيد على أهمية إعطاء أول إجابة تتبادر إلى ذهنه وأهمية الصدق في الإجابة (الوقت المستغرق للتنفيذ : ٢٥ دقيقة)

المراجع

إبراهيم، عبد الستار. (٤٩٩١). العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث. القاهرة، دار الفجر.
بيك، أرون. (٢٠٠٢). العلاج المعرفي والاضطرابات الانفعالية. (ترجمة مصطفى، عادل).
القاهرة، دار الأفاق العربية.

الجوهي، عبد الله عمر (٢٠٠٢م) أثر النموذج المعرفي السلوكي في علاج عينة من مرضى
الإدمان. رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة المنيا، مصر .

الجلبي، قتيبة و اليحيا، فهد. (٦٩٩١). العلاج النفسي وتطبيقاته في المجتمع العربي. الرياض،
الإعلامية للنشر.

الحجار، محمد (٩٠٤١هـ) التدريب العلاجي الطبي السلوكي في موضوع الإدمان على المواد
المبدلة للمزاج، الكحول والمواد المخدرة .

الحجار، محمد. (٢٩٩١). العلاج النفسي الحديث للإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.
الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.

الحسين، أسماء عبد العزيز (٧٩٩١م)، فاعلية العلاج النفسي السلوكي الجماعي في خفض
درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات الإقامة الداخلية في جامعة الملك
سعود، رسالة ماجستير في علم النفس (غير منشورة)، الرياض: جامعة الملك سعود.

الخطيب، جمال (٢٠٩٩م)، تعديل السلوك - القوانين و الإجراءات، الطبعة الثانية: الرياض.

الزراد، فيصل محمد خير (٨٨٩١)، علاج الأمراض النفسية و الاضطرابات السلوكية، دار
العلم للملايين.

الزهراني، أحمد سعيد (٢٠٠٢م) فعالية برنامج علاجي نفسي مقترح لخفض درجة بعض
الاضطرابات النفسية التالية للصدمة . رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية ، الرياض : السعودية .

زهران، حامد (٧٧٩١م)، الصحة النفسية والعلاج النفسي: الطبعة الثانية.

_____ (٤٩٩١م) . الصحة النفسية و العلاج النفسي . (ط ٢) ، القاهرة: عالم الكتب.

سري، إجلال محمد (٩٩١م)، علم النفس العلاجي، القاهرة: ك عالم الكتب.

الشناوي محمد ، والسيد عبد الرحمن (٨٩٩١م) العلاج السلوكي الحديث ، القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر، ص ٤٤٤ .

عيسوي، عبد الرحمن (٤٨٩١م)، العلاج النفسي، بيروت: دار النهضة العربية.

غانم ، محمد حسن محمد (٢٠٠٢م) الدافعية للعلاج لدى المدمنين - دراسة نفسية مقارنة. المجلة المصرية للدراسات النفسية ، المجلد العاشر ، العدد ٥٢ - الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، القاهرة : مصر .

فطيم، لطفي (٣٩٩١م)، العلاج النفسي الجمعي: مكتبة الأنجلو المصرية.

كمال، وعلي (٤٩٩١م)، العلاج النفسي قديماً وحديثاً: الطبعة الأولى.

المحارب، ناصر ابراهيم. (٢٠٠٠). المرشد في العلاج الاستعرافي السلوكي. الرياض، دار الزهراء.

محمد، عادل عبدالله. (٢٠٠٠). العلاج المعرفي السلوكي أسس وتطبيقات. القاهرة. دار الرشاد. محي الدين ، أحمد حسين (١٩٨٨م) الدافعية العامة وأبعادها عند الذكور : دراسة عاملية في إطار المجتمع السعودي . دراسات في الدافعية والدوافع ، الطبعة الأولى - دار المعارف ، القاهرة .

مصطفى فهمي ١٩٦٠، الدوافع النفسية . القاهرة ، مكتبة مصر: ٤٩ .

مليكه، لويس كامل (١٩٩٤م)، العلاج السلوكي وتعديل السلوك: الطبعة الثانية.

الملحق رقم (٤) قائمة بأسماء محكمين
البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان

م	الاسم
١	د . حسين الحميد استشاري الطب النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
٢	د . سامر محمد محمد عرار أستاذ علم النفس الإرشادي بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
٣	د . سيد احمد الوكيل أستاذ علم النفس والتقويم النفسي بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
٤	د . صلاح فؤاد الشعراوي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
٥	د . عبد الرحمن عيد الجهني أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة الطائف
٦	أ . عبد الله أحمد الوائلي أخصائي نفسي إكلينيكي أول بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
٧	د . محمد القرني استشاري العلاج النفسي ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
٨	د . مروان علي المحمدي أستاذ علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
٩	أ.د . عادل كمال خضر أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
١٠	د . يوسف سطاتم العنزي أخصائي نفسي إكلينيكي أول ورئيس قسم الخدمات النفسية بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض

الملحق رقم (٥) المخاطبات الرسمية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Higher Education
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY
Faculty of Education



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك عبد العزيز
كلية التربية

Ref. :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :

Date :

التاريخ :

Encl. :

المرفقات :

سعادة رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة نايف وفاقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالإشارة إلى إفادتكم بتاريخ ١٤٣٠/١/١٧ هـ . بخصوص
الطالب / يزيد بن محمد الشهري الدارس بمرحلة الدكتوراه
والمتمضمن التطبيق الميداني لرسالته

بعنوان (بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية
الدافعية للعلاج من الإدمان وقياس فاعليته) .

عليه نفيدكم بأن الطالب قد أنهى تطبيق برنامجه العلاجي
المعرفي السلوكي، على عينة من المدمنين بمكافحة
المخدرات بجدة للفترة من ١٤٣١/٢/١٦ هـ إلى
١٤٣١/٣/٧ هـ تحت إشرافي .

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،،

١٤٣١/٢/١٦
الدكتور / محمد بن سالم السهيمي
دكتوراه في العلاج النفسي

رئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجدة

استشاري علاج نفسي بمستشفى الملك فهد بجدة



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
Ref. :
Date :
Encl. :

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة نايف وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالإشارة إلى إفادتكم بتاريخ ١٤٣٠/١/١٧ هـ بخصوص
الطالب / يزيد بن محمد الشهري الدارس بمرحلة الدكتوراه
والمتمضمن التطبيق الميداني لرسالته

بعنوان (بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية
الدافعية للعلاج من الإدمان وقياس فاعليته) .

عليه نفيدكم بأن الطالب قد أنهى تطبيق برنامج العلاجي
المعرفي السلوكي، على عينة من المدمنين بمكافحة
المخدرات بجدة للفترة من ١٤٣١/٢/١٦ هـ إلى
١٤٣١/٣/٧ هـ تحت إشرافي .

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،،

الدكتور / محمد بن سالم السليمي
دكتوراه في العلاج النفسي

رئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجدة

استشاري علاج نفسي بمستشفى الملك فهد بجدة